

Gladius series
Halberd

Astato series
ASAHI Gaia PV

Peripheral Guide Wire

SYMBOLS	1
English [EN]	9
Dansk [DA]	12
Nederlands [NL]	15
Suomi [FI]	18
Français [FR]	21
Deutsch [DE]	24
Ελληνικά [EL]	28
Magyar [HU]	32
Italiano [IT]	35
Polski [PL]	38
Português [PT]	42
Español [ES]	45
Svenska [SV]	48
Česky [CS]	51
Norsk [NO]	54
Slovenský [SK]	57
Eesti keel [ET]	60
Latviešu [LV]	63
Lietuvių kalba [LT]	66
Türkçe [TR]	69
Русский [RU]	72
Български [BG]	76
Hrvatski [HR]	80
Română [RO]	83
Slovenščina [SL]	86
Malti [MT]	89

SYMBOLS

	English	Dansk	Nederlands	Suomi	Français	Deutsch	Ελληνικά
	Legal manufacturer	Autoriseret producent	Wettelijke fabrikant	Laillinen valmistaja	Fabricant légal	Juristischer Hersteller	Νόμιμος κατασκευαστής
	Do not use if package is damaged	Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	Älä käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Nicht verwenden, falls Packung beschädigt ist	Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
	Do not reuse	Må ikke genbruges	Niet opnieuw gebruiken	Älä käyttää uudelleen	Ne pas réutiliser	Nicht wiederverwenden	Μην επαναχρησιμοποιήσετε
	Do not resterilize	Må ikke resteriliseres	Niet opnieuw steriliseren	Älä steriloi uudelleen	Ne pas restériliser	Nicht erneut sterilisieren	Μην επαναποστεριρώσετε
	Caution, consult accompanying documents	Forsigtig, se de medfølgende dokumenter	Let op, zie bijgevoegde documentatie	Varoitus, katso mukana toimitetut asiakirjat	Avertissement, consulter la documentation d'accompagnement	Vorsicht, beiliegende Dokumente beachten	Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα
	Use by	Anvendes inden	Uiterste gebruiksdatum	Viimeinen käyttöpäivä	Expiration	Verwenden bis	Χρήση από
	Keep dry	Opbevares tørt	Droog bewaren	Pidä kuivana	À conserver au sec	Vor Nässe schützen	Διατηρήστε το στεγνό
	Keep away from sunlight	Undgå direkte sol	Niet aan zonlicht blootstellen	Pidä poissa auringonvalosta	À conserver à l'abri de la lumière	Vor Sonneneinstrahlung schützen	Κρατήστε το μακριά από το φως του ήλιου
	Authorized Representative in the European Union	Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union	Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie	Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa	Représentant habilité dans l'Union européenne	Bevollmächtigter in der Europäischen Union	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	LOT number	Lotnummer	Partijnummer	Eränumero	Numéro de LOT	Losnummer	Αριθμός παρτίδας
	Catalogue number	Katalognummer	Catalogusnummer	Tuotenumero	Numéro de référence	Katalognummer	Αριθμός καταλόγου
	Sterilized using ethylene oxide	Steriliseret med ethylenoxid	Gesteriliseerd met ethyleenoxide	Steriloitu etyleenioksidilla	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	Mit Ethylenoxid sterilisiert	Αποστεριώνεται με χρήση οξειδίου του αιθυλενίου

	English	Dansk	Nederlands	Suomi	Français	Deutsch	Ελληνικά
	Unit	Produkt	Eenheid	Määrä	Unité	Einheit	Μονάδα
	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use	Se brugsanvisningen eller se den elektroniske brugsanvisning	Zie de (elektronische) gebruiksaanwijzing	Katso käyttöohjeet tai sähköiset käyttöohjeet	Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi en format électronique	Bitte die beiliegende Gebrauchsanweisung oder die elektronische Gebrauchsanweisung lesen	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης.
	Straight	Lige	Recht	Suora	Droit	Gerade	Τσιο
	Pre-shaped	Præformet	Voorgevormd	Valmiiksi muotoiltu	Préformé	Vorgeformt	Προδιαμορφωμένο
	Contents	Indhold	Inhoud	Sisältö	Contenu	Inhalt	Περιεχόμενα
	Guide Wire	Ledningstråd	Geleidedraad	Ohjainvaijeri	Fil guide	Führungsdraht	Καθοδηγητικό σύρμα
	Torque device	Momentanordning	Koppelinstrument	Vääntömomentti laite	Dispositif de rotation	Torquer	Συσκευή ροπής
	Medical device	Medicinsk udstyr	Medisch instrument	Lääkinnällinen laite	Dispositif médical	Medizingerät	Ιατρική συσκευή
	Single sterile barrier system	Enkelt steril barriersystem	Enkelvoudig steriel barriersysteem	Yksinkertainen steriili estejärjestelmä	Système de barrière stérile unique	Individuelles Sterilbarriersystem	Ενιαίο σύστημα αποστειρωμένου φραγμού
	Contains hazardous substances	Indeholder farlige stoffer	Bevat gevaarlijke stoffen	Sisältää haitallisia aineita	Contient des substances dangereuses	Enthält gefährliche Inhaltsstoffe	Περιέχει επικίνδυνες ουσίες
	Importer	Importør	Importeur	Maahantuoja	Importateur	Importeur	Εισαγωγέας

	Magyar	Italiano	Polski	Português	Español	Svenska	Česky
	Hivatalos gyártó	Produttore legale	Legalny producent	Fabricante legal	Fabricante legal	Juridisk tillverkare	Výrobce
	Ne alkalmazza az eszközt, ha a csomagolás sérült.	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	No lo utilice si el envase está dañado	Använd inte om förpackningen är skadad	V případě, že je obal poškozený, výrobek nepoužívejte
	Ne használja újból.	Non riutilizzare	Nie używać ponownie	Não reutilizar	No lo reutilice	Får inte återanvändas	Nepoužívejte opakovaně
	Ne fertőtlenítse újbóli használatához.	Non risterilizzare	Nie sterylizować ponownie	Não reesterilizar	No lo reesterilice	Får inte omsteriliseras	Nesterilizujte opakovaně
	Figyelem, olvassa el a mellékelt dokumentumokat	Attenzione, consultare la documentazione di accompagnamento	Uwaga, zapoznać się z dołączonymi dokumentami	Cuidado, consulte os documentos anexos	Precaución, consulte los documentos que se incluyen	Varning, läs medföljande dokument	Upozornění – přečtěte si průvodní dokumentaci
	Lejárat	Utilizzare entro	Data ważności	Utilizar até	Fecha de caducidad	Använd före	Spotřebujte do
	Száraz helyen tárolja	Conservare in luogo asciutto	Chronić przed wilgocią	Manter seco	Manténgalo seco	Förvaras torrt	Uchovávejte v suchu
	Tartsa távol napfénytől	Tenere lontano dai raggi solari	Chronić przed światłem słonecznym	Manter distante da luz do sol	Manténgalo alejado de la luz del sol	Håll undan från solljus	Chraňte před slunečním světlem
	Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban	Rappresentante autorizzato nell'Unione Europea	Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej	Representante autorizado na União Europeia	Representante autorizado en la Unión Europea	Auktoriserad representant i EU	Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii
	Helyrajzi szám	Numero di LOTTO	Numer partii	Número de LOTE	Número del lote	LOT-nummer	Číslo šarže
	Katalógusszám	Numero di catalogo	Numer katalogowy	Número de catálogo	Número del catálogo	Katalognummer	Katalogové číslo
	Etilén-oxiddal fertőtlenítve	Sterilizzato mediante ossido di etilene	Steryliзовany tlenkiem etylenu	Esterilizado com óxido de etileno	Esterilizado con óxido de etileno	Steriliserad med etylenoxid	Sterilizováno pomocí ethylenoxidu
	Egység	Unità	Jednostka	Unidade	Unidad	Enhet	Jednotka

	Magyar	Italiano	Polski	Português	Español	Svenska	Česky
	Olvassa el a használati útmutatót vagy az elektronikus használati útmutatót	Consultare le istruzioni per l'uso o le istruzioni per l'uso elettroniche	Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub z elektroniczną instrukcją użytkowania	Consulte as instruções de utilização ou consulte as instruções de utilização eletrônicas	Consulte las instrucciones de uso en papel o en formato electrónico.	Se bruksanvisningen eller elektronisk bruksanvisning	Přečtěte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití
	Egyenes	Dritto	Prosty	Reto	Recto	Rak	Rovný
	Előre kialakított	Presagomato	Wstępnie formowany	Pré-moldado	Preconformado	Förhandsformad	Tvarovaný
Contents	A csomag tartalma	Contenuto	Zawartość	Conteúdo	Contenido	Innehåll	Obsah
	Vezetődrót	Filo guida	Prowadnik	Fio guia	Alambre guía	Ledare	Vodící drát
	Nyomatékeszköz	Dispositivo di torsione	Urządzenie dynamometryczne	Dispositivo de torção	Dispositivo de torsión	Momentenhet	Momentové zařízení
MD	Orvostechikai eszköz	Dispositivo medico	Wyrób medyczny	Dispositivo médico	Dispositivo médico	Medicinteknisk produkt	Zdravotnický prostředek
	Egyszeres steril gátrendszer	Sistema a barriera sterile singola	System pojedynczej sterylnej bariery	Sistema de barreira estéril único	Sistema de barrera estéril único	Enkelt sterilt barriärsystem	Jednoduchý sterilní bariérový systém
	Veszélyes anyagot tartalmaz	Contiene sostanze pericolose	Zawiera substancje niebezpieczne	Contém substâncias perigosas	Contiene sustancias peligrosas	Innehåller farliga ämnen	Obsahuje nebezpečné látky
	Importőr	Importatore	Importer	Importador	Importador	Importör	Dovozce

	Norsk	Slovenský	Eesti keel	Latviešu	Lietuvių kalba	Türkçe
	Produsent	Legálny výrobca	Juriidiline tootja	Likumīgs ražotājs	Teisėtas gamintojas	Yasal üretici
	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet	Nepoužívajte, ak je poškodený obal.	Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud	Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts	Jeigu pažeista pakuotė, naudoti negalima	Ambalajı hasar görmüşse ürünü kullanmayın
	Må ikke gjenbrukes	Nepoužívajte opakovane.	Mitte korduvalt kasutada	Nelietojiet atkārtoti	Nenaudoti pakartotinai	Tekrar kullanmayın
	Må ikke resteriliseres	Znovu nesterilizujte.	Mitte uuesti steriliseerida	Nesterilizējiet atkārtoti	Nesterilizuoti pakartotinai	Tekrar sterilize etmeyin
	Forsiktig, se vedlagte dokumenter	Upozornenie, pozrite si spríevodné dokumenty.	Ettevaatust! Lugege seadmega kaasasolevaid juhendeid.	Ievērojiet piesardzību, skatiet komplektācijā iekļauto dokumentāciju	Dėmesio, žr. kartu pateikiamus dokumentus	Dikkat, birlikte gelen belgelere bakın
	Brukes innen	Dátum expirácie	Aegumiskuupäev	Izmantot līdz	Tinka iki	Son kullanma tarihi
	Må oppbevares tørt	Udrživajte v suchu.	Hoida kuivas	Uzturiet sausu	Laikyti sausai	Kuru tutun
	Må ikke oppbevares i sollys	Nevystavujte slnečnému svetlu.	Hoida eemal päikesevalgusest	Sargāt no saules gaismas	Saugoti nuo saulės šviesos	Güneş ışığından uzak tutun
	Autorisert representant i EU	Autorizovaný zástupca v Európskej únii	Volitatud esindaja Euroopa Liidus	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā	Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje	Avrupa Birliği'nde Yetkili Temsilci
	Parti/Batchnummer	Číslo šarže	Partii number	Partijas numurs	Serijos numeris	LOT numarası
	Katalognummer	Katalógové číslo	Kataloogi number	Kataloga numurs	Katalogo numeris	Katalog numarası
	Sterilisert med etylenoksid	Sterilizované pomocou etylénoxidu.	Steriliseeritud etüleenoksiidiga	Sterilizēts, izmantojot etilēnoksidu	Sterilizuota etileno oksidu	Etilen oksitle sterilize edilmiştir
	Enhet	Jednotka	Üksus	Vienība	Elementas	Birim

	Norsk	Slovenský	Eesti keel	Latviešu	Lietuvių kalba	Türkçe
	Se bruksanvisningen eller se elektroniske instruksjoner for bruk	Prečítajte si návod na použitie alebo elektronický návod na použitie	Lugege kasutusjuhendit või elektroonilist kasutusjuhendit	Skatiet lietošanas norādījumus vai elektroniskos lietošanas norādījumus	Žr. naudojimo instrukciją arba elektroninę naudojimo instrukciją	Kullanım talimatlarına bakın veya elektronik kullanım talimatlarına bakın
	Rett	Rovný	Sirge	Taisns	Tiesi	Düz
	Forhåndsformet	Predtvarovaný	Eelvormitud	Iepriekš izveidota forma	Iš anksto suformuotas	Önceden şekillendirilmiş
Contents	Innhold	Obsah	Pakendi sisu	Saturs	Turiny	Paket İçeriği
	Ledesonde	Vodiaci drôt	Juhtetraat	Vadītājstīga	Kreipiamoji viela	Kılavuz Teli
	Dreiemomentenhet	Torzná pomôcka	Pöördemomentscade	Griezes momenta ierīce	Sukimo momento prietaisas	Tork cihazı
MD	Medisinsk enhet	Zdravotnícka pomôcka	Meditsiiniseade	Medicīnas ierīce	Medicinos priemonė	Tıbbi cihaz
	Enkelt steril barrieresystem	Systém jednej sterilnej bariéry	Ühekordne steriilse barjääri süsteem	Vienas sterilās barjeras sistēma	Vientisa sterilaus barjero sistema	Tekli steril bariyer sistemi
	Inneholder farlige stoffer	Obsahuje nebezpečné látky	Sisaldab ohtlikke aineid	Satur bīstamas vielas	Sudėtyje yra pavojingų medžiagų	Tehlikeli maddeler içerir
	Importer	Dovozca	Importija	Importētājs	Importuotojas	İthalatçı

	Русский	Български	Hrvatski	Română	Slovenščina	Malti
	Официальный производитель	Легален производител	Proizvođač	Producător legal	Legalni proizvajalec	Manifattur legali
	Не использовать, если упаковка повреждена	Не използвайте, ако опаковката е повредена	Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno	A nu se folosi dacă ambalajul este deteriorat	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana	Tużax jekk hemm hsara fil-pakkett
	Повторное использование запрещено	Да не се използва повторно	Nemojte ponovno koristiti	A nu se refolosi	Ne uporabljajte ponovno	Tużax iktar minn darba
	Повторная стерилизация запрещена	Да не се стерилизира повторно	Nemojte ponovo sterilizirati	A nu se resteriliza	Ne sterilizirajte ponovno	Tisterilizzax mill-ġdid
	Внимание! См. сопроводительные документы	Внимание, консултирайте се с придружаващите документи	Oprez, pogledati prateće dokumente	Atenție, a se consulta documentele de însoțire	Pozor, glejte spremne dokumente	Attenzjoni, ikkonsulta d-dokumenti ta' akkumpanjament
	Срок годности	Използвайте до	Upotrijebiti do	A se utiliza de către	Uporabno do	Uża sa
	Не допускать попадания влаги	Пазете сухо	Čuvati na suhom	A se păstra uscat	Hraniti na suhem	Żomm niexef
	Не допускать попадания солнечного света	Пазете от слънчева светлина	Čuvati dalje od sunčevog svjetla	A se păstra departe de lumina soarelui	Hranite stran od sončne svetlobe	Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx
	Уполномоченный представитель в Европейском союзе	Упълномощен представител в Европейския съюз	Ovlašteni predstavnik u Europskoj uniji	Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană	Pooblaščeni zastopnik v Evropski uniji	Rappreżentant Awtorizzat fl-Unjoni Ewropea
	Номер партии	Партиден номер	LOT broj	Număr LOT	LOT številka	Numru tal-LOTT
	Номер по каталогу	Каталожен номер	Katalogski broj	Număr de catalog	Katalogška številka	Numru tal-katalogu
	Стерилизовано этиленоксидом	Стерилизиран чрез этиленов оксид	Sterilizirano etilen oksidom	S-a sterilizat folosind oxid de etilenă	Sterilizirano z etilen oksidom	Sterilizzat bl-ossidu tal-etilen
	Упаковка	Изделие	Jedinica pakiranja	Unitate	Enota	Unità

	Русский	Български	Hrvatski	Română	Slovenščina	Malti
	Ознакомьтесь с инструкцией по применению или ознакомьтесь с электронной инструкцией по применению	Консултирайте се с инструкциите за употреба или вижте електронните инструкции за употреба	Pogledajte upute za uporabu ili pogledajte elektroničke upute za uporabu	A se consulta instrucțiunile de utilizare sau a se consulta instrucțiunile electronice de utilizare	Preberite navodila za uporabo ali elektronska navodila za uporabo	Ikkonsulta l-istruzzjonijiet għall-użu jew ikkonsulta l-istruzzjonijiet elettronici għall-użu
	Прямой	Направо	Ravno	Drept	Ravna	Dritt
	С предварительно приданной формой	Предварително оформено	Unaprijed oblikovano	Preformat	Predhodno oblikovano	Preformat
	Содержимое упаковки	Съдържание	Sadržaj	Conținut	Vsebina	Kontenut
	Проволочный проводник	Водач	Vodilica	Fir de ghidaj	Vodilna žica	Wajer Gwida
	Устройство для вращения проводника катетера	Изделие с въртящ момент	Uredaj zakretnog momenta	Dispozitiv torque	Navorni pripomoček	Apparat tat-torque
	Медицинское изделие	Медицинско изделие	Medicinski proizvod	Dispozitiv medical	Medicinski pripomoček	Apparat mediku
	Одинарная стерильная барьерная система	Система с единична стерилна бариера	Sustav jednostruke sterilne barijere	Sistem unic de bariere sterile	Enojni sterilni sistem pregrad	Sistema ta' barriera sterili unika
	Содержит опасные вещества	Съдържа опасни вещества	Sadrži opasne tvari	Conține substanțe periculoase	Vsebuje nevarne snovi	Fih sustanzi perikoluži
	Импортер	Вносител	Uvoznik	Importator	Uvoznik	Importatur

Peripheral Guide Wire

INSTRUCTIONS FOR USE

Read these instructions carefully before using this guide wire and observe the Indications for Use, Target Treated Population, Contraindications, Warnings, Precautions, and How to Use sections in this Instructions for Use. Failure to do so may result in complications, including serious injury to the patient or death.

If a user and/or a patient comes to know a serious incident that has occurred in relation to the guide wire, report the fact to the manufacturer and the competent authority of the Member State.

These Instructions for Use apply to the Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. For details (length of the guide wire, length of radiopaque section, etc.), refer to the product label.

Descriptions

The basic structure of this guide wire consists of a taper core wire, and two types of distal coils (an outer coil and an inner coil). The taper core wire and the coils are soldered. A part or the entire length of the outer coil is radiopaque so that its position can be easily confirmed under fluoroscopy. The distal sides of Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, and ASAHI Gaia PV are coated with hydrophilic polymer. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, and Gladius MG18 PV ES each has a polyurethane resin coating on the outer coil, and a hydrophilic coating on top of that. In all these guide wires, the proximal side of the taper core wire is coated with PTFE (polytetrafluoroethylene). At the proximal end of the devices other than those with total lengths of 300cm, there is a connection for an extension wire, which is used to replace the combined device; ASAHI INTECC's Extension Wire can be connected.

Refer to the table below for the tip load* of this product.

Table1. Product specifications

Product Name	Outer Diameter	Tip Load*
Gladius	0.36mm(0.014")	3gf
	0.45mm(0.018")	4gf
Gladius MG14 PV	0.36mm(0.014")	3gf
Gladius MG14 PV ES	0.36mm(0.014")	3gf
Gladius MG18 PV ES	0.46mm(0.018")	3gf
Halberd	0.36mm(0.014")	12gf
	0.45mm(0.018")	12gf
Astato XS 20	0.20mm/0.36mm(0.008"/0.014")	20gf
Astato XS 40	0.23mm/0.36mm(0.009"/0.014")	40gf
Astato 30	0.33mm/0.45mm(0.013"/0.018")	30gf
ASAHI Gaia PV	0.36mm/0.45mm(0.014"/0.018")	7.5gf

Indications for Use

This guide wire is intended for general percutaneous peripheral intervention (PPI). This guide wire is intended to facilitate the placement of interventional therapeutic devices within peripheral vasculature of the lower extremity.

This guide wire is intended for use only in peripheral vasculature of the lower extremity. This guide wire is not intended for use in the neurovasculature and cardiovascular.

Target Treated Population

This guide wire is intended for patients who meet indications for PPI procedures. It is not indicated for use on neonates, infants, or children as well as patients who are pregnant, have impaired renal function, and who have an allergic reaction to contrast media or polyethylene glycol (PEG).

Contraindications

- Confirm the compatibility of guide wire diameter with other interventional device before actual use.
- Do not use the guide wire in patients who have an allergic reaction to contrast media or who have impaired renal function.
- This guide wire contains PEG400 in its hydrophilic coating. Do not use the guide wire in patients who have allergic reactions to polyethylene glycol (PEG).
- Do not use the guide wire for pregnant patients or patients who may be pregnant (X-ray may affect the fetus).
- This guide wire must be used in an institution where emergency surgical operation can be performed immediately. If an emergency surgical operation is unavailable, in the worst case, life-threatening events may occur.
- This guide wire is presterilized with ethylene oxide gas (EOG) and is intended for single use only. Do not reuse or resterilize. If reused or resterilized, the performance or quality of this guide wire and package may be compromised and there is a risk of complications, including infection.

Warnings

- This guide wire must be used only by a physician who is fully trained in PPI treatment.
- Never use this guide wire in combination with catheters having metal parts that may directly contact the surface of this guide wire (e.g. atherectomy catheters, metal dilators), metal needles or metal introducers.
- During use of the guide wire, check and monitor the movement of its tip under fluoroscopy. Do not use in areas of vessel that are not or cannot be visualized.
- Do not connect this guide wire with detachable extension wires produced by manufacturers other than ASAHI INTECC. Do not manipulate this guide wire while the detachable extension wire is connected. Otherwise, the guide wire may be damaged, or the detachable extension wire may be unintentionally detached.
- Do not modify this guide wire for any reason.

Precautions

- Do not use the guide wire after the expiration date indicated on the label. Discard any guide wire that exceeds the expiration date.
- Guide wires are delicate instruments and should be handled carefully.
- If the package is opened or damaged, do not use the guide wire. Do not open the package until just prior to use. Use aseptic technique in handling and using the guide wire.
- Always keep the guide wire in a wet state to prevent damage to its hydrophilic coating.
- Do not wipe this guide wire using an organic solution such as alcohol.
- After use, discard this guide wire, accessories, and package as medical waste taking preventive measures against infectious diseases.
- Never push, anger, withdraw, or torque this guide wire that meets resistance. Torquing or

pushing this guide wire against resistance may cause damage and/or tip separation of this guide wire or direct damage to a vessel. Failure to do so may cause damage to this guide wire.

Determine the cause of resistance under fluoroscopy and take any necessary remedial action.

- Always advance or withdraw the guide wire slowly and carefully.
- When torquing this guide wire inside the blood vessel, do not torque continuously in the same direction. When torquing the guide wire, rotate it clockwise and counterclockwise alternately. Do not rotate more than two rotations (720°) in the same direction.
- Flush the guide wire with heparinized and sterilized saline or other suitable solution while removing and reinserting it to prevent air from entering the interventional device. Perform exchange of this guide wire carefully to prevent air entry and/or trauma. When reintroducing the guide wire, confirm that the interventional device tip is free within the vessel lumen and is not against the vessel wall. Failure to do so may result in trauma. Use the radiopaque marker of the interventional device to confirm position.
- Free movement of the guide wire within the interventional device is an important feature of a steerable guide wire system because it gives the user valuable tactile information. Test the system for any resistance prior to use. Adjust or replace the hemostasis valve with an adjustable valve if it is found to inhibit the guide wire movement.
- Do not perform stent placement using more than one guide wire or wire operation through stent strut. Otherwise, the stent may be damaged or the guide wire may break or break apart.
- Before use, confirm that this guide wire is appropriate in size and shape for the procedure and is compatible with the device to be used in combination.
- Refer to the Instructions for Use attached to the medical device (e.g. interventional therapeutic devices) to be used in combination with this guide wire.
- When connecting the detachable extension wire with this guide wire, it should be securely inserted to the boundary line between non PTFE coating and PTFE coating at the proximal end of the guide wire. If any abnormality is found in the connection, stop using the guide wire immediately.
- Inspect the guide wire carefully for bends, kinks, or other damage prior to use and whenever possible during the procedure. Do not use the guide wire if it is damaged.
- When shaping the tip, be careful not to damage the coil.
- Before inserting the guide wire, check which end is the distal end and make sure to insert it from the distal end.
- Maintain a continuous heparinized and sterilized saline flush between the guiding catheter and the interventional device and between the interventional device and the guide wire during the procedure. Flushing prevents contrast media crystal formation and/or clotting on the guide wire and in the catheter lumen.
- For the holder with the distal end protection tube (refer to How to Use, Figure 1), do not remove or insert the distal end protection tube while the guide wire is housed in the holder.
- For the holder with the distal end protection tube (refer to How to Use, Figure 1), remove the distal end protection tube before housing the guide wire in the holder again.

Malfunctions and Adverse Events

Possible malfunctions and adverse events through usage of this guide wire include, but are not limited to the following:

1. Malfunctions

Breakage or bending of the guide wire	Damage such as separation	Coming off of coating
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------

2. Adverse events

Death	Infection	
Blood pressure reduction	Bleeding complications	Embolism
Infarction	Vascular occlusion	Thrombus
Ischemia	Arrhythmia	Vessel dissection
Vasospasm	Dizziness	Headache
Vomiting	Vessel perforation	Allergic reaction

How to Use

1. Inspection prior to use

- Before use, inspect carefully and confirm the guide wire and package are undamaged.
- Before use, confirm that the guide wire is compatible with the interventional devices to be used.

2. Preparation

- Select the most suitable guide wire for the affected area and remove the holder tube containing the guide wire from the sterile pack.
- Fill up the holder tube with heparinized and sterilized saline using a syringe to soak the

entire device. Take note that heparinized and sterilized saline may spill out of the holder tube during at this time. For the holder with the distal end protection tube (Figure 1), a syringe can be connected to the distal end protection tube.

- Fill the lumen of the interventional device with the heparinized and sterilized saline before inserting the guide wire.
- Release the guide wire from the tail clip and slide the guide wire slowly, push distal end of the guide wire through the holder tube(B). (Figure 2)

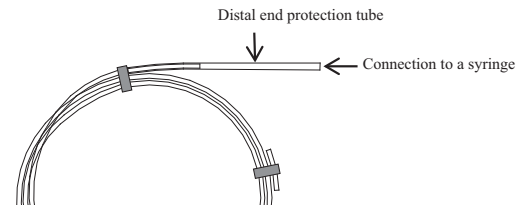


Figure 1

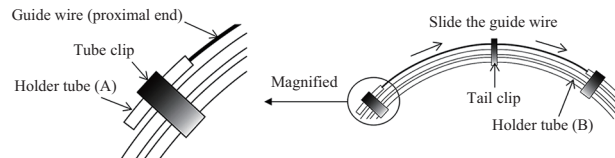


Figure 2

- e) When the distal end of the guide wire is extended 5 to 6 cm beyond the other end of the holder tube, if necessary, shape the tip in accordance with standard practice.
- f) Gently grasp the guide wire which came out from the distal end of the holder tube, at the point as close to the holder tube as possible and pull the guide wire out slowly and carefully.
- g) If resistance is felt when removing the guide wire from the holder tube, inject heparinized and sterilized saline into the holder tube again. Continue removing the guide wire after the resistance is not felt anymore. Be sure to inject enough heparinized and sterilized saline to the holder tube because hydrophilic coating may be damaged when removing the coated guide wire forcefully.
- h) After pulling the guide wire out of the holder tube, inspect it to make sure that it is not damaged.

3. Procedures for insertion

- Over-the-wire system
 - a) Insert the distal end of the guide wire carefully into the guide wire lumen of the interventional device.
 - b) Advance this guide wire carefully until its tip is just proximal to the interventional device tip.
 - c) Engage the guiding catheter and insert the interventional device system (with guide wire) into the Y connector.
 - d) Advance the interventional device system through the guiding catheter until the tip of the guide wire system is just proximal to the tip of the guiding catheter.
 - e) Tighten the hemostasis valve of Y connector to create a seal around the interventional device. Ensure the guide wire movement is still permitted.
 - f) Check to make sure the guide wire moves smoothly.
 - g) Attach the torque device to the guide wire if necessary.
 - h) Advance this guide wire under fluoroscopy to pass through the lesion. Confirm by

angiography that the guide wire has passed the narrowed target lesion.

- i) Observe the guide wire movement in the vessels.
- j) Advance the interventional device until the lesion is reached while preventing the guide wire from moving. Ensure that guide wire distal tip and its location in the vessel are visible during interventional device manipulations.
- Rapid exchange system
 - a) Engage the guiding catheter.
 - b) Insert the guide wire introducer into the Y connector of the guiding catheter.
 - c) Carefully insert the guide wire tip into the introducer.
 - d) Advance the guide wire through the guiding catheter under fluoroscopy until the guide wire tip is just proximal to the tip of the guiding catheter.
 - e) Attach the torque device to the guide wire if necessary.
 - f) Advance the guide wire under fluoroscopy to pass through the lesion. Confirm by angiography that the guide wire has passed the narrowed target lesion.
 - g) Observe the guide wire movement in the vessels.
 - h) Remove the guide wire torque device and the guide wire introducer.
 - i) Track the interventional device over the guide wire while preventing the guide wire from moving, and advance until the lesion is reached. Ensure that the guide wire distal tip and its location in the vessel are visible during interventional device manipulations.

4. Procedures to exchange the guide wire

- Over-the-wire system
 - a) Remove this guide wire slowly while monitoring the movement of this guide wire under fluoroscopy.
 - b) Insert the next guide wire in accordance with the directions in this "How to Use" section.

Expiration Date

The expiration date is indicated on the label of the guide wire package.

Contents

5 pieces / box

Liability Disclaimer

By no means shall "ASAHI INTECC CO., LTD. and its affiliated companies" (hereinafter referred to as the "Company") be liable for accidents, personal injuries, adverse events due to any improper use of the product(s) or any other use inconsistent with these instructions. In no event shall the Company be liable for any damages either (i) arising out of storage of the product(s) after the shipment from the Company or (ii) due to selection of patients, surgery techniques, or any other medical activities by the medical institution that uses the product(s)

"Gladius", "Halberd", "ASAHI Gaia" and "Astato" are trademarks or registered trademarks of ASAHI INTECC CO., LTD. in Japan and other countries.

*Tip load values represent the mean values of product specification values measured according to the internal standard testing method assuming the force applied to the lesion by the guide wire tip.

Storage Method

Do not keep the guide wire and package in a bent and/or heavily-loaded condition. This guide wire and package must be kept out of water. Store in a cool, dark, and dry place.

Perifer guidekabel

Brugsanvisning

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger denne guidewire, og overhold afsnittene **Indikationer for brug**, **Behandlet Målpopulation**, **Kontraindikationer**, **Advarsler**, **Forholdsregler** og **Anbefalet procedures** i denne brugsanvisning. Hvis dette undlades, kan det medføre komplikationer, herunder alvorlig kvæstelse af patienten eller dødsfald.

Når en bruger og/eller en patient bliver bekendt med en alvorlig hændelse, der er sket på grund af guidewiren, skal dette indberettes til producenten og myndighederne i det pågældende medlemsland.

Denne brugsanvisning gælder for Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Nærmere specifikationer (længden af guidewiren, længden af den røntgenfaste del mv.) fremgår af mærkaten på produktpakken.

Beskrivelser

Den grundlæggende struktur i denne guidekabel består af en konisk kernetråd og to typer distale spoler (en ydre spole og en indre spole). Den koniske kernetråd og spolerne er loddet. En del af eller hele længden på den ydre spole er stråleuigennemsigtig, så dens position let kan bekræftes under gennemlysning. De distale sider af Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 og ASAHI Gaia PV er belagt med hydrofil polymer. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES og Gladius MG18 PV ES har alle en polyurethanharpiksbelægning på den ydre spole og en hydrofil belægning oven på den. I alle disse guidekabler er den proksimale side af den koniske kernetråd belagt med PTFE (polytetrafluorethylen). I den proksimale ende af andre enheder end dem med en samlet længde på 300 cm er der en tilslutning til en forlængerledning, som bruges til at udskifte den kombinerede enhed; ASAHI INTECC's forlængerledning kan tilsluttes.

Se tabellen nedenfor for spidsbelastning* for dette produkt.

Tabell 1. Produktspecifikationer

Produktets navn	Udvendige diameter	Spidsbelastning*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
Hellebard	0,36 mm (0,014")	12 gf
	0,45 mm (0,018")	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008"/0,014")	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009"/0,014")	40 gf
Astato 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013"/0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014"/0,018")	7,5 gf

Indikationer for brug

Denne guidewire er beregnet til generel perkutan perifer intervention (PPI). Denne guidewire er beregnet til at lette placeringen af interventionelt terapeutisk udstyr i perifere blodkar i underkøstremiteiten.

Denne guidewire er kun beregnet til brug i perifere blodkar i underkøstremiteiten. Denne guidewire er ikke beregnet til brug i neurovaskulaturen og kardiovaskulaturen.

Målpopulation

Denne guidewire er beregnet til patienter, der opfylder indikationerne for PPI-procedurer. Den er ikke indiceret til brug hos nyfødte, spædbørn og børn samt patienter, der er gravide, har nedsat nyrefunktion eller er allergiske over for kontrastmidler eller polyethylenglykol (PEG).

Kontraindikationer

- Bekræft, at diameteren af guidewiren er kompatibel med andet interventionelt udstyr, før den anvendes.
- Guidewiren må ikke anvendes hos patienter, der er allergiske over for kontrastmidler eller har nedsat nyrefunktion.
- Denne guidewire indeholder PEG400 i sin hydrofile belægning. Brug ikke guidewiren på patienter, der har allergiske reaktioner over for polyethylenglycol (PEG).
- Brug ikke guidewiren til gravide patienter eller patienter, der kan være gravide (røntgenstråler kan påvirke fosteret).
- Guidewiren skal bruges på institutioner, hvor det er muligt øjeblikkeligt at udføre akutte kirurgiske indgreb. Hvis det ikke er muligt at udføre akutte kirurgiske indgreb, kan der i værste fald forekomme livstruende situationer.
- Guidewiren er præsteriliseret med ethylenoxidgas (EOG) og er udelukkende beregnet til engangsbrug. Må ikke genbruges eller resteriliseres. Genbrug eller resterilisering af guidetråden kan have en negativ indvirkning på guidetråden og emballagen og dermed vil være risiko for komplikationer, herunder infektioner.

Advarsler

- Denne guidewire må kun bruges af en læge, der er fuldt uddannet i PPI-behandling.
- Brug aldrig denne guidekabel i kombination med katetre med metaldele, der kan komme i direkte kontakt med overfladen af denne guidekabel (f.eks. aterektomikatetre, metaldilatorer, metalnåle eller metalindførere).
- Under brug af guidewiren skal spidens bevægelse kontrolleres og overvåges under fluoroskopi. Må ikke anvendes i dele af kar, der ikke er iagttaget eller kan iagttages.
- Guidewiren må ikke sammenkøbes med aftagelige forlænger-wirer, der er fremstillet af andre producenter end ASAHI INTECC. Guidewiren må ikke manipuleres, mens den aftagelige forlænger-wire er koblet til. I modsat fald kan guidewiren blive beskadiget, eller den aftagelige forlænger-wire kan løsnes utilsigtet.
- Guidewiren må ikke ændres uanset grunden.

Forholdsregler

- Guidewiren må ikke anvendes efter udløbsdatoen på mærkaten. Kassér alle guidewirer, der har overskredet udløbsdatoen.
- Guidewirer er skrøbelige instrumenter, der skal behandles forsigtigt.
- Guidewiren må ikke anvendes, hvis emballagen har været åbnet eller er beskadiget. Emballagen må først åbnes lige inden brug. Guidewiren skal håndteres og anvendes aseptisk.
- Hold altid guidewiren våd for at undgå beskadigelse af den hydrofile belægning.
- Undlad at aftørre guidewiren med en organisk opløsning, som f.eks. sprit.
- Efter brug skal guidekablet, tilbehøret og emballagen kasseres som medicinsk affald, og der skal træffes forebyggende foranstaltninger mod smitte mme sygdom mme.
- Guidewiren må aldrig skubbes, drejes, trækkes ud eller vrides rundt, hvis der mærkes

modstand. Hvis guidewiren vrides rundt eller skubbes til på trods af modstand, kan det beskadige spidsen af guidewiren, og/eller få spidsen til at gå af, eller det kan direkte medføre skade på karret. Hvis du ikke gør det, kan det beskadige denne guidewire. Find årsagen til modstanden under gennemlysning, og træf de nødvendige afhjælpende foranstaltninger.

- Før altid guidekablet langsomt og forsigtigt frem eller tilbage.
- Når guidewiren vrides rundt inde i blodkarret, må den ikke konstant vrides i samme retning. Guidewiren skal skiftevis vrides med og mod uret. Guidewiren må ikke drejes mere end to gange (op til 720°) rundt i samme retning.
- Skyl guidewiren med hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning eller anden velegnet opløsning, samtidig med at den tages ud og føres ind igen for at hindre luft i at komme ind i interventionsudstyret. Udvis forsigtighed under udsugning af guidewiren, så der ikke kommer luft ind og/eller forårsages skade. Under genindføring af guidewiren skal det sikres, at spidsen, der bruges til indgrebet, ligger frit inde i karrets lumen, og at den ikke ligger op mod karvæggen. I modsat fald kan der opstå traumer. Brug den røntgenfaste markør på interventionsudstyret til at fastslå positionen.
- Det er en vigtig del af det styrbare guidewiresystem, at guidewiren kan bevæge sig frit inde i interventionsudstyret, da brugeren derved kan føle sig frem til væsentlige informationer. Afprøv systemet før brug for at se, om der er modstand. Reguler, eller udskift hæmostaseventilen med en regulerbar ventil, hvis den viser sig at begrænse guidewirens bevægelsesmuligheder.
- Anlæg ikke nogen stent ved hjælp af flere end én guidewire, og før ikke guidewiren gennem stentens stivere. Ellers kan stenten blive beskadiget eller guidewiren kan lide skade eller gå i stykker.

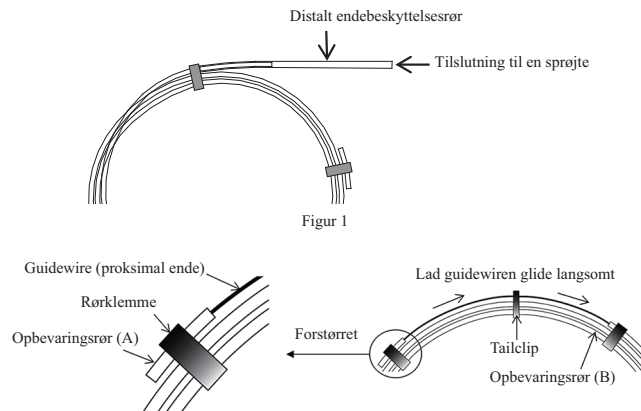
- Før brug skal det bekræftes, at denne guidewire har en hensigtsmæssig størrelse og form til proceduren og er kompatibel med den enhed, den skal bruges sammen med.
- Se brugsanvisningen til det medicinske udstyr (f.eks. interventionelt terapeutisk udstyr), der skal bruges i kombination med denne guidewire.
- Når den aftagelige forlænger-wire kobles til denne guidewire, skal den sættes godt fast til grænsefladen mellem den belægning, der ikke er PTFE, og den belægning, der er PTFE, ved guidewirens proximale ende. Der konstateres en afvigelse i forbindelsen, skal du straks stoppe med at bruge guidewiren.
- Se omhyggeligt efter, om guidewiren er bøjet, knækket eller på anden vis beskadiget før brug, og når det kan lade sig gøre under indgrebet. Brug ikke guidewiren, hvis den er beskadiget.
- Når du former spidsen, skal du være forsigtig med ikke at beskadige spolen.
- Før du indsætter guidewiren, skal du kontrollere, hvilken ende der er den distale ende, og sikre dig, at du indsætter den fra den distale ende.
- Opbehold en kontinuerlig hepariniseret og steriliseret saltvandskylning mellem føringskateteret og interventionsanordningen og mellem interventionsanordningen og guidewiren under proceduren. Gennemskylning forhindrer dannelse af kontrastmiddelkrystaller og/eller koagulation på guidewiren og i kateterlumen.
- Ved opbevaringsrøret med det distale endebeskyttelsesrør (se Anbefalet procedure, figur 1) må du ikke fjerne eller sætte det distale endebeskyttelsesrør, mens guidewiren er i opbevaringsrøret.
- Ved opbevaringsrøret med det distale endebeskyttelsesrør (se Anbefalet procedure, figur 1) skal du fjerne det distale endebeskyttelsesrør, før du sætter guidewiren tilbage i opbevaringsrøret.

2. Bivirkninger/uønskede hændelser

Død	Infektion	
Reduktion af blodtrykket	Komplikationer ved blødning	Emboli
Infarkt	Vaskulær okklusion	Trombe
Ischemia	Arrhythmia	Kardissektion
Vasospasme	Svi mmelhed	Hovedpine
Opkastning	Karperforation	Allergisk reaktion

Anbefalet procedure

1. Undersøg for brug
 - a) Kontrollér omhyggeligt før brug, at guidewiren og emballagen er ubeskadigede.
 - b) Kontrollér før brug, at guidewiren er kompatibel med det interventionsudstyr, der skal anvendes.
2. Klargøring
 - a) Vælg den mest velegnede guidewire til det berørte område, og tag opbevaringsrøret med guidewiren ud af den sterile emballage.
 - b) Fyld opbevaringsrøret med hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning ved hjælp af en sprøjte for at lægge hele enheden i blod. Vær opmærksom på, at hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning kan spildes fra opbevaringsrøret på dette tidspunkt.
 - c) Fyld interventionsudstyrets lumen med hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning, før guidewiren indføres.
 - d) Løsn guidewiren fra endeklipsen, og lad den glide langsomt igennem opbevaringsrøret (B), idet der skubbes på den distale ende af guidewiren (figur 2).



Figur 2

- e) Når den distale ende af guidewiren stikker mere end 5-6 cm ud af den anden ende af opbevaringsrøret (eller den distale ende af beskyttelsesrøret), kan spidsen eventuelt formes i henhold til standardpraksis.
- f) Hold forsigtigt om guidewiren, der udgår fra

Fejlfunktioner og bivirkninger/uønskede hændelser

Fejlfunktioner og bivirkninger/uønskede hændelser, der kan forekomme ved brugen af denne guidewire, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

1. Fejlfunktioner

Brud eller bøjning af guidewiren	Skader såsom adskillelse	Belægning forsvinder
----------------------------------	--------------------------	----------------------

den distale ende af opbevaringsrøret (eller den distale ende af beskyttelsesrøret). Hold så tæt ved røret som muligt, og træk langsomt og forsigtigt guidewiren ud.

- g) Hvis der mærkes modstand, når guidewiren tages ud af opbevaringsrøret, injiceres der igen hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning i opbevaringsrøret. Fortsæt med at tage guidewiren ud, når der ikke længere mærkes modstand. Sørg for at injicere tilstrækkelig hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning i opbevaringsrøret, fordi den hydrofile belægning kan blive beskadiget, når den belagte guidewire tages ud ved anvendelse af for meget kraft.
- h) Når guidewiren er trukket ud af opbevaringsrøret, skal den undersøges for at sikre, den ikke har lidt skade.

3. Indføringsmetoder

- Over the wire-metoden
 - a) Før forsigtigt den distale ende af guidewiren ind i guidewire-lumen på interventionsudstyret.
 - b) Fremfør forsigtigt guidewiren, til dens spids er lige netop proksimalt for spidsen af interventionsudstyret.
 - c) Hold i indføringskatetret, og før interventionsudstyret (med guidewire) ind i Y-konnektor.
 - d) Før interventionsudstyret ind gennem indføringskatetret, til spidsen af guidewiren er lige netop proksimalt for spidsen af indføringskatetret.
 - e) Spænd hæmostaseventilen på Y-konnektor, så der dannes en forsejling rundt om interventionsudstyret. Sørg for, at guidewiren fortsat kan bevæges.
 - f) Se efter, om guidewiren kan bevæges uhindret.
 - g) Sæt evt. vrideren på guidewiren.
 - h) Før denne guidewire frem, under gennemlysning, og gennem læsionen. Kontrollér med angiografi, at guidewiren

har passeret den indsnævrede mållæsion.

- i) Hold øje med, hvordan guidewiren bevæger sig inden i karrene.
- j) Før interventionsudstyret frem, til læsionen er nået, samtidig med at guidewires hindres i at bevæge sig. Sørg for, at guidewires distale spids og dens placering i karret er synlige under manipulation med interventionsudstyret.

■ Hurtig udskiftning

- a) Hold fast i indføringskatetret.
- b) Før guidewires indføringsinstrumentet ind i Y-konnektor på indføringskatetret.
- c) Før forsigtigt guidewires spids ind i indføringsinstrumentet.
- d) Før guidewiren ind gennem indføringskatetret under gennemlysning, til guidewires spids er lige netop proksimalt for spidsen af indføringskatetret.
- e) Sæt evt. vrideren på guidewiren.
- f) Før under gennemlysning guidewiren frem og gennem læsionen. Kontrollér med angiografi, at guidewiren har passeret den indsnævrede mållæsion.
- g) Hold øje med, hvordan guidewiren bevæger sig inden i karrene.
- h) Fjern vrideren til guidewiren og indføringsinstrumentet.
- i) Før interventionsudstyret hen over guidewiren, samtidig med at guidewiren hindres i at bevæge sig, og før det frem, til læsionen er nået. Sørg for, at guidewires distale spids og dens placering i karret er synlige under manipulation med interventionsudstyret.

4. Metoder til udskiftning af guidewire

- Over the wire-metoden
 - a) Tag langsomt guidewiren ud, samtidig med at der holdes øje med dens bevægelse under gennemlysning.
 - b) Før den næste guidewire ind i overensstemmelse med anvisningerne i afsnittet "Anbefalet procedure".

Udløbsdato

Udløbsdatoen er angivet på etiketten af guidewirens emballage.

Indhold

5 stk. / æske

Ansvarsfraskrivelse

Under ingen omstændigheder kan "ASAHI INTECC CO., LTD. og dens tilknyttede selskaber" (herefter kaldet "Virksomheden") gøres ansvarlig for uheld, persontilskadekomst eller bivirkninger der skyldes ukorrekt brug af produktet/produkterne eller enhver anden brug, der ikke følger disse anvisninger. Firmaet er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der enten (i) opstår som følge af opbevaring af produktet efter forsendelse fra Firmaet eller (ii) på grund af valg af patienter, kirurgisk teknik eller andre medicinske aktiviteter, der udføres af den medicinske institution, der bruger produktet.

"Gladius", "Halberd", "ASAHI Gaia" og "Astato" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende ASAHI INTECC CO., LTD. i Japan og andre lande.

*Spidsbelastningsværdier repræsenterer middelværdierne af produktspecifikationsværdier målt i henhold til den interne standardtestmetode, hvor der tages udgangspunkt i den kraft, som guidewirens spids påfører læsionen.

Opbevaringsmetode

Opbevar ikke guidewiren og emballagen bøjet eller således, at guidewiren og emballagen udsættes for stor belastning. Denne guidewire og emballagen skal holdes væk fra vand. Opbevares på et køligt, mørkt og tørt sted.

Perifere geleidedraad

Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u deze geleidedraad gebruikt en neem de hoofdstukken Gebruiksindicaties, Behandelde doelgroep, Contra-indicaties, Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en Aanbevolen procedure in deze Gebruiksaanwijzing in acht. Als u dat niet doet, kunnen er bij de patiënt complicaties optreden, waaronder ernstig letsel, en kan deze zelfs komen te overlijden.

Als een gebruiker en/of patiënt een ernstig incident waarneemt in verband met de geleidedraad, meld dit dan aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astat XS 20, Astat XS 40, Astat 30, ASAHl Gaia PV. Voor de details (lengte van de geleidedraad, lengte van het radiopake gedeelte enz.) verwijzen we naar het productlabel.

Beschrijving

De basisstructuur van deze geleidedraad bestaat uit een conische kerndraad en twee soorten distale spoelen (een buitenste spoel en een binnenste spoel). De conische kerndraad en de spoelen zijn gesoldeerd. Een deel van de buitenste spoel of de gehele buitenste spoel is radiopaak, zodat de positie eenvoudig kan worden bevestigd onder fluoroscopie. De distale zijden van Halberd, Astat XS 20, Astat XS 40, Astat 30 en ASAHl Gaia PV zijn gecoat met hydrofiel polymeer. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES en Gladius MG18 PV ES hebben elk een polyurethaanharscoating op de buitenste spoel en daarbovenop een hydrofiel coating. In al deze geleidedraden is de proximale zijde van de conische kerndraad gecoat met PTFE (polytetrafluorethyleen). Aan het proximale uiteinde van andere instrumenten dan die met een totale lengte van 300cm, bevindt zich een aansluiting voor een verlengdraad om het gecombineerde instrument te vervangen; de verlengdraad van ASAHl INTECC kan worden aangesloten. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de Belasting aan het uiteinde* van dit product.

Tabel 1. Productspecificaties

Productnaam	Buitendiameter	Belasting aan het uiteinde*
Gladius	0,36mm (0,014")	3gf
	0,45mm (0,018")	4gf
Gladius MG14 PV	0,36mm (0,014")	3gf
Gladius MG14 PV ES	0,36mm (0,014")	3gf
Gladius MG18 PV ES	0,46mm (0,018")	3gf
Halberd	0,36mm (0,014")	12gf
	0,45mm (0,018")	12gf
Astat XS 20	0,20mm/0,36mm (0,008"/0,014")	20gf
Astat XS 40	0,23mm/0,36mm (0,009"/0,014")	40gf
Astat 30	0,33mm/0,45mm (0,013"/0,018")	30gf
ASAHl Gaia PV	0,36mm/0,45mm (0,014"/0,018")	7,5gf

Gebruiksindicaties

Deze geleidedraad is bedoeld voor algemene percutane perifere interventie (PPI). Deze geleidedraad is bedoeld om de plaatsing van interventionele therapeutische hulpmiddelen in de perifere vasculatuur van de onderste extremiteit te vergemakkelijken.

Deze geleidedraad is alleen bedoeld voor gebruik in de perifere vasculatuur van de onderste extremiteit. Deze geleidedraad is niet bedoeld voor gebruik in de neurovasculatuur en cardiovasculatuur.

Behandelde doelgroep

Deze geleidedraad is bedoeld voor patiënten die voldoen aan de indicaties voor PPI-procedures. Het is niet gendiceerd voor gebruik bij pasgeborenen, zuigelingen of kinderen en patiënten die zwanger zijn, een verminderde nierfunctie hebben en allergisch reageren op contrastmiddelen of polyethyleenglycol (PEG).

Contra-indicaties

- Controleer vóór gebruik de compatibiliteit van de diameter van de geleidedraad met andere interventie-instrumenten.
- Gebruik de geleidedraad niet bij patiënten die allergisch zijn voor contrastmiddelen of die een verminderde nierfunctie hebben.
- Deze geleidedraad bevat PEG400 in zijn hydrofiel coating. Gebruik de geleidedraad niet bij patiënten die allergisch zijn voor polyethyleenglycol (PEG).
- Gebruik de geleidedraad niet bij zwangere patiënten of patiënten die zwanger kunnen zijn (röntgenstraling kan de foetus aantasten).
- Deze geleidedraad moet worden gebruikt in instellingen waar dringende chirurgische ingrepen kunnen worden verricht. Als er geen chirurgische noodingrepen kunnen worden verricht, kunnen in het ernstigste geval levensbedreigende situaties ontstaan.
- Deze geleidedraad is vooraf gesteriliseerd met ethyleenoxidegas (EOG) en is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken of opnieuw steriliseren. Bij hergebruik of hernieuwde sterilisatie kunnen de prestaties of kwaliteit van deze geleidedraad in het gedrang komen en bestaat het risico op complicaties, waaronder infecties.

Waarschuwingen

- Deze geleidedraad mag alleen worden gebruikt door een arts die volledig is opgeleid in PPI-behandeling.
- Gebruik deze geleidedraad nooit in combinatie met katheters met metalen onderdelen die direct in contact kunnen komen met het oppervlak van deze geleidedraad (bijv. atherectomie katheters, metalen dilatatoren), metalen naalden of metalen introducers.
- Controleer en bewaak tijdens het gebruik van de geleidedraad de beweging van het uiteinde ervan met behulp van fluoroscopie. Niet gebruiken in vaatgedeelten die niet zichtbaar zijn of niet zichtbaar kunnen worden gemaakt.
- Sluit deze geleidedraad niet aan op loskoppelbare verlengdraden die zijn vervaardigd door andere producenten dan ASAHl INTECC. Bewerk deze geleidedraad niet las de loskoppelbare verlengdraad is aangesloten. Anders kan de geleidedraad beschadigd raken of kan de loskoppelbare verlengdraad ongewild losraken.
- Breng om geen enkele reden aanpassingen aan deze geleidedraad aan.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de geleidedraad niet na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket. Gooi een geleidedraad waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstrekten, weg.
- Geleidedraden zijn delicate instrumenten en er moet zorgvuldig mee worden omgegaan.
- Gebruik de geleidedraad niet wanneer de verpakking open of beschadigd is. Open de

verpakking altijd vlak voor gebruik. Gebruik een aseptische techniek bij het werken met en gebruiken van de geleidedraad.

- Houd de geleidedraad altijd nat om beschadiging van de hydrofiele coating te voorkomen.
- Veeg deze geleidedraad niet schoon met een organisch oplosmiddel zoals alcohol.
- Voer deze geleidedraad, accessoires en verpakking na gebruik af als medisch afval en neem preventieve maatregelen tegen infectieziekten.
- Duw, druk of draai deze geleidedraad niet verder of trek deze niet terug wanneer u op weerstand stuit. Wanneer u de geleidedraad tegen weerstand in duwt of tordeert, kan dit schade en/of losraken van het uiteinde ervan of directe beschadiging van het bloedvat tot gevolg hebben. Bovendien kan de geleidedraad beschadigd raken. Stel middels fluoroscopie de oorzaak van de weerstand vast en onderneem de actie die nodig is om deze te verhelpen.
- Voer de geleidedraad altijd langzaam en voorzichtig op of terug.
- Wanneer u de geleidedraad in het bloedvat tordeert, moet u dat niet voortdurend in dezelfde richting doen. Wanneer u de geleidedraad draait, roteer dan afwisselend rechtsom en linksom. Draai nooit meer dan twee volledige omwentelingen (720°) in dezelfde richting.
- Spoel de geleidedraad met een gesteriliseerde zoutoplossing met heparine of een andere geschikte oplossing tijdens het verwijderen en weer invoeren, zodat wordt voorkomen dat er lucht in het interventie-instrument terecht komt. Vervang deze geleidedraad op een zorgvuldige manier zodat binnendringen van lucht en/of trauma's worden voorkomen. Controleer bij het opnieuw invoeren van de geleidedraad of het uiteinde van het interventie-instrument vrij in het vaatlumen kan bewegen en niet tegen de vaatwand zit. Wanneer u dit nalaat, kan dit leiden tot een trauma. Controleer de positie met behulp van de radiopake markering van het interventie-instrument.
- Vrije verplaatsing van de geleidedraad in het interventie-instrument is een belangrijke eigenschap van een stuurbaar geleidedraadsysteem, omdat het de gebruiker waardevolle tactiele informatie verschaft. Test voorafgaand aan gebruik het systeem op eventuele weerstand. Pas de hemostaseklep aan of vervang deze door een verstelbare klep als blijkt dat deze de beweging van de geleidedraad hindert.

- Plaats geen stent met meer dan één geleidedraad en gebruik de geleidedraad niet door een stentsteun. Zo niet dan kan de stent beschadigd worden of kan de geleidedraad breken of uit elkaar vallen.
- Controleer vóór gebruik of deze geleidedraad qua grootte en vorm geschikt is voor de procedure en compatibel is om samen met het te gebruiken instrument te worden gebruikt.
- Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing bij het medische instrument (bijv. interventionele therapeutische hulpmiddelen) dat in combinatie met deze geleidedraad wordt gebruikt.
- Wanneer u de loskoppelbare verlengdraad op deze geleidedraad aansluit, moet u deze stevig aansluiten op de grenslijn tussen de non- PTFE-coating en de PTFE-coating aan het proximale uiteinde van de geleidedraad. Als er een afwijking in de aansluiting wordt geconstateerd, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de geleidedraad.
- Inspecteer de geleidedraad vóór gebruik en, voor zover mogelijk, ook tijdens de procedure zorgvuldig op buigingen, knikken of andere beschadigingen. Gebruik de geleidedraad niet als deze beschadigd is.
- Let er bij het vormen van het uiteinde op dat u de spoel niet beschadigt.
- Voordat u de geleidedraad inbrengt, moet u controleren welk uiteinde het distale uiteinde is en ervoor zorgen dat u de draad vanaf het distale uiteinde inbrengt.
- Zorg voor een continue spoeling met gehepariniseerde en gesteriliseerde zoutoplossing tussen de geleidekatheter en het interventie-instrument en tussen het interventie-instrument en de geleidedraad tijdens de procedure. Spoelen voorkomt kristalvorming en/of stolling van contrastmiddel op de geleidedraad en in het katheterlumen.
- Bij de houder met de beschermbuis voor het distale uiteinde (zie Aanbevolen procedure, afbeelding 1) mag de beschermbuis voor het distale uiteinde niet verwijderd of geplaatst worden terwijl de geleidedraad in de houder zit.
- Bij de houder met de beschermbuis voor het distale uiteinde (zie Aanbevolen procedure, afbeelding 1) moet de beschermbuis voor het distale uiteinde worden verwijderd voordat de geleidedraad weer in de houder wordt geplaatst.

Storingen en negatieve effecten

Mogelijke storingen en negatieve effecten als gevolg van het gebruik van deze geleidedraad zijn onder meer (maar niet uitsluitend) de volgende:

1. Storingen

Break of buiging van de geleidedraad	Schade zoals scheiding	Loskomen van coating
--------------------------------------	------------------------	----------------------

2. Negatieve effecten

Overlijden	Infectie	
Verlaagde bloeddruk	Complicaties in de vorm van bloedingen	Embolie
Infarct	Vasculaire occlusie	Trombus
Ischemia	Hartritimestoornis	Vaatissectie
Vasospasme	Duizeligheid	Hoofdpijn
Braken	Vaatperforatie	Allergische reactie

Aanbevolen procedure

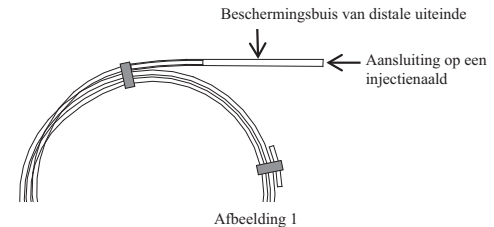
1. Inspectie voorafgaand aan gebruik

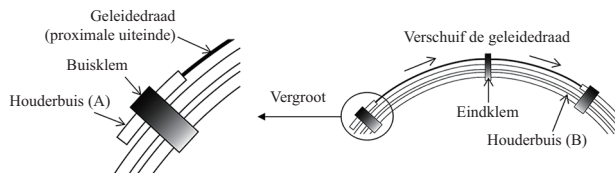
- Controleer vóór gebruik zorgvuldig of de geleidedraad en de verpakking niet beschadigd zijn.
- Stel voor gebruik vast dat de geleidedraad geschikt is voor de te gebruiken interventie-instrumenten.

2. Preparatie

- Selecteer de meest geschikte geleidedraad voor het aangedane gebied en neem de houderbuis waarin de geleidedraad zit uit de steriele verpakking.

- Vul de houderbuis met een gesteriliseerde zoutoplossing met heparine met behulp van een injectienaald om het hele instrument mee nat te maken. Houd er rekening mee dat de gesteriliseerde zoutoplossing met heparine tijdens het vullen uit de houderbuis kan morsen.
- Vul het lumen van het interventie-instrument met de gesteriliseerde oplossing met heparine voordat u de geleidedraad invoert.
- Maak de geleidedraad los uit de cindklem en schuif de geleidedraad langzaam, duw het distale uiteinde van de geleidedraad door de houderbuis(B) (Afbeelding 2).





Afbeelding 2

- e) Wanneer het distale uiteinde van de geleidedraad 5 tot 6cm voorbij het andere uiteinde van de houderbuis (of de beschermingsbuis aan het distale uiteinde) is geschoven, moet u, indien nodig, het uiteinde volgens de standaardpraktijk vormen.
- f) Pak voorzichtig de geleidedraad vast die uit het distale uiteinde van de houderbuis (of de beschermingsbuis aan het distale uiteinde) is gekomen, op het punt dat zo dicht mogelijk bij de houderbuis ligt en trek de geleidedraad er langzaam en voorzichtig uit.
- g) Als u weerstand voelt bij het uit de houderbuis verwijderen van de geleidedraad, moet u de gesteriliseerde zoutoplossing met heparine wederom in de houderbuis injecteren. Zet de verwijdering van de geleidedraad voort wanneer u geen weerstand meer voelt. Zorg ervoor dat u voldoende gesteriliseerde zoutoplossing met heparine in de houderbuis injecteert omdat de hydrofiele coating beschadigd kan raken bij een krachtige verwijdering van de gecoteerde geleidedraad.
- h) Wanneer u de geleidedraad uit de houderbuis hebt getrokken, inspecteert u de geleidedraad zodat u zeker weet dat deze niet beschadigd is.

3. Procedures voor inbrengen

■ Over-de-draad-systeem

- a) Voer het distale uiteinde van de geleidedraad voorzichtig in de geleidedraad-lumen van het interventie-instrument in.
- b) Geleid deze geleidedraad voorzichtig door totdat de tip ervan net proximaal is aan het uiteinde van het interventie-instrument.
- c) Maak de geleidekatheter vast en voer het systeem van het interventie-instrument (met geleidedraad) in de Y-aansluiting.

- d) Voer het systeem van het interventie-instrument door de geleidekatheter totdat het uiteinde van het systeem van de geleidedraad net proximaal is aan de tip van de geleidekatheter.
- e) Draai de hemostaseklep van de Y-aansluiting dicht zodat een afdichting ontstaat rond het interventie-instrument. Controleer dat verplaatsing van de geleidedraad nog mogelijk is.
- f) Controleer nogmaals dat de geleidedraad gemakkelijk kan bewegen.
- g) Bevestig het torsie-instrument aan de geleidedraad, als dat nodig is.
- h) Voer deze geleidedraad in met behulp van fluoroscopie tot voorbij de laesie. Bevestig door middel van angiografie dat de geleidedraad de vernauwde doellaesie heeft gepasseerd.
- i) Observeer de verplaatsing van de geleidedraad in de bloedvaten.
- j) Voer het interventie-instrument in tot de laesie wordt bereikt, terwijl u voorkomt dat de geleidedraad wordt verplaatst. Zorg ervoor dat het distale uiteinde van de geleidedraad en de locatie ervan in het bloedvat zichtbaar zijn wanneer u het interventie-instrument manipuleert.

■ Systeem voor snelle verwisseling

- a) Bevestig de geleidekatheter.
- b) Voer de geleidedraad-introducer in de Y-aansluiting van de geleidekatheter in.
- c) Voer voorzichtig het uiteinde van de geleidedraad in de introducer in.
- d) Voer de geleidedraad onder fluoroscopie door de geleidekatheter tot het uiteinde van de geleidedraad net proximaal is aan het uiteinde van de geleidekatheter.
- e) Bevestig het torsie-instrument aan de geleidedraad, als dat nodig is.

- f) Voer de geleidedraad in met behulp van fluoroscopie tot voorbij de laesie. Bevestig door middel van angiografie dat de geleidedraad de vernauwde doellaesie heeft gepasseerd.
- g) Observeer de verplaatsing van de geleidedraad in de bloedvaten.
- h) Verwijder het torsie-instrument en de introducer van de geleidedraad.
- i) Leid het interventie-instrument over de geleidedraad terwijl u voorkomt dat de geleidedraad wordt verplaatst en ga door tot de laesie is bereikt. Zorg ervoor dat het distale uiteinde van de geleidedraad en de

plaatsing ervan in het bloedvat zichtbaar zijn wanneer u met het interventie-instrument werkt.

4. Procedures voor het verwisselen van de geleidedraad

■ Over-de-draad-systeem

- a) Verwijder deze geleidedraad langzaam terwijl u onder fluoroscopie de verplaatsing van deze geleidedraad in de gaten houdt.
- b) Breng de volgende geleidedraad in volgens de aanwijzingen in dit hoofdstuk "Aanbevolen procedure".

Opslagmethode

Bewaar de geleidedraad en toebehoren niet in een gebogen en/of zwaar belaste toestand. Deze geleidedraad en toebehoren mogen niet nat worden. Bewaren op een koele, donkere en droge plek.

Uiterste gebruiksdatum

De uiterste gebruiksdatum van de geleidedraad staat vermeld op het etiket van de verpakking.

Inhoud

5 stuks/doos

Aansprakelijkheidsverklaring

Op geen enkele manier zal "ASAHI INTECC CO., LTD." en aan haar gelieerde bedrijven (hierna 'Bedrijf' genoemd) aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, persoonlijke verwondingen, negatieve effecten als het gevolg van een foutief gebruik van het(de) product(en) of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met deze instructies. Het Bedrijf is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade (i) voortvloeiend uit de opslag van het product en/of de producten na verzending vanuit het Bedrijf of (ii) als gevolg van de keuze van patiënten, operatietechnieken of enige andere medische activiteiten door de medische instelling die het product en/of de producten gebruikt.

"Gladius", "Halberd", "ASAHI Gaia" en "Astato" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ASAHI INTECC CO., LTD. in Japan en andere landen.

*De waarden van de belasting van het uiteinde vertegenwoordigen de gemiddelde waarden van de productspecificatiewaarden gemeten volgens de testmethode met interne standaard, uitgaande van de kracht die door het uiteinde van de geleidedraad op de laesie wordt uitgeoefend.

Perifeerinen ohjainvaijeri

Käyttöohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän ohjainvaijerin käyttämistä. Noudata näiden käyttöohjeiden kohdissa Käyttötarkoitukset, Hoidettava kohderyhmä, Vasta-aiheet, Varoitukset, Varotoimet ennen käyttöä sekä Ohjeet käyttöä varten. Muutoin seurauksena voi olla komplikaatioita, mukaan lukien potilaan vakava vammautuminen tai kuolema.

Jos käyttäjä ja/tai potilas havaitsee vakavan vaaratilanteen, joka liittyy ohjainvaijeriin, ilmoita siitä valmistajalle ja jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Nämä käyttöohjeet koskevat seuraavia malleja: Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Katso lisätiedot (ohjainvaijerin pituus, röntgenpositiivisen osan pituus, jne.) tuotteen etiketistä.

Kuvaus

Tämän ohjainvaijerin perusrakenne koostuu kapenevasta kierukkavaijerista sekä kahdesta erilaisesta distaalisesta kierukasta (ulkokierukasta ja sisäkierukasta). Kapeneva kierukkavaijeri ja kelat on juotettu. Ulkokierukan pituus on osittain tai kokonaan röntgenpositiivinen, jotta sen sijainti voidaan helposti vahvistaa läpivalaisulla. Mallien Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 ja ASAHI Gaia PV distaaliset päät on pinnoitettu hydrofiilisella polymeerillä. Mallien Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES ja Gladius MG18 PV ES ulkokierukassa on polyuretaanihartsipinnoite ja sen päällä hydrofiilinen pinnoite. Kaikissa näissä ohjainvaijereissa kapenevan kierukkavaijerin proksimaalinen puoli on pinnoitettu PTFE:llä (polytetrafluorieteeni). Muiden kuin kokonaispituudeltaan 300 cm pitkien laitteiden proksimaalisessa päässä on liitäntä jatkovaijerille, jolla korvataan yhdistetty laite. Ohjainvaijeriin voidaan liittää ASAHI INTECCin valmistama jatkovaijeri. Katso lisätietoja tämän tuotteen kärkivoimasta* alla olevasta taulukosta.

Taulukko 1. Tuotteen tekniset tiedot

Tuotteen nimi	Ulkohalkaisija	Kärkivoima*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014")	12 gf
	0,45 mm (0,018")	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm / 0,36 mm (0,008"/0,014")	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm / 0,36 mm (0,009"/0,014")	40 gf
Astato 30	0,33 mm / 0,45 mm (0,013"/0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm / 0,45 mm (0,014"/0,018")	7,5 gf

Käyttötarkoitukset

Tämä ohjainvaijeri on tarkoitettu yleisiin perkutaanisiin perifeerisiin toimenpiteisiin (PPI). Tämä ohjainvaijeri on tarkoitettu helpottamaan toimenpidevälineiden asettamista alaraajan verisuonistoon. **Tämä ohjainvaijeri on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan alaraajojen verisuonissa. Tätä ohjainvaijeria ei ole tarkoitettu käytettäväksi hermostoperäisessä ja sydämen verisuonistossa.**

Hoidettava kohderyhmä

Tämä ohjainvaijeri on tarkoitettu potilaille, jotka täyttävät PPI-toimenpiteiden käyttöaiheet. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi imeväisillä, sylilapsilla tai lapsilla, eikä potilailla, jotka ovat raskaana, joilla on munuaisten vajaatoiminta tai jotka ovat allergisia varjoaineelle tai polyteenienglykolille (PEG).

Vasta-aiheet

- Varmista, että ohjainvaijerin halkaisija sopii yhteen muiden toimenpidevälineiden kanssa, ennen kuin alat käyttää sitä.
- Älä käytä ohjainvaijeria potilailla, jotka ovat allergisia varjoaineelle tai joilla on munuaisten vajaatoiminta.
- Tämän ohjainvaijerin hydrofiilisessa pinnoitteessa on PEG400:aa. Älä käytä ohjainvaijeria potilailla, jotka ovat allergisia polyteenienglykolille (PEG).
- Älä käytä ohjainvaijeria potilailla, jotka ovat raskaana tai saattavat olla raskaana (röntgenkuvasu voi vaikuttaa sikiöön).
- Tätä ohjainvaijeria saa käyttää vain hoitolaitoksessa, jossa voidaan tarvittaessa tehdä välittömästi hätäleikkaus. Jos hätäleikkaukseen ei ole valmiutta, pahimassa tapauksessa seurauksena voi olla hengenvaara.
- Ohjainvaijeri on steriloitu valmiiksi etyleenioksidikaasulla ja se on kertakäyttöinen. Älä käytä tai steriloi sitä uudelleen. Uudelleenkäyttö tai -sterilointi voi heikentää ohjainvaijerin ja pakkausten toimintaa tai laaturaa ja aiheuttaa komplikaatioita, kuten infektion.

Varoitukset

- Ohjainvaijeria saa käyttää vain lääkäri, joka hallitsee PPI-toimenpiteen.
- Älä koskaan käytä tätä ohjainvaijeria yhdessä sellaisten katettien kanssa, joissa on metalliosia, jotka voivat olla suoraan kosketuksissa ohjainvaijerin pinnan (esim. aterekтомиakatetri, metalliset laajentimet), metallineulojen tai metallisten sisäänvientiholkkien kanssa.
- Tarkkaile ohjainvaijerin kärjen liikkettä fluoroskopian avulla, kun käytät laitetta. Älä käytä ohjainvaijeria verisuonen kohdissa, jotka eivät näy tai joita ei voi kuvantaa.
- Älä kytke tätä ohjainvaijeria muiden kuin ASAHI INTECCin valmistamiin irrotettaviin jatkovaijerihein. Älä käsittele ohjainvaijeria, kun siihen on kytketty irrotettava jatkovaijeri. Muutoin ohjainvaijeri voi vaurioitua tai irrotettava jatkovaijeri voi vahingoittaa irrota.
- Älä muuntele ohjainvaijeria mistään syystä.

Varotoimet ennen käyttöä

- Älä käytä ohjainvaijeria etikettiin merkityn viimeisen käyttöpäivän umpeuduttua. Hävitä ohjainvaijerit, joiden viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut.
- Ohjainvaijerit ovat helposti vaurioituvia instrumentteja, minkä vuoksi niitä on käsiteltävä varoen.
- Jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut, älä käytä ohjainvaijeria. Avaa pakkaus vasta juuri ennen käyttöä ohjainvaijeria verisuonen kohdissa, jotka eivät näy tai joita ei voi kuvantaa.
- Pidä ohjainvaijeri aina märkänä, jotta sen hydrofiilinen pinnoite ei vaurioiduu.
- Älä pyyhi ohjainvaijeria orgaanisella liuoksella, kuten alkoholilla.
- Hävitä käytön jälkeen tämä ohjainvaijeri, muut tarvikkeet ja pakkaus sairaalajätteenä ja noudata tartuntatautiin ennaltaehkäisytoimenpiteitä.

- Älä koskaan työnnä, kairaa, vedä tai pyöritä ohjainvajeria, jos siinä tuntuu vastusta. Ohjainvajerin pyörittäminen tai työntäminen vastusta vastaan voi aiheuttaa vaurioita ja/tai kärjen irtoamisen ohjainvajerista tai verisuonen suoran vaurioitumisen. Ohjeen noudattamisen laiminlyönti voi vaurioittaa ohjainvajeria. Selvität vastuksen syy fluoroskopian avulla ja poista se tarvittavilla korjaustoimenpiteillä.
- Työnnä ja vedä ohjainvajeria aina hitaasti ja varovasti.
- Kun pyörität ohjainvajeria verisuonessa, älä pyöritä sitä jatkuvasti samaan suuntaan. Kun pyörität ohjainvajeria, pyöritä sitä vuoroin myötä- ja vastapäivään. Pyöritä enintään kaksi täyttä kierrosta (720°) samaan suuntaan.
- Huuhtelee ohjainvajeria heparinoidulla ja steriloidulla keittosuolaliuoksella tai muulla soveltuvalla liuoksella sen poiston ja sisäänviennin aikana, jotta toimenpidevälineeseen ei pääse ilmaa. Vaihda ohjainvajeri erityisen varovasti, jotta suoneen ei pääse ilmaa ja/tai se ei vaurioitu. Kun viet ohjainvajerin uudelleen sisään, varmista, että toimenpidevälineen kärki on vapaana verisuonen lumenissa eikä kosketa verisuonen seinämää. Muutoin se saattaa aiheuttaa vamman. Varmista sijainti toimenpidevälineen röntgenpositiivisen merkittimen avulla.
- Ohjainvajerin vapaa liikkuvuus toimenpidevälineen sisällä on ohjattavan ohjainvajerin keskeinen ominaisuus, koska se antaa käyttäjälle arvokasta tuntoa perustuvaa tietoa. Tarkista järjestelmä vastuksen varalta ennen käyttöä. Jos havaitset hemostaasiventtiilin häiritsevän ohjainvajerin liikkumista, säädä hemostaasiventtiiliä tai korvaa se säädettävällä venttiilillä.
- Älä asenna stenttiä käyttäen useampaa kuin yhtä ohjainvajeria äläkä käytä ohjainvajeria stentin

- tuen läpi. Muutoin stentti saattaa vaurioitua ja ohjainvajeri murtua tai katketa.
- Varmista ennen käyttöä, että tämä ohjainvajeri on toimenpiteen kannalta sopivan kokoinen ja muutoin ja että se sopii yhteen sen kanssa käytettävän laitteen kanssa.
 - Katso tämän ohjainvajerin kanssa käytettävän lääkinnällisen laitteen (esim. toimenpidevälineen) käyttöohjeet.
 - Kun kytket ohjainvajeriin irrotettavan jatkovajerin, työnnä se kunnolla ei-PTFE-pinnoitteen ja PTFE-pinnoitteen rajaviivaan asti ohjainvajerin proksimaalisessa päässä. Jos havaitset kytkennässä jotakin epätavallista, lopeta ohjainvajerin käyttö välittömästi.
 - Tarkista ohjainvajeri huolellisesti ennen käyttöä ja mahdollisuuksien mukaan toimenpiteen aikana mutkien, taittumisen tai muiden vaurioiden varalta. Älä käytä ohjainvajeria, jos se on vaurioitunut.
 - Varo vahingoittamasta kierukkaa, kun muotoilet kärkeä.
 - Tarkista ennen ohjainvajerin sisäänvientiä, kumpi pää on distaalinen pää, ja varmista, että viet ohjainvajerin sisään distaalisesta päästä.
 - Pidä yllä toimenpiteen ajan jatkuvaa keittosuolaliuoshuuteltua ohjainkatetrin ja toimenpidevälineen sekä toimenpidevälineen ja ohjainvajerin välillä. Huuhtelu estää varjoaineen kertymisen ja/tai hyytymisen ohjainvajeriin ja katetrin lumeniin.
 - Pakkausputki distaalisen päään suojaputkella (katso kohta Käyttö, kuva 1): älä poista tai aseta distaalisen päään suojaputkea, kun ohjainvajeri on pakkausputkessa.
 - Pakkausputki distaalisen päään suojaputkella (katso kohta Käyttö, kuva 1): poista distaalisen päään suojaputki, ennen kuin asetat ohjainvajerin uudelleen pakkausputkeen.

Toimintahäiriöt ja haittatapahtumat

Ohjainvajerin käyttöön liittyy muun muassa seuraavia mahdollisia toimintahäiriöitä ja haittatapahtumia:

1. Toimintahäiriöt

ohjainvajerin rikkoutuminen tai taipuminen	vaurioituminen, kuten katkeaminen	pinnoitteen irtoaminen
--	-----------------------------------	------------------------

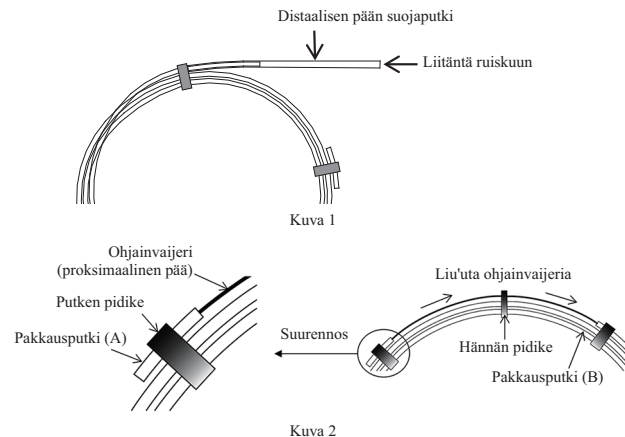
2. Haittatapahtumat

kuolema	infektio
---------	----------

Verenpaineen lasku	verenvuotekomplikaatio	embolia
infarkti	verisuonen okklusio	Trombi
iskemia	eteisvärinä	Verisuonen dissekoituma
vasospasmi	huimaus	Päänsärky
oksentaminen	Verisuonen perforaatio	allerginen reaktio

Käyttö

1. Tarkistus ennen käyttöä
 - a) Tarkista ohjainvajeri ja sen pakkaus huolellisesti ennen käyttöä ja varmista, että ne ovat vahingoittumattomia.
 - b) Varmista ennen käyttöä, että ohjainvajeri on yhteensopiva käytettävien toimenpidevälineiden kanssa.
2. Valmistelu
 - a) Valitse hoidettavalle alueelle sopivin ohjainvajeri ja poista ohjainvajerin sisältävä pakkausputki steriilistä pakkauksesta.
 - b) Täytä pakkausputki ruiskun avulla



- e) Kun ohjainvajerin distaalinen pää on tullut yli 5–6 cm ulos pakkausputken (tai distaalisen päään suojaputken) toisesta päästä, muotoile kärkeä tarvittaessa vakio menetelmän mukaisesti.
- f) Ota varovasti kiinni pakkausputken distaalisesta päästä (tai distaalisen päään suojaputkesta) ulos tulleesta ohjainvajerista mahdollisimman läheltä pakkausputkea ja vedä ohjainvajeri ulos hitaasti ja varovasti.

g) Jos tunnet vastusta ottaessasi ohjainvaijeria pois pakkausputkesta, ruiskuta pakkausputkeen lisää heparinoitua ja steriloitua keittosuolaliuosta. Jatka ohjainvaijerin poistamista putkesta vasta sitten, kun vastusta ei enää tunnu. Varmista, että ruiskutat pakkausputkeen riittävästi heparinoitua ja steriloitua keittosuolaliuosta, sillä hydrofiilinen pinnoite saattaa vaurioitua, jos pinnoitettu ohjainvaijeri otetaan putkesta väkisin.

h) Kun olet vetänyt ohjainvaijerin pakkausputkesta, tarkista se mahdollisten vaurioiden varalta.

3. Sisäänvienti

- Over-the-wire-järjestelmä
 - a) Vie ohjainvaijerin distaalinen pää varovasti toimenpidevälineen ohjainvaijerilumeniin.
 - b) Työnnä ohjainvaijeria varovasti eteenpäin, kunnes sen kärki on aivan toimenpidevälineen kärjen proksimaalisella puolella.
 - c) Kiinnitä ohjainkatetri ja vie toimenpidevälinejärjestelmää (ohjainvaijerin kanssa) Y-liitoskappaleeseen.
 - d) Työnnä toimenpidevälinejärjestelmää ohjainkatetrin läpi, kunnes ohjainvaijerijärjestelmän kärki on aivan ohjainkatetrin kärjen proksimaalisella puolella.
 - e) Kiristä Y-liitoskappaleen hemostaasiventtiiliä niin, että se tiivistyy toimenpidevälineen ympärille. Varmista, että ohjainvaijeria voi vielä liikuttaa.
 - f) Varmista, että ohjainvaijeri liikkuu tasaaisesti.
 - g) Liitä ohjainvaijeriin tarvittaessa pyöritin.
 - h) Työnnä ohjainvaijeria fluoroskopian avulla leesion läpi. Varmista angiografialla, että ohjainvaijeri on ohittanut ahtauneen

kohdelesion.

- i) Tarkkaile ohjainvaijerin liikettä verisuonissa.
- j) Työnnä toimenpidevälinettä eteenpäin leesiokohtaan ja estä samalla ohjainvaijerin liikkuminen. Varmista, että ohjainvaijerin distaalinen kärki ja sen sijainti verisuonessa ovat näkyvissä toimenpidevälineen käsittelyn aikana.

■ Rapid exchange -järjestelmä

- a) Kiinnitä ohjainkatetri.
- b) Työnnä ohjainvaijerin sisäänviejiä ohjainkatetrin Y-liitoskappaleeseen.
- c) Vie ohjainvaijerin kärki varovasti sisäänviejiin.
- d) Työnnä ohjainvaijeria ohjainkatetrin läpi fluoroskopiasa, kunnes ohjainvaijerin kärki on aivan ohjainkatetrin kärjen proksimaalisella puolella.
- e) Liitä ohjainvaijeriin tarvittaessa pyöritin.
- f) Työnnä ohjainvaijeria fluoroskopian avulla leesion läpi. Varmista angiografialla, että ohjainvaijeri on ohittanut ahtauneen kohdelesion.
- g) Tarkkaile ohjainvaijerin liikettä verisuonissa.
- h) Irrota ohjainvaijerin pyöritin ja ohjainvaijerin sisäänviejiä.
- i) Kuljeta toimenpideväline ohjainvaijeria pitkin leesiokohtaan ja estä samalla ohjainvaijerin liikkuminen. Varmista, että ohjainvaijerin distaalinen kärki ja sen sijainti verisuonessa ovat näkyvissä toimenpidevälineen käsittelyn aikana.

4. Ohjainvaijerin vaihto

- Over-the-wire-järjestelmä
 - a) Poista ohjainvaijeri varovasti ja seuraa samalla sen liikettä fluoroskopian avulla.
 - b) Vie seuraava ohjainvaijeri paikalleen kohdan ”Käyttö” ohjeiden mukaisesti.

Sisältö

5 kpl / laatikko

Vastuuvapauslauseke

”ASAHI INTECC CO., LTD. ja sen konserniyhtiöt” (jäljempänä ”yritys”) eivät vastaa millään tavoin vahinkotapahtumista, henkilövammoista tai haittatapahtumista, jotka johtuvat tuotteen (tuotteiden) epäasianmukaisesta käytöstä tai mistä tahansa muusta näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä. Yritys ei missään tapauksessa vastaa vahingoista, jotka johtuvat joko (i) tuotteen (tuotteiden) säilytyksestä sen jälkeen kun yritys on ne lähettänyt tai (ii) potilaiden valinnasta, leikkaustekniikoista tai mistä tahansa muista tuotteita (tuotteita) käyttävän hoitolaitoksen lääkinnällisistä toimenpiteistä.

”Gladius”, ”Halberd”, ”ASAHI Gaia” ja ”Astato” ovat ASAHI INTECC CO., LTD:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Japanissa ja muissa maissa.

*Kärkivoiman arvot tarkoittavat tuotteen teknisten tietojen keskiarvoja, jotka on mitattu sisäisen vakiotestausmenetelmän mukaisesti, jossa mitataan leesioon ohjainvaijerin kärjellä kohdistettu voima.

Säilytys

Älä säilytä ohjainvaijeria ja pakkausta taivutettuna ja/tai raskaasti kuormitettuna. Tämä ohjainvaijeri ja sen pakkaus on pidettävä poissa vedestä. Säilytettävä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.

Viimeinen käyttöpäivä

Viimeinen käyttöpäivä on merkitty ohjainvaijerin pakkauksen etikettiin.

Fil guide périphérique

Mode d'emploi

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce fil guide et respecter les sections Indications d'utilisation, Population traitée cible, Contre-indications, Avertissements, Précautions et Méthode d'utilisation de ce mode d'emploi. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des complications, notamment des blessures graves ou le décès du patient.

Si un utilisateur et/ou un patient a connaissance d'un incident grave lié au fil guide, il doit le signaler au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre.

Ce mode d'emploi concerne les dispositifs Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 et ASAHI Gaia PV. Pour plus de détails (longueur du fil guide, longueur de la partie radio-opaque, etc.), consulter l'étiquette du produit.

Descriptions

La structure de base de ce fil guide se compose d'un fil central conique et de deux types de spirales distales (une spirale externe et une spirale interne). Le fil central conique et les spirales sont soudés. Une partie ou l'ensemble de la spirale extérieure est radio-opaque, ce qui permet de vérifier facilement sa position par radioscopie. Les côtés distaux des dispositifs Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 et ASAHI Gaia PV sont recouverts d'un polymère hydrophile. Les dispositifs Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES et Gladius MG18 PV ES possèdent tous un revêtement en résine de polyuréthane sur la spirale extérieure et un revêtement hydrophile par-dessus. Dans tous ces fils guides, le côté proximal du fil central conique est revêtu de PTFE (polytétrafluoroéthylène). À l'extrémité proximale des dispositifs autres que ceux d'une longueur totale de 300 cm, se trouve une connexion pour un prolongateur, qui est utilisé pour remplacer le dispositif combiné ; le prolongateur d'ASAHI INTECC peut y être connecté.

Se reporter au tableau ci-dessous pour connaître la charge de pointe* de ce produit.

Tableau 1. Spécifications du produit

Nom du produit	Diamètre extérieur	Charge de pointe*
Gladius	0,36 mm (0,014 po)	3 gf
	0,45 mm (0,018 po)fo	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014 po)	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014 po)	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018 po)	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014 po)	12 gf
	0,45 mm (0,018 po)	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008 po/0,014 po)	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009 po/0,014 po)	40 gf
Astato 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013 po/0,018 po)	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014 po/0,018 po)	7,5 gf

Indications d'utilisation

Ce fil guide est destiné à l'intervention périphérique percutanée (IPP) générale. Ce fil guide est destiné à faciliter la mise en place de dispositifs thérapeutiques d'intervention dans le système vasculaire périphérique des membres inférieurs.

Ce fil guide est destiné à être utilisé uniquement dans le système vasculaire périphérique des membres inférieurs. Ce fil guide n'est pas destiné à être utilisé dans le système neurovasculaire et cardiovasculaire.

Population traitée cible

Ce fil guide est destiné aux patients qui répondent aux indications des procédures d'IPP. Le fil guide n'est pas indiqué pour les nouveau-nés, les nourrissons ou les enfants, ainsi que pour les patientes enceintes, les personnes souffrant d'insuffisance rénale et celles qui ont une réaction allergique aux produits de contraste ou au polyéthylèneglycol (PEG).

Contre-indications

- Vérifier la compatibilité du diamètre du fil guide avec d'autres dispositifs d'intervention avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le fil guide chez des patients qui ont une réaction allergique aux produits de contraste ou qui présentent une insuffisance rénale.
- Ce fil guide contient du PEG400 dans son revêtement hydrophile. Ne pas utiliser le fil guide chez des patients qui ont des réactions allergiques au polyéthylèneglycol (PEG).
- Ne pas utiliser le fil guide chez des patientes enceintes ou susceptibles de l'être (les rayons X peuvent affecter le fœtus).
- Ce fil guide doit être utilisé dans un établissement médical en mesure de réaliser immédiatement une intervention chirurgicale d'urgence. S'il n'est pas possible de réaliser d'intervention chirurgicale d'urgence, dans le pire des cas, des événements potentiellement mortels peuvent survenir.
- Ce fil guide est pré-stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène et il est destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser ou restériliser. En cas de réutilisation ou de restérilisation, les performances ou la qualité de ce fil guide et de l'emballage peuvent être affectées et il existe un risque de complications, voire d'infection.

Avertissements

- Ce fil guide ne doit être utilisé que par un médecin dûment formé au traitement par IPP.
- Ne jamais utiliser ce fil guide en association avec des cathéters comportant des parties métalliques susceptibles d'entrer directement en contact avec la surface de ce fil guide (p. ex., cathéters d'athérectomie, dilateurs métalliques), des aiguilles métalliques ou des introducteurs métalliques.
- Vérifier et surveiller le mouvement de la pointe du fil guide sous radioscopie pendant son utilisation. Ne pas utiliser dans des zones du vaisseau qui ne sont pas visibles ou ne peuvent être visualisées.
- Ne pas relier ce fil guide à des prolongateurs détachables de fabricants autres que ASAHI INTECC. Ne pas manipuler ce fil guide lorsque le prolongateur détachable est connecté. Autrement, le fil guide pourrait s'endommager, ou le prolongateur détachable pourrait se détacher involontairement.
- Ne pas modifier ce fil guide pour quelque raison que soit.

Précautions

- Ne pas utiliser le fil guide au-delà de la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Jeter tout fil guide ayant dépassé la date de péremption.
- Les fils guides sont des instruments fragiles et doivent être manipulés avec soin.
- Si l'emballage est ouvert ou endommagé, ne pas utiliser le fil guide. Ne pas ouvrir l'emballage

avant l'emploi. Prendre des mesures aseptiques au cours de la manipulation et de l'utilisation du fil guide.

- Maintenir en permanence le fil guide à l'état humide afin de ne pas endommager son revêtement hydrophile.
- Ne pas essayer ce fil guide à l'aide d'une solution organique telle que l'alcool.
- Après utilisation, mettre au rebut ce fil guide, les accessoires et l'emballage avec les déchets médicaux en prenant des mesures préventives contre les maladies infectieuses.
- Ne jamais pousser, vriller, rétracter le fil guide ou lui appliquer une torsion lorsqu'il rencontre une résistance. Le fait d'appliquer une torsion ou de pousser ce fil guide alors qu'il rencontre une résistance risque de l'endommager et/ou d'entraîner la séparation de la pointe du fil guide ou de léser directement un vaisseau. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager le fil guide. Déterminer la cause de la résistance sous radioscopie et prendre les mesures appropriées pour résoudre le problème.
- Le fil guide doit toujours être avancé ou retiré lentement et avec précaution.
- Lorsque ce fil guide est soumis à une torsion dans le vaisseau sanguin, ne pas appliquer de torsion continue dans la même direction. Lors de la torsion du fil guide, le faire tourner alternativement dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'autre sens. Ne pas effectuer plus de deux rotations (720°) dans la même direction.
- Rincer le fil guide avec une solution saline héparinisée et stérilisée ou toute autre solution adéquate lors du retrait ou de la réinsertion afin d'éviter toute pénétration d'air dans le dispositif d'intervention. Changer ce fil guide avec précautions afin d'éviter l'entrée de l'air et/ou un traumatisme. Au moment de réintroduire le fil guide, vérifier que la pointe du dispositif d'intervention n'est pas coincée dans la lumière du vaisseau et ne se trouve pas contre la paroi du vaisseau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un traumatisme. Utiliser le marqueur radio-opaque du dispositif d'intervention pour vérifier la position.
- Le libre mouvement du fil guide dans le dispositif d'intervention est une caractéristique importante d'un système de fil guide orientable puisqu'il donne à l'utilisateur de précieuses informations tactiles. Tester la résistance du

système avant toute utilisation. Régler la valve hémostatique ou la remplacer par une valve réglable s'il s'avère qu'elle empêche le mouvement du fil guide.

- Ne pas pratiquer la pose de stent en utilisant plus d'un fil guide, ne pas manipuler le fil guide à travers les entretroises du stent. Sinon, le stent peut être endommagé ou le fil guide peut se rompre ou se disloquer.
- Avant utilisation, s'assurer que ce fil guide est de taille et de forme appropriées pour la procédure et qu'il est compatible avec le dispositif à utiliser en association.
- Se reporter au mode d'emploi joint au dispositif médical (p. ex., les dispositifs thérapeutiques d'intervention) à utiliser en association avec ce fil guide.
- Lors de la connexion du prolongateur détachable à ce fil guide, celui-ci doit être inséré en toute sécurité à la ligne de démarcation entre le revêtement non PTFE et le revêtement PTFE à l'extrémité proximale de ce fil guide. Si une anomalie est constatée au niveau de la connexion, cesser immédiatement d'utiliser le fil guide.
- Inspecter soigneusement le fil guide à la recherche de plis, torsions ou autres dommages avant toute utilisation et à chaque fois que cela est possible au cours de la procédure. Ne pas utiliser le fil guide s'il est endommagé.
- Faire attention à ne pas endommager la spirale lors de la mise en forme de la pointe.
- Avant d'insérer le fil guide, vérifier quelle est l'extrémité distale et veiller à l'insérer à partir de l'extrémité distale.
- Pendant la procédure, maintenir un rinçage continu à la solution saline héparinée et stérilisée entre le cathéter guide et le dispositif d'intervention et entre le dispositif d'intervention et le fil guide. Le rinçage empêche la formation de cristaux de produit de contraste et/ou de caillots sur le fil guide et dans la lumière du cathéter.
- Pour le support avec le tube de protection de l'extrémité distale (voir Méthode d'utilisation, Figure 1), ne pas retirer ou insérer le tube de protection de l'extrémité distale lorsque le fil guide est introduit dans le support.
- Pour le support avec le tube de protection de l'extrémité distale (voir Méthode d'utilisation, Figure 1), retirer le tube de protection de

l'extrémité distale avant de réintroduire le fil guide dans le support.

Dysfonctionnements et effets indésirables

Les dysfonctionnements et effets indésirables dérivés de l'utilisation de ce fil guide comprennent, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :

1. Dysfonctionnements

Rupture ou déformation du fil guide	Dommages tels que la séparation	Décollement du revêtement
Mort	Infection	
Baisse de la tension artérielle	Complications hémorragiques	Embolie
Infarctus	Occlusion vasculaire	Thrombose
Ischémie	Arythmie	Dissection de vaisseau
Vasospasme	Vertiges	Maux de tête
Vomissements	Perforation de vaisseau	Réaction allergique

Méthode d'utilisation

1. Examen préalable à l'utilisation

- Avant utilisation, effectuer un examen attentif et s'assurer que le fil guide et l'emballage ne sont pas endommagés.
- Avant utilisation, s'assurer que le fil guide est compatible avec les dispositifs d'intervention qui seront utilisés.

2. Préparation

- Sélectionner le fil guide le plus adapté pour la zone concernée et retirer le support tubulaire contenant le fil guide de l'emballage stérile.
- Remplir le support tubulaire avec une solution saline héparinisée et stérilisée en

utilisant une seringue de manière à faire tremper l'ensemble du dispositif. Il est à noter que la solution saline héparinisée et stérilisée peut s'écouler du support tubulaire à ce moment-là.

- Remplir la lumière du dispositif d'intervention avec la solution saline héparinisée et stérilisée avant d'insérer le fil guide.
- Libérer le fil guide de l'attache et faire glisser lentement le fil guide, pousser l'extrémité distale du fil guide à travers le support tubulaire (B) (Figure 2).

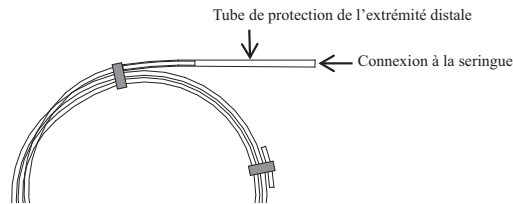


Figure 1

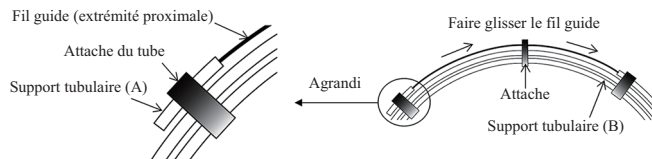


Figure 2

e) Quand l'extrémité distale du fil guide s'étend de 5 à 6 cm au-delà de l'autre extrémité du support tubulaire (ou du tube de protection de l'extrémité distale), si nécessaire, former la pointe conformément aux pratiques courantes.

f) Saisir doucement le fil guide qui sort de l'extrémité distale du support tubulaire (ou du tube de protection de l'extrémité distale), à un point aussi proche que possible du support tubulaire, et sortir le fil guide lentement et avec précautions.

g) En cas de résistance lors du retrait du fil guide du support tubulaire, injecter de nouveau de la solution saline héparinisée et stérilisée dans le support tubulaire. Une fois que la résistance a disparu, continuer à retirer le fil guide. S'assurer d'injecter suffisamment de solution saline héparinisée et stérilisée dans le support tubulaire. Le retrait forcé du fil guide revêtu peut en effet endommager le revêtement hydrophile.

h) Après avoir retiré le fil guide du support tubulaire, l'examiner pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.

3. Procédures d'insertion

■ Système sur fil

- Insérer soigneusement l'extrémité distale du fil guide dans la lumière du fil guide du dispositif d'intervention.
- Faire progresser doucement ce fil guide jusqu'à ce que sa pointe soit toute proche de la pointe du dispositif d'intervention.
- Engager le cathéter-guide et insérer le dispositif d'intervention (avec le fil guide) dans le connecteur en Y.
- Faire progresser le dispositif d'intervention dans le cathéter-guide jusqu'à ce que la pointe du système de fil guide soit toute proche de la pointe du cathéter-guide.

e) Serrer la valve hémostatique du connecteur en Y pour sceller le tout autour du dispositif d'intervention. S'assurer que le fil guide peut encore bouger.

f) Vérifier que le fil guide se déplace sans difficulté.

g) Fixer, si nécessaire, le dispositif de couple au fil guide.

h) Faire progresser ce fil guide sous radioscopie pour franchir la lésion. Confirmer par angiographie que le fil guide a franchi la lésion cible rétrécie.

i) Observer le mouvement du fil guide dans les vaisseaux.

j) Faire progresser le dispositif d'intervention jusqu'à ce qu'il atteigne la lésion tout en évitant que le fil guide ne bouge. S'assurer que la pointe distale du fil guide et son emplacement dans le vaisseau soient visibles pendant les manipulations du dispositif d'intervention.

■ Système d'échange rapide

- Engager le cathéter-guide.
- Insérer l'introducteur de fil guide dans le connecteur en Y du cathéter-guide.
- Insérer soigneusement la pointe du fil guide dans l'introducteur.
- Faire avancer le fil guide dans le cathéter-guide sous radioscopie jusqu'à ce que la pointe du fil guide soit toute proche de la pointe du cathéter-guide.
- Fixer, si nécessaire, le dispositif de couple au fil guide.
- Faire progresser le fil guide sous radioscopie pour franchir la lésion. Confirmer par angiographie que le fil guide a franchi la lésion cible rétrécie.
- Observer le mouvement du fil guide dans les vaisseaux.
- Retirer le dispositif de couple de fil guide

et l'introducteur de fil guide.

- Suivre le dispositif d'intervention sur le fil guide tout en empêchant le fil guide de bouger, et le faire avancer jusqu'à atteindre la lésion. S'assurer que la pointe distale du fil guide et son emplacement dans le vaisseau soient visibles pendant les manipulations du dispositif d'intervention.

4. Procédures de changement du fil guide

■ Système sur fil

- Retirer lentement ce fil guide en surveillant ses mouvements sous radioscopie.
- Insérer le fil guide suivant conformément aux instructions de la section « Méthode d'utilisation ».

Méthode d'entreposage

Ne pas plier le fil guide et l'emballage et/ou ne pas mettre de poids dessus. Le fil guide et l'emballage ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. Conserver dans un lieu frais, sombre et sec.

Date de péremption

La date de péremption est indiquée sur l'étiquette de l'emballage du fil guide.

Contenu

5 pièces/coffret

Clause de non-responsabilité

En aucun cas « ASAHI INTECC CO., LTD. et ses filiales » (ci-après appelées l'« Entreprise ») ne seront tenues responsables des accidents, des blessures corporelles, des effets indésirables causés par un mauvais usage du ou des produit(s) ou par un usage ne respectant pas les présentes instructions. En aucun cas, l'Entreprise ne sera tenue pour responsable de tout dommage (i) résultant du mode d'entreposage du ou des produits suite à leur expédition depuis les locaux de l'Entreprise ou (ii) dû à la sélection des patients, des techniques chirurgicales ou de toute autre procédure médicale effectuée par l'établissement de santé utilisant le ou les produits en question.

« Gladius », « Halberd », « ASAHI Gaia » et « Astato » sont des marques de commerce ou des marques déposées de ASAHI INTECC CO., LTD. au Japon et dans d'autres pays.

*Les valeurs de charge de pointe représentent les valeurs moyennes des valeurs de spécification du produit mesurées selon la méthode de test standard interne en supposant la force exercée sur la lésion par la pointe du fil guide.

Peripherer Führungsdraht

Gebrauchsanweisungen

Beachten Sie vor Verwendung dieses Führungsdrahtes genau die folgende Gebrauchsanleitung, insbesondere die Abschnitte „Indikationen“, „Behandelte Zielgruppe“, „Gegenanzeigen“, „Warnhinweise“, „Vorsichtsmaßnahmen“ und „Anwendung“. Andernfalls kann es zu Komplikationen einschließlich schwerer Verletzungen und zum Tod des Patienten kommen.

Wenn ein Benutzer und/oder ein Patient auf einen schweren Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Führungsdraht aufmerksam wird, sollte dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates gemeldet werden.

Diese Gebrauchsanweisung gilt für Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Details (Länge des Führungsdrahtes, Länge des röntgendichten Abschnitts usw.) finden Sie auf dem Etikett des Produkts.

Beschreibungen

Der Führungsdraht besteht aus einem zulaufenden Kerndraht und zwei verschiedenen distalen Spulen (einer äußeren und einer inneren Spule). Kerndraht und Spulen sind verlötet. Ein Teil der Gesamtlänge der Außenspule ist röntgendicht, sodass die Position des Führungsdrahts unter Röntgendurchleuchtung kontrolliert werden kann. Die distalen Seiten des Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 und ASAHI Gaia PV sind mit hydrophilem Polymer beschichtet. Die äußeren Spulen des Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES und Gladius MG18 PV ES sind jeweils mit Polyurethanharz beschichtet und darüber hinaus zusätzlich mit einer hydrophilen Beschichtung ummantelt. Bei allen o. g. Führungsdrähten ist die proximale Seite des Kerndrahts mit PTFE (Polytetrafluorethylen) beschichtet. Am proximalen Ende aller Führungsdrähte mit Ausnahme jener von 300 cm Länge befindet sich ein Anschluss für einen Verlängerungsdraht, der das Kombiinstrument ersetzt; es kann ein Verlängerungsdraht von ASAHI INTECC angeschlossen werden. Entnehmen Sie die Spitzenbelastung* des jeweiligen Produkts bitte der nachstehenden Tabelle.

Tabelle 1. Produktdaten

Name des Produkts	Außendurchmesser	Spitzenbelastung*
Gladius	0,36 mm (0,014 Zoll)	3 gf
	0,45 mm (0,018 Zoll)	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014 Zoll)	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014 Zoll)	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018 Zoll)	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014 Zoll)	12 gf
	0,45 mm (0,018 Zoll)	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008 Zoll/0,014 Zoll)	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009 Zoll/0,014 Zoll)	40 gf
Astato 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013 Zoll/0,018 Zoll)	30 gf

Name des Produkts	Außendurchmesser	Spitzenbelastung*
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014 Zoll/0,018 Zoll)	7,5 gf

Indikation

Dieser Führungsdraht ist für die perkutane transluminale Angioplastie (PTA) vorgesehen. Er soll die Einbringung interventioneller Therapieinstrumente in den peripheren Gefäßen der unteren Extremität erleichtern.

Dieser Führungsdraht ist ausschließlich für die Verwendung in den peripheren Gefäßen der unteren Extremität konzipiert. Er eignet sich nicht für den Einsatz in neuro- und kardiovaskulären Gefäßen.

Behandelte Zielgruppe

Dieser Führungsdraht ist für Patienten bestimmt, bei denen die Indikationen für PTA-Eingriffe gegeben sind. Sie dürfen nicht bei Neugeborenen, Säuglingen oder Kindern sowie bei Patienten eingesetzt werden, die schwanger sind, an eingeschränkter Nierenfunktion leiden oder allergisch auf Kontrastmittel oder Polyethylenglykol (PEG) reagieren.

Gegenanzeigen

- Stellen Sie vor der Verwendung die Kompatibilität des Führungsdrahtdurchmessers mit anderen interventionellen Instrumenten sicher.
 - Der Führungsdraht darf nicht bei Patienten eingesetzt werden, die allergisch auf Kontrastmittel reagieren oder an eingeschränkter Nierenfunktion leiden.
 - Die hydrophile Beschichtung dieses Führungsdrahtes enthält PEG400. Verwenden Sie den Führungsdraht nicht bei Patienten, die allergisch auf Polyethylenglykol (PEG) reagieren.
 - Verwenden Sie den Führungsdraht nicht bei Schwangeren oder möglicherweise
- schwangeren Patientinnen (Röntgenstrahlen können den Fötus schädigen).
 - Der Führungsdraht darf nur in einer Einrichtung verwendet werden, in der unverzüglich Notfalloperationen durchgeführt werden können. Wenn keine Notfalloperationen möglich sind, können schlimmstenfalls lebensbedrohliche Situationen auftreten.
 - Der Führungsdraht wurde mit Ethylenoxidgas (EOG) sterilisiert und ist ausschließlich für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren. Eine Wiederverwendung oder erneute Sterilisierung kann die Leistungsqualität des Führungsdrahts beeinträchtigen, und es besteht das Risiko von Komplikationen wie z. B. Infektionen.

Warnhinweise

- Er darf nur von einem für die Durchführung von PTA-Eingriffen qualifizierten Arzt verwendet werden.
 - Niemals darf er zusammen mit Kathetern mit Metallteilen verwendet werden, die direkt mit der Oberfläche dieses Führungsdrahtes in Berührung kommen können (z. B. Atherektomiekatether, Dilatatoren aus Metall), oder mit metallischen Kanülen oder Einführbestecken.
 - Während der Verwendung des Führungsdrahtes ist die Bewegung seiner Spitze unter
- Fluoroskopie zu kontrollieren und zu überwachen. Nicht in Bereichen von Gefäßen verwenden, die nicht mittels Bildgebung dargestellt werden oder werden können.
 - Verbinden Sie den Führungsdraht nicht mit abnehmbaren Verlängerungsdrähten, die von anderen Herstellern als ASAHI INTECC hergestellt werden. Bewegen Sie den Führungsdraht nicht, solange der abnehmbare Verlängerungsdraht noch angeschlossen ist. Der Führungsdraht kann sonst beschädigt

werden oder das abnehmbare Verlängerungskabel sich ungewollt lösen.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Führungsdraht vor.

Vorsichtsmaßnahmen

- Der Führungsdraht darf nach dem auf der Produktverpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden. Entsorgen Sie jeden Führungsdraht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Führungsdrähte sind empfindliche Instrumente und müssen vorsichtig behandelt werden.
- Verwenden Sie den Führungsdraht nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. Öffnen Sie die Verpackung immer erst kurz vor der Verwendung. Verwenden Sie bei der Handhabung und Verwendung des Führungsdrahtes aseptische Techniken.
- Achten Sie darauf, dass der Führungsdraht immer feucht gehalten wird, um eine Beschädigung seiner hydrophilen Beschichtung zu vermeiden.
- Reinigen Sie diesen Führungsdraht nicht mit einer organischen Lösung, wie z. B. Alkohol.
- Entsorgen Sie Führungsdraht, Zubehör und Verpackung nach Gebrauch als medizinischen Abfall unter Einhaltung der Präventivmaßnahmen gegen Infektionskrankheiten.
- Dieser Führungsdraht darf niemals gegen einen Widerstand geschoben, gebohrt, herausgezogen oder gedreht werden. Das Drehen oder Schieben des Führungsdrahtes gegen einen Widerstand kann zur Beschädigung bzw. Ablösung seiner Spitze oder zur unmittelbaren Beschädigung eines Gefäßes führen. Zuwiderhandlungen können zur Beschädigung des Führungsdrahtes führen. Ermitteln Sie die Ursache des Widerstands mittels Fluoroskopie und ergreifen Sie notwendige Abhilfemaßnahmen.
- Schieben bzw. ziehen Sie den Führungsdraht immer langsam und vorsichtig vor oder zurück.
- Drehen Sie den Führungsdraht im Inneren des Blutgefäßes nicht kontinuierlich in dieselbe Richtung. Drehen Sie den Führungsdraht abwechselnd im und entgegen dem Uhrzeigersinn. Drehen Sie ihn nicht häufiger als zwei Mal (720°) in dieselbe Richtung.
- Spülen Sie den Führungsdraht während des Herausziehens und Wiedereinführens mit heparinisierter und sterilisierter Kochsalzlösung oder einer anderen geeigneten Lösung, damit

- keine Luft in das interventionelle Instrument eintreten kann. Führen Sie den Austausch dieses Führungsdrahtes vorsichtig durch, um Lufteintritt bzw. Traumata zu vermeiden. Achten Sie beim Wiedereinführen des Führungsdrahtes darauf, dass die Spitze des interventionellen Instruments frei im Gefäßlumen liegt und nicht an der Gefäßwand anliegt. Es besteht ansonsten die Gefahr eines Traumas. Verwenden Sie zur Kontrolle der Position die röntgengedichtete Markierung des interventionellen Instruments.
- Die Bewegungsfreiheit des Führungsdrahtes innerhalb des interventionellen Instruments ist eine wesentliche Eigenschaft eines lenkbaren Führungsdrahtsystems, da sie dem Anwender wertvolle haptische Informationen liefert. Untersuchen Sie das System vor dem Gebrauch auf eventuelle Widerstände. Verstellen Sie das hämostatische Ventil oder ersetzen Sie es durch ein verstellbares Ventil, wenn es die Bewegungsfreiheit des Führungsdrahtes verhindert.
- Verwenden Sie bei der Platzierung des Stents nicht mehr als einen Führungsdraht und führen Sie den Führungsdraht nicht durch Stent-Stege. Der Stent kann dadurch beschädigt werden oder der Führungsdraht kann abreißen oder abbrechen.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Führungsdraht in Größe und Form für den Eingriff geeignet und mit dem zu verwendenden Instrument kompatibel ist.
- Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung zum medizinischen Instrument (z. B. interventionelle therapeutische Instrumente), das in Kombination mit diesem Führungsdraht verwendet werden soll.
- Beim Anschluss des abnehmbaren Verlängerungsdrahtes an diesen Führungsdraht sollte dieser fest an der Übergangslinie zwischen dem unbeschichteten und dem mit PTFE beschichteten Bereich am proximalen Ende des Führungsdrahtes eingeführt werden. Sollte eine Anomalie an der Verbindung festgestellt werden, ist die Verwendung des Führungsdrahts sofort zu beenden.

- Überprüfen Sie den Führungsdraht vor der Verwendung und nach Möglichkeit auch während des Eingriffs sorgfältig auf Biegungen, Knicken oder sonstige Schäden. Verwenden Sie den Führungsdraht nicht, wenn dieser beschädigt ist.
- Achten Sie beim Ausformen der Spitze darauf, die Spule nicht zu beschädigen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einführen des Führungsdrahtes, welches Ende das distale Ende ist, und führen Sie den Draht von der distalen Seite her ein.
- Sorgen Sie während des Eingriffs für eine kontinuierliche Spülung mit Kochsalzlösung zwischen Führungskatheter und interventionellem Instrument sowie zwischen

Instrument und Führungsdraht. Die Spülung verhindert die Bildung von Kontrastmittelkristallen bzw. eine Klumpenbildung am Führungsdraht und im Lumen des Katheters.

- Bei der Halterung mit einem Schutzrohr am Distalende (siehe Anwendung, Abbildung 1) darf dieses nicht entfernt oder angebracht werden, während der Führungsdraht an der Halterung befestigt ist.
- Bei der Halterung mit einem Schutzrohr am Distalende (siehe Anwendung, Abbildung 1) muss dieses entfernt werden, bevor der Führungsdraht wieder an der Halterung befestigt wird.

Fehlfunktionen und unerwünschte Ereignisse

Mögliche Fehlfunktionen und unerwünschte Ereignisse beim Gebrauch dieses Führungsdrahts sind unter anderem:

1. Fehlfunktionen

Bruch oder Verbiegen des Führungsdrahtes	Beschädigung wie z. B. Ablösung	Ablösen der Beschichtung
Tod	Infektion	
Blutdruckabfall	Komplikationen aufgrund von Blutungen	Embolie
Infarkt	Gefäßverschluss	Thrombus
Ischämie	Arrhythmie	Gefäßdissektion
Vasospasmus	Schwindel	Kopfschmerzen
Erbrechen	Gefäßperforation	Allergische Reaktion

2. Unerwünschte Ereignisse

Anwendung

1. Überprüfung vor der Verwendung
 - a) Vor dem Gebrauch alle Führungsdrähte und Verpackungen kontrollieren und auf Unversehrtheit prüfen.
 - b) Vor dem Gebrauch überprüfen, ob der Führungsdraht mit den zu verwendenden interventionellen Instrumenten kompatibel ist.
2. Vorbereitung
 - a) Wählen Sie den am besten geeigneten Führungsdraht für den betroffenen Bereich aus und entnehmen Sie den Dispenser mit dem Führungsdraht aus der sterilen Verpackung.
 - b) Befüllen Sie den Dispenser mithilfe einer Spritze mit heparinisierter und sterilisierter Kochsalzlösung, um das gesamte Instrument damit zu tränken. Beachten Sie, dass zu diesem Zeitpunkt heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung aus dem Dispenser austreten kann.
 - c) Befüllen Sie das Lumen des interventionellen Instruments vor dem Einführen des

- Führungsdrahts mit heparinisierter und sterilisierter Kochsalzlösung.
d) Lösen Sie den Führungsdraht aus dem

hinteren Clip und schieben Sie das Distale des Führungsdrahtes langsam durch das Halterrohr (B) (Abbildung 2).

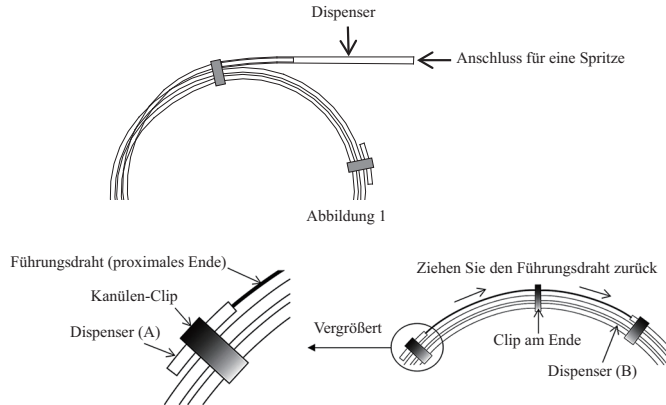


Abbildung 2

- e) Wenn das Distale des Führungsdrahtes 5 bis 6 cm über das andere Ende des Halterörchens (oder des Schutzhörchens am Distale) hinausragt, ggf. die Distalspitze entsprechend der Norm formen.
f) Fassen Sie den Führungsdraht, der aus dem Distale des Halterörchens (oder des Schutzhörchens für das Distale) gekommen ist, vorsichtig an der Stelle, die so nah wie möglich am Halterörchen liegt, und ziehen Sie den Führungsdraht langsam und vorsichtig heraus.
g) Injizieren Sie erneut heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung in den Dispenser, falls beim Herausziehen des Führungsdrahts vom Dispenser Widerstand spürbar ist. Ziehen Sie den Führungsdraht erst dann weiter heraus, wenn kein Widerstand mehr spürbar ist. Achten Sie darauf, ausreichend heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung in den Dispenser zu injizieren, da die hydrophile Beschichtung des Führungsdrahtes durch gewaltsames Herausziehen beschädigt werden kann.

- h) Untersuchen Sie den Führungsdraht nach dem Herausziehen, um sicherzugehen, dass er nicht beschädigt ist.

3. Anleitung zum Einführen

- System über den Draht
 - a) Führen Sie das distale Ende des Führungsdrahtes vorsichtig in das Führungsdrahtlumen des interventionellen Instruments ein.
 - b) Schieben Sie den Führungsdraht vorsichtig vorwärts, bis sich seine Spitze direkt proximal zur Spitze des interventionellen Instruments befindet.
 - c) Schließen Sie den Führungskatheter an und schieben Sie das interventionelle Instrumentensystem (mit Führungsdraht) in den Y-Anschluss.
 - d) Schieben Sie das interventionelle Instrumentensystem durch den Führungskatheter, bis die Spitze des Führungsdrahtes direkt proximal zur Spitze des Führungskatheters liegt.
 - e) Ziehen Sie zum Abdichten des

interventionellen Instruments das hämostatische Ventil des Y-Anschlusses an. Vergewissern Sie sich, dass sich der Führungsdraht noch nicht bewegen lässt.

- f) Prüfen Sie, ob der Führungsdraht leicht gleitet.
- g) Befestigen Sie die Rotationshilfe bei Bedarf am Führungsdraht.
- h) Schieben Sie diesen Führungsdraht unter Fluoroskopie durch die Läsion vorwärts. Kontrollieren Sie mittels Angiographie, ob der Führungsdraht die verengte Zielläsion passiert hat.
- i) Beobachten Sie die Bewegung des Führungsdrahtes in den Gefäßen.
- j) Schieben Sie das interventionelle Instrument bis zur Läsion vor und achten Sie darauf, dass sich der Führungsdraht dabei nicht bewegt. Vergewissern Sie sich, dass die distale Spitze des Führungsdrahtes und seine Position im Gefäß während der Eingriffe mit dem interventionellen Instrument sichtbar sind.

■ Schnellwechselsystem

- a) Schieben Sie den Führungskatheter ein.
- b) Setzen Sie das Einführbesteck für den Führungsdraht in den Y-Anschluss des Führungskatheters ein.
- c) Schieben Sie die Spitze des Führungsdrahtes vorsichtig in das Einführbesteck.
- d) Schieben Sie den Führungsdraht unter

Fluoroskopie durch den Führungskatheter, bis sich die Spitze des Führungsdrahtes direkt proximal zur Spitze des Führungskatheters liegt.

- e) Befestigen Sie die Rotationshilfe bei Bedarf am Führungsdraht.
- f) Schieben Sie den Führungsdraht unter Fluoroskopie durch die Läsion vorwärts. Kontrollieren Sie mittels Angiographie, ob der Führungsdraht die verengte Zielläsion passiert hat.
- g) Beobachten Sie die Bewegung des Führungsdrahtes in den Gefäßen.
- h) Entfernen Sie die Rotationshilfe und das Einführbesteck für den Führungsdraht.
- i) Folgen Sie dem interventionellen Instrument mit dem Führungsdraht. Achten Sie darauf, dass sich der Führungsdraht dabei nicht bewegt, und schieben Sie ihn bis zur Läsion vor. Vergewissern Sie sich, dass die distale Spitze des Führungsdrahtes und seine Position im Gefäß während der Eingriffe mit dem interventionellen Instrument sichtbar sind.

4. Auswechseln des Führungsdrahtes

■ System über den Draht

- a) Entfernen Sie diesen Führungsdraht langsam und überwachen Sie seine Bewegung dabei unter Fluoroskopie.
- b) Führen Sie den nächsten Führungsdraht gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Anwendung“ ein.

Lagerbedingungen

Lagern Sie den Führungsdraht und die Verpackung nicht in einem gebogenen Zustand und nicht unter schweren Gegenständen. Führungsdraht und die Verpackung vor Nässe schützen. Lagern Sie den Führungsdraht und die Verpackung an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort.

Verfallsdatum

Das Verfallsdatum ist auf dem Etikett auf der Führungsdrahtverpackung angegeben.

Inhalt

5 Stück/Schachtel

Haftungsausschluss

„ASAHI INTECC CO., LTD. und dessen Partnerunternehmen“ (im Folgenden als „Unternehmen“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle, Personenschäden und Zwischenfälle infolge des unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produkts/dieser Produkte oder jeder anderen Verwendung, die im Widerspruch zu den hier aufgeführten Anweisungen steht. Das

Unternehmen übernimmt darüber hinaus keinerlei Haftung für Schäden, die (i) aus der Lagerung des Produkts/der Produkte nach dem Versand durch das Unternehmen oder (ii) aufgrund der Auswahl der Patienten, der Operationsmethoden oder aufgrund irgendwelcher sonstigen medizinischen Tätigkeiten seitens der medizinischen Einrichtung, die dieses Produkt verwendet, entstehen.

„Gladius“, „Halberd“, „ASAHI Gaia“ and „Astato“ sind in Japan und weiteren Ländern eingetragene Warenzeichen von ASAHI INTECC CO., LTD.

*Die Spitzenbelastungswerte stellen die Mittelwerte der technischen Daten dar, die nach der internen Normprüfungsmethode gemessen wurden, unter Annahme, dass die Kraft durch die Spitze des Führungsdrahts auf die Läsion aufgebracht wird.

Περιφερικό καθοδηγητικό σύρμα

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το παρόν καθοδηγητικό σύρμα και τηρείτε τις ενότητες Ενδείξεις χρήσης, Στοχευόμενος πληθυσμός θεραπείας, Αντενδείξεις, Προειδοποιήσεις, Προφυλάξεις και Πώς χρησιμοποιείται στις παρούσες Οδηγίες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν επιπλοκές, όπως σοβαρός τραυματισμός του ασθενούς ή θάνατος.

Εάν ο χρήστης ή/και ο ασθενής λάβει γνώση ενός σοβαρού περιστατικού που συνέβη σε σχέση με το καθοδηγητικό σύρμα, πρέπει να αναφέρει το γεγονός στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους.

Οι παρούσες Οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Atrato XS 20, Atrato XS 40, Atrato 30, ASAHI Gaia PV. Για λεπτομέρειες (μήκος του καθοδηγητικού σύρματος, μήκος του ακτινοσκοπικού τμήματος κ.λπ.), ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος.

Περιγραφές

Η βασική δομή του παρόντος καθοδηγητικού σύρματος αποτελείται από ένα κοινικό σύρμα πυρήνα και δύο τύπους περιφερικών σπειραμάτων (ένα εξωτερικό σπείραμα και ένα εσωτερικό σπείραμα). Το κοινικό σύρμα πυρήνα και τα σπείράματα είναι συγκολλημένα. Ένα μερικό ή το πλήρες μήκος του εξωτερικού σπειράματος είναι ακτινοσκοπικό, ώστε η θέση του να μπορεί εύκολα να επιβεβαιωθεί υπό φθοριοσκοπία. Οι περιφερικές πλευρές των Halberd, Atrato XS 20, Atrato XS 40, Atrato 30 και ASAHI Gaia PV είναι επικαλυμμένες με υδρόφιλο πολυμερές. Τα Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES και Gladius MG18 PV ES διαθέτουν το καθένα επικάλυψη ρητίνης πολυουρεθάνης στο εξωτερικό σπείραμα και υδρόφιλη επικάλυψη από πάνω. Σε όλα αυτά τα καθοδηγητικά σύρματα, η εγγύς πλευρά του κοινικού σύρματος πυρήνα είναι επικαλυμμένη με PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο). Στο εγγύς άκρο των τεχνολογικών προϊόντων, εκτός αυτών με συνολικό μήκος 300 cm, υπάρχει μια σύνδεση για ένα σύρμα επέκτασης που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του συνδυασμένου τεχνολογικού προϊόντος. Μπορεί να συνδεθεί το Σύρμα επέκτασης της ASAHI INTECC. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για το φορτίο άκρου* του προϊόντος.

Πίνακας 1. Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα προϊόντος	Εξωτερ. διάμετρος	Φορτίο άκρου*
Gladius	0,36 mm (0,014 ίντσες)	3 gf
	0,45 mm (0,018 ίντσες)	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014 ίντσες)	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014 ίντσες)	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018 ίντσες)	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014 ίντσες)	12 gf
	0,45 mm (0,018 ίντσες)	12 gf
Atrato XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008 ίντσες/0,014 ίντσες)	20 gf

Όνομα προϊόντος	Εξωτερ. διάμετρος	Φορτίο άκρου*
Atrato XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009 ίντσες/0,014 ίντσες)	40 gf
Atrato 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013 ίντσες/0,018 ίντσες)	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014 ίντσες/0,018 ίντσες)	7,5 gf

Ενδείξεις χρήσης

Το καθοδηγητικό σύρμα προορίζεται για γενική διαδερμική περιφερική παρέμβαση (PPD). Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα προορίζεται για να διευκολύνει την τοποθέτηση επεμβατικών θεραπευτικών τεχνολογικών προϊόντων εντός της περιφερικής αγγείωσης του κάτω άκρου.

Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα προορίζεται για χρήση μόνο στην περιφερειακή αγγείωση του κάτω άκρου. Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα δεν προορίζεται για χρήση σε νευροαγγείωση και καρδιοαγγείωση.

Στοχευόμενος πληθυσμός θεραπείας

Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα προορίζεται για ασθενείς που πληρούν τις ενδείξεις για διαδικασίες PPI. Δεν ενδείκνυνται για χρήση σε νεογνά, βρέφη ή παιδιά όπως και σε ασθενείς που κυοφορούν, έχουν νεφρική δυσλειτουργία ή έχουν αλλεργική αντίδραση σε σκιαγραφικά μέσα ή πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG).

Αντενδείξεις

- Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα της διαμέτρου του καθοδηγητικού σύρματος με άλλη επεμβατική συσκευή πριν από την πραγματική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα σε ασθενείς με αλλεργική αντίδραση στο σκιαγραφικό υλικό ή με νεφρική δυσλειτουργία.
- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα περιέχει PEG400 στην υδρόφιλη επικάλυψη του. Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα σε ασθενείς με αλλεργικές αντιδράσεις στην πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG).
- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα σε έγκυες ασθενείς ή σε ασθενείς που μπορεί να είναι έγκυες (η ακτινογραφία μπορεί να επηρεάσει το έμβρυο).
- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ίδρυμα όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Εάν μια επείγουσα χειρουργική επέμβαση δεν είναι διαθέσιμη, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να συμβούν αιματηρά για τη ζωή περιστατικά.
- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα είναι προαποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EOG) και προορίζεται μόνο για μία χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε ή επαναποστείρωνετε. Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης ή επαναποστείρωσης, η απόδοση ή η ποιότητα αυτού του καθοδηγητικού σύρματος και της συσκευασίας μπορεί να υποβαθμιστεί και υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών, όπως η μόλυνση.

Προειδοποιήσεις

- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ιατρό, πλήρως εκπαιδευμένο στη θεραπεία PPI.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το καθοδηγητικό σύρμα σε συνδυασμό με καθετήρες που διαθέτουν μεταλλικά εξαρτήματα τα οποία ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με την επιφάνεια αυτού του καθοδηγητικού σύρματος (π.χ. καθετήρες αθηρεκτομής, μεταλλικοί διαστολείς), μεταλλικές βελόνες ή μεταλλικοί εισαγωγείς.
- Κατά τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος, ελέγχετε και παρακολουθείτε την κίνηση του άκρου του υπό ακτινοσκόπηση. Μην το χρησιμοποιείτε σε σημεία του αγγείου που δεν είναι ή δεν μπορούν να απεικονιστούν.

- Μην συνδέετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα με αποσπώμενα σύρματα επέκτασης τα οποία παράγονται από κατασκευαστές διαφορετικούς από την ASAHI INTECC. Μην χειρίζεστε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα όσο είναι συνδεδεμένο το αποσπώμενο σύρμα επέκτασης.

Προφυλάξεις

- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Απορρίψτε κάθε καθοδηγητικό σύρμα όταν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του.
- Τα καθοδηγητικά σύρματα είναι ευαίσθητα εργαλεία και πρέπει να τα χειρίζεστε προσεκτικά.
- Εάν η συσκευασία έχει ανοίξει ή έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα. Μην ανοίγετε τη συσκευασία μέχρι λίγο πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε ασηπτική τεχνική κατά το χειρισμό και τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος.
- Διατηρείτε πάντα το καθοδηγητικό σύρμα σε υγρή κατάσταση για να αποφύγετε τη φθορά της υδρόφιλης επικάλυψής του.
- Μην σκουπίζετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα χρησιμοποιώντας οργανικό διάλυμα, όπως οινόπνευμα.
- Μετά τη χρήση, απορρίψτε το παρόν καθοδηγητικό σύρμα, τα παρελκόμενα και τη συσκευασία ως ιατρικά απόβλητα, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για λοιμώδη νοσήματα.
- Ποτέ μην σπρώχνετε, βιδώνετε, αποσύρετε ή στρέψετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα που συναντά αντίσταση. Η στρέψη ή η πίεση αυτού του καθοδηγητικού σύρματος ενάντια στην αντίσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή/και αποκόλληση του άκρου αυτού του καθοδηγητικού σύρματος ή άμεση ζημιά σε ένα αγγείο. Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα. Προσδιορίστε την αιτία της αντίστασης υπό ακτινοσκόπηση και λάβετε κάθε αναγκαία διορθωτική ενέργεια.
- Προσέχετε ή αποσύρετε το καθοδηγητικό σύρμα πάντα αργά και προσεκτικά.
- Όταν περιστρέψετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα στο εσωτερικό του αμφοφύρου αγγείου, μην περιστρέψετε συνεχώς προς την ίδια κατεύθυνση. Κατά την περιστροφή του καθοδηγητικού σύρματος, περιστρέψτε το

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καθοδηγητικό σύρμα ή να αποκολληθεί ακούσια το αποσπώμενο σύρμα επέκτασης.
- Μην τροποποιείτε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα για κανέναν λόγο.

- Εναλλάξ δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Μην περιστρέψετε περισσότερο από δύο περιστροφές (720°) προς την ίδια κατεύθυνση.
- Ξεπλύνετε το καθοδηγητικό σύρμα με ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή άλλο κατάλληλο διάλυμα κατά την αφαίρεση και την επαντοποθέτησή του για να αποτρέψετε την είσοδο αέρα στην επεμβατική συσκευή. Πραγματοποιήστε την αλλαγή αυτού του καθοδηγητικού σύρματος προσεκτικά για να αποφύγετε την είσοδο αέρα και/ή τραυματισμό. Κατά την επανεισαγωγή του καθοδηγητικού σύρματος, επιβεβαιώστε ότι το άκρο της επεμβατικής συσκευής είναι ελεύθερο εντός του αυλού του αγγείου και δεν ακουμπά στο τοίχωμα του αγγείου. Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Χρησιμοποιήστε τον ακτινοσκιογράφο δείκτη της επεμβατικής συσκευής για να επιβεβαιώσετε τη θέση.
- Με τη ελεύθερη κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος εντός της επεμβατικής συσκευής είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος κατευθυνόμενου καθοδηγητικού σύρματος, διότι παρέχει στο χρήστη πολύτιμες πληροφορίες αψής. Δοκιμάστε το σύστημα για τυχόν αντίσταση πριν από τη χρήση. Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα αμύδασης με ρυθμιζόμενη βαλβίδα, εάν διαπιστωθεί ότι εμποδίζει την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος.
- Μην εκτελείτε τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα καθοδηγητικά σύρματα ή λειτουργία σύρματος μέσω του στηρίγματος της ενδοπρόθεσης (stent). Διαφορετικά, η ενδοπρόθεση (stent) μπορεί να υποστεί βλάβη ή το καθοδηγητικό σύρμα μπορεί να σπάσει ή να διαλυθεί.
- Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε ότι αυτό το καθοδηγητικό σύρμα έχει το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα για τη διαδικασία και είναι συμβατό με τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό.

- Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης που επισυνάπτονται στο ιατροτεχνολογικό προϊόν (π.χ. επεμβατικά θεραπευτικά τεχνολογικά προϊόντα) προς χρήση σε συνδυασμό με το παρόν καθοδηγητικό σύρμα.
- Κατά τη σύνδεση του αποσπώμενου σύρματος επεκτάσεως με αυτό το καθοδηγητικό σύρμα, θα πρέπει να εισάγεται με ασφάλεια στη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ της επικάλυψης χωρίς PTFE και της επικάλυψης PTFE στο εγγύς άκρο του καθοδηγητικού σύρματος. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωμαλία στη σύνδεση, σταματήστε αμέσως τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος.
- Ελέγξτε προσεκτικά το καθοδηγητικό σύρμα για καμπύλες, στροφές ή άλλες ζημιές πριν από τη χρήση και όποτε είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Κατά τη διαμόρφωση του άκρου, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο πνίγιο.
- Πριν εισαγάγετε το καθοδηγητικό σύρμα, ελέγξτε ποιο άκρο είναι το άνω άκρο και να βεβαιωθείτε ότι το εισαγάγετε από το άνω άκρο.

- Διατηρείτε συνεχή καταιόνιση με ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό μεταξύ του καθοδηγητικού καθετήρα και του επεμβατικού τεχνολογικού προϊόντος και μεταξύ του επεμβατικού τεχνολογικού προϊόντος και του καθοδηγητικού σύρματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η καταιόνιση προλαμβάνει τον σχηματισμό κρυστάλλων σκιογραφικού μέσου ή/και τον σχηματισμό θρόμβων στο καθοδηγητικό σύρμα και στον αυλό του καθετήρα.
- Για την υποδοχή που κρατάει τον σωλήνα προστασίας περιφερικού άκρου (βλ. ενότητα «Πώς χρησιμοποιείται», εικόνα 1), μην αφαιρείτε ή εισαγάγετε τον σωλήνα προστασίας περιφερικού άκρου, ενώ το καθοδηγητικό σύρμα στεγάζεται στην υποδοχή.
- Για την υποδοχή που κρατάει τον σωλήνα προστασίας περιφερικού άκρου (βλ. ενότητα «Πώς χρησιμοποιείται», εικόνα 1), αφαιρέστε τον σωλήνα προστασίας περιφερικού άκρου πριν στεγάζετε ξανά το καθοδηγητικό σύρμα στην υποδοχή.

Δυσλειτουργίες και αντίζοα περιστατικά

Οι πιθανές δυσλειτουργίες και τα αντίζοα περιστατικά από τη χρήση αυτού του καθοδηγητικού σύρματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Δυσλειτουργίες

Στάσιμο ή κάμψη του καθοδηγητικού σύρματος	Ζημιές όπως διαχωρισμός	Αφαίρεση επικάλυψης
Θάνατος	Μόλυνση	
Μείωση της αρτηριακής πίεσης	Αιμορραγικές επιπλοκές	Εμβολή
Έμφραγμα	Αγγειακή απόφραξη	Θρόμβος
Ισχυμία	Αρρυθμία	Διατομή αγγείου
Αγγειοσπασμός	Ζαλάδα	Κεφαλαλγία
Εμετός	Διάτρηση αγγείου	Αλλεργική αντίδραση

Πώς χρησιμοποιείται

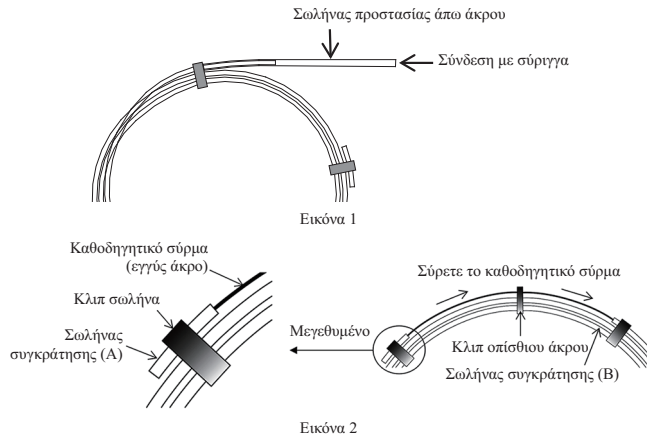
1. Έλεγχος πριν από τη χρήση
 - α) Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά και επιβεβαιώστε ότι το καθοδηγητικό σύρμα και η συσκευασία δεν έχουν υποστεί ζημιά.
 - β) Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε ότι το καθοδηγητικό σύρμα είναι συμβατό με τις επεμβατικές συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

2. Προετοιμασία

- Επιλέξτε το καταλληλότερο καθοδηγητικό σύρμα για την πληγείσα περιοχή και αφαιρέστε το σωληνάριο υποδοχής που περιέχει το καθοδηγητικό σύρμα από την αποστερωμένη συσκευασία.
- Γεμίστε τον σωλήνα υποδοχής με ηπαρινισμένο και αποστερωμένο φυσιολογικό ορό χρησιμοποιώντας μια σύριγγα για να εμποτίσετε ολόκληρη τη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι ο ηπαρινισμένος και αποστερωμένος

φυσιολογικός ορός μπορεί να ρυθεί από τον σωλήνα υποδοχής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

- Γεμίστε τον αυλό της επεμβατικής συσκευής με τον ηπαρινισμένο και αποστερωμένο φυσιολογικό ορό πριν από την εισαγωγή του καθοδηγητικού σύρματος.
- Απελευθερώστε το καθοδηγητικό σύρμα από το κλιπ, σύρετε αργά το καθοδηγητικό σύρμα και σπρώξτε το περιφερικό άκρο του καθοδηγητικού σύρματος μέσα από το σωληνάριο υποδοχής (B) (Εικόνα 2).



- Όταν το περιφερικό άκρο του καθοδηγητικού σύρματος εκτείνεται κατά 5 ως 6 cm πέρα από το άλλο άκρο του σωλήνα υποδοχής (ή το περιφερικό άκρο του σωλήνα προστασίας), εάν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε το άκρο σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική.
- Πιάστε απαλά το καθοδηγητικό σύρμα που βγήκε από το περιφερικό άκρο του σωλήνα υποδοχής (ή τον σωλήνα προστασίας περιφερικού άκρου), στο σημείο που βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον σωλήνα υποδοχής και τραβήξτε το καθοδηγητικό σύρμα αργά και προσεκτικά

προς τα έξω.

- Εάν αισθανθείτε αντίσταση κατά την αφαίρεση του καθοδηγητικού σύρματος από το σωλήνα συγκράτησης, εγχύστε ξανά ηπαρινισμένο και αποστερωμένο φυσιολογικό ορό στο σωλήνα συγκράτησης. Συνεχίστε την αφαίρεση του καθοδηγητικού σύρματος αφού η αντίσταση δεν είναι πλέον αισθητή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγχύσει αρκετό ηπαρινισμένο και αποστερωμένο φυσιολογικό ορό στο σωλήνα συγκράτησης, διότι η υδρόφιλη επίστρωση μπορεί να καταστραφεί κατά τη βίαιη αφαίρεση του επικαλυμμένου καθοδηγητικού σύρματος.

- Αφού βγάλετε το καθοδηγητικό σύρμα από το σωλήνα υποδοχής, ελέγξτε το για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.

3. Διαδικασίες για την τοποθέτηση

■ Σύστημα μέσω καλωδίου

- Εισάγετε προσεκτικά το άνω άκρο του καθοδηγητικού σύρματος στον αυλό του καθοδηγητικού σύρματος της επεμβατικής συσκευής.
- Προωθήστε προσεκτικά αυτό το καθοδηγητικό σύρμα έως ότου το άκρο του βρεθεί ακριβώς κοντά στο άκρο της επεμβατικής συσκευής.
- Ενεργοποιήστε τον καθοδηγητικό καθετήρα και εισαγάγετε το σύστημα επεμβατικής συσκευής (με το καθοδηγητικό σύρμα) στον σύνδεσμο Υ.
- Προωθήστε το σύστημα επεμβατικής συσκευής μέσω του καθοδηγητικού καθετήρα έως ότου το άκρο του συστήματος καθοδηγητικού σύρματος βρεθεί ακριβώς πλησίον του άκρου του καθοδηγητικού καθετήρα.
- Σφίξτε τη βαλβίδα αιμόστασης του συνδέσμου Υ για να δημιουργήσετε στεγανοποίηση γύρω από την επεμβατική συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος εξοκολουθεί να είναι εφικτή.
- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το καθοδηγητικό σύρμα κινείται ομαλά.
- Συνδέστε τη συσκευή περιστροφής στο καθοδηγητικό σύρμα, εάν είναι απαραίτητο.
- Προωθήστε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα υπό ακτινοσκόπηση για να περάσει μέσα από τη βλάβη. Επιβεβαιώστε με αγγειογραφία ότι το καθοδηγητικό σύρμα έχει διέλθει από τη στενωμένη βλάβη-στόχο.
- Παρατηρήστε την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος στα αγγεία.
- Προωθήστε την επεμβατική συσκευή έως ότου φτάσετε στη βλάβη, αποτρέποντας παράλληλα τη μετακίνηση του καθοδηγητικού σύρματος. Βεβαιωθείτε ότι το άνω άκρο του οδηγού σύρματος και η θέση του στο αγγείο είναι ορατά κατά τη διάρκεια των χειρισμών της επεμβατικής συσκευής.

■ Σύστημα ταχείας ανταλλαγής

- Ενεργοποιήστε τον καθοδηγητικό καθετήρα.
- Εισάγετε τον εισαγωγέα του καθοδηγητικού καθετήρα στο σύνδεσμο Υ του καθοδηγητικού καθετήρα.
- Εισάγετε προσεκτικά το άκρο του οδηγού σύρματος στον εισαγωγέα.
- Προωθήστε το καθοδηγητικό σύρμα μέσω του καθοδηγητικού καθετήρα υπό ακτινοσκόπηση έως ότου το άκρο του καθοδηγητικού σύρματος βρεθεί ακριβώς πλησίον του άκρου του καθοδηγητικού καθετήρα.
- Συνδέστε τη συσκευή περιστροφής στο καθοδηγητικό σύρμα, εάν είναι απαραίτητο.
- Προωθήστε το καθοδηγητικό σύρμα υπό ακτινοσκόπηση για να περάσει μέσα από τη βλάβη. Επιβεβαιώστε με αγγειογραφία ότι το καθοδηγητικό σύρμα έχει διέλθει από τη στενωμένη βλάβη-στόχο.
- Παρατηρήστε την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος στα αγγεία.
- Αφαιρέστε τη συσκευή ροής του καθοδηγητικού σύρματος και τον εισαγωγέα του καθοδηγητικού σύρματος.
- Παρακολούθησε την επεμβατική συσκευή πάνω από το καθοδηγητικό σύρμα αποτρέποντας την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος και προχωρήστε μέχρι να φτάσετε στη βλάβη. Βεβαιωθείτε ότι το άνω άκρο του καθοδηγητικού σύρματος και η θέση του στο αγγείο είναι ορατά κατά τη διάρκεια των χειρισμών της επεμβατικής συσκευής.

4. Διαδικασίες για την αντικατάσταση του καθοδηγητικού σύρματος

■ Σύστημα μέσω καλωδίου

- Αφαιρέστε αργά αυτό το καθοδηγητικό σύρμα, ενώ παρακολουθείτε την κίνηση αυτού του καθοδηγητικού σύρματος υπό ακτινοσκόπηση.
- Τοποθετήστε το επόμενο καθοδηγητικό σύρμα σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας ενότητας «Πώς χρησιμοποιείται».

Μέθοδος φύλαξης

Μην διατηρείτε το καθοδηγητικό σύρμα και τη συσκευασία σε λυγισμένη ή/και βαριά φορτισμένη κατάσταση. Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα και η συσκευασία πρέπει να φυλάσσονται μακριά από νερό. Φυλάσσεται σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος.

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας του καθοδηγητικού σύρματος.

Περιεχόμενα

5 τεμάχια / κουτί

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Η «ASAHI INTECC CO., LTD. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της» (εφεξής η «Εταιρεία») σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για ατυχήματα, σωματικές βλάβες, αντίξοα περιστατικά που οφείλονται σε οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση του(ων) προϊόντος(ων) ή οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνάδει με τις παρούσες οδηγίες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές είτε (i) που προκύπτουν από την αποθήκευση του προϊόντος (των προϊόντων) μετά την αποστολή από την Εταιρεία είτε (ii) που οφείλονται στην επιλογή ασθενών, τεχνικών χειρουργικής επέμβασης ή άλλων ιατρικών δραστηριοτήτων από το ιατρικό ίδρυμα που χρησιμοποιεί το προϊόν (τα προϊόντα).

Οι επωνυμίες «Gladius», «Halberd», «ASAHI Gaia» και «Astato» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της ASAHI INTECC CO., LTD. στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

*Οι τιμές φορτίου άκρου αντιπροσωπεύουν τις μέσες τιμές των τιμών προδιαγραφών του προϊόντος όπως έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμασίας εσωτερικού προτύπου υποθέτοντας τη δύναμη που εφαρμόζεται στη βλάβη από το άκρο του καθοδηγητικού σύρματος.

Perifériás vezetődrót

Használati útmutató

A vezetődrót használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és tartsa be a jelen Használati útmutató Felhasználási javallatok, Kezelt célcsoport, Ellenjavallatok, Figyelmeztetések, Övintézkedések és Használat szakaszait. A leírtak figyelmen kívül hagyása nem várt eredményeket, a páciens súlyos testi sérülését vagy halálát okozhatja.

Amennyiben a felhasználónak és/vagy a páciensnek a vezetődróttal kapcsolatos súlyos incidens jut tudomására, jelentse a tényt a gyártónak és a tagállam illetékes hatóságának.

Ez a használati útmutató a következőkre vonatkozik: Gladius, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. A részleteket (a vezetődrót hossza, a röntgensugárzást nem áteresztő rész hossza stb.) lásd a termék címkén.

Leírások

A vezetődrót alapszerkezete egy kúpos maghuzalból és kétféle disztális tekercsből (egy külső és egy belső tekercsből áll). A kúpos maghuzal és a tekercsek forrasztottak. A külső tekercs egy része vagy teljes hossza röntgensugárzást nem áteresztő, így annak pozíciója könnyen ellenőrizhető fluoroszkópia alatt. A Halberd, az Astato XS 20, az Astato XS 40, az Astato 30 és az ASAHI Gaia PV disztális oldali hidrofíl bevonattal vannak bevonva. A Gladius, a Gladius MG14 PV, a Gladius MG14 PV ES és a Gladius MG18 PV ES külső tekercsének egyaránt poliuretán gyanta bevonata van, és annak tetején hidrofíl bevonat található. Mindezen vezetődrótoknál a kúpos maghuzal proximális oldala PTFE-vel (poli-tetrafluor-etilénnel) van bevonva. Azon készülékek proximális végén, amelyek teljes hossza nem 300 cm, egy csatlakozó található egy hosszabbító vezetékhez, amely a kombinált eszköz helyettesítésére használható; ASAHI INTECC hosszabbító vezeték csatlakoztatható. A termék csúcának terhelését* lásd az alábbi táblázatban.

1. táblázat. Termékspecifikációk

Terméknév	Külső átmérő	Csúcs terhelése*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
	0,36 mm (0,014")	12 gf
Halberd	0,45 mm (0,018")	12 gf
	0,20 mm/0,36 mm (0,008"/0,014")	20 gf
Astato XS 20	0,23 mm/0,36 mm (0,009"/0,014")	40 gf
Astato XS 40	0,33 mm/0,45 mm (0,013"/0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014"/0,018")	7,5 gf

Felhasználási javallatok

Ez a vezetődrót általános percután perifériás beavatkozásra (PPI) szolgál. Ez a vezetődrót az intervenció terápiai eszközöknek az alsó végtag perifériás érrendszerébe történő elhelyezésének megkönnyítésére szolgál.

Ez a vezetődrót kizárólag az alsó végtag perifériás érrendszerében való használatra szolgál. Ez a vezetődrót nem a neurovaszkuláris rendszerben és a kardiovaszkuláris rendszerben való használatra szolgál.

Kezelt célcsoport

A vezetődrót olyan betegek számára készült, akik megfelelnek a PPI-eljárások javallatainak. Használatra nem javallott újszülöttek, csecsemők vagy gyermekek, valamint terhes, csökkent vese-funkciójú és kontrasztanyagra vagy poli-etilén-glikolra (PEG) allergiás betegek esetében.

Ellenjavallatok

- A tényleges használat előtt erősítse meg a vezetődrót átmérőjét másik intervenció eszközével.
- Ne használja a vezetődrótot olyan betegeknél, akik allergiás reakciót mutatnak a kontrasztanyagra, vagy akiknek csökkent a vese-funkciója.
- A vezetődrót hidrofíl bevonata PEG400 anyagot tartalmaz. Ne használja a vezetődrótot poli(etilén)glikolra (PEG) allergiás páciensek esetében.
- Ne használja a vezetődrótot terhes vagy gyaníthatóan terhes páciensek (a röntgensugárzás hatással lehet a magzatra).
- Ezt a vezetődrótot csak olyan intézményben szabad használni, ahol azonnal végrehajthatók a sürgősségi sebési beavatkozások. Ha sürgősségi sebési beavatkozás nem érhető el, a legrosszabb esetben életveszéllyel fenyegető események is bekövetkezhetnek.
- A vezetődrót etilén-oxid gázzal (EOG) van elősterilizálva és kizárólag egyszeri használatra készült. Ne használja vagy sterilizálja újra. Ismételt felhasználás vagy újratertilizálás esetén a vezetődrót teljesítménye és minősége csökkenhet, továbbá komplikációkat, pl. fertőzést okozhat.

Figyelmeztetések

- Ezt a vezetődrótot csak olyan orvos használhatja, aki teljes körűen képzett a PPI-kezelésben.
- Soha ne használja ezt a vezetődrótot olyan katéterekkel együtt, amelyeknek fém részei közvetlenül érintkezhetnek a vezetődrót felületével (pl. atherectomiás katéterek, fém tágitók), fémtükkkel vagy fém bevezetőkkal.
- A vezetődrót használata során fluoroszkópiás megfigyeléssel ellenőrizze és kövesse nyomon a csúcs mozgását. Ne használja olyan ereken, amelyeket nem lehet vagy tud megtekinteni.
- Ne csatlakoztassa a vezetődrótot olyan leválasztható hosszabbító vezetékhez, amelyeket nem az ASAHI INTECC, hanem más gyártó gyártott. Ne manipulálja a vezetődrótot, ha a leválasztható hosszabbító drót csatlakoztatva van. Ellenkező esetben a vezetődrót megsérülhet, illetve a leválasztható hosszabbító vezeték véletlenül megsérülhet.
- Semmilyen ok miatt ne módosítsa a vezetődrótot!

Övintézkedések

- Használja fel a vezetődrót csomagolásán feltüntetett lejárati időn belül. Dobjon el minden olyan vezetődrótot, amelynek letelt a lejárata.
- A vezetődrótok törékeny műszerek, és óvatosan kell kezelni őket.
- Ne használja a vezetődrótot, ha a csomagolás kinyílt vagy megsérült. Kizárólag közvetlenül a felhasználás előtt nyissa ki a csomagolást. A

vezetődórt kezeléséhez és használatához aszeptikus technikákat használjon.

- A vezetődórt mindig tartsa nedves állapotban, hogy meggátolja a hidrofíl bevonat károsodását.
- Semmilyen szerves oldattal (pl. alkohol) ne törölje át a vezetődórt.
- Használat után orvosi hulladékként dobja ki a vezetődórt, a tartózköket és a csomagolást, és tegyen megelőző intézkedéseket a fertőző betegségek ellen.
- Soha ne tolja, csavarja be vagy húzza ki a vezetődórt és soha ne fejtse ki nyomatként rá, ha ellenállást tapasztal. Az eszköz erővel történő nyomása vagy tolása sérülést okozhat, és/vagy a vezetődórt csúcsának leválásához vezethet, illetve közvetlen érkárosodást okozhat. Ennek elmulasztása esetén a vezetődórt károsodhat. Fluoroszkópiával állapítsa meg az ellenállás okát, és járjon el annak megfelelően.
- A vezetődórt mindig lassan és óvatosan tolja előre vagy húzza vissza.
- Ha a vezetődórt nyomattal terheli az ér belsejében, ne terhelje folyamatosan ugyanabba az irányba. Ha nyomattal terheli a vezetődórt, felváltva forgassa az óramutató járásával ellentétes és megegyező irányokba. Ne forgassa több mint két fordulatnyit (720°) ugyanabba az irányba.
- Annak elkerülése érdekében, hogy levegő kerüljön az intervenció eszköze, a vezetődórt eltávolítása és a behelyezése során folyamatosan öblítse le a vezetődórt heparinált és sterilizált sóoldattal vagy egyéb megfelelő oldattal. A levegőbejutás és/vagy a trauma elkerülése érdekében óvatosan hajtja végre a vezetődórt cseréjét. A vezetődórt ismételt bevezetésekor győződjön meg róla, hogy az intervenció csúcsa szabadon mozog az ér lumenben, és nem ütközik az érfalnak. Ennek elmulasztása sérüléshez vezethet. A helyzet megállapításához alkalmazzon sugár át nem eresztő jelzést az intervenció eszközön.
- A vezetődórt szabad mozgása a beavatkozási eszközön belül fontos tulajdonság az irányítható vezetődórtnál, mivel a felhasználónak értékes, kézzelfogható visszajelzést ad. Ellenőrizze a rendszert használat előtt, nem tapasztal-e ellenállást. Állítsa be vagy cserélje ki a hemosztázis-szelepet egy állítható szelepre, ha

úgy látja, hogy akadályozza a vezetődórt mozgását.

- Ne végezzen színt behelyezést, ha több vezetődórtot használ, vagy a színt bordán keresztül vezeti a drótot. Ellenkező esetben a színt megsérülhet vagy a vezetődórt elszakadhat vagy széttorhert.
- Használat előtt erősítse meg, hogy a vezetődórt mérete és formája megfelel-e a beavatkozásnak, és kompatibilis-e az azzal együtt használni kívánt eszközzel.
- Lásd az ezzel a vezetődórral együtt használható orvostechnikai eszközökhöz (pl. intervenció terápiai eszközök) mellékelt használati útmutatót.
- Amikor a leválasztható hosszabbító drótot ehhez a vezetődórhoz csatlakoztatja, azt megfelelően kell behelyezni a vezetődórt proximális végén található nem PTFE bevonat és PTFE bevonat közti határvonalba. Ha a csatlakozás során bármilyen rendellenességet észlel a csatlakozásban, azonnal fűggesse fel a vezetődórt használatát.
- Használat előtt, és amikor csak lehetséges a használat során, ellenőrizze a vezetődórtot, nincs-e rajta meghajlás, megtörés vagy egyéb sérülés. Ne használja a vezetődórtot, ha az sérült.
- A csúcs formázásakor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a tekercset.
- A vezetődórt behelyezése előtt ellenőrizze, hogy melyik a disztális vége, és ügyeljen arra, hogy azt a disztális végeről helyezze be.
- Az eljárás során a vezető katéter és az intervenció eszköz, valamint az intervenció eszköz és a vezetődórt közötti folyamatos heparinált és sterilizált sóoldatos öblítést kell alkalmazni. Az öblítés megakadályozza a kontrasztanyag-kristályszerkezet és/vagy a vérrögök képződését a vezetődóron és a katéter lumenében.
- A disztális végi védőcsővel ellátott tartó esetében (lásd Használat, 1. ábra) ne vegye ki vagy helyezze be a disztális végi védőcsövet, amíg a vezetődórt a tartóban van.
- A disztális végi védőcsővel ellátott tartó esetében (lásd Használat, 1. ábra) azelőtt vegye ki a disztális végi védőcsövet, mielőtt a vezetődórtot visszahelyezné a tartóba

Működési problémák és nemkívánatos események

A vezetődórt használata révén fellépő lehetséges működési problémák és nemkívánatos események többek között az alábbiak lehetnek:

1. Működési problémák

A vezetődórt törése vagy meghajlása	Sérülések, pl. szétválás	A bevonat leválása
-------------------------------------	--------------------------	--------------------

2. Nemkívánatos események

Halál	Fertőzés	
A vérnyomás csökkenése	Vérzési komplikációk	Légembólia
Infarktus	Érelzáródás	Thrombus
Iszkémia	Aritmia	Érszakadás
Érgörcs	Szédülés	Fejfájás
Hányás	Az ér perforációja	Allergiás reakciók

Használat

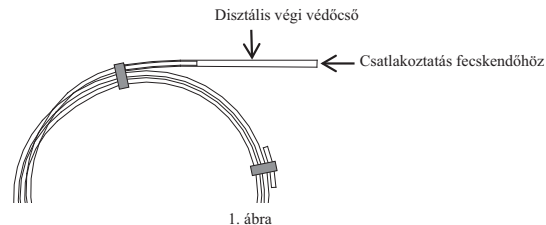
1. Ellenőrzések a használat előtt

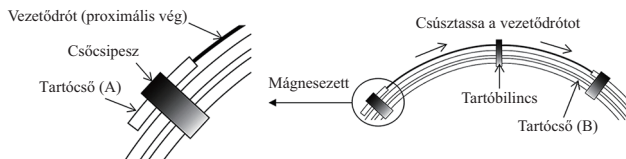
- Használat előtt vizsgálja meg figyelmesen, és győződjön meg róla, hogy a vezetődórt és csomagolása sértetlen-e.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a vezetődórt kompatibilis-e a használni tervezett intervenció eszközökkel.

2. Előkészítés

- Válassza ki az érintett területhez legmegfelelőbb vezetődórtot, és távolítsa el a vezetődórtot tartalmazó csótartót a steril csomagolásból.

- Feccskendő segítségével töltsse fel a csótartót heparinált és sterilizált sóoldattal, és áztassa be a teljes eszközt. Vigyázzon arra, hogy a heparinált és sterilizált sóoldat ennél a műveletnél kifolyhat a csótartóból.
- A vezetődórt behelyezése előtt töltsse fel az intervenció eszköz lumenjét heparinált és sterilizált sóoldattal.
- Vegye ki a vezetődórtot a tartóbilincsből, és lassan csúszassa ki a vezetődórtot, majd tolja át a vezetődórt disztális végét a tartócsövön (B) (2. ábra).





2. ábra

e) Amikor a vezetődrót disztális vége legalább 5 - 6 cm-re van a tartócső másik végétől (vagy disztális végi védőcsőtől), akkor szükség esetén alakítsa a csúcsot a normál gyakorlatnak megfelelően.

f) Fogja meg óvatosan a vezetődrótot, amely a tartócső disztális végéből (vagy a disztális végi védőcsőből) jött ki, mégpedig a tartócsőhöz legközelebbi ponton, majd húzza ki a vezetődrótot lassan és óvatosan.

g) Ha ellenállás érezhető a vezetődrót csőtartóból történő eltávolítása során, feckendezzen ismét heparinizált és sterilizált sóoldatot a csőtartóba. Az ellenállás megszűnése után folytassa a vezetődrót eltávolítását. Győződjön meg arról, hogy elegendő mennyiségű heparinizált és sterilizált sóoldatot feckendezzen be a csőtartóba, mert a hidrofíl bevonat megsérülhet a bevonatos vezetődrót erővel történő eltávolításakor.

h) Miután kihúzta a vezetődrótot a tartócsőből, vizsgálja meg, és győződjön meg róla, hogy nem sérült-e meg.

3. A behelyezés műveletei

■ Over-the-wire rendszer

a) Óvatosan nyomja be a vezetődrót disztális végét az intervenciós eszköz vezetődrót lumenébe.

b) Óvatosan vezesse be a vezetődrótot, míg a csúcsa az intervenciós eszköz csúcsának közelébe nem ér.

c) Kösse be a vezetőkatétert, és nyomja be az intervenciós eszközrendszert (a vezetődróttal) az Y-csatlakozóba.

d) Tolja át az intervenciós eszközrendszert a vezetőkatéteren, míg a vezetődrót-rendszer csúcsa meg nem közelíti a vezetőkatéter hegyét.

e) Az intervenciós eszköz körüli szigetelés

létrehozása érdekében szorítsa meg az Y-csatlakozó hemosztázis-szelepét.

Győződjön meg róla, hogy a vezetődrót mozgása továbbra is lehetséges-e.

f) Ellenőrizze, hogy a vezetődrót simán mozog-e.

g) Szükség esetén csatlakoztassa a nyomatékesszközt a vezetődróthoz.

h) Fluoroszkópia alatt tolja előre ezt a vezetődrótot, hogy átjusson a lézió. Angiográfia segítségével erősítse meg, hogy a vezetődrót áthaladt-e a beszűkült részen.

i) Figyelje a vezetődrót mozgását az erekben.

j) A lézió eléréséig tolja be az intervenciós eszközt, miközben megakadályozza a vezetődrót mozgását. Biztosítsa, hogy a vezetődrót disztális csúcsa és annak érbén történő elhelyezkedése az intervenciós eszköz használata során is látható legyen.

■ Gyors cserélőrendszer

a) Kösse be a vezetőkatétert.

b) Nyomja be a vezetődrót bevezetőjét a vezetőkatéter Y-csatlakozójába.

c) Óvatosan tolja be a vezetődrót csúcsát a bevezetőbe.

d) Fluoroszkópia mellett tolja át a vezetődrótot a vezetőkatéteren, míg a vezetődrót csúcsa a vezetőkatéter csúcsának közelébe nem kerül.

e) Szükség esetén csatlakoztassa a nyomatékesszközt a vezetődróthoz.

f) Fluoroszkópia alatt tolja előre a vezetődrótot, hogy átjusson a lézió. Angiográfia segítségével erősítse meg, hogy a vezetődrót áthaladt-e a beszűkült részen.

g) Figyelje a vezetődrót mozgását az erekben.

h) Távolítsa el a vezetődrót nyomatékesszközét és a vezetődrót

bevezetőjét.

i) Kövesse nyomon az intervenciós eszközt a vezetődrót mentén, miközben megakadályozza a vezetődrót mozgását, és addig tolja előre, míg el nem éri a léziót. Biztosítsa, hogy a vezetődrót disztális csúcsa, és annak érbén történő elhelyezkedése az intervenciós eszköz használata során is látható legyen.

4. A vezetődrót cseréjének eljárásai

■ Over-the-wire rendszer

a) Lassan távolítsa el a vezetődrótot annak folyamatos, fluoroszkópiás megfigyelése során.

b) A „Használat” fejezetben leírtaknak megfelelően helyezze be a következő vezetődrótot.

A tárolás módja

Ne tartsa a vezetődrótot és csomagolását hajlított vagy erősen terhelt állapotban. Ezt a vezetődrótot és csomagolását víztől távol kell tárolni. Hűvös, sötét és száraz helyen tárolja.

Lejárat

A lejárat dátumát lásd a vezetődrót csomagolásának címkéjén.

A csomag tartalma

5 darab / doboz

Felelősség kizárása

Az „ASAHI INTECC CO., LTD. és partnervállalatai” (a továbbiakban a „Vállalat”) semmilyen esetben sem vonható felelősségre az olyan balesetek, személyi sérülések vagy mellékhatások miatt, melyek a termék(ek) nem megfelelő, illetve a jelen utasításokkal összhangban nem lévő használatából adódnak. A vállalat semmiképpen nem felel azokért a károkért, amelyek vagy (i) a termék(ek)nek a vállalattól való kiszállítása utáni tárolására, vagy (ii) a betegek, sebészeti eljárások vagy más orvosi tevékenység megválasztására vezethetők vissza.

A „Gladius”, a „Halberd” és az „ASAHI Gaia” az ASAHI INTECC CO., LTD. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei Japánban és egyéb országokban.

*A csúcs terhelésének értékei a belső szabványos vizsgálati módszerrel mért termékspecifikációs értékek átlagértékei jelentik, feltételezve a vezetődrót csúcsa által a lézióra kifejtett erőt.

Filo guida periferico

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di usare il filo guida e rispettare le sezioni Indicazioni per l'uso, Popolazione target trattata, Controindicazioni, Avvertenze, Precauzioni e Modalità di utilizzo di queste Istruzioni per l'uso. In caso contrario potrebbero verificarsi complicanze, comprese gravi lesioni al paziente, anche mortali.

Se l'utente e/o il paziente vengono a conoscenza di un incidente grave che si è verificato in correlazione al filo guida, sono tenuti a segnalarlo al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro.

Le presenti Istruzioni per l'uso si applicano a Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Alabarda, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Per ulteriori informazioni (lunghezza del filo guida, lunghezza della sezione radiopaca, ecc.), consultare l'etichetta del prodotto.

Descrizioni

La struttura base di questo filo guida prevede un filo conico animato e due tipologie di spirali distali (una spirale esterna e una interna). Il filo conico animato e le spirali sono saldati insieme. Una parte, o l'intera lunghezza, della spirale esterna è radiopaca in modo che possa essere facilmente individuata per mezzo di una fluoroscopia. I lati distali di Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 e ASAHI Gaia PV sono rivestiti con un polimero idrofilico. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES e Gladius MG18 PV ES sono dotati ciascuno di un rivestimento in resina poliuretanicca sulla spirale esterna, ricoperto da un rivestimento idrofilico. In tutti questi fili guida il lato prossimale del filo conico animato è rivestito di PTFE (politetrafluoroetilene). Sull'estremità prossimale dei dispositivi che non hanno una lunghezza totale di 300 cm è presente un collegamento per un filo di prolunga, utilizzato per sostituire il dispositivo abbainato; a tale estremità può essere collegato il filo di prolunga ASAHI INTECC. Fare riferimento alla tabella sottostante per il carico della punta* di questo prodotto.

Tabella 1. Specifiche prodotto

Nome prodotto	Diametro esterno	Carico della punta*
Gladius	0,36 mm (0,014 pollici)	3 gf
	0,45 mm (0,018 pollici)	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014 pollici)	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014 pollici)	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018 pollici)	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014 pollici)	12 gf
	0,45 mm (0,018 pollici)	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008 pollici/0,014 pollici)	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009 pollici/0,014 pollici)	40 gf
Astato 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013 pollici/0,018 pollici)	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014 pollici/0,018 pollici)	7,5 gf

Indicazioni per l'uso

Questo filo guida è destinato all'intervento percutaneo periferico (IPP) generico. Questo filo guida è progettato per facilitare il posizionamento dei dispositivi interventistici a scopo terapeutico nell'ambito della vascolarizzazione periferica dell'arto inferiore.

Il filo guida è destinato esclusivamente all'uso nella vascolarizzazione periferica dell'arto inferiore. Questo filo guida non è destinato all'uso in ambito neurovascolare e cardiovascolare.

Popolazione target trattata

Questo filo guida è pensato per essere utilizzato su pazienti che rientrano nei canoni previsti per le procedure di IPP. Non deve essere utilizzato su neonati, lattanti o bambini, né su pazienti in stato di gravidanza, affetti da disfunzione renale e allergici al mezzo di contrasto o al polietilenglicole (PEG).

Controindicazioni

- Prima dell'uso effettivo, verificare la compatibilità del diametro del filo guida con gli altri dispositivi interventistici.
- Non utilizzare il filo guida nei pazienti allergici ai mezzi di contrasto o affetti da disfunzione renale.
- Il rivestimento idrofilico del filo guida contiene PEG400. Non utilizzare il filo guida nei pazienti allergici al polietilenglicole (PEG).
- Non utilizzare il filo guida nelle pazienti in stato di gravidanza, anche presunto, (i raggi X possono nuocere al feto).
- Il filo guida deve essere utilizzato in strutture sanitarie in grado di eseguire prontamente un intervento chirurgico d'urgenza. Nel caso in cui sia impossibile eseguire un intervento chirurgico d'urgenza, nel peggiore dei casi possono verificarsi eventi con rischio per la vita del paziente.
- Il filo guida è presterilizzato con ossido di etilene (EOG) ed è inteso esclusivamente monouso. Non riutilizzare né risterilizzare. Se riutilizzato o risterilizzato, le prestazioni o la qualità del filo guida e della confezione possono risultare compromesse, con rischio di complicanze, comprese infezioni.

Avvertenze

- Questo filo guida deve essere utilizzato solo da un medico specializzato nel trattamento degli IPP.
- Questo filo guida non deve mai essere utilizzato in combinazione con cateteri con parti metalliche che possono entrare in contatto diretto con la superficie del filo guida (ad es. cateteri per aterectomia, dilatatori metallici), aghi metallici o introduttori metallici.
- Durante l'uso del filo guida, controllare e monitorare il movimento della punta sotto guida fluoroscopica. Non utilizzare in aree vascolari non visualizzate o impossibili da visualizzare.
- Non collegare il filo guida a fili di prolunga scollegabili prodotti da aziende diverse da ASAHI INTECC. Non maneggiare il filo guida con il filo di prolunga scollegabile collegato. In caso contrario, il filo guida può subire danni o la prolunga rimovibile può staccarsi accidentalmente.
- Non modificare il filo guida per nessun motivo.

Precauzioni

- Non utilizzare il filo guida oltre la data di scadenza riportata sull'etichetta. Eliminare il filo guida se la data di scadenza è stata superata.
- I fili guida sono strumenti delicati che vanno maneggiati con cura.
- Non utilizzare il filo guida se la confezione è aperta o danneggiata. Non aprire la confezione fino al momento immediatamente precedente all'uso. Maneggiare e utilizzare il filo guida in condizioni asettiche.
- Mantenere sempre umido il filo guida, in modo da evitare danni al rivestimento idrofilico.
- Non pulire il filo guida con soluzioni organiche come alcol.

- Dopo l'uso, smaltire il filo guida, gli accessori e la confezione seguendo le indicazioni di smaltimento dei rifiuti medici, applicando misure preventive contro le malattie infettive.
- In caso di resistenza, non spingere, ruotare, ritrarre o torcere il filo guida. Torcere o spingere il filo guida a fronte di resistenza può danneggiarlo e/o causarne il distacco della punta ovvero danneggiare direttamente un vaso. In caso contrario, il filo guida può subire danni. Determinare le cause della resistenza tramite fluoroscopia e intraprendere le necessarie azioni correttive.
- Far sempre avanzare o retrocedere il filo guida lentamente e con attenzione.
- Durante la torsione del filo guida all'interno di un vaso sanguigno, non procedere sempre nella stessa direzione, bensì ruotarlo alternativamente in senso orario e antiorario. Non eseguire più di due rotazioni (720°) nello stesso senso.
- Durante la rimozione o il reinserimento del filo guida, irrigarlo con soluzione salina eparinata e sterilizzata o con altra soluzione idonea per evitare l'ingresso di aria nel dispositivo interventistico. Eseguire con cautela la sostituzione del filo guida per evitare l'ingresso di aria e/o traumi. Quando si introduce nuovamente il filo guida, verificare che la punta del dispositivo interventistico sia libera all'interno del lume del vaso e non urti contro la parete del vaso stesso. In caso contrario, si possono provocare traumi. Utilizzare il marcatore radiopaco del dispositivo interventistico per verificare la posizione.
- Il movimento libero del filo guida all'interno del dispositivo interventistico è una caratteristica importante dei sistemi a filo guida orientabile perché fornisce all'operatore utili informazioni tattili. Prima dell'uso verificare la presenza di resistenze nel sistema. Se si nota che la valvola emostatica si oppone al movimento del filo guida, regolarla o sostituirla con una valvola regolabile.
- Non eseguire il posizionamento di stent utilizzando più di un filo guida o facendo

passare il filo attraverso le maglie dello stent. In caso contrario, lo stent può danneggiarsi o il filo guida può rompersi o spezzarsi.

- Prima dell'uso, verificare che il filo guida abbia le dimensioni e la forma corrette per la procedura specifica e sia compatibile con il dispositivo da abbinare.
- Consultare le Istruzioni per l'uso allegate al dispositivo medico (ad es. i dispositivi terapeutici interventistici) da utilizzare in combinazione con questo filo guida.
- Quando si collega il filo di prolunga scollegabile al filo guida, questo deve essere inserito saldamente tra il segmento rivestito in PTFE e il segmento non rivestito in PTFE sull'estremità prossimale del filo guida. In caso di anomalia durante l'inserimento, interrompere immediatamente l'uso del filo guida.
- Controllare attentamente l'eventuale presenza di piegature, torsioni o altri danni del filo guida prima dell'uso e, se possibile, durante la procedura. Non utilizzare il filo guida se è danneggiato.
- Durante la sagomatura della punta, prestare attenzione a non danneggiare la spirale.
- Prima di inserire il filo guida, individuare l'estremità distale e verificare che venga inserito con questa estremità.
- Durante la procedura mantenere un flusso continuo di soluzione fisiologica eparinata e sterilizzata tra il catetere guida e il dispositivo interventistico e tra il dispositivo interventistico e il filo guida. Il flusso impedisce la formazione di cristalli del mezzo di contrasto e/o coaguli sul filo guida e nel lume del catetere.
- Per il contenitore con tubo di protezione dell'estremità distale (vedere Modalità di utilizzo, Figura 1), non rimuovere o inserire il tubo di protezione dell'estremità distale mentre il filo guida è alloggiato nel contenitore.
- Per il contenitore con tubo di protezione dell'estremità distale (vedere Modalità di utilizzo, Figura 1), rimuovere il tubo di protezione dell'estremità distale prima di alloggiare nuovamente il filo guida nel contenitore.

1. Malfunzionamenti

Rottura o piegatura del filo guida	Danni quali distacco	Distacco del rivestimento
Decesso	Infezioni	
Riduzione della pressione arteriosa	Complicanze emorragiche	Embolia
Infarto	Occlusione vascolare	Trombo
Ischemia	Aritmia	Dissezione vascolare
Vasospasmo	Senso di vertigine	Mal di testa
Vomito	Perforazione vascolare	Reazione allergica

Modalità di utilizzo

1. Ispezione prima dell'uso

- Prima dell'uso, eseguire un'ispezione accurata e verificare che il filo guida e la relativa confezione non siano danneggiati.
- Prima dell'uso, verificare che il filo guida sia compatibile con il dispositivo interventistico da utilizzare.

2. Preparazione

- Selezionare il filo guida più adatto per l'area interessata e rimuovere dalla confezione sterile il tubo contenitore con il filo guida.
- Riempire il tubo contenitore con soluzione

salina eparinata e sterilizzata utilizzando una siringa, in modo da immergere l'intero dispositivo. Durante l'operazione, la soluzione salina eparinata e sterilizzata può fuoriuscire dal tubo contenitore.

- Prima di inserire il filo guida, riempire il lume del dispositivo interventistico con la soluzione salina eparinata e sterilizzata.
- Rilasciare il filo guida dal fermo di coda e farlo scorrere lentamente, spingendone l'estremità distale attraverso il tubo contenitore (B) (Figura 2).

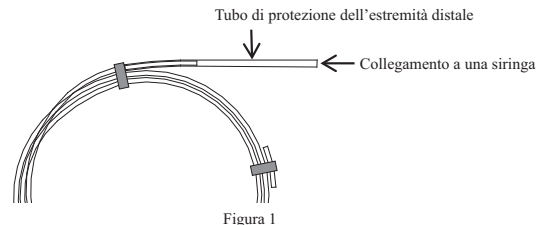


Figura 1

Malfunzionamenti ed eventi avversi

I possibili malfunzionamenti ed eventi avversi durante l'uso del filo guida comprendono, tra gli altri:

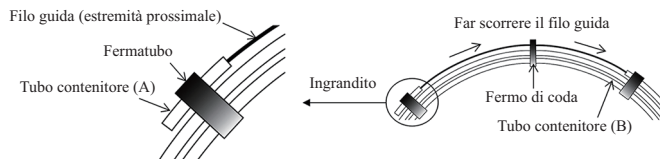


Figura 2

- e) Quando l'estremità distale del filo guida sporge di 5 o 6 cm oltre l'altra estremità del tubo contenitore (o dell'estremità distale del tubo di protezione), se necessario, sagomare la punta secondo le pratiche standard.
- f) Afferrare delicatamente il filo guida fuoriuscito dall'estremità distale del tubo contenitore (o dell'estremità distale del tubo di protezione), il più vicino possibile al tubo contenitore, ed estrarlo lentamente e con cautela.
- g) In caso di resistenza durante la rimozione del filo guida dal tubo contenitore, iniettare altra soluzione salina eparinata e sterilizzata nel tubo contenitore. Continuare a rimuovere il filo guida quando non si avverte più resistenza. Assicurarsi di iniettare nel tubo contenitore sufficiente soluzione salina eparinata e sterilizzata perché il rivestimento idrofílico potrebbe subire danni se si rimuove con forza il filo guida rivestito.
- h) Dopo avere estratto il filo guida dal tubo contenitore, ispezionarlo per verificare che non sia danneggiato.

3. Procedure per l'inserimento

■ Sistema Over-the-wire

- a) Inserire con attenzione l'estremità distale del filo guida nel lume del filo guida del dispositivo interventistico.
- b) Far avanzare con cautela il filo guida finché la punta non si trovi in posizione appena prossimale rispetto alla punta del dispositivo interventistico.
- c) Innestare il catetere guida e inserire il sistema del dispositivo interventistico (con il filo guida) nel connettore a Y.
- d) Far avanzare il sistema del dispositivo interventistico attraverso il catetere guida finché la punta del sistema del filo guida non si trovi in posizione appena prossimale

rispetto alla punta del catetere guida.

- e) Serrare la valvola emostatica del connettore a Y per creare una chiusura ermetica attorno al dispositivo interventistico. Verificare che il movimento del filo guida sia ancora possibile.
- f) Verificare che il filo guida si muova agevolmente.
- g) Se necessario, applicare sul filo guida il dispositivo di controllo della torsione.
- h) Far avanzare il filo guida sotto guida fluoroscopica attraverso la lesione. Verificare mediante angiografia che il filo guida abbia superato la lesione target sede del restringimento.
- i) Osservare il movimento del filo guida nei vasi.
- j) Far avanzare il dispositivo interventistico fino a raggiungere la lesione, evitando che il filo guida si sposti. Verificare che la punta distale del filo guida e la sua posizione nel vaso siano visibili durante la manipolazione del dispositivo interventistico.

■ Sistema di sostituzione rapida

- a) Innestare il catetere guida.
- b) Inserire l'introduttore del filo guida nel connettore a Y del catetere guida.
- c) Inserire con cautela la punta del filo guida nell'introduttore.
- d) Far avanzare il filo guida attraverso il catetere sotto guida fluoroscopica finché la punta del filo guida non si trova in posizione appena prossimale rispetto alla punta del catetere guida.
- e) Se necessario, applicare sul filo guida il dispositivo di controllo della torsione.
- f) Far avanzare il filo guida sotto guida fluoroscopica attraverso la lesione.

Verificare mediante angiografia che il filo guida abbia superato la lesione target sede del restringimento.

- g) Osservare il movimento del filo guida nei vasi.
- h) Rimuovere il dispositivo di controllo della torsione del filo guida e l'introduttore del filo guida.
- i) Guidare il dispositivo interventistico sul filo guida evitando lo spostamento e avanzare fino a raggiungere la lesione. Verificare che la punta distale del filo guida

e la sua posizione nel vaso siano visibili durante la manipolazione del dispositivo interventistico.

4. Procedure per la sostituzione del filo guida

■ Sistema Over-the-wire

- a) Rimuovere lentamente il filo guida, controllandone il movimento sotto guida fluoroscopica.
- b) Inserire il nuovo filo guida secondo le indicazioni contenute nella presente sezione "Modalità di utilizzo".

Metodo di conservazione

Non conservare il filo guida e la relativa confezione ripiegati e/o sottoposti a carichi pesanti. Il filo guida e la relativa confezione devono essere conservati lontano dall'acqua. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Data di scadenza

La data di scadenza è indicata sull'etichetta applicata sulla confezione del filo guida.

Contenuto

5 pezzi / scatola

Esclusione di responsabilità

In nessun modo "ASAHI INTECC CO., LTD. e le sue affiliate" (in seguito denominate "Azienda") possono essere ritenute responsabili per incidenti, lesioni personali ed eventi avversi dovuti a qualsiasi utilizzo improprio di questo/i prodotto/i in contravvenzione alle presenti istruzioni. In nessun caso l'Azienda può essere ritenuta responsabile dei danni derivanti (i) dalla conservazione dei prodotti dopo la spedizione dall'Azienda stessa o (ii) causati dalla selezione di pazienti, tecniche chirurgiche o altre attività mediche effettuate dalla struttura medica che utilizza i prodotti.

"Gladius", "Halberd", "ASAHI Gaia" e "Astatò" sono marchi commerciali o marchi registrati di ASAHI INTECC CO., LTD. in Giappone e in altri Paesi.

*I valori di carico della punta rappresentano le medie dei valori delle specifiche tecniche del prodotto misurate secondo il metodo di prova standard interno, ipotizzando la pressione applicata alla lesione dalla punta del filo guida.

Prowadnik obwodowy

Instrukcja użytkowania

Przed użyciem tego przewodnika należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania i przestrzegać zawartych w Instrukcji użytkowania sekcji Wskazania do stosowania, Docelowa populacja poddawana leczeniu, Przeciwwskazania, Przestrogi, Środki ostrożności oraz Sposób korzystania z produktu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować powikłaniami, które mogą prowadzić do poważnych urazów u pacjenta bądź do jego śmierci.

Jeżeli użytkownik i/lub pacjent dowie się o poważnym zdarzeniu związanym z przewodnikiem, powinien zgłosić ten fakt producentowi i właściwemu organowi w państwie członkowskim.

Niniejsza instrukcja użytkowania dotyczy urządzeń Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Aстато XS 20, Aстато XS 40, Aстато 30, ASAHI Gaia PV. Informacje szczegółowe (długość przewodnika, długość odcinka nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich, itd.) podano na etykiecie produktu.

Opis

Podstawowa struktura tego przewodnika składa się ze stożkowego przewodu głównego oraz dwóch rodzajów spirali dystalnych (spirali zewnętrznej i spirali wewnętrznej). Stożkowy przewód główny i spirale są lutowane. Część lub cała długość spirali zewnętrznej nie przepuszcza promieni rentgenowskich, dzięki czemu jej położenie można łatwo sprawdzić za pomocą fluoroskopii. Dystalne części Halberd, Aстато XS 20, Aстато XS 40, Aстато 30 i ASAHI Gaia PV są pokryte hydrofilowym polimerem. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES i Gladius MG18 PV ES mają powłokę z żywicy poliuretanowej na zewnętrznej spirali i powłokę hydrofilną na wierzchu. We wszystkich tych seriach przewodników maksymalna strona stożkowego przewodu głównego jest pokryta PTFE (politetrafluoroetylenem). Na proksymalnym końcu wyrobów o długości innej niż 300 cm znajduje się przyłącze przewodu przedłużającego, który służy do wymiany wyrobu używanego w połączeniu; można podłączyć przewód przedłużający ASAHI INTECC. Poniższa tabela zawiera informacje na temat obciążenia końcówki* tego produktu.

Tabela 1. Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Średnica zewnętrzna	Obciążenie końcówki*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014")	12 gf
	0,45 mm (0,018")	12 gf
Aстато XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008"/0,014")	20 gf
Aстато XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009"/0,014")	40 gf

Nazwa produktu	Średnica zewnętrzna	Obciążenie końcówki*
Aстато 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013"/0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014"/0,018")	7,5 gf

Wskazania do stosowania

Ten przewodnik jest przeznaczony do ogólnych przezskórnych interwencji obwodowych (PPI). Ten przewodnik jest przeznaczony do ułatwiania umieszczania interwencyjnych wyrobów terapeutycznych w obrębie naczyń obwodowych kończyny dolnej.

Ten przewodnik jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w obwodowych naczyniach kończyn dolnych. Ten przewodnik nie jest przeznaczony do stosowania w układzie nerwowo-naczyniowym i sercowo-naczyniowym.

Docelowa populacja poddawana leczeniu

Ten przewodnik jest przeznaczony dla pacjentów spełniających wskazania do zabiegów PPI. Nie jest wskazany do stosowania u noworodków, niemowląt lub dzieci, a także u pacjentów w ciąży, z zaburzeniami czynności nerek i reakcjami alergicznymi na środki kontrastowe lub glikol polietylenowy (PEG).

Przeciwwskazania

- Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność średnicy przewodnika z innym urządzeniem interwencyjnym.
- Nie należy stosować przewodnika u pacjentów, u których występuje reakcja alergiczna na środki kontrastowe lub z zaburzeniami czynności nerek.
- Ten przewodnik zawiera w swojej powłoce hydrofilnej PEG400. Nie stosować przewodnika u pacjentów, u których występują reakcje alergiczne na glikol polietylenowy (PEG).
- Nie stosować przewodnika u pacjentek w ciąży lub pacjentek, które mogą być w ciąży (promieniowanie rentgenowskie może szkodliwie oddziaływać na płód).
- Przewodnik musi być używany w instytucji, w której można przeprowadzać zabiegi chirurgiczne w trybie pilnym. Jeśli przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego w trybie pilnym będzie niemożliwe, w najgorszym przypadku może dojść do zdarzeń zagrażających życiu.
- Przewodnik jest wstępnie sterylizowany tlenkiem etylenu (EOG) i jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie ani nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie lub ponowna sterylizacja mogą negatywnie wpłynąć na działanie lub jakość przewodnika i opakowanie, a także sprzyjają ryzyku wystąpienia powikłań, z zakażeniem włącznie.

Przestrogi

- Ten przewodnik może być używany wyłącznie przez lekarza w pełni przeszkolonego w zakresie leczenia PPI.
- Nigdy nie należy używać tego przewodnika w połączeniu z cewnikami posiadającymi metalowe części, które mogą bezpośrednio stykać się z powierzchnią tego przewodnika (np. cewniki do aterektomii, metalowe rozszerzacze), metalowymi igłami lub metalowymi przewodnikami.
- Podczas stosowania przewodnika należy sprawdzać i monitorować ruch jego końcówki pod kontrolą fluoroskopii. Nie używać w obszarach naczyń, które nie są lub nie mogą zostać uwidocznione.
- Nie należy łączyć tego przewodnika z przedłużaczami wyprodukowanymi przez firmę inną niż ASAHI INTECC. Nie ruszać przewodnikiem, gdy podłączony jest przedłużacz. W przeciwnym razie przewodnik

może zostać uszkodzony lub przedłużyć może zostać nieumyślnie odłączony.

Środki ostrożności

- Nie używać tego przewodnika po upływie daty ważności wskazanej na etykiecie. Wszystkie przewodniki, których data ważności upłynęła, należy wyrzucić.
- Przewodniki to delikatne instrumenty i należy obchodzić się z nimi ostrożnie.
- Jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, nie należy używać przewodnika. Produkt należy rozpakować zawsze bezpośrednio przed użyciem. Podczas przenoszenia i użycia przewodnika należy zachować zasady aseptyki.
- Należy zawsze utrzymywać przewodnik w stanie wilgotnym, aby nie uszkodzić jego powłoki hydrofilnej.
- Nie należy wycierać tego przewodnika używając roztworu organicznego, np. alkoholu.
- Po użyciu należy wyrzucić przewodnik, akcesoria i opakowanie jako odpady medyczne, stosując środki zapobiegawcze przeciwko chorobom zakaźnym.
- Nigdy nie należy pchać, wkręcać, wyciągać ani obracać przewodnika, który napotyka na opór. Obracanie lub pchanie przewodnika wbrew napotkanemu oporowi może spowodować uszkodzenie i/lub oddzielenie końcówki przewodnika lub uszkodzić bezpośrednio naczynie. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia tego przewodnika. Należy określić fluoroskopowo przyczynę oporu i podjąć wszelkie niezbędne środki zaradcze.
- Przewodnik należy zawsze wysuwać i wsuwać powoli i ostrożnie.
- Obracając ten przewodnik w naczyniu krwionośnym, nie należy obracać go ciągle w tym samym kierunku. Obracając przewodnik, należy to czynić naprzemiennie zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nie należy obracać o więcej niż dwa obroty (720°) w tym samym kierunku.
- Podczas wyciągania i ponownego wprowadzania przewodnika należy przepłukać go heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej lub innym odpowiednim roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do urządzenia zabiegowego. Przewodnik należy wymieniać ostrożnie, aby nie dopuścić powietrza i/lub nie spowodować urazu. Wprowadzając przewodnik ponownie,

- W żaden sposób nie modyfikować przewodnika.

- należy upewnić się, czy końcówka urządzenia zabiegowego jest swobodna w świetle naczynia i czy nie jest nastawiona na ścianę naczynia. W przeciwnym razie może dojść do urazu. Aby potwierdzić położenie, należy zastosować nieprzepuszczający promieni rentgenowskich znacznik urządzenia zabiegowego.
- Swobodny ruch przewodnika w urządzeniu zabiegowym jest ważną cechą sterowalnego systemu przewodnika, ponieważ daje użytkownikowi cenne, realne informacje. Przed użyciem należy sprawdzić system pod kątem występowania oporu. Wyregulować lub wymienić zastawkę hemostatyczną na zastawkę regulowaną jeśli hamuje ruch przewodnika.
 - Nie umieszczać stentu przy użyciu więcej niż jednego przewodnika lub operując przewodnikiem za pośrednictwem rozporki stentu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia stentu bądź pęknięcia lub rozpadnięcia się przewodnika.
 - Przed użyciem należy sprawdzić, czy ten przewodnik ma odpowiedni rozmiar i kształt do zabiegu oraz czy jest kompatybilny z urządzeniem, które będzie używane w połączeniu z nim.
 - Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania dołączonej do wyrobu medycznego (np. urządzenia do terapii interwencyjnej), które ma być używane w połączeniu z tym przewodnikiem.
 - Podłączając przedłużacz do tego przewodnika należy go bezpiecznie włożyć do linii granicznej pomiędzy powłoką niewykonaną z PTFE a powłoką z PTFE na proksymalnym końcu przewodnika. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w połączeniu, należy natychmiast zaprzestać używania przewodnika.
 - Dokładnie sprawdzić przewodnik, czy nie uległ zgięciu, zagięciu lub innemu uszkodzeniu przed użyciem, a także dokładnie go sprawdzić, jeśli to możliwe, podczas wykonywania zabiegu. Nie używać uszkodzonego przewodnika.
 - Podczas formowania końcówki należy uważać, aby nie uszkodzić spirali.

- Przed wprowadzeniem przewodnika należy sprawdzić, który koniec jest końcem dystalnym i upewnić się, że jest on wprowadzany od strony dystalnej.
- Podczas zabiegu należy utrzymywać ciągłe płukanie heparyną i sterylizowaną solą fizjologiczną między cewnikiem prowadzącym a urządzeniem interwencyjnym oraz między urządzeniem interwencyjnym a przewodnikiem. Płukanie zapobiega tworzeniu się krystalów środka kontrastowego i/lub skrzepów na przewodniku i w świetle cewnika.

- W przypadku uchwytu z ręką zabezpieczającą końcówkę dystalną (patrz Sposób korzystania z produktu, Rysunek 1), nie wyjmuj i nie wkładaj rurki zabezpieczającej końcówkę dystalną, gdy przewodnik jest umieszczony w uchwycie.
- W przypadku uchwytu z ręką zabezpieczającą końcówkę dystalną (patrz Sposób korzystania z produktu, Rysunek 1), wyjmij rękę zabezpieczającą końcówkę dystalną przed ponownym umieszczeniem przewodnika w uchwycie.

Usterki, uszkodzenia i zdarzenia niepożądane

Eventualnie usterki, uszkodzenia i zdarzenia niepożądane związane z użyciem przewodnika obejmują m.in.:

1. Nieprawidłowe działania

Złamanie lub wygięcie przewodnika	Uszkodzenia takie jak oddzielenie	Odczodzenie powłoki
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------

2. Zdarzenia niepożądane

Śmierć	Zakażenie	
Obniżenie ciśnienia krwi	Powikłania związane z krwawieniem	Zator
Zawał	Okluzja naczyniowa	Powstanie zakrzepu
Ischemia	Arytmia	Rozwarstwienie ściany naczynia
Skurcz naczyń	Zawroty głowy	Ból głowy
Wymioty	Perforacja naczynia	Reakcja alergiczna

Sposób korzystania z produktu

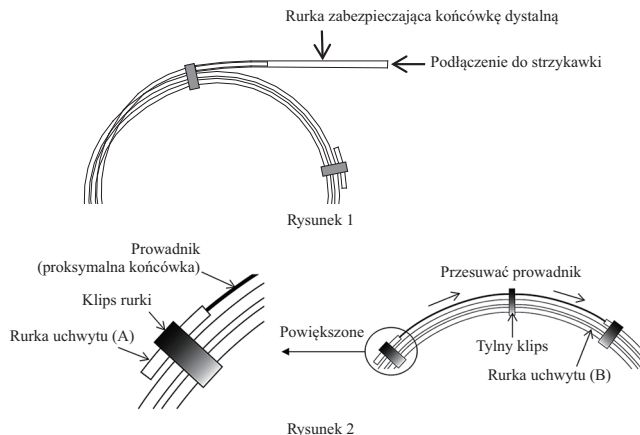
1. Sprawdzenie przed użyciem

- Przed użyciem dokładnie sprawdzić i potwierdzić, czy przewodnik i opakowanie nie są uszkodzone.
- Przed użyciem potwierdzić, że przewodnik jest kompatybilny z mającymi zostać użytymi urządzeniami interwencyjnymi.

2. Przygotowanie

- Wybrać najbardziej odpowiedni przewodnik dla zmienionego chorobowo miejsca i wyciągnąć rękę uchwytu zawierającą przewodnik ze sterylnego opakowania.
- Napełnić rękę uchwytu heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej przy

- użyciu strzykawki, aby nawilżyć całe urządzenie. Należy pamiętać, że heparynizowany i jałowy roztwór soli fizjologicznej może wtedy wylać się z rurki uchwytu.
- Przed włożeniem przewodnika napełnij światło urządzenia zabiegowego heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej.
 - Zwolnij przewodnik z tylnego klipsa i wolno go przesunąć, pchnąć dystalną końcówkę przewodnika przez rękę uchwytu (B) (Rys. 2).



e) Gdy końcówka dystalna przewodnika zostanie wysunięta o 5 do 6 cm poza drugi koniec uchwytu rurki (lub rurki zabezpieczającej końcówkę dystalną), w razie potrzeby należy uformować końcówkę zgodnie ze standardową praktyką.

f) Delikatnie chwycić przewód wychodzący z końcówki dystalnej rurki uchwytu (lub rurki zabezpieczającej końcówkę dystalną), w miejscu jak najbliższe rurki uchwytu i powoli i ostrożnie wyciągnąć przewód.

g) Jeśli odczuwalny jest opór podczas wyjmowania przewodnika z rurki uchwytu, należy ponownie wstrzyknąć heparynizowany i jałowy roztwór soli fizjologicznej do rurki uchwytu. Kiedy opór przestanie być wyczuwalny, należy kontynuować wyciąganie przewodnika. Należy upewnić się, że wstrzyknięto odpowiednią ilość heparynizowanego i jałowego roztworu soli fizjologicznej do rurki uchwytu, ponieważ podczas wyjmowania powlekanego przewodnika z użyciem dużej siły może dojść do uszkodzenia powłoki hydrofilnej.

h) Wyciągnąć przewód z rurki uchwytu, sprawdzić, czy nie jest uszkodzony.

3. Procedury wkładania

■ System over-the-wire

a) Włożyć dystalną końcówkę przewodnika ostrożnie w światło przewodnika urządzenia interwencyjnego.

b) Wprowadzić ten przewód ostrożnie do momentu, gdy jego końcówka jest w pozycji proksymalnej do końcówki urządzenia interwencyjnego.

c) Zaczepić cewnik prowadzący i włożyć urządzenie interwencyjne (z przewodnikiem) do złącza Y.

d) Wprowadzać urządzenie interwencyjne przez cewnik prowadzący do momentu, gdy końcówka przewodnika będzie w pozycji proksymalnej w stosunku do końcówki cewnika prowadzącego.

e) Zaciśnąć zastawkę hemostatyczną złącza Y, aby utworzyć uszczelnienie dookoła urządzenia interwencyjnego. Upewnić się, czy ruch przewodnika jest ciągle dozwolony.

f) Sprawdzić, czy przewód porusza się gładko.

g) Dołączyć urządzenie obrotowe do przewodnika, jeśli to konieczne.

h) Wprowadzić przewód pod obserwacją fluoroskopową, aby przejść przez zmianę. Potwierdzić za pomocą angiografii, że przewód przeszedł przez docelową zwężoną zmianę.

i) Obserwować ruch przewodnika w naczyniach.

j) Wprowadzić urządzenie interwencyjne do momentu osiągnięcia zmiany zapobiegając ruchowi przewodnika. Zapewnić, by dystalna końcówka przewodnika i jego umiejscowienie były widoczne podczas poruszania urządzeniem interwencyjnym.

■ System szybkiej wymiany

a) Zaczepić cewnik prowadzący.

b) Wprowadzić introduktor przewodnika do złącza Y cewnika prowadzącego.

c) Ostrożnie włożyć końcówkę przewodnika do introduktora.

d) Wprowadzić przewód przez cewnik wprowadzający pod kontrolą fluoroskopową do momentu, gdy końcówka przewodnika znajdzie się w pozycji proksymalnej do końcówki cewnika wprowadzającego.

e) Dołączyć urządzenie obrotowe do

przewodnika, jeśli to konieczne.

f) Wprowadzić przewód pod kontrolą fluoroskopową, aby przejść za zmianę. Potwierdzić za pomocą angiografii, że przewód przeszedł przez docelową zwężoną zmianę.

g) Obserwować ruch przewodnika w naczyniach.

h) Usunąć urządzenie obrotowe przewodnika oraz introduktor przewodnika.

i) Śledzić urządzenie interwencyjne za przewodnikiem, zapobiegając ruszaniu się przewodnika, wprowadzać do momentu dotarcia do zmiany. Zadbaj o to, by dystalna końcówka przewodnika i jej miejsce w naczyniu były widoczne w trakcie wykonywania ruchów urządzeniem interwencyjnym.

4. Procedury wymiany przewodnika

■ System over-the-wire

a) Usunąć wolno przewód, monitorując ruch przewodnika fluoroskopowo.

b) Włożyć następny przewód zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Sposób korzystania z produktu”.

Przechowywanie

Nie przechowywać przewodnika i opakowania w pozycji zgiętej i/lub silnie obciążonej. Przewódnik i opakowanie należy przechowywać z dala od wody. Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.

Data ważności

Data ważności jest podana na etykiecie umieszczonej na opakowaniu przewodnika.

Zawartość

5 sztuk / pudełko

Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej

Firma „ASAHI INTECC CO., LTD. i jej podmioty zależne” (odtąd nazywane „Firmą”) w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, obrażenia osób, zdarzenia niepożądane spowodowane nieprawidłowym stosowaniem produktu lub produktów albo jakimkolwiek innym działaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe (i) wskutek nieprawidłowego przechowywania produktu po jego wysyłce z Firmy lub (ii) wskutek niewłaściwego wyboru pacjentów, technik chirurgicznych lub jakichkolwiek innych działań lekarskich powziętych przez instytucję medyczną korzystającą z produktu.

„Gladius”, „Halberd”, „ASAHI Gaia” oraz „Astato” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ASAHI INTECC CO., LTD. w Japonii i innych krajach.

*Wartości obciążenia końcówki reprezentują średnie wartości specyfikacji produktu zmierzone zgodnie ze standardową wewnętrzną metodą testowania przy założeniu siły przyłożonej do zmiany przez końcówkę przewodnika.

Fio guia periférico

Instruções de utilização

Leia estas instruções de utilização antes de usar este fio guia e tenha em conta as secções Indicações de utilização, População-alvo tratada, Contraindicações, Advertências, Precauções e Como utilizar nas Instruções de utilização. A não observação pode resultar em complicações, incluindo lesão grave ou morte do paciente.

Se um utilizador e/ou um paciente tomar conhecimento de um incidente grave relacionado com o fio guia, comunique o facto ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-Membro.

Estas Instruções de utilização aplicam-se ao Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Para informações (comprimento do fio guia, comprimento da secção radiopaca, etc.), consulte a etiqueta do produto.

Descrição

A estrutura básica deste fio guia consiste num cabo principal cónico e em dois tipos de bobinas distais (uma bobina externa e uma bobina interna). O cabo principal cónico e as bobinas são soldados. Um comprimento parcial ou total da bobina externa é radiopaca para que a sua posição possa ser confirmada facilmente por fluoroscopia. Os lados distais do Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 e ASAHI Gaia PV são revestidos com um polímero hidrófilo. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES e Gladius MG18 PV ES: cada um tem um revestimento de resina de poliuretano na bobina externa e um revestimento hidrófilo sobre o mesmo. Em todos estes fios guia, o lado proximal do fio principal cónico é revestido com PTFE (politetrafluoroetileno). Na extremidade proximal dos dispositivos que não têm comprimentos totais de 300 cm existe uma ligação para um fio de extensão, que é utilizado para substituir o dispositivo combinado; é possível ligar o fio de extensão do ASAHI INTECC. Consulte na tabela seguinte a carga da ponta* deste produto.

Tabela1. Especificações do produto

Nome do Produto	Diâmetro Externo	Carga da ponta*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014")	12 gf
	0,45 mm (0,018")	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008"/0,014")	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm/0,36 mm(0,009"/0,014")	40 gf
Astato 30	0,33 mm/0,45 mm(0,013"/0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014"/0,018")	7,5 gf

Indicações de utilização

Este fio guia destina-se à intervenção periférica percutânea (IPP) geral. Este fio guia destina-se a facilitar a colocação de dispositivos terapêuticos interventivos na vasculatura periférica da extremidade inferior. **Este fio guia destina-se apenas à utilização na vasculatura periférica da extremidade inferior. Este fio guia não se destina à utilização na neurovasculatura, nem na cardiovascular.**

População-alvo tratada

Este fio guia destina-se a doentes elegíveis para procedimentos de IPP. Não é indicado para uso em neonatos, bebés ou crianças, bem como em pacientes grávidas, com função renal prejudicada e que tenham reacção alérgica a meios de contraste ou polietileno glicol (PEG).

Contraindicações

- Confirmar a compatibilidade do diâmetro do fio guia com outro dispositivo de intervenção antes da utilização efetiva.
- Não utilizar o fio guia em doentes que façam reacção alérgica ao meio de contraste ou que tenham disfunção renal.
- O fio guia contém PEG400 no seu revestimento hidrófilo. Não utilizar o fio guia em doentes que façam reacções alérgicas ao polietileno glicol (PEG).
- Não use o fio guia em doentes grávidas ou que possam estar grávidas (o raio X pode afetar o feto).
- Este fio guia deve ser utilizado numa instituição onde seja possível efetuar imediatamente uma cirurgia de emergência. Se não estiver disponível uma cirurgia de emergência, no pior dos cenários, podem ocorrer eventos potencialmente fatais.
- Este fio guia foi pré-esterilizado com gás de óxido de etileno (GOE) e destina-se apenas a uma utilização única. Não reutilize ou reesterilize. Se reutilizado ou reesterilizado, o desempenho ou a qualidade deste fio guia e respetiva embalagem podem ficar comprometidos, havendo o risco de ocorrência de complicações, incluindo infeção.

Advertências

- Este fio guia deve ser utilizado apenas por um médico com a formação completa no tratamento de IPP.
- Nunca utilize este fio guia em conjunto com cateteres que tenham peças de metal que possam entrar em contacto direto com a superfície deste fio guia (p. ex., cateteres de aterectomia, dilataadores metálicos), agulhas metálicas ou introdutores metálicos.
- Durante a utilização do fio guia, verificar e controlar o movimento da sua ponta sob fluoroscopia. Não utilize em áreas dos vasos que não sejam ou não possam ser visualizadas.
- Não ligue este fio guia a fios de extensão destacáveis disponibilizados por outros fabricantes além da ASAHI INTECC. Não manipule este fio guia enquanto o fio de extensão destacável estiver ligado. De contrário, o arame guia poderá ser danificado ou o fio de extensão destacável poderá ser separado não intencionalmente.
- Não modifique este fio guia sob nenhum pretexto.

Precauções

- Não utilize o fio guia após o prazo de validade indicado na etiqueta. Elimine qualquer fio guia que ultrapasse o prazo de validade.
- Os fios-guia são instrumentos delicados e devem ser manuseados com cuidado.
- Não utilize o fio guia se a embalagem estiver aberta ou danificada. Abra a embalagem diretamente antes da utilização do produto. Utilize uma técnica asséptica no manuseamento e utilização do fio guia.
- Mantenha sempre o fio guia no estado húmido para evitar danos no revestimento hidrófilo.
- Não limpe este fio guia utilizando uma solução orgânica como álcool.

- Após a utilização, elimine este fio guia, os acessórios e a embalagem com resíduos médicos, tomando as devidas medidas de prevenção para doenças infecciosas.
- Nunca empurre, force, retire ou rode este fio guia a ponto de sentir resistência. Rodar ou empurrar este fio guia quando sentir resistência pode provocar danos e/ou a separação da ponta deste fio guia ou lesões diretas num vaso. Não seguir estas indicações poderá causar danos a este fio guia. Determine a causa da resistência sob fluoroscopia e adote quaisquer medidas necessárias.
- Avance ou retire sempre o fio guia devagar e cuidadosamente.
- Ao rodar este fio guia dentro do vaso sanguíneo, não rode continuamente na mesma direção. Ao rodar o fio guia, faça-o alternadamente no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido inverso. Não exceda as duas rotações (720°) na mesma direção.
- Irrigue o fio guia com solução salina heparinizada e esterilizada ou outra solução adequada enquanto o remove e reinsere para evitar a entrada de ar no dispositivo de intervenção. Efetue a troca deste fio guia com cuidado para evitar a entrada de ar e/ou traumatismos. Ao reintroduzir o fio guia, confirme se a ponta do dispositivo de intervenção está desobstruída no lúmen do vaso e não está a incidir contra a parede do vaso. A não observação desta regra pode resultar em trauma. Utilize o marcador radiopaco do dispositivo de intervenção para confirmar a posição.
- A liberdade de movimentos do fio guia dentro do dispositivo de intervenção é uma característica importante de um sistema de fio guia orientável porque fornece ao utilizador informações tácteis úteis. Teste o sistema para verificar se apresenta resistência antes da utilização. Regule ou substitua a válvula hemostática por uma válvula regulável caso se considere que esta inibe os movimentos do fio guia.
- Não efetue a administração do stent utilizando mais de um fio guia ou operação com fio através

- de um suporte do stent. De contrário, o stent poderá danificar-se ou o fio guia poderá partir-se ou partir-se.
- Antes de utilizar, confirme que este fio guia tem o tamanho e formato apropriados para o procedimento e se é compatível com o dispositivo a ser utilizado em combinação.
- Consulte as Instruções de utilização anexadas ao dispositivo médico (p. ex., dispositivos terapêuticos intervencionais) usados em combinação com este fio guia.
- Quando ligar o fio de extensão destacável a este fio guia, deverá ser firmemente inserido até à linha divisória entre os segmentos não revestidos com PTFE e os segmentos revestidos com PTFE na extremidade proximal do fio guia. Se alguma anormalidade for encontrada na conexão, deixe de utilizar o fio guia imediatamente.
- Inspeccione cuidadosamente o fio guia para verificar se apresenta dobras, vincos ou outros danos antes da utilização e sempre que possível durante o procedimento. Não utilize o fio guia se este estiver danificado.
- Ao moldar a ponta, tenha cuidado para não danificar a bobina.
- Antes de inserir o fio guia, verifique qual é a extremidade distal e certifique-se de o inserir a partir da extremidade distal.
- Durante o procedimento, mantenha uma irrigação contínua com uma solução salina heparinizada e esterilizada entre o cateter guia e o dispositivo intervencional e entre o dispositivo intervencional e o fio guia. A irrigação evita a formação de cristais e/ou a coagulação do meio de contraste no fio guia e no lúmen do cateter.
- Para o suporte com tubo de proteção da extremidade distal (consulte Como utilizar, Figura 1), não remova ou insira o tubo de proteção da extremidade distal enquanto o fio guia estiver alojado no suporte.
- Para o suporte com tubo de proteção da extremidade distal (consulte Como utilizar, Figura 1), remova o tubo de proteção da extremidade distal antes de alojar novamente o fio guia no suporte.

1. Avarias

Quebra ou dobra do fio guia	Danos como separação	Saída do revestimento
-----------------------------	----------------------	-----------------------

2. Eventos adversos

Morte	Infeção	
Redução da pressão arterial	Complicações de hemorragia	Embolia
Enfarte	Oclusão vascular	Trombo
Isquemia	Arritmia	Dissecção do vaso
Vasoespasmso	Tonturas	Dor de cabeça
Vómitos	Perfuração do vaso	Reação alérgica

Como utilizar

1. Inspeção antes da respetiva utilização

- Antes da utilização, inspecione e confirme cuidadosamente se o fio guia e a embalagem não estão danificados.
- Antes da utilização, confirme se o fio guia é compatível com o dispositivo de intervenção a utilizar.

2. Preparativos

- Selecione o fio guia mais adequado para a área afetada e remova o tubo de suporte que contém o fio guia da embalagem esterilizada.
- Encha o tubo de suporte com solução salina

heparinizada e esterilizada utilizando, uma seringa para embeber o dispositivo completo. Tenha em atenção que a solução salina heparinizada e esterilizada pode derramar do tubo de suporte durante esta ação.

- Encha o lúmen do dispositivo de intervenção com a solução salina heparinizada e esterilizada antes de inserir o fio guia.
- Liberte o fio guia do clipe traseiro e faça-o deslizar lentamente, empurre a extremidade distal do fio guia através do tubo de suporte (B) (Figura 2).

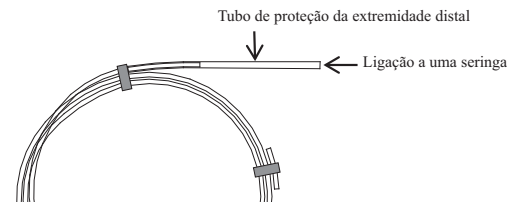


Figura 1

Avarias e eventos adversos

As possíveis avarias e eventos adversos resultantes da utilização deste fio guia incluem, sem carácter limitativo:

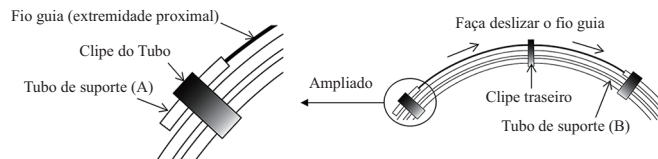


Figura 2

- e) Quando a extremidade distal do fio guia for superior a 5 a 6 cm para além da outra extremidade do tubo de proteção (ou o tubo de proteção da extremidade distal), caso seja necessário, deverá moldar a ponta em conformidade com a prática padrão.
- f) Segure gentilmente o fio guia que saiu da extremidade distal do tubo de proteção pela ponta, de modo a ficar o mais próximo possível do tubo de suporte, e puxe o fio guia lenta e cuidadosamente.
- g) Se sentir resistência ao remover o fio guia do tubo de suporte, volte a injetar a solução salina heparinizada e esterilizada no tubo de suporte. Continue a remover o fio guia depois de deixar de sentir resistência. Certifique-se de que injeta solução salina heparinizada e esterilizada suficiente no tubo de suporte, visto que o revestimento hidrófilo pode danificar-se ao remover o fio guia revestido com força excessiva.
- h) Depois de puxar o fio guia para fora do tubo de suporte, inspecione-o para garantir que não está danificado.

3. Procedimentos de inserção

- Sistema ao longo do fio
 - a) Insira a extremidade distal do fio guia cuidadosamente no lúmen do fio guia do dispositivo de intervenção.
 - b) Faça avançar este fio guia cuidadosamente até a ponta ficar proximal à ponta do dispositivo de intervenção.
 - c) Encaixe o cateter-guia e insira o sistema de dispositivo de intervenção (com o fio guia) no conector em Y.
 - d) Faça avançar o sistema de dispositivo de intervenção pelo cateter-guia até a ponta do sistema de fio guia ficar proximal à ponta do cateter-guia.
 - e) Aperte a válvula hemostática do conector

em Y para criar um isolamento em torno do dispositivo de intervenção. Certifique-se de que o fio guia ainda apresenta liberdade de movimentos.

- f) Certifique-se de que o fio guia se move sem obstruções.
- g) Coloque o dispositivo de rotação no fio guia, se necessário.
- h) Faça avançar este fio guia sob fluoroscopia para passar pela lesão. Através de angiografia, confirme se o fio guia passou pela lesão-alvo estreita.
- i) Observe o movimento do fio guia nos vasos.
- j) Faça avançar o dispositivo de intervenção até atingir a lesão, evitando que o fio guia se mova. Certifique-se de que a ponta distal do fio guia e a respetiva localização no vaso são visíveis durante as manipulações do dispositivo de intervenção.

- Sistema de troca rápida
 - a) Encaixe o cateter-guia.
 - b) Insira o introdutor do fio guia no conector em Y do cateter-guia.
 - c) Insira cuidadosamente a ponta do fio guia no introdutor.
 - d) Faça avançar o fio guia pelo cateter-guia sob fluoroscopia até a ponta do fio guia ficar proximal à ponta do cateter-guia.
 - e) Coloque o dispositivo de rotação no fio guia, se necessário.
 - f) Faça avançar o fio guia sob fluoroscopia para passar pela lesão. Através de angiografia, confirme se o fio guia passou pela lesão-alvo estreita.
 - g) Observe o movimento do fio guia nos vasos.
 - h) Remova o dispositivo de rotação do fio guia e o introdutor do fio guia.

- i) Localize o dispositivo de intervenção no fio guia evitando que este se mova e faça-o avançar até atingir a lesão. Certifique-se de que a ponta distal do fio guia e a respetiva localização no vaso são visíveis durante as manipulações do dispositivo de intervenção.

4. Procedimentos para trocar o fio guia

- Sistema ao longo do fio
 - a) Remova este fio guia lentamente enquanto monitoriza o movimento deste fio guia sob fluoroscopia.
 - b) Insira o fio guia seguinte de acordo com as instruções da secção “Procedimento recomendado”.

Método de armazenamento

Não mantenha o fio guia e a embalagem dobrados e/ou sob carga excessiva. Este fio guia e embalagem devem ser mantidos afastados de água. Guarde num local fresco, escuro e seco.

Data de validade

A data de validade é indicada na etiqueta da embalagem do fio guia.

Conteúdo

5 peças/caixa

Exoneração de responsabilidade

De modo algum deverá a “ASAHI INTECC CO., LTD. e a suas empresas afiliadas” (doravante designada como a “Empresa”) ser responsabilizada por acidentes, lesões pessoais, efeitos adversos devido ao uso inapropriado do(s) produto(s) ou outro uso inconsistente com estas instruções. Em circunstância alguma será a Empresa responsável por quaisquer danos (i) decorrentes do armazenamento do(s) produto(s) após a expedição por parte da Empresa ou (ii) devido à seleção dos doentes, técnicas cirúrgicas ou quaisquer outras intervenções médicas efetuadas pela instituição médica que utiliza o(s) produto(s).

“Gladius”, “Halberd”, “ASAHI Gaia” e “Astato” são marcas comerciais ou marcas registadas da ASAHI INTECC CO.,LTD. no Japão e noutros países.

*Os valores da carga da ponta representam os valores médios dos valores de especificação do produto medidos de acordo com o método de teste padrão interno, assumindo a força aplicada à lesão pela ponta do fio guia.

Alambre guía periférico

Instrucciones de uso

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar este alambre guía y cumpla con las secciones Indicaciones para el uso, Población tratada objetivo, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones y Procedimientos recomendados de estas Instrucciones de uso. Si no se hace de este modo, pueden surgir complicaciones, incluyendo lesiones graves del paciente o su muerte.

Si un usuario o paciente se entera de que ha ocurrido un incidente grave en relación con el alambre guía, informe el hecho al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro.

Estas Instrucciones de uso se aplican a Gladius, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Para ver los detalles (longitud del alambre guía, longitud de la sección radiopaca, etc.), consulte la etiqueta del producto.

Descripciones

La estructura básica de este alambre guía consiste en un alambre central cónico y dos tipos de espirales distales (una espiral exterior y una espiral interior). El alambre central cónico y las espirales están soldados. Una parte de toda la longitud de la espiral exterior es radiopaca, de modo que su posición puede confirmarse fácilmente mediante fluoroscopia. Los lados distales de Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 y ASAHI Gaia PV están recubiertos con polímero hidrófilo. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES y Gladius MG18 PV ES tienen un revestimiento de resina de poliuretano en la espiral exterior y un revestimiento hidrófilo encima de él. En todos estos alambres guía, el lado proximal del alambre central cónico está revestido de PTFE (politetrafluoroetileno). En el extremo proximal de los dispositivos que no tienen una longitud total de 300 cm, hay una conexión para un alambre de extensión, que se utiliza para reemplazar el dispositivo combinado; puede conectarse el alambre de extensión de ASAHI INTECC.

Consulte la siguiente tabla para ver la carga de la punta* de este producto.

Tabla 1. Especificaciones del producto

Nombre del producto	Diámetro exterior	Carga de la punta*
Gladius	0,36 mm (0,014 in)	3 gf
	0,45 mm (0,018 in)	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014 in)	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014 in)	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018 in)	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014 in)	12 gf
	0,45 mm (0,018 in)	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008 in/0,014 in)	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009 in/0,014 in)	40 gf
Astato 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013 in/0,018 in)	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014 in/0,018 in)	7,5 gf

Indicaciones para el uso

Este alambre guía está diseñado para la angioplastia periférica percutánea (APP) general. Este alambre guía está diseñado para facilitar la colocación de dispositivos terapéuticos de intervención dentro de la vasculatura periférica de la extremidad inferior.

Este alambre guía está diseñado solamente para usarse en la vasculatura periférica de la extremidad inferior. Este alambre guía no está diseñado para usarse en la neurovasculatura y la cardiovascular.

Población tratada objetivo

Este alambre guía está diseñado para pacientes que cumplen con las indicaciones para los procedimientos de APP. No está indicado para usarse en neonatos, bebés pequeños o niños, ni en pacientes embarazadas, con disfunción renal alterada o que tienen una reacción alérgica a los medios de contraste o al polietilenglicol (PEG).

Contraindicaciones

- Confirme la compatibilidad del diámetro del alambre guía con el de otro dispositivo quirúrgico antes de su uso real.
- No utilice el alambre guía en pacientes que presenten una reacción alérgica a los medios de contraste o que tengan disfunción renal alterada.
- Este alambre guía contiene PEG400 en su revestimiento hidrófilo. No utilice el alambre guía en pacientes que presenten reacciones alérgicas a polietilenglicol (PEG).
- No utilice el alambre guía en pacientes embarazadas o que puedan estarlo (los rayos X podrían afectar el feto).
- Este alambre guía se debe utilizar en lugares donde se pueda realizar de modo inmediato una operación quirúrgica de emergencia. Si no se puede ejecutar una operación quirúrgica de emergencia, en el peor de los casos, pueden producirse situaciones en las que se ponga en peligro la vida.
- Este alambre guía está esterilizado previamente con gas de óxido de etileno (EOG), habiéndose concebido solo para un único uso. No lo vuelva a utilizar ni a esterilizar. Si se reutiliza o se vuelve a esterilizar, el rendimiento o la calidad de este alambre guía y paquete puede verse afectada y existen riesgos de complicaciones, incluida una infección.

Advertencias

- Solo un médico completamente capacitado en tratamiento de APP debe usar este alambre guía.
- Nunca use este alambre guía en combinación con catéteres que tengan partes metálicas que puedan entrar en contacto directo con la superficie de este alambre guía (por ejemplo, catéteres de aterectomía, dilataadores de metal), agujas de metal o introductores de metal.
- Durante el uso del alambre guía, verifique y controle el movimiento de esta punta bajo fluoroscopia. No lo utilice en zonas de vasos que no se visualicen o no se puedan visualizar.
- No conecte este alambre guía con alambres de extensión desmontables producidos por fabricantes distintos a ASAHI INTECC. No manipule este alambre guía mientras se encuentra conectado el alambre de extensión desmontable. En caso contrario, el alambre guía puede resultar dañado o se puede desacoplar accidentalmente el alambre de extensión desmontable.
- No modifique este alambre guía bajo ninguna circunstancia.

Precauciones

- No utilice el alambre guía después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta.
- Los alambres guía son instrumentos delicados y Deseche cualquier alambre guía después de su fecha de caducidad. se deben manejar con cuidado.

- Si el envase está abierto o deteriorado, no utilice el alambre guía. No abra el envase hasta inmediatamente antes de proceder a su uso. Utilice técnicas asépticas en la manipulación y el empleo del alambre guía.
- Siempre mantenga el alambre guía en estado húmedo para evitar daños en su revestimiento hidrófilo.
- No limpie este alambre guía con una solución orgánica, como alcohol.
- Después de usar este alambre guía, sus accesorios y el paquete, descártelos como desechos médicos tomando medidas preventivas contra enfermedades infecciosas.
- No empuje, taladre, retire, ni presione nunca este alambre guía cuando note resistencia. Torsionar o empujar este alambre guía contra una resistencia puede dañar o separar la punta de este alambre guía o dañar directamente un vaso. Si no se hace de este modo, podría dañarse el alambre guía. Determine la causa de la resistencia bajo fluoroscopia y tome las medidas necesarias.
- Siempre haga avanzar o retire el alambre guía de manera lenta y cuidadosa.
- Al girar este alambre guía en el interior del vaso sanguíneo, no proceda a su rotación continua en el mismo sentido. Al girar el alambre guía, rótelo en sentido horario y antihorario de forma alternativa. No gire más de dos vueltas (720°) en la misma dirección.
- Rocíe el alambre guía con una solución salina esterilizada y heparinizada o de otro tipo adecuado al proceder a la retirada y a la reintroducción para evitar que entre aire en el dispositivo quirúrgico. Tenga cuidado al cambiar este alambre guía para evitar que entre aire o que se produzcan traumatismos. Al reintroducir el alambre guía, confirme que la punta del dispositivo quirúrgico se encuentra libre en el vaso y no se apoya contra la pared del mismo. Si no se hace de este modo, se puede provocar un traumatismo. Utilice el marcador radiopaco del dispositivo quirúrgico para confirmar la posición.
- El movimiento libre del alambre guía dentro del dispositivo quirúrgico es una característica importante de un sistema de alambre guía direccionable, ya que da al usuario una información táctil valiosa. Pruebe la resistencia del sistema antes de utilizarlo. Ajuste o cambie la válvula hemostática con una válvula

- regulable si observa que inhibe el movimiento del alambre guía.
- No proceda a la colocación de un stent empleando más de un alambre guía ni a la operación del alambre a través del tirante de un stent. En caso contrario, el stent puede resultar dañado o el alambre guía se podría romper o quedar inservible.
 - Antes de utilizarlo, confirme que este alambre guía es adecuado en tamaño y forma para el procedimiento y compatible con el dispositivo que se utilizará en combinación.
 - Consulte las Instrucciones de uso adjuntas al dispositivo médico (por ejemplo, dispositivos terapéuticos de intervención) que se usará en combinación con este alambre guía.
 - Al conectar el alambre de extensión desmontable con este alambre guía, se debe insertar firmemente en la línea límite que se encuentra entre los revestimientos de PTFE y distinto a PTFE en el extremo proximal del alambre guía. Si se encuentra alguna anomalía en la conexión, deje de usar el alambre guía inmediatamente.
 - Revise el alambre guía atentamente por si tiene dobleces, torceduras, u otro daño, antes de utilizarlo y siempre que sea posible durante el procedimiento. No utilice el alambre guía si está dañado.
 - Al conformar la punta, tenga cuidado de no dañar la espiral.
 - Antes de insertar el alambre guía, verifique cuál es el extremo distal y asegúrese de insertarlo desde el extremo distal.
 - Mantenga un flujo salino heparinizado y esterilizado continuo entre el catéter guía y el dispositivo de intervención y entre el dispositivo de intervención y el alambre guía durante el procedimiento. El flujo evita la formación de cristales o la coagulación en los medios de contraste en el alambre guía y en la luz del catéter.
 - Para el sujetador con el tubo de protección del extremo distal (consulte Procedimientos recomendados, figura 1), no retire o inserte el tubo de protección del extremo distal mientras el alambre guía esté colocado en el sujetador.
 - Para el sujetador con el tubo de protección del extremo distal (consulte Procedimientos recomendados, figura 1), retire el tubo de protección del extremo distal antes de volver a colocar el alambre guía en el sujetador.

Fallos de funcionamiento y efectos adversos

Se pueden producir posibles fallos de funcionamiento y efectos adversos en el uso de este alambre guía, entre los que se encuentran los siguientes:

1. Fallos de funcionamiento

Rotura o curvatura del alambre guía	Daños como la separación	Desprendimiento del revestimiento
Muerte	Infección	
Reducción de la presión arterial	Complicaciones de hemorragia	Embolia
Infarto	Oclusión vascular	Trombo
Isquemia	Arritmia	Vessel dissection
Vasoespasmio	Mareo	Dolor de cabeza
Vómitos	Perforación del vaso	Reacción alérgica

2. Efectos adversos

Procedimientos recomendados

1. Inspección antes de utilizarlo

- Antes de utilizarlo, revise atentamente y confirme que ningún alambre guía o paquete está dañado.
- Antes de utilizarlo, confirme que el alambre guía sea compatible con los dispositivos quirúrgicos que se utilizarán.

2. Preparación

- Seleccione el alambre guía más adecuado para el área afectada y retire el tubo sujetador que contiene el alambre guía del paquete estéril.
- Rellene el tubo sujetador con una solución salina esterilizada y heparinizada empleando una jeringuilla para empapar el dispositivo en su conjunto. Tenga en cuenta que la solución salina esterilizada y heparinizada se puede derramar del tubo sujetador en este momento.
- Rellene la luz del dispositivo quirúrgico con solución salina esterilizada y heparinizada antes de insertar de nuevo la guía.
- Suelte la guía del clip de cola y deslicela lentamente, presione el extremo distal de la guía a través del tubo sujetador (B) (Figura 2).

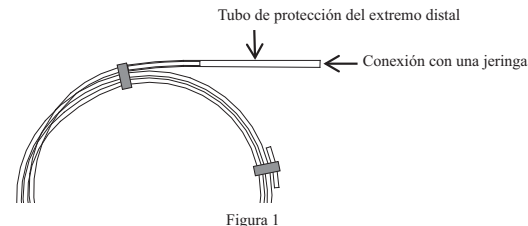


Figura 1

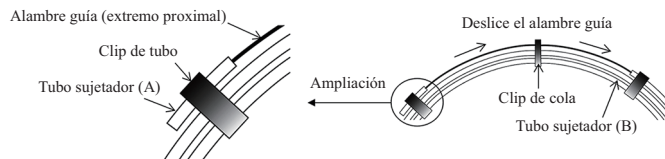


Figura 2

- e) Cuando el extremo distal del alambre guía se extienda entre 5 y 6 cm más allá del otro extremo del tubo sujetador (o el tubo de protección del extremo distal), de ser necesario, conforme la punta de acuerdo con la práctica estándar.
- f) Sujete suavemente, por el punto más cercano posible al tubo sujetador, el alambre guía que sale del extremo distal del tubo sujetador (o el tubo de protección del extremo distal), y extraiga el alambre guía lenta y cuidadosamente.
- g) Si se siente resistencia al extraer el alambre guía del tubo sujetador, inyecte de nuevo una solución salina esterilizada y heparinizada en el tubo sujetador. Continúe extrayendo el alambre guía cuando haya dejado de percibirse la resistencia. Asegúrese de inyectar suficiente solución salina esterilizada y heparinizada en el tubo sujetador, debido a que el revestimiento hidrófilo puede dañarse al extraer con fuerza el alambre guía.
- h) Después de sacar el alambre guía del tubo sujetador, compruebe que no esté dañado.

3. Procedimientos de inserción

- Sistema del alambre
 - a) Inserte el extremo distal del alambre guía con cuidado en la luz del alambre guía del dispositivo quirúrgico.
 - b) Avance este alambre guía con cuidado hasta que su punta esté inmediatamente próxima a la punta del dispositivo quirúrgico.
 - c) Meta el catéter guía e inserte el sistema del dispositivo quirúrgico (con el alambre guía) en el conector en Y.
 - d) Avance el sistema del dispositivo quirúrgico a lo largo del catéter guía hasta que la punta del sistema del alambre guía

esté inmediatamente próxima a la punta del catéter guía.

- e) Apriete la válvula hemostática del conector en Y para cerrar herméticamente alrededor del dispositivo quirúrgico. Compruebe que aún se pueda mover el alambre guía.
- f) Asegúrese de que el alambre guía se mueva sin problemas.
- g) Si es necesario, sujete el dispositivo de torsión al alambre guía.
- h) Avance este alambre guía bajo fluoroscopia para que pase por la lesión. Confirme por angiografía que el alambre guía ha pasado la lesión objetivo más estrecha.
- i) Observe el movimiento del alambre guía en los vasos.
- j) Avance el dispositivo quirúrgico hasta que alcance la lesión mientras que evita que se mueva el alambre guía. Asegúrese de que la punta distal del alambre guía y su posición en el vaso estén visibles durante las manipulaciones del dispositivo quirúrgico.

■ Sistema de intercambio rápido

- a) Meta el catéter guía.
- b) Inserte el introductor del alambre guía en el conector en Y del catéter guía.
- c) Conecte con cuidado la punta del alambre guía en el introductor.
- d) Avance el alambre guía a lo largo del catéter guía bajo fluoroscopia hasta que la punta del alambre guía esté inmediatamente próxima a la punta del catéter guía.
- e) Si es necesario, sujete el dispositivo de torsión al alambre guía.
- f) Avance el alambre guía bajo fluoroscopia para que pase por la lesión. Confirme por angiografía que el alambre guía ha pasado

- la lesión objetivo más estrecha.
- g) Observe el movimiento del alambre guía en los vasos.
- h) Extraiga el dispositivo de torsión del alambre guía y el introductor del alambre guía.
- i) Siga al dispositivo quirúrgico por el alambre guía mientras evita que este se mueva, y avance hasta que alcance la lesión. Asegúrese de que la punta distal del alambre guía y su posición en el vaso

estén visibles durante las manipulaciones del dispositivo quirúrgico.

4. Procedimientos para cambiar el alambre guía
 - Sistema del alambre
 - a) Extraiga este alambre guía despacio mientras controla su movimiento bajo fluoroscopia.
 - b) Inserte el siguiente alambre guía siguiendo las instrucciones de la sección Procedimientos recomendados.

Método de conservación

No conserve la guía y el envase doblados ni soportando cargas pesadas. Esta guía y su envase se deben mantener alejados del agua. Proceda a su almacenamiento en un lugar fresco, oscuro y seco.

Fecha de caducidad

La fecha de caducidad se indica en la etiqueta del envase del alambre guía.

Contenido

5 unidades/caja

Exención de responsabilidad

“ASAHI INTECC CO., LTD. y sus empresas afiliadas” (en adelante, “la Compañía”) no se hace responsable bajo ningún concepto por accidentes, heridas personales, efectos adversos debido al mal uso de cualquier índole del producto o de los productos, o cualquier uso que no observe estas instrucciones. En ningún caso la Compañía será responsable por daños (i) procedentes de la conservación de los productos una vez enviados por la Compañía o (ii) debidos a la selección de pacientes, técnicas quirúrgicas o cualquier otra actividad médica de la institución médica que utilice los productos.

“Gladius”, “Halberd”, “ASAHI Gaia” y “Astat” son marcas comerciales o marcas registradas de ASAHI INTECC CO., LTD. en Japón y otros países.

* Los valores de carga de la punta representan los valores medios de los valores de especificación del producto medidos de acuerdo con el método interno de prueba estándar que asume la fuerza que la punta del alambre guía aplica a la lesión.

Perifer ledare

Bruksanvisning

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder denna ledare och se avsnitten om indikationer, behandlad målpopulation, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och användning i denna bruksanvisning. Om instruktionerna inte följs kan det leda till komplikationer inklusive allvarliga personskador för patienten eller till och med dödsfall.

Om en användare och/eller patient får kännedom om en allvarlig incident som har inträffat i samband med ledaren ska detta rapporteras till tillverkaren och medlemsstatens behöriga myndighet.

Denna bruksanvisning gäller för Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Detaljerad information (ledarens längd, längd på röntgentät del, osv.), anges på produktens etikett.

Beskrivningar

Ledarens grundläggande struktur består av en konisk kärntråd och två typer av distala spolar (en yttre spole och en inre spole). Den koniska kärntråden och spolarna är lödda. En partiell längd av den yttre spolen är röntgentät så att dess position enkelt kan bekräftas under fluoroskopi. De distala sidorna på Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 och ASAHI Gaia PV är belagda med hydrofil polymer. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES och Gladius MG18 PV ES har en polyuretanhartsbeläggning på den yttre spolen och en hydrofil beläggning ovanpå den. I alla dessa ledare är den proximala sidan av den koniska kärntråden belagd med PTFE (polytetrafluoretylen). Vid den proximala änden på enheterna, förutom de som har en längd kortare än 300 cm, finns en anslutning för en förlängningskabel som används för att ersätta den kombinerade enheten. ASAHI INTECC:s förlängningskabel kan anslutas.

Se nedanstående tabell för spetsbelastning* för denna produkt.

Tabell 1 Produktspecifikationer

Produktnamn	Ytterdiameter	Spetsbelastning*
Gladius	0,36 mm (0,014 tum)	3 gf
	0,45 mm (0,018 tum)	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014 tum)	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014 tum)	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018 tum)	3 gf
	0,36 mm (0,014 tum)	12 gf
Halberd	0,45 mm (0,018 tum)	12 gf
	0,20 mm/0,36 mm (0,008 tum/0,014 tum)	20 gf
Astato XS 20	0,23 mm/0,36 mm (0,009 tum/0,014 tum)	40 gf
Astato XS 40	0,33 mm/0,45 mm (0,013 tum/0,018 tum)	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014 tum/0,018 tum)	7,5 gf

Indikationer

Denna ledare är avsedd för allmän perkutan perifer intervention (PPI). Denna ledare är avsedd att underlätta placeringen av interventionella terapeutiska enheter i perifera kärl i de nedre extremiteterna. Denna ledare är endast avsedd för användning i perifera kärl i den nedre extremiteten. Denna ledare är inte avsedd för användning i neurovaskulaturen och kardiovaskulaturen.

Mål behandlad population

Denna ledare är avsedd för patienter som uppfyller indikationer för PPI-ingrepp. Den är inte indicerad för användning på nyfödda, spädbarn eller barn samt patienter som är gravida, har nedsatt njurfunktion och som har en allergisk reaktion mot kontrastmedel eller polyetylen glykol (PEG).

Kontraindikationer

- Bekräfta ledarens diameter är kompatibel med annan interventionsanordning före faktisk användning.
- Använd inte ledaren i patienter som har en allergisk reaktion mot kontrastmedel eller som har nedsatt njurfunktion.
- Denna ledare innehåller PEG400 i sin hydrofila beläggning. Använd inte ledaren i patienter som har allergiska reaktioner mot polyetylen glykol (PEG).
- Använd inte ledaren för gravida patienter eller patienter som kan vara gravida (röntgen kan påverka fostret).
- Denna ledare måste användas på en institution där det finns omedelbar tillgång till nödkirurgi. Om det inte finns tillgång till nödkirurgi kan det i värsta fall uppstå livshotande situationer.
- Denna ledare är försteriliserad med etylenoxidgas (EOG) och endast avsedd för engångsbruk. Får inte återanvändas eller omsteriliseras. Om den återanvänds eller steriliseras på nytt kan ledarens och förpackningens prestanda eller kvalitet försämrats vilket ger en risk för komplikationer, inklusive infektion.

Varningar

- Denna ledare får endast användas av en läkare som är fullt utbildad i PPI-behandling.
- Använd aldrig denna ledare i kombination med katetrar som har metalldelar som kan komma i direkt kontakt med ytan på denna ledare (t.ex. aterektomikatetrar, metalldilatorer), metallnålar eller metallinförare.
- Vid användning av ledaren ska du kontrollera och övervaka rörelsen av dess spets under fluoroskopi. Använd inte i kärlområden som inte är visualiserade eller inte kan visualiseras.
- Anslut inte denna ledare till en avtagbar förlängningsledare tillverkad av en annan producent än ASAHI INTECC. Manipulera inte denna ledare när den löstagbara förlängningsledaren är ansluten. Detta kan annars leda till att ledaren skadas eller att den avtagbara förlängningsledaren lossnar.
- Modifiera inte ledaren av något skäl.

Försiktighetsåtgärder

- Använd inte ledaren efter utgångsdatumet på etiketten. Kassera alla ledare som har passerat utgångsdatumet.
- Ledare är ömtåliga instrument och ska hanteras försiktigt.
- Använd inte ledaren om förpackningen är öppen eller skadad. Öppna inte förpackningen förrän alldeles innan produkten ska användas. Använd användning och vidta förebyggande åtgärder aseptisk teknik vid hantering och användning av ledaren.
- Förvara alltid ledaren i vått tillstånd för att förhindra skador på dess hydrofila beläggning.
- Torka inte av ledaren med en organisk lösning, t.ex. alkohol.
- Avyttra denna ledare med tillbehör och alldeles innan produkten ska användas. Använd användning och medicinskt avfall efter mot infektionssjukdomar.

- Du får aldrig trycka, borra, dra tillbaka eller vrida denna ledare vid motstånd. Om ledaren förs in eller trycks mot motstånd kan det orsaka skador på spetsen och/eller leda till att spetsen lossnar från ledaren eller orsaka direkta skador på ett kärl. Underlåtenhet att göra så kan orsaka skada på ledaren. Fastställ orsaken till motståndet under fluoroskopi och vidta alla nödvändiga korrigerande åtgärder.
- För alltid in eller dra tillbaka ledaren långsamt och försiktigt.
- När ledaren vrids inuti blodkärlet ska den inte vridas i samma riktning hela tiden. Roter ledaren medurs och moturs om vartannat när du vrider den. Roter inte mer än två varv (720°) i samma riktning.
- Spola ledaren med steril hepariniserad koksaltlösning eller annan lämplig lösning när den dras ut eller förs in för att förhindra att det tränger in luft i interventionsinstrumentet. Byten av ledaren ska utföras försiktigt för att förhindra trauma och/eller att det tränger in luft. När ledaren förs in igen är det viktigt att säkerställa att interventionsinstrumentets spets är fri inom kärlets lumen och att den inte ligger mot kärlets vägg. Om du inte gör detta kan det orsaka trauma. Använd interventionsinstrumentets röntgentäta markör för att bekräfta positionen.
- Ledarens fria rörelse inuti interventionsinstrumentet är en viktig funktion i ett styrbart ledarsystem eftersom det ger användaren värdefull känselinformation. Testa systemet för motstånd före användning. Justera eller ersätt hemostasventilen med en justerbar ventil om den förhindrar ledarens rörelse.
- Placera inte stenten med hjälp av mer än en ledare eller ledar användning genom stentstödet. Detta kan annars leda till att stenten skadas eller att ledaren bryts av eller går sönder.

Funktionsfel och biverkningar

Möjliga funktionsfel och biverkningar som kan uppstå vid användning av denna ledare inkluderar, men är inte begränsade till följande:

1. Funktionsfel

Brott eller böjning av ledaren	Skador såsom separation	Kommer av beläggningen
--------------------------------	-------------------------	------------------------

2. Biverkningar

Dödsfall	Infektion
----------	-----------

- Kontrollera innan användning att ledaren har en lämplig storlek och form för proceduren och är kompatibel med enheten som den ska användas med.
- Se bruksanvisningen som bifogas den medicinska enhet (t.ex. terapeutiska interventionsenheter) som ska användas i kombination med denna ledare.
- Vid anslutning av den löstagbara förlängningskabeln till ledaren bör den föras in säkert till gränslinjen mellan icke-PTFE-höljet och PTFE-höljet i den proximala änden av ledaren. Om någon avvikelse upptäcks i anslutningen så ska du omedelbart sluta använda ledaren.
- Inspektera ledaren noggrant för böjningar, veck eller andra skador före användning och när det är möjligt under proceduren. Använd inte ledaren om den är skadad.
- När du formar spetsen ska du vara försiktig så att du inte skadar spolen.
- Innan du för in ledaren ska du ta reda på vilken ände som är den distala änden och se till att föra in den från den distala änden.
- Upprätthåll en kontinuerlig spolning med hepariniserad och steriliserad saltlösning mellan styrkatetern och interventionsenheten och mellan interventionsenheten och ledaren under proceduren. Spolning förhindrar bildandet av kontrastmedelskristaller och/eller koagulering på ledaren och i kateterlumen.
- För hållaren med skyddstuben för den distala änden (se Användning, figur 1), ta inte bort eller sätt inte in skyddstuben för den distala änden medan ledaren är placerad i hållaren.
- För hållaren med skyddstuben för den distala änden (se Användning, figur 1), ta bort skyddstuben för den distala änden innan du placerar styrtråden i hållaren igen.

Blodtryckssänkning

Infarkt

Ischemi

Vasospasm

Kräkningar

Blödningskomplikationer

Vaskulär tilltäppning

Arytmi

Yrsel

Kärlperforering

Embolism

Trombos

Kärldissektion

Huvudvärk

Allergisk reaktion

Användning

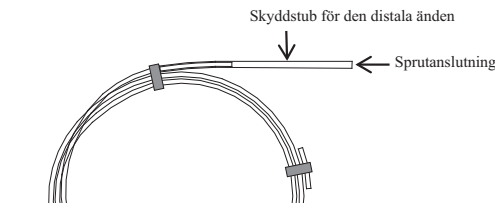
1. Inspektion innan användning

- Kontrollera noggrant att ledaren och förpackningen är oskadade före användning.
- Bekräfta att ledaren är kompatibel med interventionsinstrumentet som ska användas före användning.

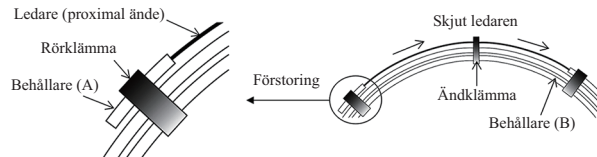
2. Förberedelse

- Välj den lämpligaste ledaren för det drabbade området och avlägsna behållaren som innehåller ledaren från den sterila förpackningen.

- Fyll behållaren med steril hepariniserad koksaltlösning med hjälp av en spruta för att blöta hela utrustningen. Tänk på att steril hepariniserad koksaltlösning kan rinna över ur behållaren när du gör detta.
- Fyll lumen på interventionsinstrumentet med steril hepariniserad koksaltlösning innan ledaren förs in.
- Lösa ledaren från ändklämma och skjut ledaren långsamt framåt. Tryck ledarens distala ände genom behållaren (B) (figur 2).



Figur 1



Figur 2

- När ledarens distala ände sticker ut 5 till 6 cm bortom den andra änden av hållartuben (eller skyddstuben för den distala änden), forma vid behov spetsen i enlighet med vanlig praxis.
- Greppa försiktigt ledaren som sticker ut ur

- den distala änden av hållartuben (eller skyddstuben för den distala änden), vid spetsen så nära hållartuben som möjligt och dra sakta och försiktigt ut ledaren.
- Om du känner ett motstånd när ledaren tas ut

behållaren så injicerar du steril hepariniserad koksaltlösning i behållaren igen. Fortsätt att ta bort ledaren när du inte längre känner motståndet. Se till att injicera tillräckligt med steril hepariniserad koksaltlösning i behållaren eftersom den hydrofila beläggningen kan skadas om den ytbehandlade ledaren dras ut med våld.

- h) När ledaren har dragits ut ur den rörformiga behållaren ska den inspekteras för att kontrollera att den inte är skadad.

3. Procedur för insättning

- System med införsel via ledare
 - a) För in den distala änden av ledaren försiktigt i ledarlumen för interventionsinstrumentet.
 - b) För fram ledaren försiktigt tills dess spets befinner sig precis proximalt i relation till interventionsinstrumentets spets.
 - c) Anslut ledarkatetern och för in interventionsinstrumentsystemet (med ledare) i Y-anslutningen.
 - d) För fram interventionsinstrumentsystemet genom ledarkatetern tills spetsen för ledarsystemet befinner sig precis proximalt i relation till spetsen för ledarkatetern.
 - e) Stäng Y-anslutningens hemostasventil för att skapa en försegling runt interventionsinstrumentet. Säkerställ att det fortfarande går att röra ledaren.
 - f) Kontrollera att det är möjligt att röra ledaren friktionsfritt.
 - g) Fäst den medföljande vridenheten vid ledaren vid behov.
 - h) För in ledaren under fluoroskopi för att passera genom lesionsområdet. Bekräfta via angiografi att ledaren har passerat det förträngda lesionsområdet.

- i) Observera ledarens rörelse i kärlen.
- j) För in interventionsinstrumentet tills lesionsområdet nås samtidigt som rörelse av ledaren förhindras. Säkerställ att ledarens distala spets och dess läge i kärlet är synliga under manipulering av interventionsinstrumentet.

■ System för snabbt byte

- a) Anslut ledarkatetern.
- b) För in ledarens införsare i ledarkateterns Y-anslutning.
- c) För försiktigt in ledarens spets i införsaren.
- d) För in ledaren genom ledarkatetern under fluoroskopi tills ledarens spets befinner sig precis proximalt i relation till ledarkateterns spets.
- e) Fäst den medföljande vridenheten vid ledaren vid behov.
- f) För in ledaren under fluoroskopi för att passera genom lesionsområdet. Bekräfta via angiografi att ledaren har passerat det förträngda lesionsområdet.
- g) Observera ledarens rörelse i kärlen.
- h) Avlägsna ledarens vridenhet och införsare.
- i) För interventionsinstrumentet över ledaren samtidigt som rörelse av ledaren förhindras, tills lesionsområdet nås. Säkerställ att ledarens distala spets och dess läge i kärlet är synliga under manipulering av interventionsinstrumentet.

4. Procedurer för byte av ledaren

- System med införsel via ledare
 - a) Avlägsna ledaren långsamt, samtidigt som ledarens rörelser övervakas via fluoroskopi.
 - b) För in nästa ledare i enlighet med anvisningarna i avsnittet "Användning".

Ansvarsfriskrivning

Under inga omständigheter är "ASAHI INTECC CO., LTD. och dess dotterbolag" (kallas nedan för "Företaget") ansvarig för olyckor, personsador, biverkningar som beror på felaktig användning av produkten/produkterna eller annan användning oförenlig med dessa instruktioner. I inget fall ska Företaget hållas ansvarigt för skador som antingen (i) uppstår från förvaring av produkten/produkterna efter transport från Företaget eller (ii) inträffar på grund av patientval, operationstekniker eller någon annan medicinsk aktivitet av den sjukvårdsinrättning som använder produkten/produkterna.

"Gladius", "Halberd", "ASAHI Gaia" och "Astato" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ASahi INTECC CO., LTD. i Japan och andra länder.

*Spetsbelastningsvärden representerar medelvärdena för produktspecifikationsvärden som är uppmätta enligt den interna standardtestmetoden under antagande av den kraft som appliceras på lesionen av styrtrådsspetsen.

Förvaring

Ledaren och förpackningen får inte förvaras böjd och/eller utsättas för stor belastning vid förvaring. Denna ledare och förpackning ska skyddas mot vatten. Förvara den på en sval, mörk och torr plats.

Utgångsdatum

Utgångsdatumet anges på etiketten på ledarens förpackning.

Innehåll

5 stycken/ask

Periferní vodící drát

Návod k použití

Před použitím tohoto vodícího drátu si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte pokyny v částech Indikace pro použití, Cílová léčená populace, Kontraindikace, Upozornění, Bezpečnostní pokyny a části Doporučený postup při použití v tomto návodu k použití. V opačném případě může dojít ke komplikacím, včetně závažného poranění pacienta nebo smrti.

Pokud se uživatel a/nebo pacient dozví o závažné události, ke které došlo v souvislosti s vodícím drátem, oznámte tuto skutečnost výrobci a příslušnému orgánu členského státu.

Tento návod k použití platí pro Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Detailní charakteristiku (délku vodícího drátu, délku radiokontrastní části atd.) naleznete na štítku na obalu výrobku.

Popis

Základní struktura tohoto vodícího drátu se skládá z kuželového drátu a dvou typů distálních cívek (vnější a vnitřní cívka). Kuželový drát a cívky jsou pájené. Část nebo celá délka vnější cívky je radiopřůhledná, takže její polohu lze snadno potvrdit při fluoroskopii. Distální strany u Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 a ASAHI Gaia PV jsou potaženy hydrofilním polymerem. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES a Gladius MG18 PV ES mají na vnější cívce povlak z polyuretanové pryskyřice a na něm hydrofilní povlak. U všech těchto vodících drátů je proximální strana kuželového drátu potažena PTFE (polytetrafluorethylenem). Na proximálním konci jiných zařízení než těch s celkovou délkou 300 cm je přípojka pro prodlužovací drát, který se používá k nahrazení kombinovaného zařízení; lze připojit prodlužovací drát ASAHI INTECC. Zatížení špičky* tohoto výrobku je uvedeno v tabulce níže.

Tabulka 1. Specifikace produktu

Název produktu	Vnější průměr	Zatížení špičky*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014")	12 gf
	0,45 mm (0,018")	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm / 0,36 mm (0,008" / 0,014")	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm / 0,36 mm (0,009" / 0,014")	40 gf
Astato 30	0,33 mm / 0,45 mm (0,013" / 0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm / 0,45 mm (0,014" / 0,018")	7,5 gf

Indikace pro použití

Tento vodící drát je určen pro všeobecné perkutánní periferní intervence (PPI). Tento vodící drát je určen k usnadnění umísťování intervenčních terapeutických zařízení do periferních cév dolní končetiny. Tento vodící drát je určen pouze pro použití v periferních cévách dolní končetiny. Tento vodící drát není určen pro použití v neurovaskulatuře a kardiovaskulatuře.

Cílová léčená populace

Tento vodící drát je určen pro pacienty, kteří splňují indikace k zákroku PPI. Není indikován k použití u novorozenců, kojenců nebo dětí a u pacientů, kteří jsou těhotní, mají poruchu funkce ledvin a alergickou reakci na kontrastní látku nebo polyetylenyglykol (PEG).

Kontraindikace

- Před vlastním použitím ověřte kompatibilitu průměru vodícího drátu s jiným intervenčním zařízením.
 - Nepoužívejte vodící drát u pacientů, kteří jsou alergičtí na kontrastní látku, nebo u pacientů s dysfunkcí ledvinou.
 - Tento vodící drát obsahuje ve svém hydrofilním povlaku PEG400. Vodící drát nepoužívejte u pacientů, kteří jsou alergičtí na Polyethylenyglykol (PEG).
 - Vodící drát nepoužívejte u těhotných pacientek ani pacientek, které mohou být těhotné (rentgenové záření může ovlivnit plod).
 - Tento vodící drát je nutné používat pouze ve zdravotnickém zařízení, které disponuje
- možností hned provést akutní chirurgický zákrok. Pokud není možnost provést akutní chirurgický zákrok, v nejhorším případě může dojít k příhodám ohrožujícím pacienta na životě.
- Vodící drát je předem sterilizován plyným ethylenoxidem (EOG) a je určen na jedno použití. Nepoužívejte jej opakovaně ani neprovádějte opakovanou sterilizaci. V případě opakovaného použití nebo sterilizování vodícího drátu může být snížena jeho funkčnost nebo kvalita a může dojít ke komplikacím, včetně infekce.

Upozornění

- Tento vodící drát smí používat pouze lékař, který je plně vyzkolen v léčbě PPI.
- Nikdy nepoužívejte tento vodící drát v kombinaci s katétry s kovovými částmi, které se mohou přímo dotýkat povrchu tohoto vodícího drátu (např. atereotomické katétry, kovové dilatátory), kovovými jehlami nebo kovovými zaváděči.
- Během používání vodícího drátu kontrolujte a sledujte pohyb jeho špičky pod skiaskopickou kontrolou. Nepoužívejte v oblastech, které nejsou viditelné nebo je zviditelnit nelze.
- Vodící drát nepřipojujte k odnímatelným prodlužovacím drátům vyráběným jinými výrobci než společností než ASAHI INTECC. Vodícím drátem nemanipulujte, když je připojen odnímatelný prodlužovací drát. Jinak může dojít k poškození vodícího drátu nebo neúmyslnému uvolnění odnímatelného prodloužení.
- V žádném případě vodící drát neupravujte.

Bezpečnostní pokyny

- Vodící drát nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeného na štítku. Po datu použitelnosti je nutné vodící drát zlikvidovat.
 - Vodící dráty jsou jemné nástroje a je nutné s nimi pracovat opatrně.
 - Pokud je balení otevřeno nebo poškozeno, vodící drát nepoužívejte. Obal otevřete až
- bezprostředně před použitím. Při manipulaci s vodícím drátem dodržujte aseptické podmínky.
- Vodící drát udržujte vždy vlhký, aby nedošlo k poškození jeho hydrofilního povlaku.
 - Vodící drát neteřteje organickými roztoky (jako např. alkohol).

- Po použití zlikvidujte tento vodící drát, příslušenství a obal jako zdravotnický odpad a proveďte preventivní opatření proti infekčním chorobám.
- Nikdy netlačte, nevytahujte ani nekruťte nebo nesazte vrtat vodícím drátem, který narazil na odpor. Kroucení nebo zatlačování vodícího drátu proti odporu může vést k poškození nebo oddělení špičky vodícího drátu nebo přímému poškození cévy. V opačném případě může dojít k poškození tohoto vodícího drátu. Skiaskopem zjistěte důvod odporu a proveďte veškeré potřebné nápravné akce.
- Vodící drát vždy posouvejte nebo vytahujte pomalu a opatrně.
- Při rotaci vodícího drátu uvnitř krevní cévy neotáčejte stále ve stejném směru. Při rotaci vodícího drátu jím otáčejte střídavě ve směru a proti směru hodinových ručiček. Neotáčejte o více než dvě otočení (do 720°) ve stejném směru.
- Při vyjímání a opakovaném zavádění vodící drát propláchněte heparinizovaným sterilním fyziologickým roztokem nebo jinou vhodnou tekutinou, aby se zabránilo vniknutí vzduchu do intervenčního zařízení. Při výměně vodícího drátu postupujte opatrně, aby do systému nevnikl vzduch nebo nedošlo k poranění. Při opakovaném zavádění vodícího drátu se ujistěte, že je špička intervenčního zařízení volně umístěna v lumen cévy a nenaléhá na její stěnu. Jinak může dojít k poranění. Pro potvrzení polohy intervenčního zařízení použijte radiokontrastní markery.
- Volný pohyb vodícího drátu uvnitř intervenčního zařízení představuje důležitou funkci řídícího systému vodícího drátu, jelikož podává uživateli důležité taktické informace. Před použitím systém otestujte, jestli při průchodu necítíte žádný odpor. Pokud zjistíte, že hemostatický ventil zpomaluje pohyb vodícího drátu, upravte jej nebo jej nahraďte nastavitelným ventilem.
- K zavádění stentu nepoužívejte více než jeden vodící drát ani drát nezavádějte mřížkou stentu. V opačném případě může dojít k poškození

stentu nebo poškození či zlomení vodícího drátu.

- Před použitím se ujistěte, že tento vodící drát má odpovídající velikost a tvar pro daný zákrok a že je kompatibilní se zařízením, v kombinaci s kterým má být použit.
- Viz návod k použití přiložený ke zdravotnickému prostředku (např. intervenčnímu terapeutickému prostředku), který má být použit v kombinaci s tímto vodícím drátem.
- Při připojování k vodícímu drátu je nutné odnímatelný prodlužovací drát bezpečně zasunout k hraniční čáře mezi povrchovou úpravou bez PTFE a s PTFE na proximálním konci vodícího drátu. Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu připojení, okamžitě přestaňte vodící drát používat.
- Vodící drát před použitím, a kdykoli to bude během zákroku možné, pečlivě kontrolujte, jestli není ohnutý, zalomený nebo poškozený jiným způsobem. Pokud je vodící drát poškozený, nepoužívejte jej.
- Při tvarování špičky dávejte pozor, abyste nepoškodili vinuti.
- Před zavedením vodícího drátu zkontrolujte, který konec je distální, a ujistěte se, že provádíte zavádění z distálního konce.
- Během zákroku udržujte mezi vodícím katétre a intervenčním zařízením a mezi intervenčním zařízením a vodícím drátem nepřetržitý proplach heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokem. Proplachování zabraňuje tvorbě krystalů kontrastní látky a/ nebo srážení na vodícím drátu a v lumen katétru.
- U držáku s ochrannou trubičkou distálního konce (viz Doporučený postup při použití, obr. 1) nevyjímejte ani nezasouvejte ochrannou trubičku distálního konce, pokud je vodící drát umístěn v držáku.
- U držáku s ochrannou trubičkou distálního konce (viz Doporučený postup při použití, obr. 1) odstraňte ochrannou trubičku distálního konce před opětovným uložením vodícího drátu do držáku.

1. Poruchy funkce

Odlomení nebo ohnutí vodícího drátu	Poškození, jako je oddělení	Odlupování povlaku
Úmrtí	Infekce	
Snížení krevního tlaku	Komplikace spojené s krvácením	Embolie
Infarkt	Okluze cév	Krevní sraženina
Ischémie	Arytmie	Disekce cévy
Vasospasmus	Závrať	Bolest hlavy
Zvracení	Perforace cévy	Alergická reakce

Doporučený postup při použití

1. Prohlídka před použitím

- Před použitím pečlivě zkontrolujte, jestli nejsou vodící drát a obal poškozeny.
- Před použitím se ujistěte, že je vodící drát kompatibilní s používanými intervenčními zařízeními.

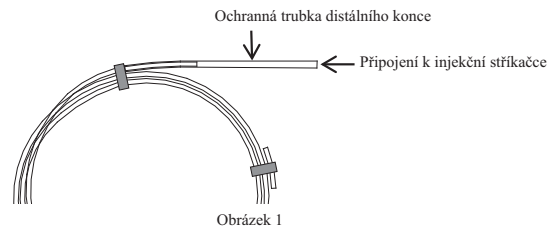
2. Příprava

- Vyberte nejvhodnější vodící drát pro postiženou oblast a vyjměte krycí trubici s vodícím drátem ze sterilního obalu.
- Pomocí injekční stříkačky naplňte krycí trubici heparinizovaným, sterilním

fyziologickým roztokem tak, aby se namočilo celé zařízení. Vezměte na vědomí, že heparinizovaný, sterilní fyziologický roztok může z krycí trubice uniknout.

c) Před zavedením vodícího drátu, naplňte lumen intervenčního zařízení heparinizovaným, sterilním fyziologickým roztokem.

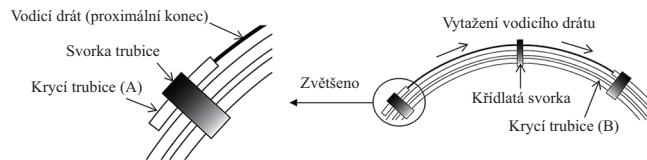
d) Vodící drát uvolněte z křídlaté svorky a pomalu jej suňte, protlačte distální konec vodícího drátu přes krycí trubici (B) (Obrázek 2).



Obrázek 1

Poruchy funkce a nežádoucí příhody

Poruchy funkce a nežádoucí příhody spojené s používáním tohoto vodícího drátu mohou mimo jiné zahrnovat následující:



Obrázek 2

- e) Vyčíná-li distální konec vodicího drátu o 5 až 6 cm z opačného konce trubky držáku (nebo ochranné trubky distálního konce), je možné v případě potřeby upravit jeho špičku v souladu s běžnou praxí.
- f) Jemně uchopte vodicí drát vyčínající z distálního konce trubky držáku (nebo ochranné trubky distálního konce) v nejbližším možném místě u držáku a pomalu a opatrně jej vytáhněte.
- g) Pokud při vytahování vodicího drátu z krycí trubice zjistíte odpor, znovu do krycí trubice vstříkněte heparinizovaný, sterilní fyziologický roztok. Jakmile odpor odezní, pokračujte ve vytahování vodicího drátu. Do krycí trubice je nutné vstříknout dostatečný objem heparinizovaného, sterilního fyziologického roztoku, aby nedošlo k poškození hydrofilního povlaku při vytahování vodicího drátu za použití síly.
- h) Po vytáhnutí vodicího drátu z krycí trubice jej zkontrolujte a ujistěte se, že není poškozen.

3. Postupy při zavádění

■ Systém Over-the-wire

- a) Opatrně vložte distální konec vodicího drátu do lumen pro vodicí drát intervenčního zařízení.
- b) Vodicí drát opatrně zavádějte, dokud jeho špička nedosáhne polohy proximální ke špičce intervenčního zařízení.
- c) Zařaďte vodicí katétr a vložte systém intervenčního zařízení (s vodicím drátem) do Y konektoru.
- d) Posunujte systém intervenčního zařízení skrz vodicí katétr, dokud špička vodicího drátu nedosáhne proximální polohy vůči špičce vodicího katétru.
- e) Utáhněte hemostatický ventil Y konektoru, aby se vytvořilo těsné spojení kolem intervenčního zařízení. Ujistěte se, že je

stále umožněn pohyb vodicího drátu.

- f) Zkontrolujte, že se vodicí drát pohybuje hladce.
- g) V případě potřeby připojte k vodicímu drátu přiložené rotační zařízení.
- h) Za skioskopické kontroly posunujte tento vodicí drát směrem k lézi. Angiograficky potvrďte, že vodicí drát dosáhl zúžené cílové léze.
- i) Kontrolujte pohyb vodicího drátu v cévách.
- j) Posunujte intervenční zařízení, dokud nedosáhnete léze, při tom zajistěte, aby se vodicí drát nepohyboval. Zajistěte, aby distální špička vodicího drátu a její poloha v cévě byly při manipulaci s intervenčním zařízením viditelné.

■ Systém rychlé výměny

- a) Zařaďte vodicí katétr.
- b) Vložte zavaděč vodicího drátu do Y konektoru vodicího katétru.
- c) Do zavaděče opatrně vložte špičku vodicího drátu.
- d) Za skioskopické kontroly posunujte vodicí drát přes vodicí katétr, dokud špička vodicího drátu nedosáhne polohy proximálně od špičky vodicího katétru.
- e) V případě potřeby připojte k vodicímu drátu přiložené rotační zařízení.
- f) Za skioskopické kontroly posunujte vodicí drát směrem k lézi. Angiograficky potvrďte, že vodicí drát dosáhl zúžené cílové léze.
- g) Kontrolujte pohyb vodicího drátu v cévách.
- h) Vyjměte rotační zařízení vodicího drátu a zavaděč vodicího drátu.
- i) Intervenční zařízení posunujte po vodicím drátě, dokud nedosáhnete léze, při tom zamezte pohybu vodicího drátu. Zajistěte,

aby distální špička vodicího drátu a její poloha v cévě byly při manipulaci s intervenčním zařízením viditelné.

- a) Vodicí drát pomalu vyjměte za skioskopického monitorování pohybu.
- b) Vložte další vodicí drát v souladu s pokyny uvedenými v části „Doporučený postup při použití“.

4. Postupy při výměně vodicího drátu

■ Systém Over-the-wire

Podmínky uchovávání

Vodicí drát a obal se nesmí při uchovávání ohýbat ani silně zatěžovat. Tento vodicí drát a obal musí být uchovávaný mimo dosah vody. Uchovávejte v chladu, temnu a suchu.

Datum použitelnosti

Datum použitelnosti je uvedeno na štítku na obalu vodicího drátu.

Obsah

5 kusů / krabička

Odmítnutí odpovědnosti

V žádném případě není „ASAHI INTECC CO., LTD. a přidružené společnosti“ (dále jen „Společnost“) odpovědná za nehody, zranění osob, nežádoucí příhody vzniklé v důsledku jakéhokoli nesprávného použití výrobku (výrobků) nebo za jakékoli jiné použití, které není v souladu s těmito pokyny. V žádném případě nebude Společnost odpovědná za škody (i) vzniklé v důsledku skladování výrobku nebo výrobků po dodání od Společnosti nebo (ii) v důsledku výběru pacientů, operačních technik nebo jakýchkoli jiných lékařských úkonů prováděných zdravotnickým zařízením, které výrobek nebo výrobky používá.

„Gladius“, „Halberd“, „ASAHI Gaia“ a „Astato“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti ASAHI INTECC CO., LTD. v Japonsku a dalších zemích.

*Hodnoty zatížení špičky představují průměrné hodnoty specifikací produktu naměřené podle testovací metody interního standardu za předpokladu síly působící na lézi hrotem vodicího drátu.

Perifer ledesonde

Bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk denne ledesonden, og følg avsnittene Indikasjoner for bruk, Målgruppe for behandling, Kontraindikasjoner, Advarsler, Forholdsregler ved bruk og Anbefalt prosedyre i denne bruksanvisningen. Innlatelse av å gjøre dette kan føre til komplikasjoner, inkludert alvorlig skade på pasienten eller død.

Hvis en bruker eller en pasient får kjennskap til en alvorlig hendelse som har oppstått i forhold til ledesonden, må dette rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemsstaten.

Denne bruksanvisningen gjelder for Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. For detaljer (lengde av ledesonden, lengden på den røntgentette seksjonen, osv.), se produktetiketten.

Beskrivelser

Den grunnleggende strukturen til denne ledesonden består av en konisk kjernesonde og to typer distale spoler (en ytre spole og en indre spole). Den koniske kjernesonden og spolene er loddet. En del av eller hele den ytre spolen er røntgentett, slik at posisjonen enkelt kan bekreftes under fluoroskopi. De distale sidene til Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 og ASAHI Gaia PV er belagt med hydrofil polymer. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES og Gladius MG18 PV ES er alle belagt med polyuretanharpiks på den ytre spolen og et hydrofilt belegg utenpå. I alle disse ledesondene er den proksimale siden av den koniske kjernesonden belagt med PTFE (polytetrafluoretylen). Enheten er mindre enn andre enheter med total lengde 300 cm, men i den proksimale enden er det en kobling for forlengelsessonde. Denne kan brukes i stedet for den kombinerte enheten. ASAHI INTECCs forlengelsessonde kan kobles til.

Se tabellen nedenfor for informasjon om produktets tuppbelastning*.

Tabell 1. Produktspesifikasjoner

Produktnavn	Ytre diameter	Tuppbelastning*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014")	12 gf
	0,45 mm (0,018")	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm / 0,36 mm (0,008"/0,014")	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm / 0,36 mm (0,009"/0,014")	40 gf
Astato 30	0,33 mm / 0,45 mm (0,013"/0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm / 0,45 mm (0,014"/0,018")	7,5 gf

Indikasjoner for bruk

Denne ledesonden er ment for generell perkutan perifer intervensjon (PPI). Denne guidekabelen er utformet for å gjøre det lettere å plassere intervensjonelle terapeutiske enheter i perifer vaskulatur i underekstremiteten.

Denne ledesonden er utelukkende laget for bruk i perifere blodårer i underekstremiteten. Denne ledesonden er ikke laget for å brukes i nevrovaskulaturen eller kardiovaskulaturen.

Målgruppe for behandling

Denne ledesonden er beregnet på pasienter som møter indikasjonene for PPI-prosedyrer. Den er ikke beregnet for bruk på nyfødte, spedbarn eller barn, samt pasienter som er gravide, har nedsatt nyrefunksjon og som har en allergisk reaksjon på kontrastmidler eller polyetylen glykol (PEG).

Kontraindikasjoner

- Bekreft kompatibiliteten til diameteren på ledesonden med andre enheter for intervensjon før faktisk bruk.
- Ikke bruk ledesonden til pasienter som har en allergisk reaksjon på kontrastmidler, eller som har nedsatt nyrefunksjon.
- Denne ledesonden inneholder PEG400 i sitt hydrofile belegg. Ikke bruk ledesonden hos pasienter som har allergiske reaksjoner på polyetylen glykol (PEG).
- Ikke bruk ledesonden til gravide pasienter eller pasienter som kan være gravide (røntgen kan påvirke fosteret).
- Denne ledesonden skal brukes i institusjoner der akuttkirurgi kan utføres umiddelbart. Hvis akuttkirurgi ikke er tilgjengelig, kan i verste fall livstruende situasjoner oppstå.
- Ledesonden og emballasjen er sterilisert på forhånd med etylenoksidgass (EOG) og er kun beregnet for engangsbruk. Skal ikke resteriliseres eller brukes på nytt. Hvis ledesonden brukes på nytt eller resteriliseres, kan det gå ut over ytelsen eller kvaliteten til denne ledesonden og pakken, og det er fare for komplikasjoner, inkludert infeksjon.

Advarsler

- Denne ledesonden skal bare brukes av en lege som er fullt opplært i PPI-behandling.
- Denne ledesonden skal aldri brukes sammen med katetre som inneholder metalldeleer som kan komme i direkte kontakt med overflaten på ledesonden (f.eks. aterektomikatetre, metalldilatorer), metallnåler eller metallinnførere.
- Når ledesonden brukes, kontroller og overvåk bevegelsen til tuppen under fluoroskopi.
- Enheten må ikke brukes i blodåren som ikke kan sees eller visualiseres.
- Ledesonden skal ikke kobles til avtakbare forlengelsessonder produsert av andre enn ASAHI INTECC. Ledesonden må ikke manipuleres mens den avtakbare forlengelsen er tilkoblet. Hvis ikke kan ledesonden bli skadet eller den avtakbare forlengelsessonden kan løsne uten at det er meningen.
- Ikke endre denne ledesonden av noen årsaker.

Forholdsregler ved bruk

- Bruk ikke ledesonden etter holdbarhetsdatoen som er angitt på etiketten. Kast ledesonder som overskrider holdbarhetsdatoen.
- Ledesonder er ømfintlige instrumenter og bør behandles forsiktig.
- Ikke bruk ledesonden dersom emballasjen er åpnet eller skadet. Ikke åpne emballasjen før like før bruk. Bruk aseptisk teknikk ved håndtering og bruk av ledesonden.
- Hold alltid ledesonden i våt tilstand for å unngå skade på dets hydrofile belegg.
- Ledesonden må ikke tørkes med en organisk løsning som alkohol.
- Etter bruk skal denne ledesonden, tilbehøret og emballasjen avhendes som medisinsk avfall, og det skal iverksettes forebyggende tiltak mot smittsomme sykdommer.

- Ledsesonder som møter motstand må aldri skyves, skrues, trekkes tilbake eller ettertrekkes. Hvis ledesonden skyves eller ettertrekkes mot motstand, kan dette forårsake skade og/eller separasjon av tuppen fra ledesonden eller direkte skader på blodårene. Unnlattelse av å gjøre det kan føre til skade på denne ledesonden. Fastslå årsaken til motstanden under gjennomlysning, og iverksett nødvendige tiltak.
- Ledsonden skal alltid føres inn og trekkes ut sakte og forsiktig.
- Ved ettertrekking av denne ledesonden inne i blodåren, skal den ikke ettertrekkes kontinuerlig i samme retning. Når ledesonden ettertrekkes, skal den roteres vekselvis med klokken og mot klokken. Ikke overstig to rotasjoner (720°) i samme retning.
- Skyll ledesonden med heparinisert og sterilisert saltvann eller annet egnet løsning mens ledesonden fjernes og settes inn igjen for å hindre at det kommer luft inn i intervensjonsenheten. Utfør utveksling av denne ledesonden nøye for å hindre at det kommer luft inn og/eller traumer. Når ledesonden føres inn på nytt, må du bekrefte at tuppen på intervensjonsenheten er fri innenfor lumen til blodåren og ikke ligger mot årevæggen. Uten slik observasjon kan det oppstå skade. Bruk den røntgentette markøren på intervensjonsenheten til å bekrefte plasseringen.
- Fri bevegelse av ledesonden innen intervensjonsenheten er en viktig funksjon i en styrbar ledesonde fordi det gir brukeren verdifull informasjon. Systemet må testes for motstand før bruk. Juster eller bytt hemostaseventilen en justerbar ventil dersom det hemmer bevegelsen til ledesonden.
- Ikke utfør stentplassering ved bruk av mer enn én ledesonde eller bruk av vaier gjennom

- stentveggen. Hvis ikke kan stenten bli skadet eller ledesonden kan brenne.
- Før bruk, kontroller at denne ledesonden er passende i størrelse og form for prosedyren og er kompatibel med enheten som skal brukes i kombinasjon.
- Se den medfølgende bruksanvisningen for det medisinske utstyret (f.eks. intervensjonsterapeutisk utstyr) som skal brukes i kombinasjon med denne ledesonden.
- Når den avtakbare forlengelsessonden kobles sammen med denne ledesonden, bør ledesonden være satt godt inn i grenselinjen mellom ikke-PFTE-belegg og PRFE-belegg i den proksimale enden av ledesonden. Slutt å bruke ledesonden umiddelbart hvis det blir funnet noe unormalt i tilkoblingen.
- Sjekk ledesonden nøye for bend, knekk eller andre skader før bruk og når det er mulig under prosedyren. Ikke bruk ledesonden hvis den er skadet.
- Når du former tuppen, vær forsiktig så du ikke skader spolen.
- Før du setter inn ledesonden, sjekk hvilken ende som er den distale enden og sørg for å sette den inn fra den distale enden.
- La en kontinuerlig heparinisert og sterilisert saltvannsspyling opprettholdes mellom føringskateteret og intervensjonsenheten og mellom intervensjonsenheten og ledesonden mens operasjonen pågår. Skylling forhindrer at det dannes kontrastmiddelkrystaller og/eller koagulering på ledesonden og i kateterlumen.
- For holderen med beskyttelseshylse på den distale enden (se Anbefalt prosedyre, figur 1), ikke fjern eller sett inn beskyttelseshylsen på den distale enden mens ledesonden er plassert i holderen.
- For holderen med beskyttelseshylse på den distale enden (se Anbefalt prosedyre, figur 1), fjern beskyttelseshylsen på den distale enden før ledesonden plasseres i holderen igjen.

Feilfunksjoner og ugunstige effekter

Mulige feilfunksjoner og ugunstige effekter ved bruk av denne ledesonden inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

1. Feilfunksjoner

Brudd eller bøyning av ledesonden

Skader som separasjon

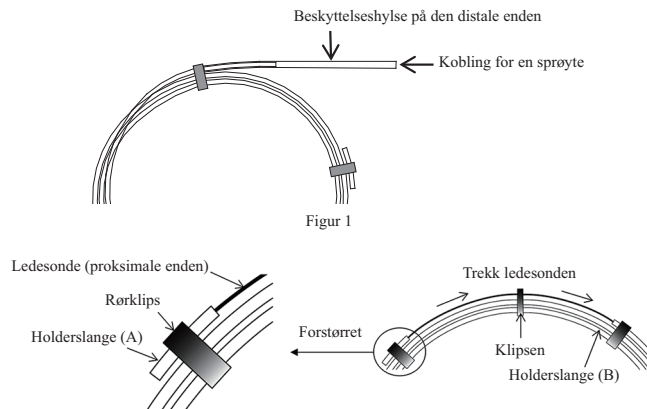
Belegget går av

2. Ugunstige effekter

Dødsfall	Infeksjon	Emboli
Blodtrykksreduksjon	Blødningskomplikasjoner	Trombe
Infarkt	Vaskulær okklusjon	Disseksjon
Ischemia	Arytmi	Hodepine
Vasospasm	Svimmelhet	Allergisk reaksjon
Oppkast	Karperforering	

Anbefalt prosedyre

1. Inspeksjon før bruk
 - a) Før bruk, sjekk nøye og bekreft at alle ledesonder og pakker er uskadet.
 - b) Før bruk, bekreft at ledesonden er kompatibel med intervensjonsenheten som skal brukes.
2. Forberedelse
 - a) Velg den mest passende ledesonden for det berørte området; fjern holderslangen som inneholder ledesonden fra den sterile pakningen.
 - b) Fyll holderslangen med heparinisert og sterilisert saltvann ved bruk av en sprøyte, for å væte hele enheten. Merk deg at heparinisert og sterilisert saltvann kan søle ut av slangen på dette tidspunktet.
 - c) Fyll lumen på intervensjonsenheten med heparinisert og sterilisert saltvann før du fører inn ledesonden.
 - d) Løsne ledesonden fra klipsen og trekk ledesonden sakte mens du skyver den distale enden av ledesonden gjennom holderslangen (B) (Figur 2).



Figur 2

- e) Når ledesondens distale ende stikker mer enn 5–6 cm ut av den andre enden av holderslangen (eller beskyttelseshylsen på den distale enden), former du om nødvendig tuppen i samsvar med standard praksis.
- f) Ta forsiktig tak i ledesonden som kom ut fra

den distale enden av holderslangen (eller beskyttelseshylsen på den distale enden), på et punkt som er så nær holderslangen som mulig, og trekk ledesonden ut sakte og forsiktig.

- g) Hvis du merker motstand når ledesonden fjernes fra holderslangen, skal du sprøyte inn heparinisert og sterilisert saltvann i holderslangen på nytt. Fortsett å fjerne ledesonden når du ikke lenger kjenner motstand. Pass på at du sprøyter inn tilstrekkelig heparinisert og sterilisert saltvann i holderslangen, da det hydrofile belegget kan bli skadet hvis du fjerner den belagte ledesonden med tvang.
- h) Når ledesonden trekkes ut av holderslangen, sjekk for skader.

3. Prosedyrer for innsetting

- Over-the-wire-systemet
 - a) Sett den distale enden av ledesonden forsiktig inn i lumen til intervensjonsenheten.
 - b) Flytt ledesonden forsiktig frem inntil tuppen er proksimalt til tuppen av intervensjonsenheten.
 - c) Aktiver ledekateret og sett intervensjonssystemet (med ledesonde) inn i Y-koblingen.
 - d) For intervensjonssystemet fremover gjennom det ledekateret til tuppen av ledesondesystemet er proksimalt til tuppen av det ledekateret.
 - e) Stram hemostaseventilen på Y-koblingen for å lage en forsegling rundt intervensjonsenheten. Sørg for at ledesonden fortsatt kan bevegese.
 - f) Sjekk at ledesonden beveger seg jevnt.
 - g) Fest enheten for dreiemoment til ledesonden om nødvendig.
 - h) For ledesonden fremover til du har passert lesjonen. Bruk fluoroskopi til å kontrollere fremdriften. Bekreft med angiografi at ledesonden har passert den innsnevrede

delen av mållesjonen.

- i) Observer ledesondens bevegelse i blodåren.
- j) For intervensjonsenheten fremover inntil lesjonen er nådd mens du hindrer ledesonden i å bevege seg. Sørg for at den distale tuppen av ledesonden og dens plassering i blodåren blir synlig under manipulasjoner av intervensjonsenheten.

■ System for raskt bytte

- a) Aktiver ledekateret.
- b) Sett innføringssettet på ledesonden inn i Y-koblingen på ledekateret.
- c) Sett tuppen forsiktig inn i innføringssettet.
- d) For ledesonden fremover gjennom det ledekateret under fluoroskopi inntil tuppen til ledesonden er proksimalt til tuppen av det ledekateret.
- e) Fest enheten for dreiemoment til ledesonden om nødvendig.
- f) Flytt ledesonden frem under fluoroskopi og passer gjennom lesjonen. Bekreft med angiografi at ledesonden har passert den innsnevrede delen av mållesjonen.
- g) Observer ledesondens bevegelse i blodåren.
- h) Fjern ledesondens vridningsenhet og innføringssettet til ledesonden.
- i) Spor intervensjonsenheten over ledesonden mens du hindrer ledesonden i å bevege seg, og før den fremover inntil lesjonen er nådd. Sørg for at den distale tuppen til ledesonden og dens plassering i blodåren blir synlig under manipulasjon av intervensjonsenheten.

4. Prosedyrer for å bytte ut ledesonden

- Over-the-wire-systemet
 - a) Fjern ledesonden sakte mens ledesondens bevegelse overvåkes under fluoroskopi.
 - b) Sett inn den neste ledesonden i samsvar med retningslinjene i denne "Anbefalt prosedyre"-delen.

Innhold

5 stk/eske

Ansvarsfraskrivelse

“ASAHI INTECC CO., LTD. og dets tilsluttede selskaper” (heretter kalt “selskapet”) skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for ulykker, personskader, ugunstige effekter fra uriktig bruk av produktet eller produktene eller annen bruk som ikke er i overensstemmelse med disse instruksjonene. Selskapet skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for skader (i) som oppstår på grunn av hvordan produktet/-ene oppbevares etter forsendelse fra Selskapet, eller (ii) på grunn av pasientutvalg, kirurgiske teknikker eller noen andre medisinske aktiviteter ved helseinstitusjonen som bruker produktet/-ene.

“Gladius”, “Halberd”, “ASAHI Gaia” og “Astato” er registrerte varemerker som tilhører ASAHI INTECC CO., LTD. i Japan og andre land.

*Tuppbelastningsverdiene representerer gjennomsnittsverdier for produktspesifikasjonsverdiene målt iht. den interne standardtestmetoden, forutsatt at ledesondens tupp påfører kraften på lesjonen.

Oppbevaring

Ikke oppbevar ledesonden og emballasjen i bøyd stilling eller med svært tung belastning. Denne ledesonden og emballasjen skal holdes borte fra vann. Oppbevares mørkt, tørt og kjølig.

Holdbarhetsdato

Holdbarhetsdatoen er angitt på etiketten på ledesondens emballasje.

Periférny vodiaci drôt

Návod na použitie

Pred použitím tohto vodiaceho drôtu si pozorne prečítajte tieto pokyny a dodržiavajte pokyny v častiach Indikácie na použitie, Cieľová liečená populácia, Kontraindikácie, Upozornenia, Bezpečnostné opatrenia a Spôsob použitia v tomto návode na použitie. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku komplikáciám, vrátane vážneho zranenia alebo smrti pacienta.

Ak sa používateľ a/alebo pacient dozvie o závažnom incidente, ku ktorému došlo v súvislosti s vodiacim drôtom, musí túto skutočnosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému úradu členského štátu.

Tento návod na použitie platí pre Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Aстато XS 20, Aстато XS 40, Aстато 30, ASAHI Gaia PV. Podrobnosti (dĺžka vodiaceho drôtu, dĺžka kontrastnej časti a pod.) nájdete na etikete výrobcu.

Popis

Základná štruktúra vodiaceho drôtu pozostáva z kužeľového jadrového drôtu a dvoch typov distálnych cievok (vonkajšia cievka a vnútorná cievka). Kužeľový jadrový drôt a cievky sú spájkované. Čiastočná alebo úplná dĺžka vonkajšej cievky je röntgenkontrastná, vďaka čomu možno ľahko potvrdiť jej polohu pomocou fluoroskopie. Distálne strany pomociek Halberd, Aстато XS 20, Aстато XS 40, Aстато 30 a ASAHI Gaia PV sú potiahnuté hydrofilným polymérom. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES a Gladius MG18 PV ES majú na vonkajšom závitte povlak z polyuretánovej živice a na nej hydrofilnú povrchovú vrstvu. Vo všetkých týchto vodiaciach drôtoch je proximálna strana kužeľového jadrového drôtu potiahnutá PTFE (polytetrafluoretyénom). Na inom proximálnom konci pomocky ako tých, ktoré majú celkovú dĺžku 300 cm, sa nachádza pripojka pre predlžovací drôt, ktorý sa používa na nahradenie kombinovanej pomôcky. Je možné pripojiť predlžovací drôt od spoločnosti ASAHI INTECC. Zaťaženie špičky* tohto produktu nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 1. Špecifikácie produktu

Názov produktu	Vonkajší priemer	Zaťaženie špičky*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014")	12 gf
	0,45 mm (0,018")	12 gf
Aстато XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008"/0,014")	20 gf
Aстато XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009"/0,014")	40 gf
Aстато 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013"/0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm(0,014"/0,018")	7,5 gf

Indikácie na použitie

Tento vodiaci drôt je určený na všeobecnú perkutánnu periférnu intervenciu (PPI). Tento vodiaci drôt je určený na uľahčenie umiestnenia intervenčných terapeutických pomôcok do periférnych ciev dolných končatín.

Tento vodiaci drôt je určený len na použitie v periférnych cievach dolných končatín. Tento vodiaci drôt nie je určený na použitie v neurovaskulárnom a kardiovaskulárnom systéme.

Cieľová liečená populácia

Tento vodiaci drôt je určený pre pacientov, ktorí spĺňajú indikácie na zázroky PPI. Nie je indikovaný na použitie u novorodencov, dojčiat alebo detí, ani u pacientiek, ktoré sú tehotné, majú poruchu funkcie obličiek a alergickú reakciu na kontrastné látky alebo polyetylénlykol (PEG).

Kontraindikácie

- Pred samotným použitím overte kompatibilitu priemeru vodiaceho drôtu s inou intervenčnou pomôckou.
- Vodiaci drôt nepoužívajte u pacientov s alergickou reakciou na kontrastnú látku alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek.
- Hydrofilná povrchová vrstva tohto vodiaceho drôtu obsahuje PEG400. Nepoužívajte vodiaci drôt u pacientov, u ktorých sa vyskytla alergická reakcia na polyetylénlykol (PEG).
- Nepoužívajte vodiaci drôt u tehotných pacientok alebo pacientok, ktoré môžu byť tehotné (röntgenové žiarenie môže ovplyvniť plod).
- Tento Vodiaci drôt sa smie používať v inštitúcii, kde sa môže okamžite vykonať pohotovostná chirurgická operácia. Ak nie je dostupná pohotovostná chirurgická operácia, v najhoršom prípade môže dôjsť k život ohrozujúcim udalostiam.
- Vodiaci drôt je vopred sterilizovaný plyným etylénoxidom (EOG) a je určený len na jedno použitie. Nepoužívajte ani nesterilizujúce opakované. Keby sa opakované použil alebo sterilizoval, mohla by sa narušiť funkčnosť alebo kvalita vodiaceho drôtu a hrozilo by riziko komplikácií, vrátane infekcie.

Upozornenia

- Tento vodiaci drôt musí používať len lekár, ktorý má plnú odbornú prípravu v oblasti liečby pomocou PPI.
- Nikdy nepoužívajte tento vodiaci drôt v kombinácii s katétami obsahujúcimi kovové časti, ktoré môžu prísť do priameho kontaktu s povrchom tohto vodiaceho drôtu (napr. atereotomické katétre či kovové dilatátory), kovovými ihlami alebo kovovými záväzmi.
- Počas používania vodiaceho drôtu kontrolujte a monitorujte pohyb jeho špičku pod fluoroskopom. Nepoužívajte ho v oblastiach ciev, ktoré nemožno vizualizovať.
- Vodiaci drôt nespájajte s odnímateľnými predlžovacími drôti od iných výrobcov ako ASAHI INTECC. Nemanipulujte s vodiacim drôtom, kým je k nemu pripojený odnímateľný vodiaci drôt. Ináč sa vodiaci drôt poškodí alebo sa odpojitelný predlžujúci drôt neúmyselne odpojí.
- Vodiaci drôt zo žiadneho dôvodu neupravujte.

Bezpečnostné opatrenia

- Vodiaci drôt nepoužívajte po dátume expirácie uvedenom na etikete obalu. Zlikvidujte všetky vodiace drôty, ktoré sú po dátume expirácie.
- Vodiace drôty sú citlivé nástroje a je potrebné narábať s nimi opatrne.
- Ak je obal otvorený alebo poškodený, vodiaci drôt nepoužívajte. Obal otvárajte až tesne pred použitím. Pri manipulácii s vodiacim drôtom, ako aj pri ich používaní, použite aseptickú techniku.
- Vodiaci drôt udržiavajte vždy vo vlhkom stave, aby ste zabránili poškodeniu jeho hydrofilnej povrchovej vrstvy.

- Vodiaci drôt neutierajte pomocou organického roztoku, napríklad alkoholu.
- Po použití zlikvidujte tento vodiaci drôt, príslušenstvo a obal ako zdravotnícky odpad a prijmite preventívne opatrenia na ochranu pred infekčnými ochoreniami.
- Nikdy netlačte, neskrúčajte, nevŕtajte ani netočte vodiaci drôt takou silou, aby ste cítili odpor. Točenie alebo zatlačenie vodiaceho drôtu napriek odporu môže spôsobiť poškodenie vodiaceho drôtu a oddelenie jeho špičky alebo priame poškodenie cievy. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vodiaceho drôtu. Pod fluoroskopickým pozorovaním určite príčinu odporu a podniknite potrebný nápravný krok.
- Vodiaci drôt vždy zavádzajte alebo vyťahujte pomaly a opatrne.
- Počas krútenia vodiacim drôtom vnútri krvnej cievy nekrúťte ním stále tým istým smerom. Pri krútení vodiacim drôtom ho striedavo otáčajte v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
- Dbajte na to, aby ste nevykonali viac ako dve rotácie (720°) tým istým smerom.
- Pri odstraňovaní a opätovnom zavádzaní vodiaci drôt opláchnite heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom alebo iným vhodným roztokom, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchu do intervenčnej pomôcky. Výmene vodiaceho drôtu vykonajte opatrne, aby nedošlo k vniknutiu vzduchu a/alebo vzniku traumy. Pri opakovanom zavádzaní vodiaceho drôtu sa presvedčte, že špička intervenčnej pomôcky je v lúмене cievy voľná a že nesmeruje k stene cievy. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu. Polohu potvrdte pomocou kontrastnej značky intervenčnej pomôcky.
- Voľný pohyb vodiaceho drôtu v intervenčnej pomôcke je dôležitým príznakom ovládacieho systému vodiaceho drôtu, pretože používateľovi poskytuje cenné dotykové informácie. Pred použitím systému vyskúšajte, ako sa správa pri odpore. Nastavte alebo vymeňte hemostatický ventil pomocou nastavovacieho ventilu, ak je prítomný, aby ste zamedzili pohybu vodiaceho drôtu.
- Stent neumiestňujte pomocou viacerých vodiacich drôtov ani nemanipulujte s drôtom prostredníctvom výstupu stentu. V opačnom

- pripade sa stent môže poškodiť a vodiaci drôt sa môže zlomiť alebo roztrhnúť.
- Pred použitím sa uistite, že vodiaci drôt má vhodnú veľkosť a tvar pre daný postup a je kompatibilný s pomôckou, ktoré sa má použiť v kombinácii s ním.
 - Pozrite si návod na použitie priložený k zdravotníckej pomôcke (napr. k intervenčným terapeutickým pomôckam), ktorá sa má používať v kombinácii s týmto vodiacim drôtom.
 - Pri pripájaní odnímateľného predlžovacieho drôtu k tomuto vodiacemu drôtu by sa drôt mal bezpečne zaviesť po hraničnú líniu medzi vrstvou bez polytetrafluóretylénu (PTFE) a vrstvou s PTFE na proximálnom konci vodiaceho drôtu. Ak sa v pripojke zistí akákoľvek abnormalita, okamžite prestaňte vodiaci drôt používať.
 - Pred použitím vodiaceho drôtu a kedykoľvek je to možné počas zákroku dôkladne skontrolujte, či vodiaci drôt nie je ohnutý, zauzlený alebo inak poškodený. Ak je vodiaci drôt poškodený, nepoužívajte ho.
 - Pri tvarovaní špičky dávajte pozor, aby ste nepoškodili cievkou.
 - Pred zavedením vodiaceho drôtu skontrolujte, ktorý koniec je distálny, a dbajte na to, aby ste ho zavádzali z distálneho konca.
 - Počas zákroku zaistite nepretržitý preplachovanie heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom medzi vodiacim katétrom a intervenčnou pomôckou a tiež medzi intervenčnou pomôckou a vodiacim drôtom. Preplachovanie zabraňuje tvorbe kryštálikov kontrastnej látky a/alebo zrážaniu na vodiacom drôte a v lúмене katétra.
 - V prípade držača s ochrannou rúrkou distálneho konca (pozri časť Spôsob použitia, obrázok 1) neodstraňujte ani nekladajte ochrannú rúrkou distálneho konca, kým je vodiaci drôt umiestnený v držiaču.
 - V prípade držača s ochrannou rúrkou distálneho konca (pozri časť Spôsob použitia, obrázok 1) odstráňte ochrannú rúrkou distálneho konca pred opätovným vložení vodiaceho drôtu do držača.

1. Porucha činnosti

Zlomenie alebo ohnutie vodiaceho drôtu	Poškodenie, ako napríklad oddelenie	Odlúpenie povrchovej vrstvy
Úmrtie	Infekcia	
Zníženie krvného tlaku	Krvácavé komplikácie	Embólia
Infarkt	Cievna oklúzia	Trombus
Ischémia	Arytmia	Disekcia cievy
Vazospazmus	Závraty	Bolesť hlavy
Vracanie	Perforácia cievy	Alergická reakcia

Spôsob použitia

1. Kontrola pred použitím

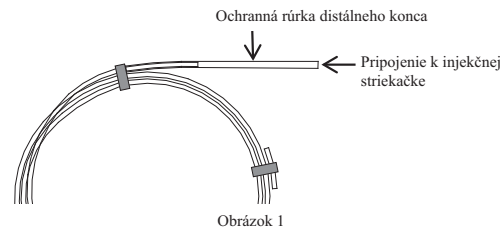
- Pred použitím dôkladne skontrolujte a overte, či vodiaci drôt a obal nie sú poškodené.
- Pred použitím sa presvedčte, že vodiaci drôt je kompatibilný s intervenčnými pomôckami, ktoré sa majú použiť.

2. Príprava

- Zvoľte najvhodnejší vodiaci drôt pre postihnutú oblasť a pridržiavaciu rúrkou obsahujúcu vodiaci drôt vyberte zo sterilného obalu.
- Pridržiavaciu rúrkou pomocou injekčnej striekačky naplňte heparinizovaným a

sterilizovaným fyziologickým roztokom, aby sa navlhčila celá pomôcka. Pripomíname, že počas tohto úkonu môže heparinizovaný a sterilizovaný fyziologický roztok vytiecť z pridržiavacej rúrky.

- Pred zavedením vodiaceho drôtu naplňte lúmen intervenčnej pomôcky heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom.
- Vodiaci drôt uvoľnite zo zadnej svorky a pomaly ho posúvajte, distálny koniec vodiaceho drôtu tlačte cez pridržiavaciu rúrkou (B) (Obrázok 2).



Obrázok 1

Poruchy činnosti a nežiaduce účinky

K možným poruchám činnosti a nežiaducim účinkom pri používaní vodiaceho drôtu okrem iného patria:



e) Ak sa distálny koniec vodiaceho drôtu vysunie o viac ako 5 – 6 cm za opačný koniec pridržiavacej rúrky (ochranné rúrky distálneho konca), v prípade potreby upravte tvar špičky podľa štandardného postupu.

f) Jemne uchopte vodiaci drôt, ktorý vychádza z distálneho konca rúrky držiaka (alebo ochranné rúrky distálneho konca) v bode, ktorý je čo najbližšie k pridržiavacej rúrke, a vodiaci drôt pomaly a opatrne vytiahnite.

g) Ak pri vytáňovaní vodiaceho drôtu z pridržiavacej rúrky pociťte odpor, znovu vstreknite do pridržiavacej rúrky heparinizovaný a sterilizovaný fyziologický roztok. Keď sa odpor stratí, pokračujte vo vytáňovaní vodiaceho drôtu. Dajte na to, aby ste do pridržiavacej rúrky vstrekli dostatok heparinizovaného a sterilizovaného fyziologického roztoku, pretože pri násilnom vytáňovaní potiahnutého vodiaceho drôtu sa môže poškodiť jeho hydrofílna povrchová vrstva.

h) Po vytiahnutí vodiaceho drôtu z pridržiavacej rúrky sa presvedčte, či nie je poškodený.

- **Systém Over the wire (OTW)**
 - a) Distálny koniec vodiaceho drôtu opatrne zaveďte do lúmenu pre vodiaci drôt intervenčnej pomôcky.
 - b) Opatrne zasúvajte vodiaci drôt, až kým sa jeho špička nedostane najbližšie k špičke intervenčnej pomôcky.
 - c) Nasadte vodiaci katéter a zaveďte systém intervenčnej pomôcky (s vodiacim drôtom) do Y-konektora.
 - d) Systém intervenčnej pomôcky zasúvajte cez vodiaci katéter, až kým sa špička systému vodiaceho drôtu nedostane najbližšie k špičke vodiaceho katétra.
 - e) Utiahnite hemostatický ventil Y-konektora.

- f) Kontrolou sa presvedčte, že sa vodiaci drôt hladko pohybuje.
- g) V prípade potreby pripevnite k vodiacemu drôtu torzné zariadenie.
- h) Vodiaci drôt zasúvajte pod fluoroskopickým pozorovaním, až kým neprejde cez léziu. Angiografiou overte, či vodiaci drôt prešiel zúženou cieľovou léziou.
- i) Sledujte pohyb vodiaceho drôtu v cievach.
- j) Intervenčnú pomôcku zasúvajte, až kým sa nedostane k lézii, pričom zabránite pohybu vodiaceho drôtu. Zabezpečte, aby bola distálna špička vodiaceho drôtu a jej poloha v cieve viditeľná počas manipulácie s intervenčnou pomôckou.

- Nasaďte vodiaci katéter.
- Zavádzajte vodiaceho drôtu zaveďte do Y-konektora vodiaceho katétra.
- Opatrne zaveďte špičku vodiaceho drôtu do zadržáča.
- Vodiaci drôt zasúvajte cez vodiaci katéter pod fluoroskopickým pozorovaním, až kým sa špička vodiaceho drôtu nedostane najbližšie k špičke vodiaceho katétra.
- V prípade potreby pripevnite k vodiacemu drôtu torzné zariadenie.
- Vodiaci drôt zasúvajte pod fluoroskopickým pozorovaním tak, aby prešiel cez lúziu. Angiografiou overte, či vodiaci drôt prešiel zúženou cieľovou lúziou.
- Sledujte pohyb vodiaceho drôtu v cievacích.
- Odstáňte torzné zariadenie vodiaceho drôtu a zavádzajte vodiaceho drôtu.
- Veďte intervenčnú pomocku po vodiacom

- a) Vodiaci drôt pomaly odstraňujte, pričom sledujte pohyb vodiaceho drôtu pod fluoroskopickým pozorovaním.
- b) Zaveďte ďalší vodiaci drôt v súlade s pokynmi v časti Spôsob použitia.

* Hodnoty zaťaženia špičky predstavujú priemerné hodnoty hodnôt špecifikácie produktu namerané podľa internej štandardnej testovacej metódy za predpokladu sily pôsobiacej na léziu špičkou vodiaceho drôtu.

Perifeerne juhtetraat

Kasutusjuhend

Enne selle juhteraadi kasutamist lugege hoolikalt käesolevaid juhiseid ja järgige kasutusjuhendit, ravi sihtrühma, vastunäidustusi, hoiatusi, ettevaatusabinõusid ja kasutamissuuniste jaotisi. Vastasel juhul võivad tekkida tüsistused, sh patsiendi raske vigastus või surm. Selle teabe eiramine võib viia tüsistusteni, kaasa arvatud patsiendi tõsine vigastus või surm.

Kui kasutaja ja/või patsient saab teada tõsisest vahejuhtumist, mis juhtetraadiga seoses aset leidis, tuleb tootjat ja liikmesriigi pädevat asutust sellest teavitada.

Käesolev kasutusjuhend kehtib seadmetele Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Andmeid juhtetraadi pikkus, röntgenkontrastse osa pikkus jne) vaadake tootesildilt.

Kirjeldused

Selle juhteraadi põhistruktuur koosneb koonilisest sisetraadist ja kahte tüüpi distaalsest spiraalst (välisest ja sisemisest spiraalst). Kooniline sisetraat ja spiraalid on joodetud. Välise spiraali osa või kogu väline spiraal on röntgenkontrastne, seega saab selle asendisi fluoroskoopia abil hõlpsasti veenduda. Juhtetraadide Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 ja ASAHI Gaia PV distaalsed küljed on kaetud hüdrofiilse polümeeriga. Juhtetraadide Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES ja Gladius MG18 PV ES välisel spiraalil on polüuretaanvaigust kate ja selle peal hüdrofiilne kate. Kõigi nende juhtetraadide koonilise sisetraadi proksimaalne külg on kaetud PTFE-ga (polüetrafluorotüleen). Seadmete proksimaalses otsas (v.a 300 cm kogupikkusega seadmete puhul) on ühenduskoht pikendustraadi jaoks, mida kasutatakse kombineeritud seadme asendamiseks, ühendada võib ettevõtte ASAHI INTECC pikendustraadi. Selle toote otsa koormuse* teavet vt alltoodud tabelist.

Tabel 1. Toote tehnilised andmed

Toote nimi	Välisläbimõõt	Otsa koormus*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014")	12 gf
	0,45 mm (0,018")	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008"/0,014")	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009"/0,014")	40 gf
Astato 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013"/0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014"/0,018")	7,5 gf

Näidustused

See juhtetraat on ette nähtud üldiseks perkutaanseks perifeerseks sekkumiseks. See juhtetraat on ette nähtud sekkumisraviseadmete paigutamiseks alajäseme perifeersetesse vereossetesse. See juhtetraat on ette nähtud kasutamiseks üksnes alajäseme perifeersetes vereossetes. See juhtetraat ei ole ette nähtud kasutamiseks närvisüsteemi vereossetes ega südamevereossetes.

Ravi sihtrühm

See juhtetraat on mõeldud patsientidele, kellel esinevad näidustused perkutaanse perifeerse sekkumise protseduuriks. See ei ole ette nähtud kasutamiseks vastsündinutel, imikutel, lastel ega rasedatel, neerufunktsiooni häirega patsientidel ega neil, kel on allergiline reaktsioon kontrastaine või polüetüleenlülukooli (PEG) suhtes.

Vastunäidustused

- Kontrollige enne tegelikku kasutamist juhtetraadi läbimõõdu ühilduvust muu sekkumisseadmega.
- Ärge kasutage juhtetraati patsientidel, kellel on kontrastaine suhtes allergiline reaktsioon või kellel on neerufunktsiooni häire.
- Juhtetraat sisaldab hüdrofiilset kattel ainet PEG400. Ärge kasutage juhtetraati patsientidel, kes on polüetüleenlülukooli (PEG) suhtes allergilised.
- Ärge kasutage juhtetraati rasedate või potentsiaalselt rasedate patsientide puhul (röntgenikiirgus võib loodet mõjutada).
- Seda juhtetraati tohib kasutada vaid asutuses, kus on võimalik erakorralise kirurgilise operatsiooni viivitamatu teostamine. Kui erakorralise kirurgilise operatsiooni tegemise võimalus puudub, võivad halvalmal juhul tekkida surmaga lõppevad tüsistused.
- See juhtetraat on eelsteriliseeritud etüleenoksiidiga (EO) ja on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Ärge kasutage ega steriliseerige korduvalt. Korduv kasutamine võib korduv steriliseerimine võib halvendada juhtetraadi kvaliteeti ja kahjustada selle pakendit, ning sellega kaasneb komplikatsioonide risk, kaasa arvatud infektsioonirisk.

Hoiatused

- Seda juhtetraati tohivad kasutada üksnes arstid, kes on saanud täieliku väljaõppe perkutaanse perifeerse sekkuva ravi alal.
- Ärge kasutage seda juhtetraati mingil juhul koos kateetritega, millel on metalllosad, mis võivad selle juhtetraadi pinnaga otseselt kokku puutuda (nt aterektomiakateetrid, metall-laiendajad); metallnõelte ega metallist sisestusseadmetega.
- Juhtetraadi kasutamise ajal kontrollige ja jälgige selle otsa liikumist röntgenoloogiliselt. Ärge kasutage vereosone piirkondades, mille visualiseerimine ei ole võimalik.
- Ärge ühendage selle juhtetraadi külge eemaldatavaid pikendustraate, mille tootja on muu kui ettevõtte ASAHI INTECC. Ärge käsitage seda juhtetraati, kui eemaldatav pikendustraad on ühendatud. Vastasel juhul võite kahjustada juhtetraati või eemaldatava pikendustraadi tahtmatult lahti ühendada.
- Ärge muutke juhtetraati ühelgi põhjusel.

Ettevaatusabinõud

- Ärge kasutage juhtetraati pärast sildil toodud aegumiskuupäeva möödumist. Aegumiskuupäeva ületanud juhtetraadid tuleb ära visata.
- Juhtetraadid on õrnad instrumendid ja neid tuleb käsitseda ettevaatlikult.
- Ärge kasutage juhtetraati, kui pakend on avatud või kahjustatud. Avage pakend alles vahetult enne kasutamist. Kasutage juhtetraadi käsitlemisel aseptilist tehnikat.
- Hoidke juhtetraati alati märjana, et vältida selle hüdrofiilse katte kahjustamist.

- Ärge pühkige juhtetraati orgaanilise lahusega, näiteks alkoholiga.
- Pärast kasutamist kõrvaldage see juhtetraat, tarvikud ja pakend niisugisemiliste jäätmetena, võttes nakkushaigusi ennetavalt meetmed.
- Ärge kunagi lükkake, keerake, tõmmake välja ega pöörake juhtetraati, mille osas on tunda takistust. Juhtetraadi pööramine või liikumine takistuse vastu võib juhtetraati kahjustada ja/või põhjustada juhtetraadi otsa eraldumist või otseselt kahjustada vereosont. Selle eiramine võib juhtetraati kahjustada. Tehke takistuse põhjus röntgenoloogiliselt kindlaks ja kõrvaldage see.
- Alati lülitage juhtetraati edasi või tõmmake tagasi aeglaselt ja ettevaatlikult.
- Juhtetraadi pööramisel vereosone sees ärge pöörake seda pidevalt ühes suunas. Seadme pööramisel pöörake seda vaheldumisi päripäeva ja vastupäeva. Ärge pöörake ühes suunas järjest rohkem kui kaks täispöörde (kuni 720°).
- Juhtetraadi eemaldamiseks ja uuesti sisestamiseks loputage seda hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahuse või muu sobiva lahusega, et takistada õhu sattumist röntgenoloogilisse seadmesse. Vahetage juhtetraati ettevaatlikult, et vältida õhu sisnemist ja/või trauma tekkimist. Juhtetraadi uuesti sisestamisel veenduge, et röntgenoloogilise seadme ots oleks vabalt vereosone valendikus ega puutuks vastu vereosone seina. Vastasel juhul tekib vigastuste oht. Asukohta kindimiteks kasutage röntgenoloogilise seadme röntgenkontrastset markerit.
- Juhtetraadi vaba liikumine röntgenoloogilises seadmes on juhitava juhtetraadi süsteemi oluline funktsioon, kuna see annab kasutajale väärtuslikku takistust teavet. Enne kasutamist kontrollige süsteemi mis tahes takistuste suhtes. Kui hemostaatiline klapp takistab juhtetraadi liikumist, reguleerige hemostaatilist klappi või vahetage see välja reguleeritava klapi vastu.

Tõrked ja kõrvaltoimed

Juhtetraadi kasutamises tingitud võimalike tõrgete ja kõrvaltoimete hulka kuuluvad muuhulgas järgmised.

1. Talitlushäired

Juhtetraadi purunemine või kõverdumine	Kahjustus, näiteks eraldumine	Katte eraldumine
		

- Ärge sisestage stenti kasutades enam kui ühte juhtetraati või kui käsitseti traati läbi stendi seinaga. Vastasel juhul võib stent kahjustada või juhtetraat võib puruneda või lahtil tulla.
- Enne kasutamist veenduge, et juhtetraat oleks protseduuri jaoks sobiva suuruse ja kujuga ning ühilduks kombineeritud kasutatava seadmega.
- Lugege selle juhtetraadiga koos kasutatava meditsiiniseadme (nt sekumisiraviseadme) kasutusjuhendit.
- Juhtetraadiga ühendamiseks tuleb eemaldatav pikendustraati kindlalt sisestada juhtetraadi proksimaalse otsa mitte-PTFE katte ja PTFE katte piirile. Kui ühenduses avastatakse hääreid, lõpetage juhtetraadi kasutamine kohe.
- Kontrollige juhtetraati hoolikalt painutuskohtade, keerdude ja muude kahjustuste suhtes enne kasutamist ja igal võimalikul ajal protseduuri jooksul. Ärge kasutage juhtetraati, kui see on kahjustatud. Olge otsa vormimisel ettevaatlik, et spiraali mitte kahjustada.
- Enne juhtetraadi sisestamist kontrollige, milline ots on distaalse otsa, ja sisestage see kindlasti distaalsest otsast.
- Protseduuri ajal säilitage pidev hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahuse vool juhtekateetri ja sekumiseadme ning sekumiseadme ja juhtetraadi vahel. Lõbbivoolutus ennetab kontrastaine kristallide teket ja/või hüüvete tekkimist juhtetraati ning kateetri valendikku.
- Kui hoidikul on distaalse otsa kaitsetoru (vt Kasutamine, joonis 1), ärge eemaldage ega sisestage distaalse otsa kaitsetoru siis, kui juhtetraat paikneb hoidikus.
- Kui hoidikul on distaalse otsa kaitsetoru (vt Kasutamine, joonis 1), eemaldage distaalse otsa kaitsetoru enne juhtetraadi uuesti hoidikusse paigutamist.

2.Kõrvaltoimed

Surm	Infektsioon	
Vererõhu langus	Veritsustüsistused	Emboolia
Kärbumine	Vaskulaarne oklusioon	Tromb
Isheemia	Arütmia	Veresoone dissektsioon
Vasospasm	Pearinglus	Peavalu
Oksendamine	Veresoone perforatsioon	Allergiline reaktsioon

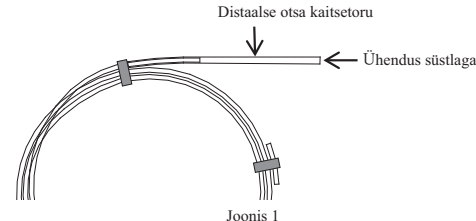
Kasutamine

- | | |
|--|---|
| <p>1. Kasutuseelne kontrollimine</p> <p>a) Enne kasutamist kontrollige juhttraati ja pakendit hoolikalt ja veenduge, et need oleksid kahjustamata.</p> <p>b) Enne kasutamist veenduge, et juhttraat ühilduks kasutatavate menetlusradioloogiliste seadmetega.</p> <p>2. Ettevalmistus</p> <p>a) Valige kahjustatud ala jaoks sobivaim juhttraat ja eemaldage hoidiktoru koos juhttraadiga steriilselt pakendist.</p> <p>b) Täitke hoidiktoru hepariniseeritud ja</p> | <p>steriliseeritud füsioloogilise lahusega, kasutades kogu seadme märjaks tegemiseks süstalt. Arvestage, et sellel ajal võib hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogiline lahus hoidiktorust välja pritsida.</p> <p>c) Täitke röntgenoloogilise seadme valendik hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahusega enne juhttraadi sisestamist.</p> <p>d) Vabastage juhttraat sabaklambrist ja lükake juhttraadi distaalne ots aeglaselt läbi hoidiktoru (B) (joonis 2).</p> |
|--|---|

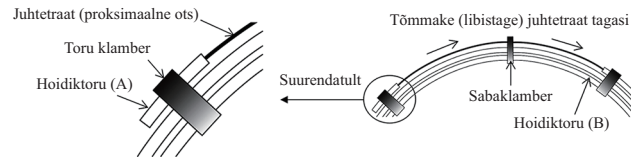
steriliseeritud füsioloogilise lahusega, kasutades kogu seadme märjaks tegemiseks süstalt. Arvestage, et sellel ajal võib hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogiline lahus hoidiktorust välja pirtsida.

c) Täitke röntgenoloogilise seadme valendik hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahusega enne juhtetraadi sisestamist.

d) Vabastage juhtetraat sabaklambrist ja lükake juhtetraadi distaalne ots aeglaselt läbi hoidiktoru (B) (joonis 2).



Joonis 1



Joonis 2

- e) Kui juhtetraadi distaalne ots on hoidiktoru teisest otsast (või distaalse otsa kaitsetorust)

rohkem kui 5 kuni 6 cm väljas, siis võite vajaduse korral muuta otsa kuju tavapärase

- praktika kohaselt.
- f) Haarake õrnalt juhtetraadist, mis väljus hoidiktoru distaalsest otsast (või distaalse otsa kaitsetorust), võimalikult hoidiku toru lähedalt ning tõmmake juhtetraat aeglaselt ja ettevaatlikult välja.
- g) Kui juhtetraadi eemaldamisel hoidiktorust on tunda takistust, süstige hepariniseeritud ja steriiliseeritud füsioloogilist lahust uuesti hoidiktorusse. Jätka juhtetraadi eemaldamist kui takistust pole enam tunda. Veenduge, et süstiksite hoidiktorusse piisavalt hepariniseeritud ja steriiliseeritud füsioloogilist lahust, sest hüdrofiilne kate võib kahjustada, kui kattega juhtetraadi eemaldamisel kasutatakse jõudu.
- h) Pärast juhtetraadi hoidiktorust välja tõmbamist kontrollige, et see ei oleks kahjustatud.

3. Sisestamismeetodid

- Üle traadi süsteem
 - a) Sisestage juhtetraadi distaalne ots ettevaatlikult röntgenoloogilise seadme juhtetraadi valendikku.
 - b) Lükake juhtetraati ettevaatlikult edasi, kuni selle ots on röntgenoloogilise seadme otsa suhtes täpselt proksimaalselt.
 - c) Haarake juhtekateeter ja sisestage röntgenoloogilise seadme süsteemi (koos juhtetraadiga) Y-konnectorisse.
 - d) Lükake röntgenoloogilise seadme süsteemi läbi juhtekateetri kuni juhtetraadi süsteemi ots on juhtekateetri otsa suhtes täpselt proksimaalselt.
 - e) Pinguldage Y-konnectori hemostaatilist klappi, et röntgenoloogilise seadme ümber tekiks tihend. Veenduge, et juhtetraati saaks siiski liigutada.
 - f) Kontrollige, et juhtetraat liiguks sujuvalt.
 - g) Vajaduse korral kinnitage traadipööramise seadme juhtetraadi külge.
 - h) Lükake seda juhtetraati kahjustusest läbi minemiseks röntgenoloogilisel kontrollides edasi. Veenduge

angiograafiliselt, et juhtetraat oleks läbinud vastava kitsenenud kahjustuskolde.

i) Jälgige juhtetraadi liikumist veresoontes.

j) Lükake röntgenoloogilist seadet edasi kuni kahjustuseni ja hoidke samas juhtetraati liikumatuna. Veenduge, et juhtetraadi distaalne ots ja selle asukoht veresoones oleks röntgenoloogilise seadme kasutamise ajal nähtav.

■ Kiire vahetamise süsteem

- a) Kinnitage juhtekateeter.
- b) Sisestage juhtetraadi sisestaja juhtekateetri Y-konnectorisse.
- c) Sisestage juhtetraadi ots ettevaatlikult sisestajasse.
- d) Lükake röntgenoloogilisel kontrollides juhtetraati läbi juhtekateetri kuni juhtetraadi ots on juhtekateetri otsaga täpselt proksimaalselt.
- e) Vajaduse korral kinnitage traadipööramise seadme juhtetraadi külge.
- f) Lükake juhtetraati kahjustusest läbi minemiseks röntgenoloogilisel kontrollides edasi. Veenduge angiograafiliselt, et juhtetraat oleks läbinud vastava kitsenenud kahjustuskolde.
- g) Jälgige juhtetraadi liikumist veresoontes.
- h) Eemaldage juhtetraadi pööramise seadme ja juhtetraadi sisestaja.
- i) Tuvastage juhtetraadil olev röntgenoloogiline seade, hoidke samas juhtetraati liikumatuna, ja lükake edasi kuni kahjustuseni. Veenduge, et juhtetraadi distaalne ots ja selle asukoht veresoones oleks röntgenoloogilise seadme kasutamise ajal nähtav.

4. Viisid juhtetraadi vahetamiseks

■ Üle traadi süsteem

- a) Eemaldage see juhtetraat aeglaselt ja jälgige samas juhtetraadi liikumist röntgenoloogilisel.
- b) Sisestage järgmine juhtetraat vastavalt peatikis „Kasutamine“ toodud juhiste.

Aegumiskuupäev

Aegumiskuupäev on toodud juhtetraadi pakendi etiketil.

Pakendi sisu

5 tükki karbis

Vastutusest loobumise säte

„ASAHI INTECC CO., LTD.“ ja sellega seotud ettevõtted (edaspidi „ettevõtte“) ei vastuta mingil viisil õnnetuste, vigastuste ega kõrvaltoimete eest, mille põhjuseks on toote sobimatu kasutamine või käesoleva juhendi eiramine. Mitte ühelgi juhul ei ole ettevõtte vastutav mis tahes kahjude eest, mis tulenevad kas i) toote (toodete) hoiustamisest pärast ettevõttepoolset tarnimist või ii) patsientide, operatsioonitehnikate või mis tahes muude meditsiiniliste tegevuste valikust toodet (tooteid) kasutava meditsiinasutuse poolt.

„Gadius“, „Halberd“, „ASAHI Gaia“ ja „Astato“ on ettevõtte ASAHI INTECC CO., LTD. registreeritud kaubamärgid Jaapanis ja teistes riikides.

* Otsa koormuse väärtused tähistavad keskmisi toote tehnilisi väärtusi, mis on mõõdetud standardse rahvusvahelise testimismetoodiga, mille kohaselt avaldatakse juhtetraadi otsaga lesioonile jõudu.

Hoiustamine

Ärge hoidke juhtetraati ja pakendit painutatuna ega suure raskuse all. Juhtetraati ja pakendit peab veest eemal hoidma. Hoidke jahedas, pimedas ja kuivas kohas.

Perifērā vadītājstīga

Lietošanas norādījumi

Pirms šīs vadītājstīgas lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un ievērojiet lietošanas norādījumus, kā arī šo lietošanas norādījumu mērķa ārstēšanas populācijas, kontrindikāciju, brīdinājumu, piesardzības pasākumu un lietošanas iedaļas. To neievērojot, var izraisīt sarežģījumus, tajā skaitā nopietnus pacienta savainojumus vai nāvi.

Ja lietotājs un/vai pacients uzzina par nopietnu negadījumu, kas radies saistībā ar vadītājstīgu, ziņojiet par šo faktu ražotājam un kompetentajai iestādei attiecīgajā dalībvalstī.

Šie lietošanas norādījumi attiecas uz šādām ierīcēm: Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Detalizētu informāciju (vadītājstīgas garumu, starojumu neausrūpīgās daļas garumu u. c.) skatiet izstrādājuma etiķetē.

Apraksts

Šīs vadītājstīgas pamatstruktūra sastāv no koniskās stīgas serdes un divu veidu distālajiem tinumiem (āreajā tinuma un iekšējā tinuma). Koniskā stīgas serde un tinumi ir lodēti. Daļa āreajā tinuma garuma ir rentgenkontrastējoša, lai tā novietojumu varētu viegli apstiprināt fluoroskopijas laikā. Ierīču Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 un ASAHI Gaia PV distālās malas ir pārklātas ar hidrofilu polimēru. Uz Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES un Gladius MG18 PV ES āreajā tinuma ir poliuretāna sveķu pārklājums, uz kura ir hidrofilis pārklājums. Visu šo vadītājstīgu koniskās stīgas serdes proksimālajā pusē ir pārklāta ar PTFE (politetrafluoretilēnu). Ierīču, kas ir īsākas par 300 cm, proksimālajā galā ir savienojuma vieta pagarinājuma stīgai, kura tiek izmantota, lai aizstātu kombinēto ierīci. Šajā vietā var pievienot ASAHI INTECC pagarinājuma stīgu. Lai uzzinātu par šā izstrādājuma uzgaļa slodzi*, skatiet tabulu tālāk tekstā.

1. tabula. Izstrādājuma specifiskācijas

Izstrādājuma nosaukums	Ārējais diametrs	Uzgaļa slodze*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014")	12 gf
	0,45 mm (0,018")	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm / 0,36 mm (0,008" / 0,014")	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm / 0,36 mm (0,009" / 0,014")	40 gf
Astato 30	0,33 mm / 0,45 mm (0,013" / 0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm / 0,45 mm (0,014" / 0,018")	7,5 gf

Lietošanas indikācijas

Šī vadītājstīga ir paredzēta vispārējai perkutānai perifērai intervencei (PPI). Šī vadītājstīga ir paredzēta, lai atvieglotu invazīvu terapeitisko ierīču ievietošanu apakšējo ekstremitāšu perifērajos asinsvados.

Šī vadītājstīga ir paredzēta lietošanai tikai apakšējo ekstremitāšu perifērajos asinsvados. Šī vadītājstīga nav paredzēta lietošanai neirovaskulārajās un kardiovaskulārajās sistēmās.

Ārstējamā mērķa populācija

Šī vadītājstīga ir paredzēta pacientiem, kuri atbilst PPI procedūru indikācijām. Tā nav indicēta lietošanai jaundzimušajiem, zīdaiņiem vai bērniem, kā arī pacientiem, kuri ir grūtnieces, kuriem ir nieru darbības traucējumi un kuriem ir alerģiska reakcija pret kontrastvielu vai polietilēnglikolu (PEG).

Kontrindikācijas

- Pirms faktiskās izmantošanas pārbaudiet vadītājstīgas diametra atbilstību citām ķirurģiskajām ierīcēm.
- Neizmantojiet šo vadītājstīgu pacientiem, kuriem ir alerģiska reakcija pret kontrastvielu vai kuriem ir nieru darbības traucējumi.
- Šīs vadītājstīgas hidrofilajā pārklājumā ir savienojums PEG400. Nelietojiet vadītājstīgu pacientiem, kuriem ir alerģiska reakcija uz polietilēna glikolu (PEG).
- Neizmantojiet vadītājstīgu grūtniecēm vai pacientēm, kurām varētu būt iestājusies grūtniecība (rentgenstari var ietekmēt augli).
- Šī vadītājstīga jāizmanto iestādē, kur var tūlītēji veikt ķirurģisku operāciju. Ja nav pieejama tūlītēja ķirurģiskas operācijas iespēja, jaunākajā gadījumā var tikt izraisīti dzīvībai bīstami notikumi.
- Šī vadītājstīga ir iepriekš sterilizēta ar etilēnoksidu gāzi (EOG) un paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Neizmantojiet un nesterilizējiet atkārtoti. Ja to izmanto atkārtoti vai atkārtoti sterilizē, šīs vadītājstīgas un iepakojuma veiktspēja vai kvalitāte var tikt apdraudēta, un pastāv komplikācijas, tostarp, infekcijas risks.

Brīdinājumi

- Šī vadītājstīga jāizmanto tikai ārstam, kas pilnībā apguvis ārstēšanu ar PPI.
- Nekad neizmantojiet šo vadītājstīgu kopā ar katetriem, kuros ir metāla daļas, kas var nonākt tiešā saskarē ar šīs vadītājstīgas virsmu (piemēram, aterektomijas katetri, metāla dilatori), metāla adatas vai metāla ievadītāji.
- Vadītājstīgas lietošanas laikā pārbaudiet un uzraugiet tās uzgaļa kustību fluoroskopijas kontrolē. Nelietojiet tajās asinsvadu vietās, kuras netiek vizualizētas vai nevar vizualizēt.
- Nepievienojiet šo vadītājstīgu atvienojamiem stīgas pagarinājumiem, kas nav ASAHI INTECC ražojums. Neveiciet manipulācijas ar vadītājstīgu, kamēr ir pievienots atvienojamais stīgas pagarinājums. Pretējā gadījumā var sabojāties vadītājstīga vai var netīšām atvienoties atvienojamais vadītājstīgas pagarinājums.
- Nekādā gadījumā nemodificējiet šo vadītājstīgu.

Piesardzības

- Nelietojiet vadītājstīgu pēc etiķetē norādītā derīguma termiņa beigām. Izmetiet visas vadītājstīgas, kuru derīguma termiņš ir beidzies.
- Vadītājstīgas ir trausli instrumenti, tāpēc ar tām jārikojas uzmanīgi.
- Ja iesaiņojums ir atvērts vai bojāts, nelietojiet šo vadītājstīgu. Neatveriet iesaiņojumu līdz pašai lietošanai. Pārvietojot un izmantojot vadītājstīgu, izmantojiet aseptisku tehniku.
- Vadītājstīgai vienmēr jābūt mitrai, lai novērstu tās hidrofilā pārklājuma bojājumus.
- Neslaukiet vadītājstīgu, izmantojot organisku šķīdumu, piemēram, alkoholu.
- Pēc lietošanas izmetiet vadītājstīgu, piederumus un iepakojumu kā medicīniskos atkritumus,

ievērojot profilaktiskus pasākumus, lai novērstu infekcijas slimību izplatību.

- Nekādā gadījumā nestumiet, negrieziet, neizvelciet un nespiediet šo vadītājstīgu, ja ir jūtama pretestība. Stumjot vai spiežot šo vadītājstīgu ar spēku, iespējama vadītājstīgas sabojāšana un/vai uzgāļa atdalīšanās, kā arī iespējami tieši asinsvadu bojājumi. To neievērojot, šai vadītājstīgai var rasties bojājumi. Ar fluoroskopijas palīdzību nosakiet pretestības cēloni un veiciet visas nepieciešamās korektīvās darbības.
- Vienmēr virziet uz priekšu un atvelciet vadītājstīgu lēnām un uzmanīgi.
- Grozot šo vadītājstīgu asinsvadā, negroziet to nepārtraukti vienā virzienā. Griežot vadītājstīgu, griežiet to pamišus pulksteņrādītāju kustīgas virzienā un pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Neveiciet vairāk nekā divus apgriezienus (720°) vienā virzienā.
- Ņemot un no jauna ievietojot vadītājstīgu, noskalojiet to ar sterilizētu heparinizētu fizioloģisko šķīdumu, lai nepieļautu gaisa iekļuvi ķirurģiskajā ierīcē. Uzmanīgi veiciet šīs vadītājstīgas nomaiņu, lai nepieļautu gaisa iekļuvi un/vai traumas. Ievadot vadītājstīgu no jauna, pārliecinieties, vai ķirurģiskās ierīces gals ir brīvs asinsvada lūmenā un nepieskaras asinsvada sienai. To neievērojot, var izraisīt asinsvada traumas. Lai apstiprinātu pozīciju, izmantojiet storojuma necaurīdīgu ķirurģiskās ierīces marķieri.
- Brīva vadītājstīgas kustība ķirurģiskajā ierīcē ir svarīga vadāmas vadītājstīgas sistēmas funkcija, jo lietotājam tā nodrošina vērtīgu taustes informāciju. Pirms lietošanas pārbaudiet sistēmu, vai nav nekādas pretestības. Ja konstatējat, ka hemostatiskais vārsts kavē vadītājstīgas kustību, koriģējiet to vai aizstājiet ar regulējamu vārstu.
- Neveiciet stenta ievietošanu, izmantojot vairāk nekā vienu vadītājstīgu vai asinsvada operāciju

cauri stenta sienai. Pretējā gadījumā stents var tikt bojāts vai vadītājstīga var salūzt vai pārlūzt.

- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ir izvēlēts procedūrai atbilstošs vadītājstīgas izmērs un forma un vai tā ir saderīga ar ierīci, ko paredzēts lietot kombinācijā ar šo vadītājstīgu.
- Skatiet lietošanas norādījumus, kas pievienoti medicīniskajai ierīcei (piemēram, invazīvām terapeitiskām ierīcēm), ko jāizmanto kopā ar vadītājstīgu.
- Savienojot ar vadītājstīgu atvienojamo vadītājstīgas pagarinājumu, tas stingri jāievieto līdz robežlīnijai starp ne PTFE un PTFE pārkļāpumu vadītājstīgas proksimālajā galā. Ja savienojumā ir novērojama jebkāda problēma, nekavējoties pārtrauciet vadītājstīgas izmantošanu.
- Pirms lietošanas un procedūras veikšanas laikā (kad vien iespējams) uzmanīgi pārbaudiet vadītājstīgu, vai nav liekumu, mezglu vai citu bojājumu. Nelietojiet vadītājstīgu, ja tai ir bojājumi.
- Uzgāļa veidošanas laikā rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu tūnūmu.
- Pirms vadītājstīgas ievietošanas pārbaudiet, kurš ir distālais gals, un sāciet ievietošanu ar distālo galu.
- Procedūras laikā posmu starp vadītājkatetru un invazīvo ierīci, kā arī starp invazīvo ierīci un vadītājstīgu pastāvīgi skalojiet ar heparinizētu un sterilizētu fizioloģisko šķīdumu. Skalošana nodrošina, ka neveidojas kontrastvielas kristāli un/vai ka vadītājstīgā un katetra lūmenā neveidojas recekļi.
- Ja turētājs ir aprīkots ar distālā uzgāļa aizsargcauruli (skatiet 1. attēlu sadaļā Lietošana), nenovietojiet distālā gala aizsargcauruli, kamēr vadītājstīga ir ievietota turētājā.
- Ja turētājs ir aprīkots ar distālā uzgāļa aizsargcauruli (skatiet 1. attēlu sadaļā Lietošana), ņemiet distālā uzgāļa aizsargcauruli, pirms vadītājstīga no jauna tiek ievietota turētājā.

1. Darbības traucējumi

Vadītājstīgas salūšana vai saliekšanās	Bojājums, piemēram, atdalīšanās	Pārkļāpuma atdalīšanās
Nāve	Infekcija	
Asinsspiediena pazemināšanās	Asināšanas sarežģījumi	Embolija
Infarkts	Asinsvadu aizsprostojums	Trombi
Išēmija	Aritmija	Asinsvada disekcija
Asinsvadu spazmas	Reibonis	Galvassāpes
Vemšana	Asinsvada perforācija	Alerģiska reakcija

Lietošana

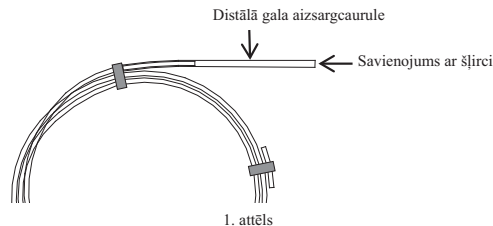
1. Pārbaude pirms lietošanas

- Pirms lietošanas uzmanīgi pārbaudiet vadītājstīgu un iepakojumu un pārliecinieties, vai nav bojājumu.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, vai vadītājstīga ir saderīga ar izmantojamo ķirurģisko ierīci.

2. Sagatavošana

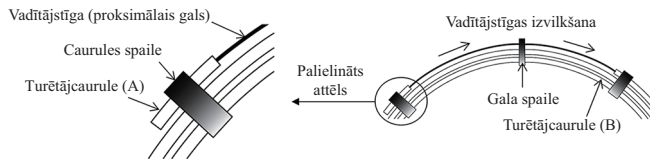
- Izvēlieties attiecīgajai vietai vispiemērotāko vadītājstīgu un izņemiet no sterila iepakojuma turētājcauruli, kurā ir vadītājstīga.

- Piepildiet turētājcauruli ar heparinizētu, sterilu fizioloģisko šķīdumu, izmantojot šļirci, lai samērcētu visu ierīci. Ievērojiet, ka, to darot, no turētājcaurules var izlīst heparinizētais, sterlais fizioloģiskais šķīdums.
- Pirms ievietojat vadītājstīgu, piepildiet ķirurģiskās ierīces lūmenu ar heparīnu saturošu sterilizētu fizioloģisko šķīdumu.
- Atbrīvojiet vadītājstīgu no gala spaites un lēni kustiniet vadītājstīgu, izstumiet vadītājstīgas distālo galu caur turētājcauruli (B) (2. attēls).



Darbības traucējumi un blakusparādības

Izmantojot šo vadītājstīgu, iespējamie darbības traucējumi un blakusparādības ietver, bet neaprobežojas ar tālāk norādītajiem.



2. attēls

e) Kad vadītājstīgas distālais gals ir izvērsts 5–6 cm aiz turētājcaurules otra gala (vai distālā gala aizsargcaurules), ja nepieciešams, veidojiet uzgāļa formu atbilstoši standartu praksei.

f) Vadītājstīgu, kas tika izvērta no turētājcaurules distālā gala (vai distālā gala aizsargcaurules), saudzīgi satveriet pēc iespējas tuvāk turētājcaurulei un lēnām un uzmanīgi izvelciet.

g) Ja, izņemot vadītājstīgu no turētājcaurules, jūtama pretestība, injicējiet turētājcaurulē no jauna heparīnu saturošu sterilizētu fizioloģisko šķidrumu. Kad vairs nav jūtama pretestība, turpiniet vadītājstīgas izņemšanu. Noteikti injicējiet turētājcaurulē pietiekamu heparīnu saturošu sterilizētu fizioloģiskā šķidruma daudzumu, jo ar spēku noņemot pārkāto vadītājstīgu, var sabojāt hidrofilo pārklājumu.

h) Pēc vadītājstīgas izvilkšanas no turētājcaurules pārbaudiet to, lai pārlielinātās, vai nav bojājumu.

3. Ievietošanas procedūras

■ Stīgas sistēma

- Uzmanīgi ievietojiet vadītājstīgas distālo galu ķirurģiskās ierīces vadītājstīgas lūmenā.
- Uzmanīgi virziet šo vadītājstīgu, līdz tās gals ir tieši pie ķirurģiskās ierīces gala.
- Izmantojiet virzītājkatetru un ievietojiet ķirurģiskās ierīces sistēmu (ar vadītājstīgu) Y veida savienotājā.
- Virziet ķirurģiskās ierīces sistēmu caur virzītājkatetru, līdz vadītājstīgas sistēmas gals ir tieši pie virzītājkatetra gala.
- Savelciet Y veida savienotāja hemostatisko vārstu, lai izvairītos ķirurģiskās ierīces izolāciju. Pārliiciniet, vai vadītājstīgas kustība netiek traucēta.

f) Pārbaudiet, vai vadītājstīgas kustība notiek bez aizķeršanās.

g) Ja nepieciešams, pievienojiet vadītājstīgai pagriešanas ierīci.

h) Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājstīgu cauri bojājumam. Izmantojot angiogrāfiju, pārliiciniet, vai vadītājstīga ir pavirzīta garām sašaurinātajam mērķa bojājumam.

i) Novērojiet vadītājstīgas virzību asinsvadā.

j) Virziet ķirurģisko ierīci, līdz tiek sasniegts bojājums, vienlaikus nepieļaujot vadītājstīgas kustību. Nodrošiniet, lai, veicot manipulācijas ar ķirurģisko ierīci, būtu redzams vadītājstīgas distālais gals un tā atrašanās vieta asinsvadā.

■ Straujas nomaņas sistēma

- Izmantojiet virzītājkatetru.
- Ievietojiet vadītājstīgas ievadītāju virzītājkatetra Y veida savienotājā.
- Uzmanīgi ievietojiet vadītājstīgas galu ievadītājā.
- Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājstīgu caur virzītājkatetru, līdz vadītājstīgas gals ir tieši pie virzītājkatetra gala.
- Ja nepieciešams, pievienojiet vadītājstīgai pagriešanas ierīci.
- Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājstīgu, lai tā izietu cauri bojājumam. Izmantojot angiogrāfiju, pārliiciniet, vai vadītājstīga ir pavirzīta garām sašaurinātajam mērķa bojājumam.
- Novērojiet vadītājstīgas virzību asinsvadā.
- Izmēriet vadītājstīgas pagriešanas ierīci un vadītājstīgas ievadītāju.
- Virziet ķirurģisko ierīci pa vadītājstīgu, vienlaikus nepieļaujot vadītājstīgas

kustību, un virziet to, līdz tiek sasniegts bojājums. Nodrošiniet, lai, veicot manipulācijas ar ķirurģisko ierīci, būtu redzams vadītājstīgas distālais gals un tā atrašanās vieta asinsvadā.

■ Stīgas sistēma

- Izmēriet vadītājstīgu lēni, vienlaikus novērojot tās kustību ar fluoroskopijas palīdzību.
- Ievietojiet nākamo vadītājstīgu atbilstoši norādījumiem šajā sadaļā "Lietošana".

4. Vadītājstīgas maiņas procedūras

Uzglabāšanas metode

Neglabājiet vadītājstīgu un iesaiņojumu saliektā un/vai noslogotā stāvoklī. Šī vadītājstīga un iesaiņojums jāsgargā no ūdens. Glabājiet tos vēsā, tumšā un sausā vietā.

Derīguma termiņš

Derīguma termiņš norādīts uz vadītājstīgas iesaiņojuma etiķetes.

Saturs

5 gabali/kaste

Saistību atruna

“ASAHI INTECC CO., LTD. un tā filiāles” (tālāk tekstā — “Uzņēmums”) nekādā gadījumā neatbild par negatīviem, personāla traumām un blakusparādībām, kas radušās, nepareizi vai jebkā citādi šiem norādījumiem neatbilstoši lietojot produktu(-s). Uzņēmums nekādā gadījumā neatbild ne par kādiem bojājumiem, kas (i) rodas, produktu(-s) glabājot pēc nosūtīšanas no Uzņēmuma, vai (ii) rodas, medicīnas iestādei, kura izmanto produktu(-s), izvēloties pacientus, ķirurģiskās iejaukšanās paņēmienus vai jebkādas citas medicīniskas darbības.

“Gladius”, “Halberd”, “ASAHI Gaia” un “Astato” ir uzņēmuma ASAHI INTECC CO., LTD. Japānā un citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

*Uzgāļa slodzes vērtības atspoguļo produkta specifikācijas vērtību vidējās vērtības, kas izmēritas saskaņā ar iekšējo standarta testēšanas metodi, nosakot spēku, ar kādu vadstīgas uzgali iedarbojas uz bojājumu.

Periferinė kreipiamoji viela

Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami šią kreipiamąją vielą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir atsižvelkite į šioje naudojimo instrukcijoje pateiktas naudojimo indikacijas, tikslinę gydymų asmenų grupę, kontraindikacijas, išspėjimus, atsargumo priemones bei skyrius „Kaip naudoti“. To nepadarius gali kilti komplikacijų, įskaitant sunkius paciento sužalojimus arba mirtį.

Jei naudotojas ir (arba) pacientas sužino apie rimtą incidentą, susijusį su kreipiamąja viela, jie turi pranešti apie tai gamintojui ir kompetentingai šalies narės institucijai.

Ši naudojimo instrukcija taikoma „Gladius“, „Gladius MG14 PV“, „Gladius MG14 PV ES“, „Gladius MG18 PV ES“, „Halberd“, „Astato XS 20“, „Astato XS 40“, „Astato 30“, „ASAHI Gaia PV“. Išsamios informacijos (kreipiamosios vielos ilgis, rentgenokontrastinės dalies ilgis ir t. t.) ieškokite gaminio etiketėje.

Aprašas

Pagrindinė šios kreipiamosios vielos konstrukciją sudaro kūginė pagrindinė viela ir dviejų tipų distalinės ritės (išorinė ritė ir vidinė ritė). Kūginė pagrindinė viela ir ritės yra sulituotos. Išorinė ritė iš dalies arba visa yra rentgenokontrastinė, todėl atliekant fluoroskopiją galima lengvai patvirtinti jos padėtį. Distalinės „Halberd“, „Astato XS 20“, „Astato XS 40“, „Astato 30“ ir „ASAHI Gaia PV“ pusės padengtos hidrofiliniu polimeru. „Gladius“, „Gladius MG14 PV“, „Gladius MG14 PV ES“ ir „Gladius MG18 PV ES“ yra padengtos poliuretano dervos danga ant išorinės ritės ir ant viršaus dar padengtos hidrofiline danga. Visų šių kreipiamųjų vielų proksimalinė kūginės pagrindinės vielos pusė yra padengta PTFE (politetrafluoretilenu). Proksimaliniame prietaisy, kurių bendrasis ilgis kitoks nei 300 cm, gale yra jungtis, skirta ilginamajai vielai, kuri naudojama siekiant pakeisti sudėtinį prietaisą. Galima prijungti ASAHI INTECC ilginamąją vielą.

Šio gaminio galiuko apkrova* nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.

1 lentelė. Gaminio specifikacijos

Gaminio pavadinimas	Išorinis skersmuo	Galiuko apkrova*
„Gladius“	0,36 mm (0,014 col.)	3 gf
	0,45 mm (0,018 col.)	4 gf
„Gladius MG14 PV“	0,36 mm (0,014 col.)	3 gf
„Gladius MG14 PV ES“	0,36 mm (0,014 col.)	3 gf
„Gladius MG18 PV ES“	0,46 mm (0,018 col.)	3 gf
	0,36 mm (0,014 col.)	12 gf
„Halberd“	0,45 mm (0,018 col.)	12 gf
	0,20 mm / 0,36 mm (0,008 col. / 0,014 col.)	20 gf
„Astato XS 20“	0,23 mm / 0,36 mm (0,009 col. / 0,014 col.)	40 gf
„Astato 30“	0,33 mm / 0,45 mm (0,013 col. / 0,018 col.)	30 gf
„ASAHI Gaia PV“	0,36 mm / 0,45 mm (0,014 col. / 0,018 col.)	7,5 gf

Naudojimo indikacijos

Ši kreipiamoji viela skirta naudoti bendrosios perkutaninės periferinės intervencijos (PPI) tikslais. Ši kreipiamoji viela skirta intervencinių gydymų prietaisų įvedimui į periferinę apatinių galūnių kraujagyslių sistemą palengvinti.

Ši kreipiamoji viela skirta naudoti tik periferinėje apatinių galūnių kraujagyslių sistemoje. Ši kreipiamoji viela neskirta naudoti neurovaskulinėje ir širdies bei kraujagyslių sistemoje.

Tikslinė gydymų asmenų grupė

Ši kreipiamoji viela skirta pacientams, kurie atitinka PPI procedūrų indikacijas. Šio įtaiso negalima naudoti naujagimiams, kūdikiams ar vaikams, taip pat nėščioms pacientėms, pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi ir kurie yra alergiški kontrastinei medžiagai ar polietilenglikoliui (PEG).

Kontraindikacijos

- Prieš naudodami patikrinkite kreipiamosios vielos skersmens suderinamumą su kitu intervenciniu prietaisu.
- Kreipiamosios vielos negalima naudoti pacientams, kurie yra alergiški kontrastinei medžiagai arba kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas.
- Šios kreipiamosios vielos hidrofilinėje dangoje yra PEG400. Nenaudokite kreipiamosios vielos pacientams, kurie yra alergiški polietilenglikoliui (PEG).
- Nenaudokite kreipiamosios vielos nėščioms arba galimai nėščioms pacientėms (rentgeno spinduliai gali paveikti vaisių).
- Ši kreipiamoji viela turi būti naudojama įstaigoje, kurioje nedelsiant galima atlikti neatidėliotą chirurginę operaciją. Jei neatidėliotinos chirurginės operacijos atlikti negalima, blogiausiu atveju gali įvykti gyvybei pavojingų įvykių.
- Ši kreipiamoji viela iš anksto sterilizuota etileno oksido dujomis (EOG) ir yra skirta naudoti tik vieną kartą. Nenaudokite ir nesterilizuokite pakartotinai. Pakartotinai naudojant ar pakartotinai sterilizuojant šią kreipiamąją vielą gali pablogėti jos veikimas ar kokybė ir gali padidėti komplikacijų, įskaitant infekciją, rizika.

Išspėjimai

- Šią kreipiamąją vielą gali naudoti tik gydytojas, išklaušęs visus PPI gydymo mokymus.
- Šios kreipiamosios vielos niekada nenaudokite kartu su kateteriais, turinčiais metalinių dalių, kurios gali tiesiogiai kontaktuoti su šios kreipiamosios vielos paviršiumi (pvz., aterektomijos kateteriais, metaliniais plėtikliais), metalinėmis adatomis arba metaliniais įvedikliais.
- Naudodami kreipiamąją vielą tikrinkite ir stebėkite jos galiuko judėjimą fluoroskopu.
- Nenaudokite kraujagyslės srityse, kurios nėra arba negali būti atvaizduotos.
- Nejunkite šios kreipiamosios vielos prie numamų ilginamųjų vielų, kurias pagamino ne ASAHI INTECC. Nevaldykite šios kreipiamosios vielos, kai prijungta numama ilginamoji viela. Priešingu atveju galite sugadinti kreipiamąją vielą arba gali netyčia atsijungti numama ilginamoji viela.
- Nemodifikuokite šios kreipiamosios vielos dėl bet kokios priežasties.

Atsargumo priemonės

- Nenaudokite kreipiamosios vielos pasibaigus etiketėje nurodytam galiojimo terminui. Išmeskite visas kreipiamąsias vielas, kurių galiojimo terminas praėjęs.
- Kreipiamosios vielos yra jautrūs instrumentai ir su jomis reikia elgtis atsargiai.
- Jei pakuotė atidaryta arba pažeista, kreipiamosios vielos nenaudokite. Pakuotę atidarykite tik prieš pat naudojimą. Įdomai ir naudodami kreipiamąją vielą, naudokite aseptinius metodus.

- Kreipiamąją vielą visada laikykite drėgnai, kad nepažeistumėte jos hidrofilinės dangos.
- Nevalykite kreipiamosios vielos organiniu tirpalu, pvz., alkoholiu.
- Panaudoję, išmeskite šią kreipiamąją vielą, priedus ir pakuotę kaip medicininės atliekas, imdamiesi apsauginių priemonių, skirtų apsisaugoti nuo infekcinių ligų.
- Nebandykite stumti, sukti, ištraukinėti ir sukioti kreipiamosios vielos, jeigu jaučiamas pasipriešinimas. Sukant ar stumiant per jėgą kyla gali būti pažeista kreipiamoji viela ir (arba) gali atitrūkti jos galiukas, arba gali būti tiesiogiai pažeista kraujagyslė. Nesilaikydami šių nurodymų, galite sugadinti šią kreipiamąją vielą. Fluoroskopu nustatykite pasipriešinimo priežastį ir imkitės visų reikalingų taisomųjų veiksmų.
- Kreipiamąją vielą visada stumkite arba traukite lėtai ir atsargiai.
- Sukdami šią kreipiamąją vielą kraujagyslėje, nesukite jos pastoviai ta pačia kryptimi. Kai sukate kreipiamąją vielą, pakaitomis sukite prieš laikrodžio rodyklę ir pagal laikrodžio rodyklę. Nesukite daugiau nei du sukimus (720°) ta pačia kryptimi.
- Kreipiamąją vielą ištraukdami ir vėl įstatydami praplaukite heparinizuotu ir sterilizuotu fiziologiniu tirpalu arba kitu atitinkamu tirpalu, kad išvengtumėte oro patekimo į intervencinį prietaisą. Atsargiai pakeiskite šią kreipiamąją vielą, kad išvengtumėte oro patekimo ir (arba) traumos. Vėl kišdami kreipiamąją vielą įsitikinkite, kad intervencinio prietaiso galiukas kraujagyslės spindyje juda laisvai ir nėra prie kraujagyslės sienelės. To nepadarys galite sukelti traumą. Padėti patvirtinkite naudojamesi intervencinio prietaiso rentgenokontrastiniais žymekliais.
- Tai, kad kreipiamoji viela gali lengvai judėti intervenciniame prietaise, yra svarbi valdomosios kreipiamosios vielos sistemos savybė, nes suteikia naudotojui vertingos taktinės informacijos. Prieš naudodami patikrinkite, ar sistemoje nėra pasipriešinimo. Sureguliuokite arba pakeiskite hemostazinį vožtuvą reguliuojamą vožtuvą, jei jis trukdo kreipiamajai vielai judėti.
- Įvesdami stentą naudokite tik vieną kreipiamąją vielą ir nebandykite kišti vielos pro stento atramą. Priešingu atveju stentas gali būti pažeistas arba kreipiamoji viela gali sulūžti arba perlūžti.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad ši kreipiamoji viela yra tinkamo dydžio ir formos, kad būtų galima atlikti procedūrą, ir yra suderinama su prietaisu, kuris bus naudojamas kartu.
- Žr. naudojimo instrukciją, pateiktą su medicinos prietaisu (pvz., intervenciniais gydymaisiais prietaisais), ketinamu naudoti su šia kreipiamąja viela.
- Nuimamą ilginamąją vielą prijungiant prie šios kreipiamosios vielos, kreipiamąją vielą gali reikėti tvirtai įstatyti prie ribinės linijos tarp dangos be PTFE ir PTFE dangos proksimaliniame kreipiamosios vielos galiuke. Jei jungtyje aptinkama kokių nors anomalijų, nedelsdami nustokite naudoti kreipiamąją vielą.
- Prieš naudodami ir, jei įmanoma, per procedūrą atidžiai patikrinkite, ar kreipiamoji viela nėra sulenkta, susisukusi ar kitaip pažeista. Nenaudokite kreipiamosios vielos, jei ji pažeistas.
- Formuodami galiuką būkite atsargūs, kad nepažeistumėte ritės.
- Prieš įvesdami kreipiamąją vielą patikrinkite, kuris galiukas yra distalinis, ir įsitikinkite, kad ji vedate pradėdami nuo distalinio galiuko.
- Per procedūrą užtikrinkite nuolatinį plovimą heparinizuotu ir sterilizuotu fiziologiniu tirpalu tarp kreipiamojo kateterio ir intervencinio prietaiso bei tarp intervencinio prietaiso ir kreipiamosios vielos. Plovimas neleidžia kristalizuotis kontrastinei medžiagai ir (arba) krešuliams susidaryti ant kreipiamosios vielos ir kateterio spindyje.
- Jei naudojate laikiklį su distalinio galo apsauginiu vamzdeliu (žr. „Kaip naudoti“, 1 pav.), neišimkite ir neikiškite distalinio galo apsauginio vamzdelio, kol kreipiamoji viela yra laikiklyje.
- Jei naudojate laikiklį su distalinio galo apsauginiu vamzdeliu (žr. „Kaip naudoti“, 1 pav.), prieš vėl įdėdami kreipiamąją vielą į laikiklį, išimkite distalinio galo apsauginį vamzdelį.

Sutrikimai ir nepageidaujami reiškiniai

Naudojant šią kreipiamąją vielą gali pasitaikyti toliau išvardytų sutrikimų ir nepageidaujamų reiškinių, tačiau šis sąrašas nėra išsamus.

1. Sutrikimai

Kreipiamosios vielos lūžis arba sulinkimas	Pažeidimas, pavyzdžiui, atsiskyrimas	Dangos atsiskyrimas
Mirtis	Infekcija	
Sumažėjęs kraujo spaudimas	Komplikacijos dėl kraujavimo	Embolija
Infarktas	Kraujagyslių okliuzija	Trombas
Išemija	Aritmija	Kraujagyslės disekcija
Vazospažmas	Galvos svaigimas	Galvos skausmas
Vėmimas	Kraujagyslės perforacija	Alerginė reakcija

Kaip naudoti

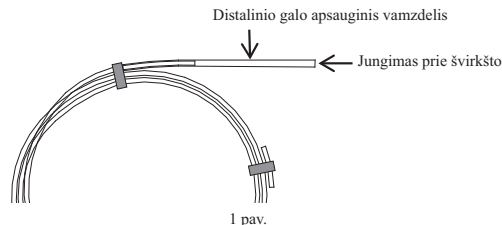
1. Apžiūra prieš naudojant

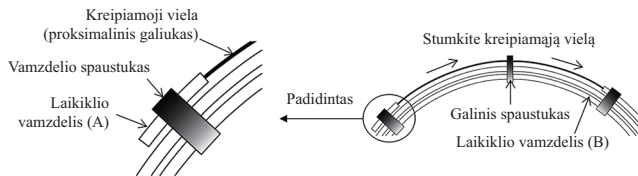
- Prieš naudodami atidžiai apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad kreipiamoji viela ir pakuotė nepažeisti.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar kreipiamoji viela yra suderinama su intervenciniu prietaisu, kurį planuojama naudoti.

2. Paruošimas

- Pasirinkite pažeistai sričiai tinkamiausią kreipiamąją vielą ir iš sterilios pakuotės išimkite laikiklio vamzdelį, kuriame yra kreipiamoji viela.
- Laikiklio vamzdelį švirkštu užpildykite

- heparinizuotu ir sterilizuotu fiziologiniu tirpalu, kad sudrėkintumėte visą prietaisą. Atkreipkite dėmesį, kad šiuo metu heparinizuotas ir sterilizuotas fiziologinis tirpalas neišsiliėtų iš laikiklio vamzdelio.
- Prieš įvesdami kreipiamąją vielą intervencinio prietaiso spindį užpildykite heparinizuotu ir sterilizuotu fiziologiniu tirpalu.
 - Atjunkite kreipiamąją vielą nuo galinio spaustuvo ir lėtai slinkite kreipiamąją vielą, kreipiamosios vielos distalinį galą stumkite pro laikiklio vamzdelį (B) (2 pav.).





2 pav.

- e) Kai kreipiamosios vielos distalinis galas išlenda 5–6 cm pro kitą laikiklio vamzdelio galą (arba distalinio galo apsauginio vamzdelio galą), jei reikia, galiuką galite suformuoti įprastai.
- f) Švelniai stumkite kreipiamąją vielą, išlindusią pro distalinio galo laikiklio vamzdelį (arba distalinio galo apsauginį vamzdelį), kuo arčiau laikiklio vamzdelio, ir lėtai bei atsargiai ištraukite kreipiamąją vielą.
- g) Jeigu kreipiamąją vielą ištraukiant iš laikiklio vamzdelio juntamas pasipriešinimas, į laikiklio vamzdelį vėl suleiskite heparinizuoto ir sterilizuoto fiziologinio tirpalo. Kai nebejausite pasipriešinimo, toliau traukite kreipiamąją vielą. Būtinai į laikiklio vamzdelį suleiskite pakankamai heparinizuoto ir sterilizuoto fiziologinio tirpalo, nes stipriai traukiant kreipiamąją vielą su danga galima pažeisti hidrofilinę dangą.
- h) Ištraukę iš laikiklio vamzdelio kreipiamąją vielą, patikrinkite, ar ji nepažeista.

3. Įstatymo procedūros

- „Over-the-wire“ sistema
- Atsargiai įstatykite distalinį kreipiamosios vielos galiuką į intervencinio prietaiso kreipiamosios vielos spindį.
 - Stumkite kreipiamąją vielą, kol jos galiukas bus prie intervencinio prietaiso galiuko.
 - Prijunkite kreipiamąjį kateterį į įstatykite intervencinio prietaiso sistemą (su kreipiamąją viela) į Y formos jungiamąją dalį.
 - Stumkite intervencinio prietaiso sistemą pro kreipiamąjį kateterį, kol kreipiamosios vielos sistemos galiukas bus šalia kreipiamojo kateterio galiuko.
 - Užsukite Y formos jungiamosios dalies

- hemostazinį vožtuvą, kad intervencinis prietaisas būtų sandarus. Įsitikinkite, kad kreipiamoji viela vis dar gali judėti.
- Patikrinkite, ar kreipiamoji viela sklandžiai juda.
 - Jei reikia, prie kreipiamosios vielos prijunkite sukimo prietaisą.
 - Stebėdami fluoroskopu prakiškite kreipiamąją vielą pro pažeidimą. Naudodami angiografiją įsitikinkite, kad kreipiamoji viela praėjo pro siauriausią tikslinį pažeidimą.
 - Stebėkite kreipiamosios vielos judėjimą kraujagyslėje.
 - Nejudindami kreipiamosios vielos, stumkite intervencinį prietaisą, kol pasieksite pažeidimo vietą. Įsitikinkite, kad kreipiamosios vielos distalinis galiukas ir jo padėtis kraujagyslėje matoma atliekant manipuliacijas intervenciniu prietaisu.

■ Greitojo pakeitimo sistema

- Prijunkite kreipiamąjį kateterį.
- Įstatykite kreipiamosios vielos stūmiklį į kreipiamojo kateterio Y formos jungiamąją dalį.
- Atsargiai įstumkite kreipiamosios vielos galiuką į stūmiklį.
- Stumkite kreipiamąją vielą pro kreipiamąjį kateterį stebėdami fluoroskopu, kol kreipiamosios vielos galiukas atsidurs šalia kreipiamojo kateterio galiuko.
- Jei reikia, prie kreipiamosios vielos prijunkite sukimo prietaisą.
- Stebėdami fluoroskopu prakiškite kreipiamąją vielą pro pažeidimą. Naudodami angiografiją įsitikinkite, kad kreipiamoji viela praėjo pro siauriausią tikslinį pažeidimą.
- Stebėkite kreipiamosios vielos judėjimą kraujagyslėje.

- h) Nuimkite kreipiamosios vielos sukimo prietaisą ir kreipiamosios vielos stūmiklį.
- i) Stumkite intervencinį prietaisą virš kreipiamosios vielos saugodami, kad kreipiamoji viela nejudėtų, kol bus pasiektas pažeidimas. Įsitikinkite, kad kreipiamosios vielos distalinis galiukas ir jo padėtis kraujagyslėje yra matoma atliekant manipuliacijas intervenciniu

prietaisu.

4. Kreipiamosios vielos pakeitimo procedūros

- „Over-the-wire“ sistema
- a) Lėtai ištraukite kreipiamąją vielą stebėdami jos judėjimą fluoroskopu.
 - b) Remdamiesi skyriuje „Kaip naudoti“ pateiktais nurodymais, įstatykite kitą kreipiamąją vielą.

Sandėliavimo būdas

Kreipiamosios vielos ir pakuotės nelaikykite sulenktų ir (arba) labai suspaustų. Šią kreipiamąją vielą ir pakuotę reikia laikyti atokiau nuo vandens. Laikykite vėsioje, tamsioje ir sausoje vietoje.

Galiojimo terminas

Galiojimo terminas nurodytas kreipiamosios vielos pakuotės etiketėje.

Turiny

5 vienetai dėžutėje

Atsakomybės atsakymas

Bendrovė ASAHI INTECC CO., LTD. ir su ja susijusios bendrovės (toliau – „Bendrovė“) nėra atsakingos už nelaimingus atsitikimus, kūno sužalojimus ar kitus neigiamus reiškinius, kuriuos sukėlė bet koks gaminio (-ių) netinkamas naudojimas ar bet koks kitas naudojimas, kuris neatitinka šių nurodymų. Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neatsako už žalą, kuri atsiranda dėl i) netinkamo gaminio (-ių) laikymo po įsigijimo iš Bendrovės dienos arba ii) dėl netinkamo sveikatos priežiūros įstaigos, kuri naudoja gaminį (-ius), pacientų, operacinės technikos ar medicininių procedūrų pasirinkimo.

„Gladius“, „Halberd“, „ASAHI Gaia“ ir „Astato“ yra „ASAHI INTECC CO., LTD.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Japonijoje ir kitose šalyse.

*Galiuko apkrovos vertės yra vidutinės gaminio specifikacijos vertės, išmatuotos pagal vidinį standartinį bandymų metodą, darant prielaidą, kad kreipiamosios vielos galiukas veikia pažeidimą jėga.

Periferik Kılavuz Teli

Kullanım Talimatları

Bu kılavuz telini kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve bu Kullanım Talimatlarında yer alan Kullanım Endikasyonları, Tedaviye Yönelik Hedef Kitle, Kontrendikasyonlar, Uyarılar, Kullanım Önlemleri ve Kullanma Şekli bölümlerini inceleyin. Aksi durumda hastanın ciddi şekilde yaralanması veya ölümü dâhil komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Bir kullanıcı ve/veya hasta kılavuz telle ilgili ciddi bir olaydan haberdar olursa bu durumu üreticiye ve Üye Devletin yetkili makamına bildirin.

Bu Kullanım Talimatları; Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV için geçerlidir. Ayrıntılı bilgi için (kılavuz tel uzunluğu, radyopak bölüm uzunluğu, vb.), ürün etiketine bakın.

Açıklamalar

Bu kılavuz telinin temel yapısı konik bir çekirdek tel ve iki çeşit distal halkadan (bir dış halka ve bir iç halka) oluşur. Konik çekirdek tel ve halkalar lehimlidir. Dış halkanın bir kısmı veya tamamı radyopaklıdır, böylece floroskopi ile yeri kolayca tespit edilebilir. Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 ve ASAHI Gaia PV'nin distal tarafları hidrofilik polimer ile kaplanmıştır. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES ve Gladius MG18 PV ES'nin her birinin dış halkasından poliyüreten rezin kaplama ve bunun üzerinde hidrofilik kaplama bulunmaktadır. Tüm bu kılavuz tellerinde konik çekirdek telin proksimal tarafı PTFE (politetrafloroetilen) ile kaplıdır. Toplam uzunluğu 300 cm olanlar dışındaki cihazların proksimal ucunda, birleşik cihazı değiştirmek için kullanılan bir uzatma teli için bir bağlantı vardır; ASAHI INTECC'in Uzatma Teli bağlanabilir.

Bu ürünün uç yükü* için aşağıdaki tabloya bakın.

Tablo 1. Ürün özellikleri

Ürün Adı	Dış Çap	Uç Yüğü*
Gladius	0,36 mm (0,014 inç)	3 gf
	0,45 mm (0,018 inç)	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014 inç)	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014 inç)	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018 inç)	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014 inç)	12 gf
	0,45 mm (0,018 inç)	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008 inç/0,014 inç)	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009 inç/0,014 inç)	40 gf
Astato 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013 inç/0,018 inç)	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014 inç/0,018 inç)	7,5 gf

Kullanım Endikasyonları

Bu kılavuz teli, genel perkütan periferik girişim (PPI) için tasarlanmıştır. Bu kılavuz teli, girişimsel terapötik cihazların alt ekstremitenin periferik vaskülatürü içine yerleştirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Bu kılavuz teli yalnızca alt ekstremitenin periferik vaskülatüründe kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kılavuz teli nörovaskülatür ve kardiyovaskülatürde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Tedaviye Yönelik Hedef Kitle

Bu kılavuz teli, PPI prosedürlerine ilişkin endikasyonlara sahip hastalar için tasarlanmıştır. Yenidoganlarda, bebeklerde veya çocuklarda ve hamile olan, böbrek fonksiyon bozukluğu olan ve kontrast maddelere veya polietilen glikole (PEG) karşı alerjik reaksiyon gösteren hastalarda kullanım için endike değildir.

Kontrendikasyonlar

- Gerçek kullanımdan önce kılavuz tel çapının diğer girişimsel cihazlarla uyumluğunu onaylayın.
- Kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gösteren veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kılavuz teli kullanmayın.
- Bu kılavuz tel, hidrofilik kaplamasında PEG400 içerir. Polietilen glikole (PEG) karşı alerjik reaksiyon gösteren hastalarda kılavuz teli kullanmayın.
- Kılavuz teli hamile hastalar veya hamile olma ihtimali olan hastalar için kullanmayın (Röntgen fetüsü etkileyebilir).
- Bu kılavuz tel, acil cerrahi işlemlerin hemen gerçekleştirilebileceği bir tıbbi kurumda kullanılmaldır. Bir acil cerrahi işlem yapılmazsa en kötü durumda yaşamı tehdit edici olaylar meydana gelebilir.
- Bu kılavuz tel, etilen oksit gazıyla (EOG) önceden sterilize edilmiştir ve yalnızca tek kullanımlıktır. Tekrar kullanmayın veya tekrar sterilize etmeyin. Tekrar kullanıldığında veya tekrar sterilize edildiğinde kılavuz telin ve paketin performansı veya kalitesi bozulabilir ve enfeksiyon dâhil komplikasyon riski oluşabilir.

Uyarılar

- Bu kılavuz telini yalnızca PPI tedavisi konusunda tam eğitim almış bir hekim kullanılmaldır.
- Bu kılavuz telini asla bu kılavuz telinin yüzeyine doğrudan temas edebilecek metal parçalara sahip kateterler (ör. aterektomi kateterleri, metal dilatörler), metal iğneler veya metal introdüserlerle birlikte kullanmayın.
- Kılavuz telin kullanımı sırasında ucunun hareketini floroskopi altında kontrol edin ve izleyin. Görselleştirilmemiş veya görselleştirilemeyen damar bölgelerinde kullanmayın.
- Bu kılavuz teli, ASAHI INTECC dışındaki üreticilerin ürettiği ayrılabilir uzatma telleriyle bağlamayın. Bu kılavuz teli, ayrılabilir uzatma teli bağliken hareket ettirmeyin. Aksi halde kılavuz tel hasar görülebilir veya ayrılabilir uzatma teli kazara çıkabilir.
- Bu kılavuz tel üzerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapmayın.

Kullanım Önlemleri

- Bu kılavuz teli etikette belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Son kullanma tarihi geçmiş telleri atın.
- Kılavuz teller hassas aletlerdir ve dikkatle kullanılmaldır.
- Ambalajı açılmış veya hasar görmüş kılavuz teli kullanmayın. Kullanımın hemen öncesine kadar ambalajı açmayın. Kılavuz teli taşırlan ve kullanırken aseptik teknik kullanın.
- Hidrofilik kaplamanın zarar görmesini önlemek için kılavuz teli daima ıslak halde tutun.

- Bu kılavuz teli alkol gibi organik bir solüsyon kullanılarak silmeyin.
- Kullanımdan sonra, bulaşıcı hastalıklara karşı önleyici tedbirler olarak bu kılavuz telini, aksesuarları ve ambalajı tıbbi atık olarak atın.
- Bu kılavuz teli direnç hissedilebilecek şekilde hiçbir zaman itmeyin, bükmeyin, geri çekmeyin veya bastırmayın. Bu kılavuz telin dirence karşı torklanması veya itilmesi, bu kılavuz telin hasar görmesine ve/veya ucunun ayrılmasına veya bir kaba doğrudan zarar vermesine neden olabilir. Bunun yapılmaması bu kılavuz telin hasar görmesine neden olabilir. Direncin nedenini floreskopi altında belirleyin ve durumu düzeltmek için gereken önlemleri alın.
- Kılavuz telini her zaman yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerletin veya geri çekin.
- Bu kılavuz tele kan damarının içinde tork uygularken torku sürekli aynı yönde uygulamayın. Bu kılavuz tele tork uygularken teli sırayla saat yönünde ve saat yönünün tersine döndürün. Kılavuz teli aynı yönde ikiden fazla kez (720°) döndürmeyin.
- Kılavuz teli çıkarırken veya yeniden takarken girişimsel cihaza hava girmesini önlemek için kılavuz teli heparinize salın veya uygun başka solüsyonla yıkayın. Hava girmesini ve/veya travma oluşmasını önlemek için bu kılavuz teli dikkatle değiştirin. Kılavuz teli yeniden yerleştirirken girişimsel cihazın ucunun damar lümeninin içinde sürekli bir heparinize ve damar duvarına yaslanmadığını teyit edin. Bunun yapılmaması travmaya neden olabilir. Konumu doğrulamak için girişimsel cihazın radyopak işaretçiyi kullanın.
- Kılavuz telin girişimsel cihazın içerisinde serbest hareket etmesi, yönlendirilebilir bir kılavuz tel sisteminin önemli bir özelliğidir, çünkü bu, kullanıcıya değerli dokunma bilgileri verir. Sistemi kullanmadan önce direnç olup olmadığını test edin. Kılavuz telin hareketini engellediği görülüyorsa hemostaz valfini ayarlayın veya ayarlanabilir bir valfle değiştirin.

- Birden fazla kılavuz tel kullanarak veya stent desteği aracılığıyla teli kullanarak stent yerleştirmeyin. Aksi durumda stent hasar görebilir, kılavuz tel kopabilir veya kırılabilir.
- Kullanmadan önce, bu kılavuz telin boyut ve şekil olarak prosedür için uygun olduğunu ve birlikte kullanılacak cihazla uyumlu olduğunu onaylayın.
- Bu kılavuz teli ile birlikte kullanılacak tıbbi cihaza (ör. girişimsel terapötik cihazlar) ait Kullanım Talimatlarına bakın.
- Ayrılabilir uzatma telini bu kılavuz tele bağlarken ayrılabilir uzatma teli PTFE olmayan kaplama ve kılavuz telin proksimal ucuındaki PTFE kaplama arasındaki sınır çizgisine güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir. Bağlantıda herhangi bir anormallik tespit edilirse kılavuz teli kullanmayı derhal bırakın.
- Kullanmadan önce ve mümkün olduğu her durumda işlem sırasında kılavuz teli bükülmeler, kıvrılmalar ve başka hasarlar açısından dikkatle inceleyin. Kılavuz tel hasarlıysa kullanmayın.
- Ucu şekillendirirken bobine zarar vermemeye dikkat edin.
- Kılavuz teli yerleştirmeden önce hangi ucun distal uç olduğunu kontrol edin ve distal uçtan yerleştirdiğinizden emin olun.
- İşlem sırasında kılavuz kateter ile girişimsel cihaz arasında ve girişimsel cihaz ile kılavuz teli arasında sürekli bir heparinize ve sterilize salın yıkaması sağlayın. Yıkama işlemi kılavuz teli üzerinde ve kateter lümeninde kontrast madde kristal oluşumunu ve/veya pıhtılaşmayı önler.
- Distal uç koruma tüpüne sahip tutucu için (bkz. Kullanma Şekli, Şekil 1), kılavuz teli tutucu içindeyken distal uç koruma tüpünü çıkarmayın veya takmayın.
- Distal uç koruma tüpüne sahip tutucu için (bkz. Kullanma Şekli, Şekil 1), kılavuz teli tekrar tutucuya yerleştirmeden önce distal uç koruma tüpünü çıkarın.

2. Advers olaylar

Ölüm	Enfeksiyon	Emboli
Kan basıncında azalma	Kanamam komplikasyonları	Trombüs
Enfarktüs	Damar tıkanıklığı	Damar kesilmesi
İşkemi	Aritmi	baş ağrısı
Vazospazm	Baş dönmesi	Alerjik reaksiyon
Kusma	Damar delinmesi	

Kullanma Şekli

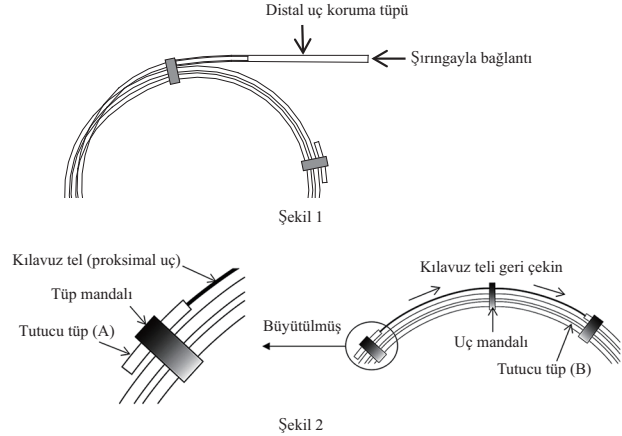
1. Kullanım öncesi denetim

- Kullanmadan önce, kılavuz telin ve ambalajının hasarsız olduğunu dikkatle inceleyin ve onaylayın.
- Kullanmadan önce, kılavuz telin kullanılacak girişimsel cihazla uyumlu olduğunu doğrulayın.

2. Hazırlık

- Etkilenen bölge için en uygun kılavuz teli seçin ve kılavuz teli içeren tutucu tüpü steril ambalajdan çıkarın.

- Tüm cihazı ıslatmak için bir şırınga kullanarak tutucu tüpü heparinize ve sterilize salinle doldurun. Bu sırada tutucu tüpten heparinize ve sterilize salın dökülebileceğini unutmayın.
- Kılavuz teli yerleştirmeden önce, girişimsel cihazın lümenini heparinize ve sterilize salinle doldurun.
- Kılavuz teli arkadaki mandaldan serbest bırakın ve kılavuz teli yavaşça kaydırarak kılavuz telin distal ucunu tutucu tüpten itin (B) (Şekil 2).



Arızalar ve Advers Olaylar

Bu kılavuz teli kullanırken ortaya çıkabilecek arızalar ve advers olaylar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler bulunmaktadır:

1. Arızalar

Kılavuz telin kırılması veya bükülmesi	Ayrılma gibi hasarlar	Kaplamanın çıkması
--	-----------------------	--------------------

- Kılavuz telin distal ucu, tutucu tüpün (veya distal uç koruma tüpü) diğer uçundan 5-6 cm uzaklıktaysa, gerektiği takdirde standart uygulamaya uygun şekilde ucu şekillendirin.
- Tutucu tüpün (veya distal uç koruma tüpü) distal uçundan çıkan kılavuz telini hafifçe

kavrayın, tutucu tüpe mümkün olduğunca yakın bir noktada kılavuz teli yavaş ve dikkatli şekilde dışarı çekin.

- g) Kılavuz teli tutucu tüpten çıkarırken direnç hissederseniz, tutucu tüpe yeniden heparinize ve sterilize salın ekleyin. Direnç hissetmeye kadar kılavuz teli çıkarmaya devam edin. Kaplamalı kılavuz tel kuvvetlice çıkarılırken hidrofilik kaplama hasar görebileceğinden, tutucu tüpe heparinize ve sterilize salın eklemeyi unutmayın.
- h) Kılavuz teli tutucu tüpten çekip çıkardıktan sonra, hasar görmediğinden emin olmak için kılavuz teli inceleyin.

3. Yerleştirme işlemleri

- Tel üzeri sistem
 - a) Kılavuz telin distal ucunu, girişimsel cihazın kılavuz tel lümeninin içine dikkatle yerleştirin.
 - b) Bu kılavuz teli, ucu girişimsel cihazın ucuna tam proksimal olana kadar dikkatle ilerletin.
 - c) Kılavuz kateter takın ve girişimsel cihaz sistemini (kılavuz telle birlikte) Y konektörüne yerleştirin.
 - d) Kılavuz tel sistemi kılavuz kateterin ucuna tam proksimal olana kadar girişimsel cihaz sistemini kılavuz katetere yerleştirin.
 - e) Y konektörünün hemostaz valfini sıkarak, girişimsel cihazın etrafından bir mühür oluşmasını sağlayın. Kılavuz telin halen hareket edebildiğinden emin olun.
 - f) Kılavuz telin pürüzsüz bir şekilde hareket ettiğini kontrol edin.
 - g) Gerekirse tork cihazını kılavuz tele takın.
 - h) Bu kılavuz teli, lezyondan geçene dek floroskopi altında ilerletin. Kılavuz telin hedef lezyonun dar bölümünden geçtiğini anjiyografiyle doğrulayın.
 - i) Kılavuz telin damarlardaki hareketini

gözlemleyin.

- j) Girişimsel cihazı, lezyona ulaşana kadar ilerletin ve bu sırada kılavuz telin hareket etmesini önleyin. Kılavuz telin distal ucunun ve damardaki konumunun girişimsel cihazın kullanılması sırasında görünür olduğundan emin olun.

■ Hızlı değiştirme sistemi

- a) Kılavuz kateteri takın.
- b) Kılavuz tel yerleştiricisini kılavuz kateterin Y konektörüne yerleştirin.
- c) Kılavuz telin ucunu yerleştiricinin içine dikkatle yerleştirin.
- d) Kılavuz teli, kılavuz telin ucu kılavuz kateterin ucuna tam proksimal olana kadar kılavuz katetere floroskopi altında ilerletin.
- e) Gerekirse tork cihazını kılavuz tele takın.
- f) Kılavuz teli, lezyondan geçene dek floroskopi altında ilerletin. Kılavuz telin hedef lezyonun dar bölümünden geçtiğini anjiyografiyle doğrulayın.
- g) Kılavuz telin damarlardaki hareketini gözlemleyin.
- h) Kılavuz tel tork cihazını ve kılavuz tel yerleştiricisini çıkarın.
- i) Kılavuz telin hareket etmesini önleyerek, girişimsel cihazı kılavuz telin üzerinden izleyin ve lezyona ulaşana kadar ilerletin. Kılavuz telin distal ucunun ve damardaki konumunun girişimsel cihazın kullanılması sırasında görünür olduğundan emin olun.

4. Kılavuz tel değiştirme işlemleri

- Tel üzeri sistem
 - a) Bu kılavuz telin hareketini floroskopi altında gözlemleyerek bu kılavuz teli yavaşça çıkarın.
 - b) Sonraki kılavuz teli, bu “Kullanma şekli” bölümündeki talimatlara göre yerleştirin.

Paket İçeriği

5 adet/kutu

Yükümlülük Feragatı

“ASAHI INTECC CO., LTD. ve bağlı şirketleri” (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ürünün/ürünlerin hatalı kullanımından veya bu talimatlara uygun olmayan her türlü kullanımdan kaynaklanan kazalarda, bedensel yaralanmalarda ve advers olaylarda hiçbir şekilde yükümlülük kabul etmez. Şirket, şu nedenlere bağlı olarak meydana gelen zararlardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz: (i) Ürün veya ürünlerin şirket tarafından sevkiyatı tamamlandıktan sonraki saklama ve depolama koşullarına bağlı olarak meydana gelen zarar(lar) veya (ii) ürün veya ürünleri kullanan sağlık kuruluşunun hasta, cerrahi teknik ve diğer tıbbi cihazlara ilişkin seçimine bağlı olarak meydana gelen zarar(lar).

“Gladius”, “Halberd”, “ASAHI Gaia” ve “Astato”, ASAHI INTECC CO., LTD.’nin Japonya’da ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

*Uç yükü değerleri, kılavuz telin ucu tarafından lezyona uygulanan kuvvet varsayılarak iç standart test yöntemine göre ölçülen ürün spesifikasyon değerlerine ilişkin ortalama değerleri ifade eder.

Saklama Biçimi

Kılavuz teli ve paketini bükülmüş ve/veya aşırı yüklü bir durumda muhafaza etmeyin. Bu kılavuz tel ve paket suyun dışında tutulmalıdır. Serin, karanlık ve kuru bir yerde saklayın.

Son Kullanma Tarihi

Son kullanma tarihi, kılavuz tel ambalajının etiketinde gösterilmiştir.

Проволочный проводник для периферических
сосудов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием проволочного проводника внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по применению и придерживайтесь содержащихся в ней разделов «Показания к применению», «Целевая группа пациентов», «Противопоказания», «Предупреждения», «Меры предосторожности» и «Процедура применения». Несоблюдение этих требований может привести к осложнениям, включая серьезные травмы или смерть пациента.

Если пользователю и/или пациенту стало известно о серьезном происшествии, связанном с данным проволочным проводником, следует сообщить об этом производителю и в уполномоченную организацию государства-члена ЕС.

Данная инструкция по применению относится к продуктам Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Дополнительные сведения (длина проволочного проводника, рентгеноконтрастной части и т. д.) указаны на этикетке изделия.

Описание

Основная структура данного проволочного проводника состоит из конического сердечника и двух типов дистальных спиралей (внешней и внутренней). Конический сердечник проводника и спирали спаяны. Часть или вся длина внешней спирали рентгеноконтрастна, поэтому ее положение можно легко подтвердить при рентгенокопии. Дистальные стороны продуктов Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 и ASAHI Gaia PV покрыты гидрофильным полимером. Все продукты Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES и Gladius MG18 PV ES имеют покрытие из полиуретановой смолы на внешней спирали и гидрофильное покрытие поверх него. Во всех данных моделях проволочного проводника проксимальная сторона конического сердечника проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ). На проксимальном конце устройств общей длиной менее 300 см имеется соединитель для удлинительного провода, который используется с целью замены комбинированного устройства. Можно подсоединить удлинитель ASAHI INTECC.

Значения нагрузки на наконечник* для данного продукта см. в таблице ниже.

Таблица 1. Технические характеристики продукта

Наименование продукта	Внешний диаметр	Нагрузка на наконечник*
Gladius	0,36 мм (0,014 дюйма)	3 гс
	0,45 мм (0,018 дюйма)	4 гс
Gladius MG14 PV	0,36 мм (0,014 дюйма)	3 гс
Gladius MG14 PV ES	0,36 мм (0,014 дюйма)	3 гс
Gladius MG18 PV ES	0,46 мм (0,018 дюйма)	3 гс
Halberd	0,36 мм (0,014 дюйма)	12 гс
	0,45 мм (0,018 дюйма)	12 гс

Наименование продукта	Внешний диаметр	Нагрузка на наконечник*
Astato XS 20	0,20/0,36 мм (0,008/0,014 дюйма)	20 гс
Astato XS 40	0,23/0,36 мм (0,009/0,014 дюйма)	40 гс
Astato 30	0,33/0,45 мм (0,013/0,018 дюйма)	30 гс
ASAHI Gaia PV	0,36/0,45 мм (0,014/0,018 дюйма)	7,5 гс

Показания к применению

Данный проводник предназначен для общего чрескожного периферического вмешательства (ЧПВ). Данный проволочный проводник предназначен для облегчения установки интервенционных терапевтических устройств в периферической сосудистой системе нижних конечностей.

Данный проволочный проводник предназначен только для использования в периферической сосудистой системе нижних конечностей. Данный проволочный проводник не предназначен для использования в нейрососудистой и сердечно-сосудистой системах.

Целевая группа пациентов

Данный проволочный проводник предназначен для пациентов, отвечающих показаниям к процедуре ЧПВ. Он не показан для использования у новорожденных, младенцев и детей, а также у беременных, пациентов с нарушением функции почек и аллергической реакцией на контрастное вещество или полиэтиленгликоль (ПЭГ).

Противопоказания

- Перед использованием проверить соответствие диаметра проволочного проводника другому интервенционному устройству.
- Запрещается использовать проволочный проводник для пациентов с аллергической реакцией на контрастное вещество или с нарушением функции почек.
- В гидрофильном покрытии данного проволочного проводника содержится ПЭГ400. Запрещается использовать проволочный проводник для пациентов с аллергическими реакциями на полиэтиленгликоль (ПЭГ).
- Запрещается использовать проволочный проводник для беременных пациенток или пациенток, которые предположительно могут быть беременны (рентгеновское излучение может повлиять на плод).
- Данный проволочный проводник разрешается использовать только в тех учреждениях, где может быть выполнено неотложное хирургическое вмешательство. Если неотложное хирургическое вмешательство невозможно, то при самом худшем варианте развития событий могут возникнуть явления, представляющие угрозу жизни пациента.
- Проволочный проводник перед отгрузкой стерилизуется этиленоксидом и предназначен только для однократового использования. Запрещается повторное использование или стерилизация. Повторное использование или стерилизация могут отрицательно влиять на эксплуатационные характеристики и качество проволочного проводника и его упаковки, что сопряжено с риском осложнений, в частности инфекции.

Предупреждения

- Данный проволочный проводник должен использоваться только врачом, владеющим техникой выполнения ЧПВ.
- Запрещается использовать данный проволочный проводник в сочетании с катетерами, содержащими металлические

детали, которые могут непосредственно соприкасаться с поверхностью проводника (например, катетеры для атерэктомии, металлическими расширителями), металлическими иглами или металлическими инструментами для введения интродьюсера.

• В процессе использования проводочного проводника проверяйте и контролируйте движение его наконечника посредством рентгеноскопии. Запрещается применение в тех областях сосуда, которые не визуализированы или не могут быть визуализированы.

Меры предосторожности

- Запрещается использовать проводочный проводник по истечении срока годности, указанного на этикетке. Если срок годности истек, утилизируйте проводочный проводник.
- В силу своей хрупкости проводочные проводники требуют осторожного обращения.
- Запрещается использовать проводочный проводник, если упаковка вскрыта или повреждена. Упаковку разрешается вскрывать только непосредственно перед использованием. При обращении с проводочным проводником и его использовании обязательно применение асептического способа.
- Чтобы не повредить гидрофильное покрытие проводника, постоянно держите его во влажном состоянии.
- Запрещается протирать проводочный проводник органическим раствором, например, спиртом.
- После использования примите профилактические меры во избежание инфицирования. Утилизируйте данный проводочный проводник с принадлежностями и его упаковку в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.
- Запрещается прилагать силу при проталкивании, вывинчивании, извлечении или вращении проводочного проводника, если ощущается сопротивление. Вращение или проталкивание проводочного проводника при наличии сопротивления может привести к повреждению и/или

- Запрещается подсоединять к данному проводочному проводнику съемные удлинители проводника, изготовленные не компанией ASAHI INTECC. Запрещается производить манипуляции проводочным проводником с присоединенным съемным удлинителем проводника. В противном случае можно повредить проводочный проводник или случайно отделить съемный удлинитель проводника.
 - Запрещается вносить изменения в конструкцию проводочного проводника независимо от причин.
- отделению наконечника проводочного проводника или непосредственному повреждению сосуда. Невыполнение этого требования может привести к повреждению проводочного проводника. Определите причину сопротивления с помощью рентгеноскопии и выполните соответствующие действия для исправления ситуации.
- Во всех случаях продвигайте или извлекайте проводочные проводники медленно и осторожно.
 - Запрещается вращать проводочный проводник внутри кровеносного сосуда постоянно в одном направлении. При вращении проводочного проводника чередуйте повороты по часовой стрелке с поворотами против часовой стрелки. Запрещается делать более двух оборотов (720°) в одном направлении.
 - В целях предотвращения попадания воздуха в интервенционное устройство промывайте проводочный проводник гепаринизированным и стерильным физиологическим раствором или иным подходящим раствором при извлечении и повторном введении. При замене проводочного проводника проявляйте осторожность, чтобы не допустить попадания воздуха и/или нанесения травмы. При повторном введении проводочного проводника убедитесь, что наконечник интервенционного устройства свободно расположен в просвете сосуда и не упирается в его стенку. Невыполнение этого требования может привести к травме. Для

определения положения следите за рентгеноконтрастным маркером интервенционного устройства.

- Свободное движение проводочного проводника внутри интервенционного устройства является важной характеристикой системы управляемого проводочного проводника, дающей пользователю ценную осязательную информацию. Перед применением проверьте систему на наличие сопротивления. Если гемостатический клапан ограничивает движение проводочного проводника, то отрегулируйте его или замените на регулируемый клапан.
- Запрещается выполнять установку стента с помощью более чем одного проводочного проводника или перемещать проводочный проводник через каркас стента. В противном случае можно повредить стент, а также повредить или сломать проводочный проводник.
- Перед применением убедитесь, что размер и форма данного проводочного проводника соответствуют проводовой процедуре, а также устройству, в сочетании с которым он будет использоваться.
- Ознакомьтесь с инструкцией по применению, прилагаемой к медицинскому изделию (например, к интервенционным терапевтическим устройствам), которое должно использоваться в сочетании с данным проводочным проводником.
- При подсоединении съемного удлинителя к проводочному проводнику следует надежно вставить его до граничной линии между покрытием не из ПТФЭ и покрытием из ПТФЭ на проксимальном конце проводочного проводника. Немедленно прекратите использование проводочного

проводника при обнаружении каких-либо неисправностей в соединении.

- Перед использованием и по мере возможности во время проведения процедуры внимательно осматривайте проводочный проводник на предмет изгибов, перекручивания или иных повреждений. Запрещается использовать поврежденный проводочный проводник.
- Во время придания формы наконечнику будьте осторожны, чтобы не повредить спираль.
- Перед введением проводочного проводника проверьте, какой конец является дистальным и удостоверьтесь, что устройство вводится именно дистальным концом.
- При выполнении процедуры обеспечивайте постоянную промывку гепаринизированным и стерилизованным физиологическим раствором участка между проводниковым катетером и интервенционным устройством, а также между интервенционным устройством и проводочным проводником. Промывка позволяет предотвратить образование кристаллов и (или) коагуляцию контрастного вещества на проводочном проводнике и в просвете катетера.
- Для держателя с защитной трубкой на дистальном конце (см. раздел «Процедура применения», Рис. 1) не вынимайте и не вставляйте защитную трубку на дистальном конце, пока проводник находится в держателе.
- Для держателя с защитной трубкой на дистальном конце (см. раздел «Процедура применения», Рис. 1), снимите защитную трубку на дистальном конце, прежде чем снова помещать проводочный проводник в держатель.

Неправильное функционирование и неблагоприятные явления

К возможным случаям неправильного функционирования и неблагоприятным явлениям для данного проводочного проводника относятся, в частности, следующие:

1. Неправильное функционирование

Повреждение или изгиб проводочного проводника

Повреждение, как например, отделение

Отслоение покрытия

2. Неблагоприятные явления

Смерть	Инфекция	Эмболия
Снижение кровяного давления	Геморрагические осложнения	
Образование инфаркта	Окклюзия сосудов	Тромб
Ишемия	Аритмия	Расщепление сосуда
Спазм сосудов	Головокружение	головная боль
Рвота	Перфорация сосуда	Аллергическая реакция

Процедура применения

1. Осмотр перед использованием

- Перед использованием внимательно осмотрите и проверьте проволоочный проводник и упаковку на предмет повреждений.
- Перед использованием убедитесь, что проволоочный проводник совместим с используемым интервенционным устройством.

2. Подготовка

- Выберите проволоочный проводник, наиболее подходящий для пораженного участка, и извлеките из стерильной упаковки трубку-держатель, в которой находится проволоочный проводник.
- С помощью шприца полностью заполните трубку-держатель гепаринизированным и

стерильным физиологическим раствором для промывки всего устройства. Имейте в виду, что во время этой процедуры гепаринизированный и стерильный физиологический раствор может выливаться из трубки-держателя.

- Перед введением проволоочного проводника заполните просвет интервенционного устройства гепаринизированным и стерильным физиологическим раствором.
- Извлеките проволоочный проводник из зажима, затем медленно и плавно перемещайте проволоочный проводник, проталкивая дистальный конец проволоочного проводника через трубку-держатель (В) (Рис. 2).

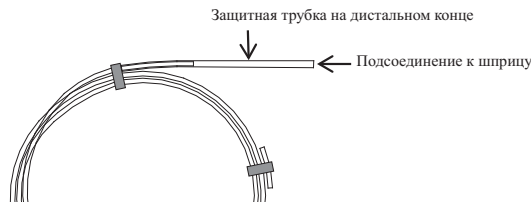


Рис. 1

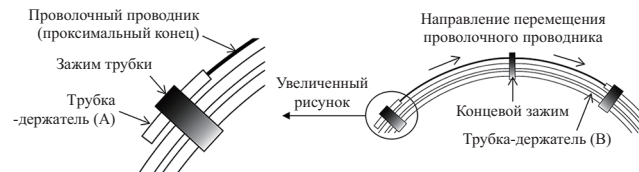


Рис. 2

- Когда дистальный конец проволоочного проводника выступит на 5–6 см за другой конец трубки-держателя (защитной трубки на дистальном конце), при необходимости придайте наконечнику форму в соответствии со стандартным методом.
- Осторожно захватите проволоочный проводник, который выступил из трубки-держателя на дистальном конце (или защитной трубки на дистальном конце), как можно ближе к трубе-держателю и вытяните проволоочный проводник медленно и осторожно.
- Если при извлечении проволоочного проводника из трубки-держателя чувствуется сопротивление, снова шприцом введите гепаринизированный и стерильный физиологический раствор в трубку-держатель. Продолжайте извлечение проволоочного проводника, только если не будете чувствовать сопротивления при его перемещении. Убедитесь, что впрыскиваете в трубку-держатель достаточное количество гепаринизированного и стерильного физиологического раствора, поскольку при извлечении проволоочного проводника с усилием его гидрофильное покрытие может быть повреждено.
- После извлечения проволоочного проводника из трубки-держателя осмотрите его на предмет повреждений.

3. Процедуры введения

- Система доставки по проводнику
 - Осторожно вставьте дистальный конец проволоочного проводника в просвет для проволоочного проводника в интервенционном устройстве.
 - Осторожно продвигайте проволоочный проводник, пока его наконечник не

окажется проксимальным к концу интервенционного устройства.

- Присоедините проводниковый катетер и вставьте систему интервенционного устройства (с проволоочным проводником) в Y-образный соединитель.
- Продвигайте систему интервенционного устройства через проводниковый катетер, пока наконечник системы проволоочного проводника не окажется проксимальным к наконечнику проводникового катетера.
- Затяните гемостатический клапан Y-образного соединителя, чтобы создать герметичную среду вокруг интервенционного устройства. Убедитесь, что проволоочный проводник все еще можно перемещать.
- Убедитесь, что проволоочный проводник движется плавно.
- По мере необходимости присоедините к проволоочному проводнику устройство для вращения.
- Под контролем рентгенокопии продвигайте проволоочный проводник, пока он не пройдет участок поражения. С помощью ангиографии убедитесь, что проволоочный проводник прошел суженный целевой участок поражения.
- Следите за продвижением проволоочного проводника в сосудах.
- Продвигайте интервенционное устройство до участка поражения, предотвращая движение проволоочного проводника. При манипулировании интервенционным устройством должны быть видны дистальный конец проволоочного проводника и его положение в сосудах.

■ Система быстрой замены

- a) Присоедините проводниковый катетер.
- b) Вставьте интродьюсер проволочного проводника в Y-образный соединитель проводникового катетера.
- c) Осторожно вставьте наконечник проволочного проводника в интродьюсер.
- d) Под контролем рентгеноскопии продвигайте проволочный проводник через проводниковый катетер, пока наконечник проволочного проводника не окажется проксимальным к наконечнику проводникового катетера.
- e) По мере необходимости присоедините к проволочному проводнику устройство для вращения.
- f) Под контролем рентгеноскопии продвигайте проволочный проводник, пока он не пройдет участок поражения. С помощью ангиографии убедитесь, что проволочный проводник прошел суженный целевой участок поражения.
- g) Следите за продвижением проволочного

проводника в сосудах.

- h) Извлеките устройство для вращения и интродьюсер проволочного проводника.
- i) Продвигайте интервенционное устройство по проволочному проводнику до участка поражения, предотвращая движение проволочного проводника. При манипулировании интервенционным устройством должны быть видны дистальный конец проволочного проводника и его положение в сосуде.

4. Процедура замены проволочного проводника

■ Система доставки по проводнику

- a) Медленно извлеките проволочный проводник, контролируя его перемещение с помощью рентгеноскопии.
- b) Согласно указаниям раздела «Процедура применения» вставьте следующий проволочный проводник.

* Значения нагрузки на наконечник представляют собой средние значения технических характеристик продукта, измеренные в соответствии с методом испытаний по внутреннему стандарту с учетом силы, прилагаемой к очагу поражения наконечником проволочного проводника.

Условия хранения

Запрещается хранить проволочный проводник и его упаковку в изогнутом виде и/или подвергая их избыточной нагрузке. Запрещается хранить данный проволочный проводник и его упаковку вблизи воды. Храните их в прохладном, сухом и темном месте.

Срок годности

Срок годности изделия указан на этикетке на упаковке проволочного проводника.

Содержимое упаковки

5 шт. / коробка

Отказ от ответственности

Компания ASAHI INTECC CO., LTD и ее дочерние компании (в дальнейшем вместе именуемые «Компания») никоим образом не несут ответственности за несчастные случаи, травмирование персонала и неблагоприятные явления, произошедшие вследствие неправильного использования изделия (изделий) или любого другого действия с нарушением требований этой инструкции. Компания ни при каких условиях не несет ответственность за какие-либо повреждения, (i) возникшие в результате хранения данного изделия (изделий) после доставки его Компанией или (ii) в связи с выбором медицинским учреждением, использующим данное изделие (изделия), определенных пациентов, методов операций или каких-либо других медицинских действий.

«Gladius», «Halberd», «ASAHI Gaia» и «Astato» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ASAHI INTECC CO.,LTD в Японии и других странах.

Периферен водач

Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този водач и спазвайте разделите Показания за употреба, Целева популация, подлежаща на лечение, Противопоказания, Предупреждения, Предпазни мерки и Как да използвате в тези Инструкции за употреба. Неизпълнението на тези инструкции може да доведе до усложнения, включително сериозно нараняване на пациента или смърт.

Ако даден потребител и/или пациент разбере за сериозен инцидент, възникнал във връзка с водача, той следва да докладва този факт на производителя и компетентния орган на държавата членка.

Тези инструкции за употреба се отнасят за Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. За подробности (дължина на водача, дължина на рентгеноконтрастната част и т.н.) направете справка с етикета на продукта.

Описания

Основната структура на този водач се състои от конусовидна сърцевина на проводника, два вида дистални намотки (външна намотка и вътрешна намотка). Конусовидната сърцевина на проводника и намотките са запоеани. Една част от цялата дължина на външната намотка е рентгеноконтрастна, така че нейната позиция може лесно да бъде потвърдена при флуороскопия. Дисталните страни на Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 и ASAHI Gaia PV са покрити с хидрофилен полимер. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, и Gladius MG18 PV ES имат покритие от полиуретанова смола върху външната намотка и хидрофилно покритие отгоре. Във всички тези водачи проксималната страна на конусовидната сърцевина на проводника е покрита с PTFE (политетрафлуоретилен). В проксималния край на изделията, различни от тези с обща дължина 300 см, има връзка за удължител, който се използва за заместване на комбинираното изделие; Удължителът на ASAHI INTECC може да бъде свързан. Вижте таблицата по-долу за натоварването на върха* за този продукт.

Таблица 1. Продуктови спецификации

Наименование на продукта	Външен диаметър	Натоварване на върха*
Gladius	0,36 мм (0,014")	3 gf
	0,45 мм (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 мм (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 мм (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 мм (0,018")	3 gf
Halberd	0,36 мм (0,014")	12 gf
	0,45 мм (0,018")	12 gf
Astato XS 20	0,20 мм/0,36 мм (0,008"/0,014")	20 gf
Astato XS 40	0,23 мм/0,36 мм (0,009"/0,014")	40 gf

Наименование на продукта	Външен диаметър	Натоварване на върха*
Astato 30	0,33 мм/0,45 мм (0,013"/0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 мм/0,45 мм (0,014"/0,018")	7,5 gf

Инструкции за употреба

Този водач е предназначен за обща перкутанна периферна интервенция (PPI). Този водач е предназначен да улесни поставянето на интервенционални терапевтични устройства в периферната васкулатура на долния крайник.

Този водач е предназначен за употреба само в периферната васкулатура на долния крайник. Този водач не е предназначен за използване в невроваскулатурата и сърдечно-съдовата система.

Целева популация, подлежаща на лечение

Този водач е предназначен за пациенти, които отговарят на показания за PPI процедури. Той не е предназначен за употреба при новородени, кърмачета или деца, както и пациенти, които са бременни, имат увредена бъбречна функция и които имат алергична реакция към контрастни вещества или полиетилен гликол (PEG).

Противопоказания

- Потвърдете съвместимостта на диаметъра на водача с друго интервенционално устройство преди реална употреба.
- Не използвайте водача при пациенти, които имат алергична реакция към контрастни вещества или които имат нарушена бъбречна функция.
- Този водач съдържа PEG400 в своето хидрофилно покритие. Не използвайте водача при пациенти, които имат алергични реакции към полиетилен гликол (PEG).
- Не използвайте водача при бременни пациентки или пациентки, които може да са бременни (рентгеновите лъчи могат да засегнат плода).
- Този водач трябва да се използва в здравно заведение, където може незабавно да бъде извършена спешна хирургична операция. Ако не е възможна спешна хирургична операция, в най-лошия случай може да настъпят животозастрашаващи събития.
- Този водач е подложен на предварителна газова стерилизация с етилен оксид (EOG) и е предназначен само за еднократна употреба. Не използвайте повторно или не стерилизирайте повторно. Ако се използва или стерилизира повторно, работата или качеството на този водач и опаковка могат да бъдат компрометирани и съществува риск от усложнения, включително инфекция.

Предупреждения

- Този водач трябва да се използва само от лекар, който е напълно обучен за лечение чрез PPI.
- Никога не използвайте този водач в комбинация с катетри, които имат метални части, които могат да влязат в директен контакт с повърхността на този водач (напр. катетри за атеректомия, метални дилататори), метални игли или изделия за поставяне на метални обвивки.
- По време на използване на водача проверявайте и наблюдавайте движението на върха му под флуороскопия. Не използвайте в тези части на съда, които не са или не могат да бъдат визуализирани.
- Не свързвайте този водач с подвижни удължители от производители, различни от ASAHI INTECC. Не манипулирайте този водач, докато подвижният удължител е свързан. В противен случай водачът може да се повреди или подвижният удължител може неволно да се откачи.
- Не модифицирайте този водач по каквато и да е причина.

Предпазни мерки

- Не използвайте водача след изтичане на срока на годност, посочен на етикетата. Изхвърлете всеки водач с изтекъл срок на годност.
- Водачите са деликатни инструменти и с тях трябва да се работи внимателно.
- Ако опаковката е отворена или повредена, не използвайте водача. Отворете опаковката точно преди непосредствена употреба. Използвайте асептична техника при боравене и използване на водача.
- Винаги дръжте водача в мокро състояние, за да предотвратите повреда на хидрофилното му покритие.
- Не бършете този водач с органичен разтвор като спирт.
- След употреба изхвърлете този водач, аксесоарите и опаковката като медицински отпадъци, като вземете превантивни мерки срещу инфекциозни заболявания.
- Никога не натискайте, не използвайте като свредло, не изтегляйте или не затягвайте водач, който среща съпротивление. Затягането или натискането на този водач срещу съпротивление може да причини повреда и/или отделяне на върха на водача, или директно увреждане на съд. Неспазването на това предупреждение може да причини повреда на този водач. Определете причината за резистентност под флуороскопия и извършете всички необходими коригиращи действия.
- Винаги придвижвайте напред или изтегляйте водачите бавно и внимателно.
- Когато затягате този водач вътре в кръвоносния съд, не затягвайте непрекъснато в една и съща посока. Когато затягате водача, завъртете го последователно по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка. Не правете повече от две завъртания (720°) в една и съща посока.
- Промийте водача с хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор или друг подходящ разтвор, докато го изваждате и поставяте отново, за да предотвратите навлизането на въздух в интервенционалното устройство. Извършете внимателно смяната на този водач, за да предотвратите навлизане

въздух и/или нараняване. При повторно въвеждане на водача се уверете, че върхът на интервенционалното устройство е свободен в лумена на съда и не е срещу стената на съда. Ако не го направите, това може да доведе до травма. Използвайте рентгеноконтрастния маркер на интервенционалното устройство, за да потвърдите позицията.

- Свободното движение на водача в рамките на интервенционалното устройство е важна характеристика на системата с управляем водач, тъй като дава на потребителя ценна тактична информация. Тествайте системата за устойчивост преди употреба. Регулирайте или сменете хемостатната клапа с регулируема клапа, ако се установи, че възпрепятства движението на водача.
- Не извършвайте поставяне на стент, като използвате повече от един водач или операция с водач през опора на стент. В противен случай стентът може да се повреди или водачът да се счупи или да се разпадне.
- Преди употреба се уверете, че този водач е подходящ по размер и форма за процедурата и е съвместим с издेलето, което ще използвате в комбинация.
- Консултирайте се с Инструкциите за употреба, приложени към медицинското изделие (напр. интервенционални терапевтични устройства), което ще се използва в комбинация с този водач.
- Когато свързвате подвижния удължител с този водач, той трябва да бъде здраво поставен в граничната линия между покритието без PTFE и покритието с PTFE в проксималния край на водача. Ако се открие някаква неизправност във връзката, незабавно спрете да използвате водача.
- Проверете внимателно водача за огъвания, прегъвания или други повреди преди употреба и когато е възможно по време на процедурата. Не използвайте водача, ако е повреден.
- Когато оформяте върха, внимавайте да не повредите намотката.
- Преди да въведете водача, проверете кой край е дисталният край и се уверете, че сте го поставили от дисталния край.

- Непрекъснато промивайте с хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор между водещия катетър и интервенционалното устройство и между интервенционното устройство и водача по време на процедурата. Промиването предотвратява образуването на кристали контрастна материя и/или съсирването върху водача и в лумена на катетъра.

- За държача със защитната тръба на дисталния край (вижте Как да използвате, Фигура 1), не премахвайте и не поставяйте защитната тръба на дисталния край, докато водачът е поставен в държача.
- За държача със защитната тръба на дисталния край (вижте Как да използвате, Фигура 1), премахнете защитната тръба на дисталния край преди да поставите водача отново в държача.

Неизправности и нежелани събития

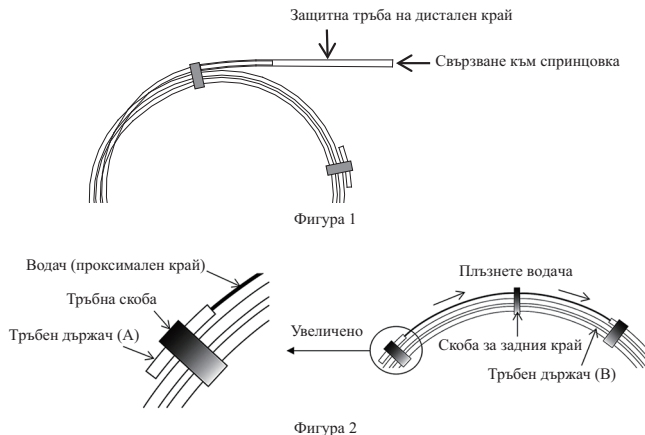
Възможните неизправности и нежелани събития при използването на този водач включват, но не се ограничават до следното:

1. Неизправности

Счупване или огъване на водача	Повреда като отделяне	Отлепване от покритието
Смърт	Инфекция	
Спадане на кръвното налягане	Усложнения, свързани с кръвене	Емболия
Инфаркт	Съдова оклузия	Тромб
Ишемия	Аритмия	Дисекция на съда
Вазоспазъм	Замаяност	Главоболне
Повръщане	Перфорация на съда	Алергична реакция

Как да използвате

1. Проверка преди употреба
 - a) Преди употреба проверете внимателно и се уверете, че водачът и опаковката не са повредени.
 - b) Преди употреба потвърдете, че водачът е съвместим с интервенционалните устройства, които ще използвате.
2. Подготовка
 - a) Изберете най-подходящия водач за засегнатата област и извадете тръбния държач, съдържащ водача, от стерилната опаковка.
 - b) Напълнете тръбния държач с хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор, като използвате спринцовка, за да намокрите цялото изделие. Обърнете внимание, че през това време хепаринизиранят и стерилизиран физиологичен разтвор може да се разлее от тръбния държач.
 - c) Напълнете лумена на интервенционалното устройство с хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор, преди да поставите водача.
 - d) Освободете водача от тръбния държач и го плъзнете бавно, бутнете дисталния край на водача през тръбния държач (В) (Фигура 2).



- е) Когато дисталният край на водача е удължен 5 до 6 см извън другия край на тръбния държач (или защитната тръба на дисталния край), ако е необходимо, оформете върха в съответствие със стандартната практика.
- ф) Внимателно хванете водача, който е излязъл от дисталния край на тръбния държач (или защитната тръба на дисталния край) в точката, която е възможно най-близо до тръбния държач, и издърпайте водача бавно и внимателно.
- г) Ако почувствате съпротивление при отстраняване на водача от тръбния държач, инжектирайте отново хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор в тръбния държач. Продължете да отстранявате водача, след като съпротивлението вече не се усеща. Уверете се, че сте инжектирали достатъчно хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор в тръбния държач, тъй като хидрофилното покритие може да се повреди при силно отстраняване на водача с покритие.
- h) След като издърпате водача от тръбния държач, проверете го, за да се уверите, че

не е повреден.

3. Процедури по въвеждане

■ Система над проводника

- а) Вкарайте дисталния край на водача внимателно в лумена на водача на интервенционалното устройство.
- б) Внимателно придвижете напред този водач, докато върхът му е точно проксимално до върха на интервенционалното устройство.
- с) Захванете водещия катетър и поставете системата за интервенционалното устройство (с водач) в Y-образния конектор.
- д) Придвигнете напред системата на интервенционалното устройство през водещия катетър, докато върхът на системата на водача е точно проксимално до върха на водещия катетър.
- е) Затегнете хемостатната клапа на Y-образния конектор, за да създадете уплътнение около интервенционното устройство. Уверете се, че движението на водача все още е допустимо.
- ф) Проверете дали водачът се движи

гладко.

- г) Прикрепете устройството за затягане към водача, ако е необходимо.
- h) Придвигнете напред този водач под флуороскопия, за да премине през лезията. Потвърдете чрез ангиография, че водачът е преминал през стеснената целева лезия.
- и) Наблюдавайте движението на водача в съдовете.
- j) Придвигнете напред интервенционалното устройство, докато се достигне лезията, като същевременно предотвратявате движението на водача. Уверете се, че дисталният връх на водача и местоположението му в съда са видими по време на манипулации с интервенционалното устройство.

■ Система за бърз обмен

- а) Включете водещия катетър.
- б) Поставете интродюсера на водача в Y-образния конектор на водещия катетър.
- с) Внимателно поставете върха на водача в интродюсера.
- д) Придвигнете напред водача през водещия катетър под флуороскопия, докато върхът на водача е точно проксимално до върха на водещия катетър.

- е) Прикрепете устройството за затягане към водача, ако е необходимо.
- ф) Придвигнете напред водача под флуороскопия, за да премине през лезията. Потвърдете чрез ангиография, че водачът е преминал през стеснената целева лезия.
- г) Наблюдавайте движението на водача в съдовете.
- h) Отстранете устройството за затягане на водача и интродюсера на водача.
- и) Проследете интервенционалното устройство през водача, като същевременно предотвратявате движението на водача, и придвигнете напред, докато се достигне лезията. Уверете се, че дисталният връх на водача и местоположението му в съда са видими по време на манипулации с интервенционалното устройство.

4. Процедури по смяна на водача

■ Система над проводника

- а) Отстранете този водач бавно, докато наблюдавате движението му под флуороскопия.
- б) Поставете следващия водач в съответствие с указанията в този раздел „Как да използвате“.

Начин на съхранение

Не дръжте водача и опаковката в огънато положение и/или в състояние под тежко натоварване. Този водач и опаковката трябва да се пазят от вода. Съхранявайте на хладно, тъмно и сухо място.

Срок на годност

Срокът на годност е посочен на етикета на опаковката на водача.

Съдържание

5 броя / кутия

Отказ от отговорност

По никакъв начин „ASAHI INTECC CO., LTD. и неговите дъщерни дружества“ (наричани по-нататък „Компанията“) не носят отговорност за злоупотреби, лични наранявания, нежелани събития, дължащи се на неправилна употреба на продукта(ите) или всяка друга употреба, несъвместима с тези инструкции. В никакъв случай Компанията не носи отговорност за каквито и да е щети или (i) произтичащи от съхранението на продукта(ите) след изпращането от Компанията, или (ii) поради подбор на пациенти, хирургични техники или всякакви други медицински дейности от лечебното заведение, което използва продукта(ите).

„Gladius“, „Halberd“, „ASAHI Gaia“ и „Astato“ са търговски марки или регистрирани търговски марки на ASAHI INTECC CO., LTD. в Япония и други страни.

*Стойностите за натоварване на върха представляват средните стойности на стойностите на продуктова спецификация, измерени съгласно вътрешния стандартен метод за изпитване, като се приема силата, приложена върху лезията от върха на водача.

Periferna vodilica

Upute za uporabu

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe vodilice i obratite pozornost odjeljke Indikacije za uporabu, Ciljana liječena populacija, Kontraindikacije, Upozorenja, Mjere opreza i Kako se koristiti u Uputama za uporabu. Ako ih se ne budete pridržavali, može doći do komplikacija, uključujući ozbiljne ozljede pacijenta ili smrtnog ishoda.

Ako korisnik i/ili pacijent dođe do saznanja o ozbiljnoj nezgodi koja se javila vezano s ovom vodicom, prijavite tu činjenicu proizvođaču i nadležnom tijelu zemlje članice.

Ove Upute za uporabu primjenjive su za proizvode Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Za pojedinosti (duljina vodilice, duljina radionepropusnog dijela, itd.), pročitajte etiketu proizvoda.

Opis

Osnovna struktura vodilice sastoji se od konusne žice s jezgrom i dvije vrste distalnih namotaja (vanjski namotaj i unutarnji namotaj). Konusna žica s jezgrom i namotaji su zalemljeni. Dio ili cijela duljina vanjskog namotaja je radionepropusna tako da se njegov položaj može lako potvrditi fluoroskopijom. Distalne strane proizvoda Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 i ASAHI Gaia PV obložene su hidrofilnim polimerom. Proizvodi Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES i Gladius MG18 PV ES imaju oblog od poliuretanske smole na vanjskom namotaju, a površ toga hidrofilni oblog. U svim ovim vodicama, proksimalna strana konusne žice s jezgrom obložena je materijalom PTFE (politetrafluoretilen). Na proksimalnom kraju proizvoda koji nemaju ukupnu duljinu od 300 cm, nalazi se priključak za produžnu žicu, koja služi za zamjenu kombiniranog uređaja; moguće je spojiti produžnu žicu tvrtke ASAHI INTECC.

Pogledajte tablicu u nastavku za opterećenje vrha* ovog proizvoda.

Tablica1. Specifikacije proizvoda

Naziv proizvoda	Vanjski promjer	Opterećenje vrha*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014")	12 gf
	0,45 mm (0,018")	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm / 0,36 mm (0,008" / 0,014")	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm / 0,36 mm (0,009" / 0,014")	40 gf
Astato 30	0,33 mm / 0,45 mm (0,013" / 0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm / 0,45 mm (0,014" / 0,018")	7,5 gf

Indikacije za uporabu

Ova vodilica namijenjena je za opću perkutanu perifernu intervenciju (PPI). Ova vodilica namijenjena je za olakšavanje plasiranja intervencijskih terapijskih uređaja u periferni vaskularni sustav donjeg ekstremiteta.

Ova vodilica namijenjena je za uporabu samo u perifernom vaskularnom sustavu donjeg ekstremiteta. Ova vodilica nije namijenjena za uporabu u neurovaskularnom i kardiovaskularnom sustavu.

Ciljana liječena populacija

Ova vodilica namijenjena je za pacijente koji imaju indikacije za PPI postupke. Nije indicirana za primjenu kod novorođenčadi, dojenčadi ili djece, kao ni kod pacijentica koje su trudne, pacijentata koji imaju oštećenu funkciju bubrega i koji imaju alergijsku reakciju na kontrastna sredstva ili polietilen glikol (PEG).

Kontraindikacije

- Potvrdite kompatibilnost promjera vodilice s drugim intervencijskim uređajem prije konkretne uporabe.
- Nemojte koristiti vodicu na pacijentima koji imaju alergijsku reakciju na kontrastne medije ili koji imaju poremećenu funkciju bubrega.
- Ova vodilica sadrži PEG400 u svojoj hidrofilnoj oblozi. Nemojte koristiti vodicu na pacijentima koji imaju alergijske reakcije na polietilen glikol (PEG).
- Nemojte koristiti vodicu na trudnicama ili pacijenticama koji bi mogle biti trudne (rendgenske zrake mogu utjecati na fetus).
- Ova se vodilica mora se koristiti u ustanovi gdje se hitna kirurška operacija može obaviti odmah. Ako hitna kirurška operacija nije dostupna, u najgoreom slučaju može doći do događaja opasnih po život.
- Ova vodilica prethodno je sterilizirana plinom etilen oksid (EOG) i namijenjena je samo za jednokratnu uporabu. Nemojte ponovno koristiti ili ponovno sterilizirati. Ako se ponovno koristi ili ponovno sterilizira, učinkovitost ili kvaliteta ove vodilice i pakiranja mogu biti narušena i postoji rizik od komplikacija, uključujući infekciju.

Upozorenja

- Ovu vodicu smije upotrebljavati samo liječnik koji je potpuno obučan za PPI liječenje.
- Nikada nemojte upotrebljavati ovu vodicu u kombinaciji s kateterima s metalnim dijelovima koji bi mogli izravno dodirivati površinu ove vodilice (npr. kateteri za aterektomiju, metalni dilatori), metalnim iglama ili metalnim uvodnim kateterima.
- Za vrijeme korištenja vodilice, provjeravajte i pratite kretanje njenog vrha pod fluoroskopijom. Nemojte koristiti u područjima žila koje nisu ili se ne mogu vizualizirati.
- Nemojte spajati vodicu s odvojivim produžnim žicama, a koje je proizveo neki drugi proizvođač a ne ASAHI INTECC. Nemojte rukovati vodicom dok je spojena odvojiva produžna žica. U suprotnom, vodilica se može oštetiti ili bi se odvojiva produžna žica mogla nenamjerno odvojiti.
- Ni iz kakvog razloga ne smijete obavljati preinake ove vodilice.

Mjere opreza

- Nemojte koristiti vodicu nakon isteka roka označenog na etiketi. Odbacite svaku vodicu kojoj je istekao rok trajanja.
- Vodicu se osjetljivi instrumenti i njima se mora rukovati pažljivo.
- Ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno, nemojte koristiti vodicu. Pakiranje otvorite isključivo neposredno prije uporabe. Pri rukovanju i korištenju vodilice koristite aseptičnu tehniku.
- Vodicu uvijek mora biti vlažna kako bi se spriječilo oštećenje njenog hidrofilnog obloga.

- Ne brišite vodilicu organskim rastvorima kao što je alkohol.
- Nakon uporabe zbrinite vodilicu, dodatke i pakiranje kao medicinski otpad poduzimanjem preventivnih mjera za zaštitu od zaraznih bolesti.
- Nikada nemojte gurati, bušiti, povlačiti ili zatezati vodilicu koja nailazi na otpor. Zatezanje ili guranje vodilice protiv otpora može uzrokovati oštećenje i/ili odvajanje vrha vodilice ili izravnu štetu na žili. Ako se ne pridržavate ovih savjeta, može doći do oštećenja vodilice. Pod fluoroskopijom utvrdite uzrok otpora i poduzmite potrebne mjere za uklanjanje.
- Uvijek polako i pažljivo uvlačite i izvlačite vodilicu.
- Pri zakretanju vodilice unutar krvne žile, nemojte zakretati stalno u istom smjeru. Pri zakretanju vodilice, okrećite je naizmjenično u smjeru kazaljke i suprotno od smjera kazaljke na satu. Nemojte okretati više od dva okreta (720°) u istom pravcu.
- Vodilicu isperite hepariniziranim i steriliziranim fiziološkom otopinom ili drugom prikladnom otopinom dok je uklanjate i ponovno uvodite, kako biste spriječili ulazak zraka u intervencijski uređaj. Pažljivo obavite zamjenu vodilice kako biste spriječili ulazak zraka i/ili ozljedu. Prilikom ponovnog uvođenja vodilice, uvjerite se da je vrh intervencijskog uređaja slobodan unutar lumena krvne žile i da nije prislonjen na stijenku žile. Ako ne postupite tako, moglo bi doći do ozljede. Za potvrdu položaja, koristite radionepropusni marker intervencijskog uređaja.
- Slobodno kretanje vodilice unutar intervencijskog uređaja važna je značajka upravljivog sustava žice za navođenje jer korisniku daje vrijedne taktilne informacije. Prije korištenja ispitajte nailazi li sustav na bilo kakav otpor. Podesite ili zamijenite ventil za hemostazu podesivim ventilom ako se ustanovi da onemogućuje kretanje vodilice.
- Nemojte postavljati stent korištenjem više od jedne vodilice ili operaciju žice kroz mrežicu stenta. U suprotnom, stent se može oštetiti ili se vodilica može slomiti ili se raspasti.
- Prije uporabe, potvrdite da je vodilica odgovarajuće veličine i oblika za taj postupak i da je kompatibilna s uređajem s kojim će se koristiti.
- Pogledajte Upute za uporabu priložene medicinskom proizvodu (npr. intervencijski terapijski uređaji) koji se upotrebljava u kombinaciji s ovom vodilicom.
- Prilikom spajanja odvojive produžne žice s ovom vodilicom, treba je sigurno umetnuti u graničnu liniju između premaza koji nije PTFE i PTFE premaza na proksimalnom kraju vodilice. Ako se u spoju otkrije abnormalnost, odmah prestanite koristiti vodilicu.
- Prije korištenja i kad god je to moguće tijekom postupka, pažljivo pregledajte ima li vodilica savijena, uskana ili ima neko drugo oštećenje. Nemojte koristiti vodilicu ako je oštećena.
- Prilikom oblikovanja vrha, pazite da ne oštetite namotaj.
- Prije uvođenja vodilice, provjerite koji kraj je distalni kraj i osigurajte da ćete uvesti sa distalnog kraja.
- Održavajte neprestano heparinizirano i sterilizirano ispiranje fiziološkom otopinom između vodećeg katetera i intervencijskog uređaja te između intervencijskog uređaja i vodilice tijekom zahvata. Ispiranje sprečava kristalizaciju kontrastnog sredstva i/ili zgrušavanje na vodilici i u lumenu katetera.
- Za držač sa zaštitnom cijevi distalnog kraja (pogledajte Kako se koristi, Slika 1), nemojte vaditi niti umetati zaštitnu cijev distalnog kraja dok je vodilica smještena u držač.
- Za držač sa zaštitnom cijevi distalnog kraja (pogledajte Kako se koristi, Slika 1) izvadite zaštitnu cijev distalnog kraja prije nego što se vodilica ponovo smjesti u držač.

Nepravilno funkcioniranje i štetni učinci

Moguće neispravno funkcioniranje i nuspojave zbog korištenja vodilice uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

1. Neispravno funkcioniranje

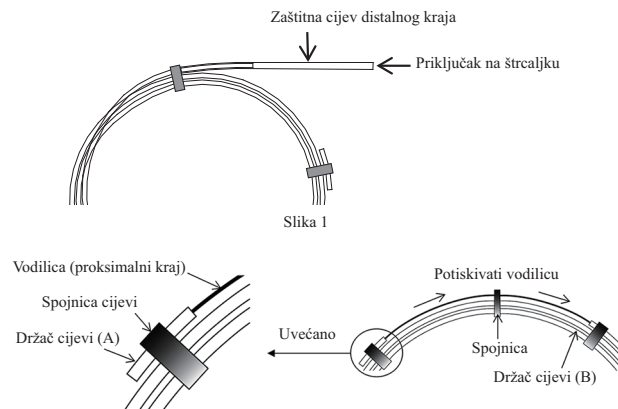
Prijelom ili savijanje vodilice Oštećenje poput odvajanja Spadanje obloga

2. Štetni učinci

Smrt	Infekcija	
Snizavanje krvnog tlaka	Komplikacije krvarenja	Embolija
Infarkcija	Vaskularna okluzija	Tromb
Ishemija	Aritmija	Disekcija žile
Vazospazam	Vrtoglavica	Vrtoglavica
Povraćanje	Perforacija žile	Alergijska reakcija

Kako se koristi

1. Pregled prije uporabe
 - a) Prije uporabe, pažljivo pregledajte i potvrdite da su vodilica i pakiranje neoštećeni.
 - b) Prije uporabe, potvrdite da je vodilica kompatibilna s intervencijskim uređajima koji će se koristiti.
2. Priprema
 - a) Izaberite najprikladniju vodilicu za zahvaćeno područje i uklonite držač cijevi u kojem je vodilica iz sterilnog pakiranja.
 - b) Napunite držač cijevi hepariniziranim i steriliziranim fiziološkom otopinom pomoću štrcaljke kako biste natopili cijeli uređaj. Napominjemo da se heparinizirana i sterilizirana fiziološka otopina za to vrijeme može izliti iz držača cijevi.
 - c) Napunite lumen intervencijskog uređaja hepariniziranim i steriliziranim fiziološkom otopinom prije umetanja vodilice.
 - d) Otpustite vodilicu iz spojnice i lagano potiskujte vodilicu, gurnite distalni kraj vodilice kroz držač cijevi (B) (Slika 2).



Slika 2

- e) Kada se distalni kraj vodilice produži 5 do 6 cm izvan drugog kraja držača cijevi (ili zaštitne cijevi distalnog kraja), po potrebi oblikujte vrh u skladu sa standardnom praksom.
- f) Nježno uhvatite vodilicu koja je izašla iz

- držača distalnog kraja zaštitne cijevi distalnog kraja (ili zaštitne cijevi distalnog kraja), na mjestu što je moguće bliže držaču cijevi i polako i pažljivo izvlaćite vodilicu.
- g) Ako osjetite otpor pri vađenju vodilice iz držača cijevi, ponovo ubrizgajte hepariniziranu i steriliziranu fiziološku otopinu u držač cijevi. Nastavite s vađenjem vodilice kada prestanete osjećati otpor. Obavezno ubrizgajte dovoljno heparinizirane i sterilizirane fiziološke otopine u držač cijevi jer se hidrofilni oblog može oštetiti prilikom nasilnog vađenja obložene vodilice.
- h) Nakon povlačenja vodilice iz držača cijevi, pregledajte ju kako biste se uvjerali da nije oštećena.

3. Postupci za uvođenje

- Sustav preko žice
 - a) Pažljivo umetnite distalni kraj vodilice u lumen vodilice intervencijskog uređaja.
 - b) Pažljivo uvodite vodilicu sve dok vrh ne bude proksimalan u odnosu na vrh intervencijskog uređaja.
 - c) Zahvatite vodeći kateter i umetnite sustav intervencijskog uređaja (s vodicom) u priključak Y.
 - d) Uvodite sustav intervencijskog uređaja kroz vodeći kateter sve dok vrh sustava vodilice ne bude proksimalan u odnosu na vrh vodećeg katetera.
 - e) Zategnite ventil za hemostazu priključka Y kako biste stvorili brtvu oko intervencijskog uređaja. Osigurajte da je pomicanje vodilice i dalje dopušteno.
 - f) Provjerite kako biste osigurali glatko pomicanje vodilice.
 - g) Ako je potrebno, pričvrstite uređaj za zakretni moment na vodilicu.
 - h) Uvodite vodilicu pod fluoroskopijom kako bi prošla kroz leziju. Angiografijom

potvrdite da je vodilica prošla kroz suženu ciljnu leziju.

- i) Promatrajte pomicanje vodilice u žilama.
- j) Uvodite intervencijski uređaj dok ne dođe do lezije, istodobno sprječavajući pomicanje vodilice. Osigurajte da su distalni vrh vodilice i njegova lokacija vidljivi tijekom manipulacije intervencijskim uređajem.

■ Sustav brze zamjene

- a) Zahvatite vodeći kateter.
- b) Umetnite uvodnicu vodilice u priključak Y vodećeg katetera.
- c) Pažljivo umetnite vrh vodilice u uvodnicu.
- d) Uvodite vodilicu kroz vodeći kateter pod fluoroskopijom dok vrh vodilice ne bude proksimalan vrhu vodećeg katetera.
- e) Ako je potrebno, pričvrstite uređaj za zakretni moment na vodilicu.
- f) Uvodite vodilicu pod fluoroskopijom kako bi prošla kroz leziju. Angiografijom potvrdite da je vodilica prošla kroz suženu ciljnu leziju.
- g) Promatrajte pomicanje vodilice u žilama.
- h) Uklonite uređaj za zakretni moment vodilice i uvodnicu vodilice.
- i) Pratite intervencijski uređaj preko vodilice, istodobno sprječavajući pomicanje vodilice i uvodite dok ne dođe do lezije. Osigurajte da su distalni vrh vodilice i njegova lokacija vidljivi tijekom manipulacije intervencijskim uređajem.

4. Postupci zamjene vodilice

- Sustav preko žice
 - a) Lagano vadite vodilicu dok nadzirete pomicanje ove vodilice pod fluoroskopijom.
 - b) Umetnite sljedeću vodilicu prema uputama iz dijela „Kako se koristi“.

Odricanje od odgovornosti

Ni u kojem slučaju „ASAHI INTECC CO., LTD. i njegove pridružene tvrtke“ (u daljnjem tekstu „Tvrtka“) biti odgovorni za nezgode, osobne ozljede, štetne učinke uslijed bilo kakve nepravilne uporabe proizvoda ili bilo koje druge uporabe koja nije u skladu s ovim uputama. Ni u kojem slučaju Tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (i) koja proizlazi iz skladištenja proizvoda nakon otpreme iz Tvrtke ili (ii) zbog odabira pacijenata, kirurških tehnika ili bilo koje druge medicinske aktivnosti od strane medicinske ustanove koja koristi proizvod(e).

„Gladius“, „Halberd“, „ASAHI Gaia“ i „Astato“ zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci ASAHI INTECC CO., LTD. u Japanu i drugim zemljama.

*Vrijednosti opterećenja vrha predstavljaju srednje vrijednosti od vrijednosti specifikacije proizvoda izmjerene u skladu s internom standardnom metodom ispitivanja uz pretpostavku sile koju na leziju primjenjuje vrh vodilice.

Način skladištenja

Ne smijete čuvati vodilicu i pakiranje u savijenom i/ili pod teškim teretom. Vodilica i pakiranje moraju se čuvati dalje od vode. Čuvati na hladnom, tamnom i suhom mjestu.

Rok trajanja

Rok trajanja označen je na etiketi pakiranja vodilice.

Sadržaj

5 komada / kutija

Fir de ghidaj periferic

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest fir de ghidaj și rețineți Indicații pentru utilizare, Populația țintă tratată, Contraindicații, Avertismente, Precauții și Mod de utilizare din aceste Instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestora poate duce la complicații, inclusiv la lezarea gravă a pacientului sau la deces.

În cazul în care un utilizator și/sau un pacient ia la cunoștință de un incident grav care a avut legătură cu firul de ghidaj, raportați acest lucru producătorului și autorității competente din statul membru.

Aceste Instrucțiuni de utilizare se aplică pentru Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Pentru detalii (lungimea firului de ghidaj, lungimea secțiunii radioopace etc.), a se consulta eticheta produsului.

Descrieri

Structura de bază a acestui fir de ghidaj consistă dintr-un miez conic al firului și două tipuri de bobine distale (o bobină exterioară și una interioară). Miezul conic al firului și bobinele sunt lipite. O porțiune sau întreaga lungime a bobinei exterioare este radioopacă, astfel încât poziția acesteia să poată fi confirmată sub fluoroscopie. Părțile distale ale Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 și ASAHI Gaia PV sunt acoperite cu un polimer hidroflic. Fiecare dintre Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES și Gladius MG18 PV ES are un strat de acoperire din rășină poliuretanică pe bobina exterioară și un strat de acoperire hidroflic deasupra acestuia. La toate aceste fire de ghidaj, partea proximală a miezului conic al firului este acoperită cu PTFE (politetrafluoroetilenă). La capătul proximal al dispozitivelor, cu excepția celor care au o lungime de 300 cm, există o conexiune pentru un fir de extensie, care este utilizat pentru a înlocui dispozitivul combinat; poate fi conectat firul de extensie de la ASAHI INTECC.

Consultați tabelul de mai jos pentru sarcina vârfului* acestui produs.

Tabelul 1. Specificațiile produsului

Nume produs	Diametrul exterior	Sarcina vârfului*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
Halberd	0,36 mm (0,014")	12 gf
	0,45 mm (0,018")	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008"/0,014")	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009"/0,014")	40 gf
Astato 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013"/0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014"/0,018")	7,5 gf

Indicații pentru utilizare

Acest fir de ghidaj este destinat pentru intervențiile percutanate periferice generale (PPI). Acest fir de ghidaj este destinat să faciliteze plasarea dispozitivelor de intervenție terapeutică în sistemul vascular periferic al extremității inferioare.

Acest fir de ghidaj este destinat pentru utilizare în sistemul vascular periferic al extremității inferioare. Acest fir de ghidaj nu este destinat utilizării în sistemul neurovascular sau cardiovascular.

Populația țintă tratată

Acest fir de ghida este destinat pacienților care îndeplinesc indicațiile pentru proceduri de PPI. Nu este indicată pentru utilizare la nou-născuți, sugari sau copii, precum și la pacienții care sunt gravide, au funcția renală afectată și care au o reacție alergică la substanța de contrast sau la polietilenglicol (PEG).

Contraindicații

- Confirmați compatibilitatea diametrului firului de ghidaj cu alt dispozitiv de intervenție înainte de utilizarea efectivă.
- Nu folosiți firul de ghidaj la pacienții care au o reacție alergică la substanța de contrast sau care au funcția renală afectată.
- Acest fir de ghidaj conține PEG400 în stratul său de acoperire hidroflic. Nu utilizați firul de ghidaj la pacienții care au reacții alergice la polietilenglicol (PEG).
- Nu utilizați firul de ghidaj la paciențele gravide sau la paciențele care ar putea fi gravide (razele X pot afecta fătul).
- Acest fir de ghidaj trebuie utilizat într-o instituție în care se poate efectua imediat intervenții chirurgicale de urgență. În cazul în care o intervenție chirurgicală de urgență nu este posibilă, în cel mai rău caz, pot apărea evenimente care pun viața în pericol.
- Acest fir de ghidaj este pre-sterilizat cu gaz de oxid de etilenă (EOG) și este destinat unei singure utilizări. A nu se reutiliza sau resteriliza. Dacă este reutilizat sau resterilizat, performanța sau calitatea acestui fir de ghidaj și a ambalajului poate fi compromisă și există riscul apariției unor complicații, inclusiv a unei infecții.

Avertismente

- Acest fir de ghidaj trebuie utilizat numai de un medic care este complet instruit în tratamentul PPI.
- Nu utilizați niciodată acest fir de ghidaj în combinație cu catetere cu părți metalice care pot intra în contact direct cu suprafața firului de ghidaj (de exemplu: catetere de aterectomie, dilatoare metalice), ace sau introductoare metalice.
- În timpul utilizării firului de ghidaj, verificați și monitorizați mișcarea vârfului acestuia sub fluoroscopie. A nu se utiliza în zone ale vasului care nu sunt sau nu pot fi vizualizate.
- A nu se conecta acest fir de ghidaj cu fire de extensie detașabile produse de alți producători decât ASAHI INTECC. A nu se manevra acest fir de ghidaj în timp ce firul de extensie detașabil este conectat. În caz contrar, firul de ghidaj se poate deteriora sau firul de extensie detașabil se poate desprinde involuntar.
- A nu se modifica acest fir de ghidaj pentru niciun motiv.

Precauții

- A nu se folosi firul de ghidaj după data de expirare indicată pe etichetă. Aruncați orice fir de ghidaj care depășește data de expirare.
- Firele de ghidaj sunt instrumente delicate și trebuie manevrate cu grijă.
- Dacă ambalajul este deschis sau deteriorat, nu folosiți firul de ghidaj. A nu se deschide ambalajul decât cu puțin timp înainte de utilizare. Folosiți o tehnică aseptică la manevrarea și utilizarea firului de ghidaj.

- Păstrați întotdeauna firul de ghidaj în stare umedă pentru a preveni deteriorarea stratului său de acoperire hidrofîl.
- Nu ștergeți acest fir de ghidaj folosind o soluție organică, cum ar fi alcoolul.
- După utilizare, eliminați firul de ghidaj, accesoriile și ambalajul precum deșeurile medicale, luând măsuri preventive împotriva bolilor infecțioase.
- Nu împingeți, nu trageți, nu retrageți și nu răsuciți niciodată acest fir de ghidaj care întâmpină rezistență. Răsucirea sau împingerea acestui fir de ghidaj care întâmpină rezistență poate provoca deteriorarea și/sau separarea vîrfului acestui fir de ghidaj sau deteriorarea directă a unui vas. În caz contrar, acest fir de ghidaj poate fi deteriorat. Determinați cauza rezistenței sub fluoroscopie și luați orice măsură de remediere necesară.
- Întotdeauna avansați sau retrageți firul de ghidaj încet și cu grijă.
- Atunci când răsuciți acest fir de ghidaj în interiorul vasului de sînge, nu răsuciți în mod continuu în aceeași direcție. Atunci când răsuciți firul de ghidaj, rotiți-l alternativ în sensul acelor de ceasornic și în sens invers. Nu efectuați mai mult de două rotații (720°) în aceeași direcție.
- Spălați firul de ghidaj cu soluție salină heparinizată și sterilizată sau cu o altă soluție potrivită în timp ce îl scoateți și îl reintroduceți pentru a preveni pătrunderea aerului în dispozitivul de intervenție. Efectuați schimbarea acestui fir de ghidaj cu atenție pentru a preveni pătrunderea aerului și/sau traumatisme. Când reintroduceți firul de ghidaj, confirmați că vîrfurile dispozitivului de intervenție nu este blocat în lumenul vasului și nu se sprijină pe peretele vasului. În caz contrar, se pot produce traumatisme. Utilizați marker-ul radioopac al dispozitivului de intervenție pentru a confirma poziția.
- Mișcarea liberă a firului de ghidaj în cadrul dispozitivului de intervenție este o caracteristică importantă a unui sistem de fire de ghidaj dirijabile, deoarece oferă utilizatorului informații tactile valoroase. Testați sistemul pentru a detecta orice rezistență înainte de utilizare. Reglați sau înlocuiți valva hemostatică cu o valvă reglabilă dacă se constată că aceasta împiedică mișcarea firului de ghidaj.
- Nu efectuați plasarea stentului folosind mai mult de un fir de ghidaj sau operația cu fire prin suportul stentului. În caz contrar, stentul poate fi deteriorat sau firul de ghidaj se poate rupe sau desprinde.
- Înainte de utilizare, confirmați că acest fir de ghidaj este adecvat ca dimensiune și formă pentru procedura și este compatibil cu dispozitivul care urmează să fie utilizat în combinație.
- Consultați Instrucțiunile de utilizare atașate dispozitivului medical (de exemplu: dispozitive de intervenții terapeutice) pentru a fi utilizat în combinație cu acest fir de ghidaj.
- Atunci când conectați firul de extensie detașabil cu acest fir de ghidaj, acesta trebuie să fie introdus în siguranță până la linia de demarcație dintre stratul de acoperire fără PTFE și stratul de acoperire cu PTFE de la capătul proximal al firului de ghidaj. În cazul în care se constată orice anomalie la conectare, întrerupeți imediat utilizarea firului de ghidaj.
- Inspectați cu atenție firul de ghidaj pentru a vedea dacă există îndoitori, noduri sau alte deteriorări înainte de utilizare și ori de câte ori este posibil în timpul procedurii. Nu utilizați firul de ghidaj dacă este deteriorat.
- Atunci când modelați vîrfurile, aveți grijă să nu deteriorați bobina.
- Înainte de a introduce firul de ghidaj, verificați care este capătul distal și asigurați-vă că îl introduceți de la capătul distal.
- Mențineți spălarea continuă cu o soluție salină heparinizată și sterilă între cateterul de ghidare și dispozitivul intervențional și între dispozitivul intervențional și firul de ghidare în timpul procedurii. Spălarea previne formarea cristalelor și/sau a cheagurilor de substanță de contrast pe firul ghid și în lumenul cateterului.
- Pentru suportul cu tubul de protecție a capătului distal (consultați Modul de utilizare, Figura 1), nu îndepărtați sau introduceți tubul de protecție a capătului distal în timp ce firul de ghidaj este găzduit în suport.
- Pentru suportul cu tubul de protecție a capătului distal (consultați Modul de utilizare, Figura 1), îndepărtați tubul de protecție a capătului distal înainte de a găzdui din nou firul de ghidaj în suport.

Defecțiuni și efecte adverse

Possibilele defecțiuni și efecte adverse cauzate de utilizarea acestui fir de ghidaj includ, dar nu se limitează la următoarele:

1. Defecțiuni

Ruperea sau îndoirea firului de ghidaj	Deteriorări, cum ar fi separarea	Desprinderea stratului de acoperire
Deces	Infecții	
Scăderea tensiunii arteriale	Complicații hemoragice	Embolie
Infarct	Ocluzii vasculare	Dezvoltarea trombilor
Ischemie	Aritmie	Disecția vaselor
Spasm vascular	Amețeli	Dureri de cap
Stări de vomă	Perforarea vaselor	Reacții alergice

Mod de utilizare

1. Inspectați înainte de utilizare

- Înainte de utilizare, inspectați cu atenție și confirmați că firul de ghidaj și ambalajul nu sunt deteriorate.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că firul de ghidaj este compatibil cu dispozitivele de intervenție care urmează să fie utilizate.

2. Pregătirea

- Selecția cel mai potrivit fir de ghidaj pentru zona afectată și îndepărtați tubul suport care conține firul de ghidaj din ambalajul steril.
- Umpleți tubul de suport cu soluție salină

heparinizată și sterilizată cu ajutorul unei seringi pentru a îmbiba întregul dispozitiv. Rețineți că soluția salină heparinizată și sterilizată se poate vărsa din tubul de suport în acest moment.

- Umpleți lumenul dispozitivului de intervenție cu soluție salină heparinizată și sterilizată înainte de a introduce firul de ghidaj.
- Eliberați firul de ghidaj din agra terminală și introduceți-l încet, împingeți capătul distal al firului de ghidaj prin tubul de suport (B) (Figura 2).

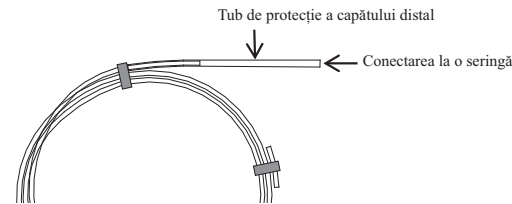


Figura 1

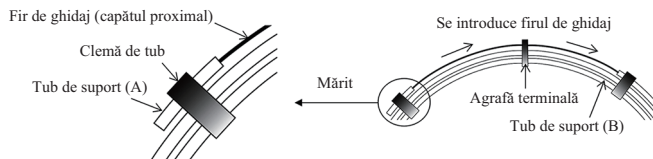


Figura 2

- e) Atunci când capătul distal al firului de ghidaj se extinde cu 5 până la 6 cm dincolo de celălalt capăt al tubului de suport (sau al tubului de protecție a capătului distal), dacă este necesar, modelați vârful în conformitate cu practica standard.
- f) Prindeți ușor firul de ghidaj care a ieșit din capătul distal al tubului de suport (sau al tubului de protecție a capătului distal), în punctul cât mai apropiat de tubul de suport și extrageți firul de ghidaj încet și cu grijă.
- g) Dacă la scoaterea firului de ghidaj din tubul de suport se întâmpină rezistență, se injectează din nou soluție salină heparinizată și sterilizată în tubul de suport. Continuați să îndepărtați firul de ghidaj după ce nu mai întâmpinați rezistență. Asigurați-vă că injectați suficientă soluție salină heparinizată și sterilizată în tubul de suport, deoarece stratul de acoperire hidrofili poate fi deteriorat atunci când îndepărtați cu forța firul de ghidaj căpușat.
- h) După ce ați extras firul de ghidaj din tubul de suport, inspectați-l pentru a vă asigura că nu este deteriorat.

3. Proceduri de inserție

- Sistem cu cateter peste firul de ghidaj
 - a) Introduceți cu grijă capătul distal al firului de ghidaj în lumenul firului de ghidaj al dispozitivului de intervenție.
 - b) Înaintați acest fir de ghidaj cu atenție până când vârful său este chiar în apropierea vârfului dispozitivului de intervenție.
 - c) Conectați cateterul de ghidaj și introduceți sistemul dispozitivului de intervenție (cu firul de ghidaj) în conectorul în Y.
 - d) Înaintați sistemul dispozitivului de intervenție prin cateterul de ghidaj până când vârful sistemului cu fir de ghidaj este chiar în apropierea vârfului cateterului de

ghidaj.

- e) Strângeți valva hemostatică a conectorului în Y pentru a crea o etanșare în jurul dispozitivului de intervenție. Asigurați-vă că mișcarea firului de ghidaj este încă posibilă.
- f) Verificați dacă firul de ghidaj se mișcă fără probleme.
- g) Atașați dispozitivul de torsiune la firul de ghidaj, dacă este necesar.
- h) Înaintați acest fir de ghidaj sub fluoroscopie pentru a străbate leziunea. Confirmați cu ajutorul angiografiei că firul de ghidaj a parcurs leziunea țintă îngustată.
- i) Observați mișcarea firului de ghidaj în vase.
- j) Înaintați dispozitivul de intervenție până când se ajunge la leziune, împiedicând în același timp mișcarea firului de ghidaj. Asigurați-vă că vârful distal al firului de ghidaj și locația acestuia în vas sunt vizibile în timpul manevrelor dispozitivului de intervenție.

■ Sistem de schimbare rapidă

- a) Conectați cateterul de ghidaj.
- b) Inserați liderul firului de ghidaj în conectorul în Y al cateterului de ghidaj.
- c) Introduceți cu grijă vârful firului de ghidaj în lider.
- d) Înaintați firul de ghidaj prin cateterul de ghidaj sub fluoroscopie până când vârful firului de ghidaj este chiar în apropierea vârfului cateterului de ghidaj.
- e) Atașați dispozitivul de torsiune la firul de ghidaj, dacă este necesar.
- f) Înaintați firul de ghidaj sub fluoroscopie pentru a străbate leziunea. Confirmați cu ajutorul angiografiei că firul de ghidaj a parcurs leziunea țintă îngustată.
- g) Observați mișcarea firului de ghidaj în

vase.

- h) Îndepărtați dispozitivul de torsiune a firului de ghidaj și liderul firului de ghidaj.
- i) Urmăriți dispozitivul de intervenție peste firul de ghidaj, împiedicând în același timp mișcarea firului de ghidaj, și avansați până când se ajunge la leziune. Asigurați-vă că vârful distal al firului de ghidaj și locația acestuia în vas sunt vizibile în timpul manevrelor dispozitivului de intervenție.

4. Proceduri de schimbare a firului de ghidaj

- Sistem cu cateter peste firul de ghidaj
 - a) Îndepărtați încet acest fir de ghidaj în timp ce monitorizați mișcarea acestuia sub fluoroscopie.
 - b) Inserați următorul fir de ghidaj în conformitate cu instrucțiunile din această secțiune "Instrucțiuni de utilizare".

Metoda de depozitare

Nu păstrați firul de ghidaj și ambalajul în stare îndoită și/sau în condiții de sarcini foarte mari. Acest fir de ghidaj și ambalajul trebuie păstrate departe de apă. Depozitați-le într-un loc răcoros, întunecat și uscat.

Data de expirare

Data de expirare este indicată pe eticheta ambalajului firului de ghidaj.

Conținut

5 bucăți / cutie

Clauza privind exonerarea de răspundere

În niciun caz „ASAHI INTECC CO., LTD. și companiile sale afiliate” (denumite în continuare „Compania”) nu vor fi răspunzătoare pentru accidente, vătămări corporale, reacții adverse datorate utilizării necorespunzătoare a produsului (produselor) sau oricăreia alte utilizări neconforme cu aceste instrucțiuni. În niciun caz Compania nu va fi răspunzătoare pentru orice daune (i) care rezultă din depozitarea produsului (produselor) după expedierea de către Companie sau (ii) datorate selecției pacienților, tehnicilor chirurgicale sau oricăror alte activități medicale desfășurate de către instituția medicală care utilizează produsul (produsele).

„Gladius”, „Halberd”, „ASAHI Gaia” și „Astato” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale ASAHI INTECC CO., LTD. în Japonia și în alte țări.

*Valorile sarcinii vârfului reprezintă valorile medii ale valorilor specificațiilor produsului măsurate în conformitate cu metoda de testare a standardului intern, presupunând forța aplicată pe leziune de către vârful firului de ghidaj.

Periferna vodilna žica

Navodila za uporabo

Pred uporabo te vodilne žice natančno preberite ta navodila in upoštevajte razdelke Indikacije za uporabo, Ciljna zdravljena populacija, Kontraindikacije, Opozorila, Previdnostni ukrepi in Kako se uporablja v teh navodilih za uporabo. Če tega ne storite, lahko pride do zapletov, vključno z resnimi poškodbami bolnika ali smrtjo.

Če uporabnik in/ali bolnik izve za resen incident, ki se je zgodil v zvezi z vodilno žico, o tem obvesti proizvajalca in pristojni organ države članice.

Ta navodila za uporabo veljajo za Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, Gladius MG18 PV ES, Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, ASAHI Gaia PV. Za podrobnosti (dolžina vodilne žice, dolžina radioopalnega odseka itd.) glejte etiketo izdelka.

Opisi

Osnovno strukturo te vodilne žice sestavljajo zožena jedrna žica in dve vrsti distalnih tuljav (zunanje tuljave in notranje tuljave). Zožena jedrna žica in tuljave so spajkane. Delna dolžina zunanje tuljave je radioopalna, tako da je njeno lego mogoče enostavno potrditi z radioskopijo. Distalne strani naprav Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30 in ASAHI Gaia PV so prevlečene s hidrofilnim polimerom. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES in Gladius MG18 PV ES imajo poliuretansko prevleko na zunanji tuljavi in hidrofilno prevleko na vrhu le-te. Pri vseh vodilnih žicah je proksimalna stran zožene jedrne žice prevlečena s PTFE (politetrafluoroetilen). Na proksimalnem koncu pripomočkov, razen tistih s skupno dolžino 300 cm, je priključek za podaljševalno žico, ki se uporablja za zamenjavo kombiniranega pripomočka. Priključite lahko podaljševalno žico ASAHI INTECC. Glejte spodnjo tabelo za obremenitev konice* tega izdelka.

Tabela1. Specifikacije izdelka

Ime izdelka	Zunanji premer	Obremenitev konice*
Gladius	0,36 mm (0,014")	3 gf
	0,45 mm (0,018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0,36 mm (0,014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0,46 mm (0,018")	3 gf
	0,36 mm (0,014")	12 gf
Halberd	0,45 mm (0,018")	12 gf
Astato XS 20	0,20 mm/0,36 mm (0,008"/0,014")	20 gf
Astato XS 40	0,23 mm/0,36 mm (0,009"/0,014")	40 gf
Astato 30	0,33 mm/0,45 mm (0,013"/0,018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0,36 mm/0,45 mm (0,014"/0,018")	7,5 gf

Indikacije za uporabo

Ta vodilna žica je namenjena splošni perkutani periferni intervenciji (PPI). Ta vodilna žica je namenjena olajšanju namestitve intervencijskih terapevtskih pripomočkov v periferno žilje spodnje okončine. Ta vodilna žica je namenjena za uporabo samo v perifernem žilju spodnje okončine. Ta vodilna žica ni namenjena za uporabo v nevrovaskularnem in kardiovaskularnem sistemu.

Ciljna zdravljena populacija

Ta vodilna žica je namenjena bolnikom, ki izpolnjujejo indikacije za postopke s PPI. Ni indicirano za uporabo pri novorojenčkih, dojenčkih ali otrocih ter bolnicah, ki so noseče, bolnikih, ki imajo okvarjeno ledvično funkcijo in imajo alergijsko reakcijo na kontrastna sredstva ali polietilen glikol (PEG).

Kontraindikacije

- Pred dejansko uporabo potrdite združljivost premera vodilne žice z drugimi intervencijskimi pripomočki.
- Vodilne žice ne uporabljajte pri bolnikih, ki imajo alergijsko reakcijo na kontrastna sredstva ali pri tistih, ki imajo oslABLJENO delovanje ledvic.
- Ta vodilna žica vsebuje PEG400 v svoji hidrofilni prevleki. Vodilne žice ne uporabljajte pri bolnikih, ki imajo alergijske reakcije na polietilen glikol (PEG).
- Vodilne žice ne uporabljajte pri nosečih bolnicah ali bolnicah, ki bi lahko bile noseče (rentgensko slikanje lahko vpliva na plod).
- To vodilno žico je treba uporabiti v ustanovi, kjer je mogoče takoj izvesti nujni kirurški poseg. Če nujni kirurški poseg ni na voljo, lahko v najslabšem primeru pride do smrtno nevarnih dogodkov.
- Ta vodilna žica je predhodno sterilizirana s plinom etilen oksidom (EOG) in je namenjena samo za enkratno uporabo. Ne uporabljajte ponovno ali ponovno sterilizirajte. Pri ponovni uporabi ali ponovni sterilizaciji je lahko učinkovitost ali kakovost te vodilne žice in embalaže ogrožena in obstaja tveganje zapletov, vključno z okužbo.

Opozorila

- To vodilno žico sme uporabljati le zdravnik, ki je popolnoma usposobljen za zdravljenje s PPI.
- Te vodilne žice nikoli ne uporabljajte v kombinaciji s katetri, ki imajo kovinske dele, ki bi lahko neposredno prišli v stik s površino te vodilne žice (npr. katetri za aterektomijo, kovinski dilatatorji), kovinskimi iglami ali kovinskimi uvodniki.
- Med uporabo vodilne žice preverite in spremljajte gibanje njene konice pod fluoroskopijo. Ne uporabljajte na območjih žile, ki niso vidna ali jih ni mogoče videti.
- Te vodilne žice ne povežite s snemljivimi podaljševalnimi žicami, ki jih proizvajajo proizvajalci, ki niso ASAHI INTECC. Ne manipulirajte s to vodilno žico, medtem ko je snemljiva podaljševalna žica priključena. V nasprotnem primeru se lahko vodilna žica poškoduje ali pa se snemljiva podaljševalna žica nenamerno sname.
- Ne spreminjajte te vodilne žice iz kakršnega koli razloga.

Previdnostni ukrepi

- Vodilne žice ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na etiketi. Zavrzite vse vodilne žice, katerim je potekel rok uporabe.
- Vodilne žice so občutljivi instrumenti, zato je treba z njimi ravnanje previdno.
- Ne brišite te vodilne žice z organsko raztopino,
- Vodilne žice ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana. Embalažo odprite šele tik pred uporabo. Pri rokovanju in uporabi vodilne žice uporabljajte aseptično tehniko.
- Vodilna žica naj bo vedno mokra, da preprečite poškodbe njene hidrofilne prevleke, kot je alkohol.

- Po uporabi to vodilno žico, dodatke in embalažo zavrzite med medicinske odpadke, pri čemer upoštevajte preventivne ukrepe proti nalezljivim boleznim.
- Te vodilne žice, ki naleti na upor, nikoli ne potiskajte, vlecite, izvlecite ali zasukajte. Vrtanje ali potiskanje te vodilne žice proti upor lahko povzroči poškodbe in/ali ločitev konice te vodilne žice ali neposredno poškodbo žile. Če tega ne storite, lahko poškodujete to vodilno žico. Ugotovite vzrok upora pod fluoroskopijo in izvedite vse potrebne popravne ukrepe.
- Vodilno žico vedno počasi in previdno premikajte ali izvlecite.
- Ko zasukate to vodilno žico znotraj krvne žile, je ne vrtite neprekinjeno v isto smer. Ko zasukate vodilno žico, jo izmenično vrtite v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca. Ne zavrtite za več kot dva obrata (720°) v isto smer.
- Med odstranjevanjem in ponovnim uvajanjem vodilno žico sperite s heparinizirano in sterilizirano fiziološko raztopino ali drugo primerno raztopino, da preprečite vstop zraka v intervencijski pripomoček. Pazljivo zamenjajte to vodilno žico, da preprečite vstop zraka in/ali poškodbe. Pri ponovnem uvajanju vodilne žice se prepričajte, da je konica intervencijskega pripomočka prosta v lumnu žile in ni ob steni žile. Če tega ne storite, lahko pride do poškodbe. Uporabite radioopaki označevalec na intervencijskem pripomočku, da potrdite položaj.
- Prosto gibanje vodilne žice znotraj intervencijskega pripomočka je pomembna značilnost vodljivega sistema vodilne žice, saj daje uporabniku dragocene občutljive informacije. Pred uporabo preizkusite sistem glede kakršnega koli upora. Prilagodite ali zamenjajte ventil za hemostazo z nastavljenim ventilom, če ugotovite, da zavira gibanje vodilne žice.
- Ne izvajajte nameščanja stenta z uporabo več kot ene vodilne žice ali postopka z žico skozi

opornik stenta. V nasprotnem primeru se lahko stent poškoduje ali pa se vodilna žica zlomi ali razpade.

- Pred uporabo se prepričajte, da je ta vodilna žica po velikosti in obliki primerna za postopek in je združljiva s pripomočkom, s katerim jo boste uporabljali.
- Glejte Navodila za uporabo, ki so priložena medicinskemu pripomočku (npr. intervencijskim terapevtskim pripomočkom), ki ga želite uporabljati v kombinaciji s to vodilno žico.
- Pri povezovanju snemljive podaljševalne žice s to vodilno žico mora biti ta varno vstavljena na mejno črto med prevleko brez PTFE in prevleko iz PTFE na proksimalnem koncu vodilne žice. Če opazite kakršno koli nepravilnost v povezavi, takoj prenehajte uporabljati vodilno žico.
- Pred uporabo in med postopkom, kadar koli je to mogoče, skrbno preglejte vodilno žico glede prepognjenosti, pregibov ali drugih poškodb. Ne uporabljajte vodilne žice, če je poškodovana.
- Pri oblikovanju konice pazite, da ne poškodujete tuljave.
- Pred uvajanjem vodilne žice, preverite, kateri konec je distalni konec, in poskrbite, da jo uvedete z distalnega konca.
- Med postopkom vzdržujte neprekinjeno izpiranje s heparinizirano in sterilizirano fiziološko raztopino med vodilnim katetrom in intervencijskim pripomočkom ter med intervencijskim pripomočkom in vodilno žico. Izpiranje prepreči nastanek kristalov kontrastnega sredstva in/ali strjevanje na vodilni žici in v lumnu katetra.
- Pri držalu z zaščitno cevjo na distalnem koncu (glejte Kako se uporablja, slika 1) ne odstranjujte ali vstavljajte zaščitne cevke na distalnem koncu, dokler je vodilna žica nameščena v držalo.
- Pri držalu z zaščitno cevjo na distalnem koncu (glejte Kako se uporablja, slika 1) odstranite zaščitno cevko na distalnem koncu, preden namestite vodilno žico v držalo.

1. Motnje delovanja

Zlom ali upogibanje vodilne žice

Poškodba kot je ločevanje

Odstopanje prevleke

2. Neželeni učinki

Smrt

Okužba

Znižanje krvnega tlaka

Zapleti krvarjenja

Embolija

Infarkt

Vaskularna okluzija

Strdek

Ishemija

Aritmija

Disekcija žil

Vazospazem

Omotica

Glavobol

Bruhanje

Perforacija žil

Alergijska reakcija

Kako se uporablja

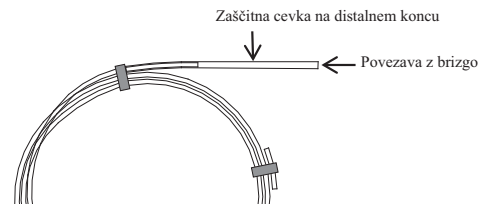
1. Pregled pred uporabo

- Pred uporabo natančno preglejte in se prepričajte, da sta vodilna žica in embalaža nepoškodovani.
- Pred uporabo preverite, če je vodilna žica združljiva z intervencijskimi pripomočki, ki jih boste uporabili.

2. Priprava

- Izberite najprimernejšo vodilno žico za prizadeto območje in odstranite nosilno cevko, ki vsebuje vodilno žico iz sterilnega ovoja.

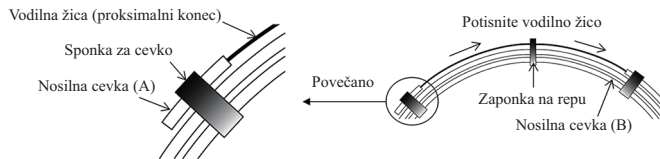
- Z brizgo napolnite nosilno cevko s heparinizirano in sterilizirano fiziološko raztopino, da namočite celotni pripomoček. Upoštevajte, da se lahko heparinizirana in sterilizirana fiziološka raztopina v tem času razlije iz nosilne cevke.
- Preden vstavite vodilno žico, napolnite lumen intervencijskega pripomočka s heparinizirano in sterilizirano fiziološko raztopino.
- Sprostite vodilno žico iz zaponke na repu in počasi potisnite vodilno žico, potisnite distalni konec vodilne žice skozi nosilno cevko (B) (Slika 2).



Slika 1

Motnje delovanja in neželeni učinki

Možne motnje delovanja in neželeni učinki zaradi uporabe te vodilne žice vključujejo, vendar niso omejeni na naslednje:



Slika 2

- e) Ko je distalni konec vodilne žice podaljšan 5 do 6 cm čez drugi konec nosilne cevke (ali čez zaščitno cevko na distalnem koncu), po potrebi oblikujte konico v skladu s standardno prakso.
- f) Vodilno žico, ki je izšla iz distalnega konca nosilne cevke na distalnem koncu (ali zaščitne cevke na distalnem koncu), nežno primate na mestu, ki je čim bližje nosilni cevki, in počasi in previdno izvlecite vodilno žico.
- g) Če pri odstranjevanju vodilne žice iz nosilne cevke začutite upor, ponovno vbrizgajte heparinizirano in sterilizirano fiziološko raztopino v nosilno cevko. Nadaljujte z odstranjevanjem vodilne žice, ko ni več čutiti upora. Prepričajte se, da ste v nosilno cevko vbrizgali dovolj heparinizirane in sterilizirane fiziološke raztopine, ker se lahko hidrofilna prevleka poškoduje, ko na silo odstranite prevlečeno vodilno žico.
- h) Ko vodilno žico izvlecete iz nosilne cevke, jo pregledajte, da se prepričate, da ni poškodovana.

3. Postopki za uvajanje

- Sistem preko žice
 - a) Distalni konec vodilne žice previdno uvajajte v lumen vodilne žice intervencijskega pripomočka.
 - b) Previdno pomaknite to vodilno žico, dokler ni njena konica tik proksimalno od konice intervencijskega pripomočka.
 - c) Vstavite vodilni kateter in uvedite sistem intervencijskega pripomočka (z vodilno žico) v priključek Y.
 - d) Pomaknite sistem intervencijskega pripomočka skozi vodilni kateter, dokler konica sistema vodilne žice ni tik proksimalno od konice vodilnega katetra.
 - e) Zategnite ventil za hemostazo priključka Y,

da ustvarite tesnjenje okoli intervencijskega pripomočka. Prepričajte se, da je premikanje vodilne žice še dovoljeno.

- f) Preverite, če se vodilna žica premika gladko.
- g) Po potrebi pritrdite navorno napravo na vodilno žico.
- h) Pomaknite to vodilno žico pod fluoroskopijo, da gre skozi lezijo. Z angiografijo potrdite, da je vodilna žica prešla skozi zoženo ciljno lezijo.
- i) Opazujte gibanje vodilne žice v žilah.
- j) Pomaknite intervencijski pripomoček naprej, dokler ne dosežete lezije, pri tem pa preprečite premikanje vodilne žice. Zagotovite, da sta distalna konica vodilne žice in njena lokacija v žili vidni med manipulacijami z intervencijskim pripomočkom.

■ Sistem hitre menjave

- a) Vstavite vodilni kateter.
- b) Uvajalnik vodilne žice vstavite v priključek Y vodilnega katetra.
- c) Konico vodilne žice previdno vstavite v uvajalnik.
- d) Pomaknite vodilno žico skozi vodilni kateter pod fluoroskopijo, dokler ni konica vodilne žice tik proksimalno od konice vodilnega katetra.
- e) Po potrebi pritrdite navorno napravo na vodilno žico.
- f) Pomaknite vodilno žico pod fluoroskopijo, da gre skozi lezijo. Z angiografijo potrdite, da je vodilna žica prešla skozi zoženo ciljno lezijo.
- g) Opazujte gibanje vodilne žice v žilah.
- h) Odstranite navorno napravo vodilne žice in uvajalnik vodilne žice.
- i) Sledite intervencijskemu pripomočku

preko vodilne žice, medtem ko preprečujete premikanje vodilne žice, in pomikajte, dokler ne dosežete lezije. Zagotovite, da sta distalna konica vodilne žice in njena lokacija v žili vidni med manipulacijami z intervencijskim pripomočkom.

4. Postopki za zamenjavo vodilne žice

- Sistem preko žice
 - a) Počasi odstranite to vodilno žico, medtem ko spremljate gibanje te vodilne žice pod fluoroskopijo.
 - b) Uvedite naslednjo vodilno žico v skladu z navodili v tem razdelku »Kako se uporablja«.

Način shranjevanja

Vodilne žice in embalaže ne hranite v upognjenem in/ali močno obremenjenem stanju. Ta vodilna žica in embalaža ne smeta biti v vodi. Hraniti v hladnem, temnem in suhem prostoru.

Rok uporabnosti

Rok uporabnosti je naveden na etiketi embalaže vodilne žice.

Vsebina

5 kosov/škatlja

Zavrnitev odgovornosti

Podjetje „ASAHI INTECC CO., LTD. in njegova pridružena podjetja“ (v nadaljevanju „podjetje“) ne odgovarjajo za nesreče, telesne poškodbe, neželene učinke zaradi kakršne koli nepravilne uporabe izdelka(-ov) ali katere koli druge uporabe, ki ni v skladu s temi navodili. Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za kakršno koli škodo bodisi (i) zaradi shranjevanja izdelka(-ov) po odpremi iz podjetja bodisi (ii) zaradi izbire bolnikov, kirurških tehnik ali katere koli druge zdravstvene dejavnosti s strani zdravstvene ustanove, ki uporablja izdelek(-e).

„Gladius“, „Halberd“, „ASAHI Gaia“ in „Astato“ so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe ASAHI INTECC CO., LTD. na Japonskem in v drugih državah.

*Vrednosti obremenitve konice predstavljajo povprečne vrednosti od vrednosti specifikacije izdelka, izmerjene v skladu z interno standardno preskusno metodo, ob predpostavki sile, ki deluje na lezijo s konico vodilne žice.

Wajer Gwida Periferali

Istruzzjonijiet għall-użu

Aqra dawn l-istruzzjonijiet b'attenzjoni qabel ma tuża dan il-wajer gwida u osserva l-Indikazzjonijiet għall-Użu, il-Popolazzjoni Ttrattata fil-Mira, il-Kontraindikazzjonijiet, it-Twissijiet, il-Prekawzjonijiet, u t-taqsimiet Kif Tuża l-Prodott f'dawn l-Istruzzjonijiet għall-Użu. Jekk dan ma jsirx, jista' jirriżulta f'kumplikazzjonijiet, inkluż korrimtent serju għall-pazjent jew mewt.

Jekk utent u/jew pazjent isir jaf dwar incident serju li sehħ b'rabta mal-wajer gwida, dan għandu jirrapporta l-fatt lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

Dawn l-Istruzzjonijiet għall-Użu japplikaw għall-Gladius, il-Gladius MG14 PV, il-Gladius MG14 PV ES, il-Gladius MG18 PV ES, il-Halberd, l-Astato XS 20, l-Astato XS 40, l-Astato 30, l-ASAHI Gaia PV. Għal dettalji (tul tal-wajer gwida, tul tas-sezzjoni radjopaka, eċċ.), irreferi għat-tikketta tal-prodott.

Deskrizzjonijiet

L-istruttura bażika ta' dan il-wajer gwida tikkonsisti minn wajer bil-qalba ġej għall-ponta, u żewġ tipi ta' kojls distali (kojl ta' barra u kojl ta' ġewwa). Il-wajer bil-qalba ġej għall-ponta u l-kojls huma ssaldjati. Parti mill-kojl ta' barra jew it-tul kollu tiegħu huwa radjopak halli l-pożizzjoni tiegħu tkun tista' tiġi kkonfermata faċilment bil-fluoroskopija. In-nahat distali ta' Halberd, Astato XS 20, Astato XS 40, Astato 30, u ASAHI Gaia PV huma miksija b'polimeru idrofiliċu. Gladius, Gladius MG14 PV, Gladius MG14 PV ES, u Gladius MG18 PV ES kollha għandhom kisi tar-reżina tal-poliuretān fuq il-kojl ta' barra, u kisi idrofiliċu fuqu. F'dawn il-wajers gwida kollha, in-naha prossimali tal-wajer bil-qalba ġej għall-ponta hija miksija bil-PTFE (politetrafluorooletilen). Fit-tarf prossimali tal-apparati minbarra dawk b'tul totali ta' 300 cm, hemm konnessjoni għal wajer ta' estensjoni, li jintuża biex jissostitwixxi l-apparat ikkombinat; il-Wajer ta' Estensjoni ta' ASAHI INTECC jista' jiġi konness. Irreferi għat-tabella hawn taht għat-tagħbija fuq il-ponta* ta' dan il-prodott.

Tabella 1. Speċifikazzjonijiet tal-prodott

Isem tal-Prodott	Dijametru ta' Barra	Tagħbija fuq il-Ponta*
Gladius	0.36 mm (0.014")	3 gf
	0.45 mm (0.018")	4 gf
Gladius MG14 PV	0.36 mm (0.014")	3 gf
Gladius MG14 PV ES	0.36 mm (0.014")	3 gf
Gladius MG18 PV ES	0.46 mm (0.018")	3 gf
Halberd	0.36 mm (0.014")	12 gf
	0.45 mm (0.018")	12 gf
Astato XS 20	0.20 mm/0.36 mm (0.008"/0.014")	20 gf
Astato XS 40	0.23 mm/0.36 mm (0.009"/0.014")	40 gf
Astato 30	0.33 mm/0.45 mm (0.013"/0.018")	30 gf
ASAHI Gaia PV	0.36 mm/0.45 mm (0.014"/0.018")	7.5 gf

Indikazzjonijiet għall-użu

Dan il-wajer gwida huwa mahsub għal intervent periferali perkutanju (PPI, percutaneous peripheral intervention) ġenerali. Dan il-wajer gwida huwa mahsub biex jiffaċilita t-tqegħid ta' apparati ta' intervent terapewtiku fil-vaskulatura periferali tal-estremità t'isfel.

Dan il-wajer gwida huwa mahsub għall-użu biss fil-vaskulatura periferali tal-estremità t'isfel. Dan il-wajer gwida mhuwex mahsub għall-użu fin-newrovaskulatura u fil-kardjovaskulatura.

Popolazzjoni Ttrattata fil-Mira

Dan il-wajer gwida huwa mahsub għal pazjenti li jissodisfaw l-indikazzjonijiet għall-proċeduri ta' PPI. Mhuwex indikat għall-użu fi trabi tat-twelid, tfaġ għar, jew tfaġ kif ukoll f'pazjenti tqal, b'insuffiċjenza renali, u b'reazzjoni allergika għal agent ta' kuntrast jew għall-polietilenglikol (PEG).

Kontraindikazzjonijiet

- Ikkonferma l-kompatibbiltà tad-dijametru tal-wajer gwida ma' apparati ta' intervent oħrajn qabel l-użu proprju.
- Tużax il-wajer gwida f'pazjenti b'reazzjoni allergika għal agenti ta' kuntrast jew li għandhom insuffiċjenza renali.
- Dan il-wajer gwida fih PEG400 fil-kisi idrofiliċu tiegħu. Tużax il-wajer gwida f'pazjenti b'reazzjoni allergika għall-polietilenglikol (PEG).
- Tużax il-wajer gwida għal pazjenti tqal jew pazjenti li jistgħu jkunu tqal (ir-raġġi X jistgħu jaffettwaw lill-fetu).
- Dan il-wajer gwida għandu jintuża f'istituzzjoni fejn tista' titwettag operazzjoni kirurġika ta' emerġenza minnufih. Jekk operazzjoni kirurġika ta' emerġenza ma tkunx disponibbli, fil-aħgar xenarju possibbli, jistgħu jsejhu avvenimenti li jheddu l-hajja.
- Dan il-wajer gwida huwa sterilizzat minn qabel bil-gass tal-ossidu etilen (EOG) u huwa mahsub biex jintuża darba biss. Terġax tuża jew tisterrilizza mill-ġdid. Jekk jintuża iktar minn darba jew ikun sterilizzat mill-ġdid, il-prestazzjoni jew il-kwalità ta' dan il-wajer gwida jistgħu jiġu kompromessi u hemm riskju ta' kumplikazzjonijiet, inkluża l-infezzjoni.

Twissijiet

- Dan il-wajer gwida jrid jintuża biss minn tabib li huwa mħarrġ sew fit-trattament PPI.
- Qatt m'għandek tuża dan il-wajer gwida flimkien ma' kateters li jkollhom partijiet tal-metall li jistgħu jiġu f'kuntatt dirett mal-wiċċ ta' dan il-wajer gwida (eż. kateters ta' aterektomija, apparat għad-dilatazzjoni tal-metall, labar tal-metall jew introdutturi tal-metall).
- Waqt l-użu tal-wajer gwida, iwwerifika u ssorvelja l-moviment tal-ponta tiegħu permezz tal-fluoroskopija. Tużax f'żoni ta' važi li ma humiex jew ma jistgħux jiġu viżwalizzati.
- Tikkonnettjix dan il-wajer gwida ma' wajers ta' estensjoni li jinqalgħu prodotti minn manifatturi għajr ASAHI INTECC. Timmanipulax dan il-wajer gwida waqt li jkun konness il-wajer ta' estensjoni li jinqala'. Jekk le, il-wajer gwida jista' jsirlu l-hsara, jew il-wajer ta' estensjoni li jinqala' jista' jinqala' involontarjament.
- Timmodifkax dan il-wajer gwida għall-ebda raġuni.

Prekawzjonijiet

- Tużax il-wajer gwida wara d-data ta' skadenza indikata fuq it-tikketta. Armi kwalunkwe wajer gwida li jaqbeż din id-data ta' skadenza.
- Il-wajers gwida huma strumenti delikati u għandhom jiġu mmanigġjati b'attenzjoni.
- Jekk il-pakkett ikun miftuħ jew dannegġat, tużax il-wajer gwida. Iftaħ il-pakkett biss eżatt qabel l-użu. Uża teknika asettika għall-immanigġjar u l-użu tal-wajer gwida.
- Dejjem zomm il-wajer gwida fi stat imxarrab biex tipprevjeni l-hsara għall-kisi idrofiliċu tiegħu.
- Timsaħx dan il-wajer gwida b'soluzzjoni organika bħall-alkohol.

- Wara l-użu, armi dan il-wajer gwida, l-aċċessorji, u l-pakkett bħala skart mediku filwaqt li tiehu miżuri ta' prevenzjoni kontra mard infettiv.
- Qatt timbotta, tittirpana, tiġbed jew iddawwar dan il-wajer gwida jekk issib rezistenza. It-tidwir jew l-imbottar ta' dan il-wajer gwida meta juri rezistenza jista' jikkawża hsara u/jew iseparazzjoni tal-ponta ta' dan il-wajer gwida jew hsara diretta lil vażu. Jekk dan ma jsirx, tista' ssir hsara lil dan il-wajer gwida. Iddetermina l-kawża tar-reżistenza bl-użu tal-fluworoskopija u hu kwalunkwe azzjoni rimedjali meħtieġa.
- Dejjem dahhal jew ohroġ il-wajer gwida bil-mod u b'attenzjoni.
- Meta ddawwar dan il-wajer gwida ġewwa l-vażu, iddawwarx kontinwament fl-istess direzzjoni. Meta ddawwar il-wajer gwida, alterna bejn tidwir skont l-arloġġ u kontra l-arloġġ. Iddawwarx aktar minn żewġ rotazzjonijiet (720°) fl-istess direzzjoni.
- Naddaf il-wajer gwida b'soluzzjoni salina jew soluzzjoni xierqa oħra eparinizzata u sterilizzata waqt li tnehhil u terġa' ddahhlu sabiex tipprevjeni milli tidhol l-arja fl-apparat ta' intervent. Skambja dan il-wajer gwida b'attenzjoni biex tipprevjeni dħul tal-arja u/jew trauma. Meta tintroduċi l-wajer gwida mill-ġdid, ikkonferma li l-ponta tal-apparat ta' intervent huwa hieles ġewwa l-lumen tal-vażu u li mhux qed imiss mal-ġenb tal-vażu. Jekk dan ma jsirx, jista' jirrizulta fi trauma. Uża l-markatur radjopak tal-apparat ta' intervent biex tikkonferma l-pożizzjoni.
- Il-moviment hieles tal-wajer gwida fl-apparat ta' intervent huwa karatteristika importanti ta' sistema ta' wajer gwida orjentabbli għaliex jagħti lill-utent informazzjoni tattili ta' valur. Ittestja s-sistema għal kwalunkwe rezistenza qabel l-użu. Aġġusta jew issostitwixxi l-valvola emostatika b'valvola aġġustabbli jekk tinsab li tostakola l-moviment tal-wajer gwida.
- Tqegħidx stent bl-użu ta' aktar minn wajer gwida wieħed jew operazzjoni ta' wajer gwida

Hsarat u Avvenimenti Avversi

Il-hsarat u l-avvenimenti avversi possibbli mill-użu ta' dan il-wajer gwida jinkludu, iżda ma humiex limitati għal dan li ġej:

1. Hsarat

Ksur jew liwi tal-wajer gwida Hsara bħal separazzjoni Tnehhija tal-kisi

bl-użu ta' stent strut. Jekk le, tista' ssir hsara lill-istent jew il-wajer gwida jista' jtkisser jew jitfarrak.

- Qabel l-użu, ikkonferma li dan il-wajer gwida huwa ta' daqs u forma xierqa għall-proċedura u li huwa kompatibbli mal-apparat li għandu jintuża flimkien miegħu.
- Irreferi għall-Istruzzjonijiet għall-Użu pprovduti mal-apparat mediku (eż. apparati ta' intervent terapewtiku) li se jintuża flimkien ma' dan il-wajer gwida.
- Meta jiġi konness il-wajer ta' estensjoni li jinqala' ma' dan il-wajer gwida, għandu jiddahhal b'mod sikur fil-linja konfinali bejn il-kisi mhux tal-PTFE u l-kisi tal-PTFE fit-tarf prossimali tal-wajer gwida. Jekk tinstab xi anomalija fil-konnessjoni, waqfa l-użu tal-wajer gwida minnufih.
- Spezzjona l-wajer gwida b'attenzjoni għal liwi, għoqiedi jew hsara oħra qabel l-użu u meta possibbli waqt il-proċedura. Tużax il-wajer gwida jekk ikun dannegġat.
- Meta tiffirma l-ponta, oqghod attent li ma tagħmilx hsara lill-kojl.
- Qabel ma ddahhal il-wajer gwida, ivverifika liema tarf huwa t-tarf distali u kun ċert li ddahhlu mit-tarf distali.
- Ara li jkun hemm tlaħlil kontinwu b' salina eparinizzata u sterilizzata bejn il-kateter gwida u l-apparat ta' intervent u bejn l-apparat ta' intervent u l-wajer gwida waqt il-proċedura. It-tlaħlil jipprevjeni l-formazzjoni tal-kristalli tal-mezz ta' kuntrast u/jew it-tagħqid ta' demm fuq il-wajer gwida u fil-lumen tal-kateter.
- Għad-detentur bit-tubu protettur tat-tarf distali (irreferi għal Kif Tuża L-Prodott, Figura 1), la għandek tneħhi u lanqas iddahhal it-tubu protettur tat-tarf distali waqt li l-wajer gwida jkun fid-detentur.
- Għad-detentur bit-tubu protettur tat-tarf distali (irreferi għal Kif Tuża L-Prodott, Figura 1), neħhi l-tubu protettur tat-tarf distali qabel ma terġa' tpoġġi l-wajer gwida fid-detentur.

2. Avvenimenti avversi

Mewt	Infezzjoni	
Pressjoni baxxa	Kumplikazzjonijiet ta' emorraġija	Embolizmu
Infart	Okklużjoni vaskulari	Trombożi
Iskemija	Arritmija	Dissezzjoni tal-vażu
Vasospazmu	Sturdament	Uġiġh ta' ras
Rimettar	Perforazzjoni tal-vażu	Reazzjoni allergika

Kif Tuża l-prodott

- Spezzjoni qabel l-użu
 - Qabel l-użu, spezzjona b'attenzjoni u kkonferma li ma hemmx hsara fil-wajer gwida u fil-pakkett.
 - Qabel l-użu, ikkonferma li l-wajer gwida huwa kompatibbli mal-apparati ta' intervent li għandhom jintużaw.
- Preparazzjoni
 - Aghzel l-aktar wajer gwida xieraq għaž-żona affettwata u neħhi l-tubu detentur li fi h il-wajer gwida mill-pakkett sterili.
 - Imla l-tubu detentur b'salina eparinizzata u sterilizzata bl-użu ta' siringa biex ixxarrab l-apparat shih. Innotta li s-salina eparinizzata u sterilizzata tista' tfur mit-tubu detentur f'dan il-mument.
 - Imla l-lumen tal-apparat ta' intervent bis-salina eparinizzata u sterilizzata qabel ma ddahhal il-wajer gwida.
 - Nehhi l-wajer gwida mill-klipp tat-tarf u żerzax il-wajer gwida bil-mod, imbotta t-tarf distali tal-wajer gwida minn ġoṭ-tubu detentur (B) (Figura 2).

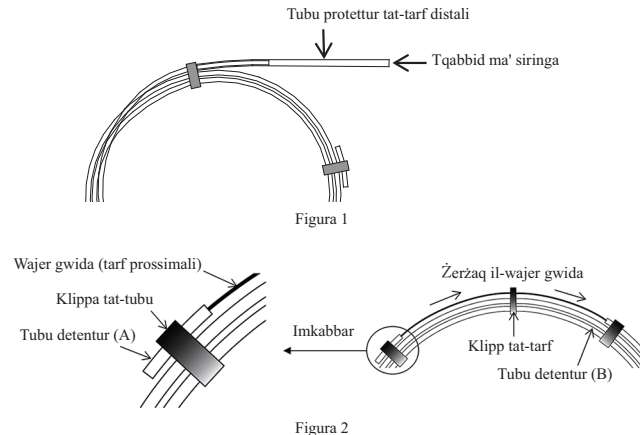


Figura 2

- Meta t-tarf distali tal-wajer gwida jiġi estż b'5 sa 6 cm lil hinn mit-tarf l-iehor tat-tubu detentur (jew tat-tubu protettur tat-tarf distali), jekk meħtieġ, ifforma l-ponta skont

il-prattika standard.

- f) Aqbad il-wajer gwida li jkun hareġ mit-tarf distali tat-tubu detentur (jew tat-tubu protettur tat-tarf distali) bil-mod, fl-eqreb punt possibbli ghat-tubu detentur u iġbed il-wajer gwida 'l barra bil-mod u b'attenzjoni.
- g) Jekk tinhass reżistenza meta tneħhi l-wajer gwida mit-tubu detentur, erga' injetta s-salina eparinizzata u sterilizzata fit-tubu detentur. Kompli neħhi l-wajer gwida wara li ma tibqax tinhass ir-reżistenza. Kun ċert li tinjetta biżżejjed salina eparinizzata u sterilizzata ghat-tubu detentur għaliex tista' ssir hsara għall-kisi idrofiliiku meta tneħhi l-wajer gwida miksi bis-sahha.
- h) Wara li tiġbed il-wajer gwida barra mit-tubu detentur, spezzjonah sabiex tkun ċert li ma hemmx hsara fih.

3. Proċeduri għall-inserzjoni

■ Sistema minn fuq il-wajer

- a) Dahhal it-tarf distali tal-wajer gwida b'attenzjoni fil-lumen tal-wajer gwida tal-apparat ta' intervent.
- b) Mexxi dan il-wajer gwida 'l quddiem b'attenzjoni sakemm it-tarf tiegħu jkun biss prossimali ghat-tarf tal-apparat ta' intervent.
- c) Qabbad il-kateter gwida u dahhal is-sistema tal-apparat ta' intervent (bil-wajer gwida) fil-konnettur Y.
- d) Mexxi s-sistema tal-apparat ta' intervent 'il quddiem minn ġol-kateter ta' gwida sakemm il-ponta tas-sistema tal-wajer gwida tkun biss prossimali għall-ponta tal-kateter gwida.
- e) Issikka l-valvola emostatika tal-konnettur Y biex tohloq siġill madwar l-apparat ta' intervent. Kun ċert li l-moviment tal-wajer gwida jkun għadu possibbli.
- f) Ivverifika li l-wajer gwida jiċċaqraq minghajr xkiel.
- g) Wahhal l-apparat tat-torque mal-wajer gwida jekk meħtieġ.
- h) Mexxi dan il-wajer gwida 'l quddiem bl-użu tal-fluworoskopija biex jgħaddi minn ġol-leżjoni. Ikkonferma bl-użu tal-angiografija li l-wajer gwida jkun għadda

mil-leżjoni ristretta fil-mira.

- i) Osserva l-moviment tal-wajer gwida fil-vazi.
- j) Mexxi l-apparat ta' intervent 'il quddiem sakemm tinklehaq il-leżjoni filwaqt li tipprevjeni l-wajer gwida milli jiċċaqraq. Kun ċert li l-ponta distali tal-wajer gwida u l-pożizzjoni tagħha fil-vażu jkunu viżibbli waqt il-manipulazzjonijiet tal-apparat ta' intervent.

■ Sistema ta' skambju rapidu

- a) Qabbad il-kateter gwida.
- b) Dahhal l-introductur tal-wajer gwida fil-konnettur Y tal-kateter gwida.
- c) Dahhal il-ponta tal-wajer gwida b'attenzjoni fl-introductur.
- d) Mexxi l-wajer gwida 'l quddiem minn ġol-kateter ta' gwida bl-użu tal-fluworoskopija sakemm il-ponta tal-wajer gwida tkun biss prossimali għall-ponta tal-kateter gwida.
- e) Wahhal l-apparat tat-torque mal-wajer gwida jekk meħtieġ.
- f) Mexxi l-wajer gwida 'l quddiem bl-użu tal-fluworoskopija biex jgħaddi minn ġol-leżjoni. Ikkonferma bl-użu tal-angiografija li l-wajer gwida jkun għadda mil-leżjoni ristretta fil-mira.
- g) Osserva l-moviment tal-wajer gwida fil-vazi.
- h) Neħhi l-apparat tat-torque tal-wajer gwida u l-introductur tal-wajer gwida.
- i) Segwi l-apparat ta' intervent minn fuq il-wajer gwida sakemm tipprevjeni l-wajer gwida milli jimxi, u mexxi 'l quddiem sakemm tinklehaq il-leżjoni. Kun ċert li l-ponta distali tal-wajer gwida u l-pożizzjoni tagħha fil-vażu jkunu viżibbli waqt il-manipulazzjonijiet tal-apparat ta' intervent.

4. Proċeduri għall-iskambju tal-wajer gwida

■ Sistema minn fuq il-wajer

- a) Neħhi dan il-wajer gwida bil-mod filwaqt li timmonitora l-moviment ta' dan il-wajer gwida bl-użu tal-fluworoskopija.
- b) Dahhal il-wajer gwida li jmiss skont id-direzzjonijiet fit-taqsim "Kif Tuża l-Prodott".

Data ta' Skadenza

Id-data ta' skadenza hija indikata fuq it-tikketta tal-pakkett tal-wajer gwida.

Kontenut

5 biċċiet / kaxxa

Ċaħda ta' Responsabbiltà

“ASAHI INTECC CO., LTD. u l-kumpaniji affiljati tagħha” (minn hawn 'il quddiem il-**“Kumpanija”**) ma għandha bl-ebda mod tinzamm responsabbli għal incidenti, korrimenti personali, avvenimenti avversi minhabba użu mhux tajjeb tal-prodott(i) jew kwalunkwe użu ieħor li huwa inkonsistenti ma' dawn l-istruzzjonijiet. Il-Kumpanija fl-ebda ċirkostanza ma għandha tkun responsabbli għal xi danni li (i) jirriżultaw mill-ħżin tal-prodott/i wara l-konsenja tal-Kumpanija jew (ii) minhabba l-għażla tal-pazjenti, it-tekniki tal-kirurgija, jew kwalunkwe attività medika mill-istituzzjoni medika li tuża l-prodott/i.

“Gladius”, “Halberd”, “ASAHI Gaia” u “Astato” huma trademarks jew trademarks irregistrati ta' ASAHI INTECC CO., LTD. fil-Gappun u f'pajjiżi oħra.

*Il-valuri tat-tagħbija fuq il-ponta jirrappreżentaw il-valuri medji tal-valuri tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott imkejla skont il-metodu tal-ittestjar intern standard fejn tiġi preżunta l-forza applikata lil-leżjoni mill-ponta tal-wajer gwida.

Metodu ta' Ħżin

Iżżommx il-wajer gwida u l-pakkett f'kundizzjoni milwija u/jew taħt toqol kbir. Dan il-wajer gwida u l-pakkett għandhom jinżammu 'l bogħod mill-ilma. Aħżen f'poż frisk, mudlam u niexef.



ASAHI INTECC CO.,LTD.

3-100 Akatsuki-cho, Seto, Aichi 489-0071 JAPAN



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands

Basic UDI-DI:4547327DGW010NY
<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>



<https://medical.asahi-intecc.com/en>

©2026 ASAHI INTECC CO., LTD.
2026-01-09 (1st edition)